

עידן מליצ'ר

סקסולוגיה

זוגיות ומיניות מאל"ף עד תי"ו

עידן מליצ'ר

סקסולוגיה

זוגיות ומיניות מאל"ף עד תי"ו



צבעונים
הוצאה לאור

Idan Militscher

SEXOLOGY

איורים: אורית קליימינץ
העורכת: ד"ר לאה צבעוני
עימוד: יהודית שטרנברג
עיצוב העטיפה: אלה רסקין

© כל הזכויות שמורות למחבר

ולצבעונים הוצאה לאור

lea@tzivonim.com www.tzivonim.com

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע
או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי
בלי אישור בכתב מהמחבר ומהמוציא לאור.

נדפס בישראל תשע"ח 2018 Printed in Israel

הספר מוקדש באהבה לאשתי דליה
לילדיי עומר יעל ורועי
ולזכר הוריי רחל וארתור

תוכן העניינים

11	הקדמה	35	הגודל
13	אהבה	36	מיקרופניס
		37	הגדלת איבר המין
		38	עקמת הפין
		39	שבר בפין
		40	מילת העורלה
41	איבר המין הנשי		
		41	הנרתיק (וגינה)
42			התעוררות, ריגוש וסיכוך
		44	יובש בנרתיק
		46	קרום הבתולים
		47	הדגדגן
		47	התרחבות הנרתיק
		49	פין או פות
50	אינטליגנציה מינית		
52	א־מיניות		
54	אקסהיביציוניזם		
55	אתרי אינטרנט		
		55	היכריות באינטרנט
		56	זוגיות וירטואלית
58	בגידה		
		58	שבירת האמון
		59	פגיעה בתא המשפחתי
		60	בגידה של גברים ונשים
11	הקדמה		
13	אהבה		
		13	אהבה וזוגיות
		14	אהבה בגיל הרך
		15	אהבה התאהבות ורגש
		16	אהבה ויופי
		17	אהבה ובריאות
19	אוננות		
		19	פעולה טבעית
		21	התמכרות
		22	אצבעות מענגות
		22	אוננות במשרד
		23	אוננות בגיל מבוגר
24	אורגזמה		
		24	נתונים
		24	התהליך
		25	התחושה והעוצמה
		27	התנונחות, חדירה ואוננות
		29	אורגזמה וגיל האישה
		29	אנאורגזמה נשית
		31	אנאורגזמה משנית
		32	אנאורגזמה מצבית
		32	אורגזמה מבוימת
34	איבר המין הגברי		
		34	מבנה הפין

90	גברים בחדר הלידה	62	אפקט קולידג'
91	חזרה לחיי מין	62	לספר או לא לספר
93	התמכרות למין	64	קשר סודי
95	וגיניזמוס	65	ביסקסואליות (דו־מיניות)
98	ויברטור	67	גיל המעבר
100	וסטיבוליטיס-וולוודניה	67	הפסקת המחזור החודשי
104	זוגיות		גיל מעבר טבעי, בטרם עת
	על תפיסת הזוגיות	68	ומלאכותי
104	זוגיות בישראל	68	הטיפול
105	זוגיות שנייה	70	גיל המעבר בגברים
106	מרחב מחיה	72	גיל שלישי
	מגורים נפרדים וחדרים	72	תחושת האושר
106	נפרדים	73	יחסי מין פעילים
108	זוגרים – חיים בלי חתונה	75	הקן המתרוקן
109	זוגיות פתוחה מוסכמת	77	גירושים
110	קנאה בזוגיות	77	הסיבות והרקע
112	זוגיות וכסף	78	המשבר
112	ריבים בזוגיות	79	פרידה, אובדן והבראה
113	שקרים בזוגיות	81	דילדו
115	זקפה	82	דימוי הגוף
	התהליך	82	חינוך וחברה
	זקפה לילית	82	סקס באור או בחושך
116	הפרעה בזקפה	84	הומוסקסואליות
118	המטופל והרופא	84	העדפה מינית
119	התרופות		נשים המעדיפות גברים
121	חיזור	86	הומוסקסואליים
123	חילופי זוגות	87	התייחסות ההורים
125	חינוך מיני	89	היריון ולידה
128	חשק ותשוקה		יחסי מין לפי הביוץ
		89	התנוחה

162	מין ואלכוהול	תשוקה 128
164	מיניות בישראל	ליבידו 128
166	מיניות במלחמה	חשק וירידה בחשק 129
167	מציצנות	הסיבות לירידה בחשק 131
168	משיכה מינית	האבחון והתרופות 134
	גברים ונשים 168	שינה וחשק מיני 134
	גורמי משיכה 170	פעילות גופנית וחשק מיני 135
	משיכה לשדיים 171	טיפול מיני 136
	משיכה לנשים בהיריון 172	הטיפול המיני והמצב בארץ 136
	כאשר המשיכה נגמרת 173	סוגי הטיפולים 137
		התמקדות בתחושות 138
174	משפחה	טיפול פוריות 139
	הכלה והחמות 174	בעיות בתפקוד המיני 139
	המחותנים 175	גבר הלוקה בפוריותו 140
	המשפחה בחגים 175	אישה הלוקה בפוריותה 140
	חופשה משפחתית 176	הטיפולים 141
	ההורים 176	טרנס־סקסואליות 142
178	נקודת הג'י	טרנסווסטיזם 143
	המקום 178	ילדים ומיניות 144
	עיבוי נקודת הג'י 179	ילדי הגן 144
	נקודת הג'י של הגבר 179	עירום ופרטיות 144
180	נשים מבוגרות וגברים צעירים	אוננות ילדים 145
182	נשיקה	כאב ראש ויחסי מין 148
	בשבח הנשיקה 182	מחלת לב ומיניות 150
	הצד הפיזיולוגי 183	מין אוראלי 151
	נשיקה וזוגיות 183	מין אנאלי 155
	כללי התנשקות 184	מין, בריאות ומחלות 158
186	סאדו־מאזוכיזם	מין בשלישייה 160
	מאזוכיזם 186	
	סאדיזם 186	

217	פעילות גופנית ומין	189	סוכרת ומיניות
	כושר ומיניות 217		המחלה 189
	רכיבה על אופניים 218		הגבר הסוכרתי 189
	ריקודים 220		האישה הסוכרתית 190
221	צרכים מיניים	192	סרטן ומיניות
223	קונדום		סרטן השד 192
226	רווקים ונשואים		ההשפעות על האישה 193
228	שפיכה מוקדמת		התפקוד הזוגי 194
	הבעיה 228		סטומה 194
	הסיבות הפסיכולוגיות 229		סרטן הערמונית 195
	גנטיקה 230	197	עוררות מינית מתמדת
	הטיפול 230	199	עירום פומבי
	ההשפעה על האישה 233	201	פאראפיליה
234	שפיכה מעוכבת		סטייה מינית 201
	הבעיה 234		סוגים והגדרות 201
	התאמה מינית 235		הטיפול 202
	גמירה בלי שפיכה 235	204	פדופיליה
238	שפיכה נשית	205	פוליאמוריה
239	תנוחות	207	פורנוגרפיה
	התנוחה המיסיונרית 239		הגישות 207
	דוגי – תנוחת הכלב 239		צפייה זוגית 209
	תנוחת האישה מעל 239		פורנו ויצר מיני 209
	תנוחת כפיות 240	210	פטישיזם
	תנוחת 69 240		המונח והסוגים 210
	עוד תנוחות 240		פטיש לכפות הרגליים 210
	תנוחות של כבדי משקל 242	212	פיוסקס
		213	פנטזיה מינית
			פנטזיות בזוגיות 213
			ההתנסות 214

הקדמה



כשבחרתי במקצוע הסקסולוגיה לפני כשלושה עשורים, הייתי בחור בן עשרים ומשהו ונסעתי ללמוד בניו יורק. לא מעט אנשים, ובהם אימא שלי, הרימו גבה לנוכח הבחירה, אבל לי לא היו ספקות. ראיתי במקצוע הזה את הבסיס להמשך חיי. לב הבחירה היה רצוני לעזור לאנשים, להבין אותם ולהיות פתוח אליהם ולצורכיהם. אני מאמין כי נתינה היא הקבלה הגדולה ביותר והיא תמיד נר לרגליי. חשוב לי להיות רגיש ואנושי למין האנושי יותר מלהיות מומחה למין.

כמו בכל טיפול, גם הטיפול המיני, הפיזיולוגי והרגשי מותאם אישית לכל מטופל. מדי יום אני פוגש במרפאה אנשים שבאים אליי אחרי הרבה התלבטויות. מגיעים אליי גברים ונשים בכל הגילים – נשואים, רווקים ואלמנים. אני יודע שלא קל להם לעשות את הצעד הזה. הם באים אחרי הרבה כישלונות, רגעים משתקים שהובילו אולי לחשש מקפיא, לאי־כולת ליצור זוגיות או לקרעים עמוקים בזוגיות שלהם. אני פוגש אותם, מקשיב ומבין שאפשר לעזור. עזרה קטנה תוכל להרחיב את הלב, להעלות חיוך על הפנים ולשנות חיים.

חקר הזוגיות והמיניות עתיק כקיומה של הבריאה האנושית, מצוי וחודר לכל תחום: דת, רפואה, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, ליריקה, ספרות, אומנות ופוליטיקה. כך בסיפורי הבריאה – הנחש שמפתה את חווה, בתרבות יוון ורומא, בקאמה־סוּטרה ההודי, אצל הציירים והפסלים של הרנסאנס, בסיפורי דקמרון של בוקצ'יו, בציריהם האירוטיים של פיקאסו ובירדסלי ובצילומיו הפרובוקטיביים של מייפלדורף. כולם עוסקים בביטויי האירוטיקה, ביצירות ובתשוקה בזוגיות של המין האנושי.

ובכל זאת המין עדיין אפוף בושה, הסתרה והכחשה. מיניות יכולה להיות פשוטה ובריאיה והיא חלק מהמהות הקיומית שלנו. אבל כשיש שם בעיה, קשה לנו מאוד לעסוק בנושא, להיות פתוחים, ועל אחת כמה וכמה – להודות בבעיה לפני עצמנו ולפני מישהו אחר.

אני מאמין שבגרותו של אדם נבחנת במה שהוא יכול ומוכן לעשות למען עתיד נכון יותר וטוב יותר, וברמת המאמץ שהוא משקיע כדי להשביח את איכות חייו ואת זוגיותו.

בטבע אחרי כל שפל באה גאות. כך גם בחיים. היכולת ליצור עתיד טוב יותר נמצאת בידיים שלנו כל הזמן. לכן בכל בעיה זוגית ומינית אל תהססו, אל תתמהמהו. ואל תזניחו את אחד הרכיבים החשובים בחיים: יחסי המין. אבל שימו לב: בדרך כלל יחסי מין הם קודם כול יחסים ואחר כך מין.

את הספר והערכים שבתוכו כתבתי להנאתי לא ממקום מחקרי מדויק אלא ממקום אכפתי ואוהב. תוכלו לקרוא בו על ההיבטים השונים ולפעמים גם קצת משונים של מיניות. יש עוד לא מעט ערכים שאפשר להכניס לספר, אך בואו נהנה ונסתפק במה שנכתב. הנושאים אינם מסודרים לפי סדר החשיבות, אלא לפי הא"ב, וכמה יפה שהכול מתחיל באהבה. כי אהבה תביא אהבה, ונאמר כבר שאם נעשה אהבה, לא תהיה מלחמה.

ד"ר עידן מיליצ'ר

המרפאה לטיפול מיני בבית החולים איכילוב

אהבה



סִמְכוּנֵי בְּאַשִׁישׁוֹת רַפְדוּנֵי בִּתְפוּחִים כִּי חוֹלֵת אֶהְבֶּה אָנִי

שיר השירים ב 5

אהבה וזוגיות

מאז ומעולם האהבה היא מילת קסם. משוררים כותבים עליה שירים, אומנים מציירים ומפסלים בהשראתה, בני אדם נלחמים למענה ובגללה. והיא – עלומה ונסתרת, חמקמקה ושבירית. לא תמיד מחזיקה זמן רב. לעיתים מתחוללת בסערה ומסתיימת בקול ענות חלושה.

מציאת האושר והאהבה בזוגיות אינה תלויה רק במציאת בן הזוג המתאים, אלא גם במידה שכל אחד מבני הזוג מוכן להשקיע למען שותפו. במערכת יחסים טובה כל אחד מבני הזוג חש שצרכיו הרגשיים והרוחניים מסופקים, ולכל אחד מבני הזוג חשוב שצרכיו של האחר בקשר יהיו מסופקים. אהבה נותנת כוח לשני בני הזוג, ולכל אחד מהם טוב יותר להיות בקשר מלהיות לבד. צריך שיהיה קשר רגשי ועמוק, תקשורת טובה, תחושת קרבה, עניין ואכפתיות. מערכת יחסים שלא מתקדמת תהיה בירידה.

קשר זוגי טוב צומח כל הזמן. קשר שמשקיעים בו לכל אורכו, יש לו יותר סיכוי להמשיך ולהצליח. לכל אחד יש צרכים משלו. הקשבה, תשומת לב וגמישות יביאו לצמיחה, להתפתחות הדדית ולזוגיות טובה ומספקת, זוגיות שבה יבואו על סיפוקם הצרכים הקוגניטיביים, הרגשיים והפיזיים.

כיצד מאהבה שהחלה בזיקוקי דינור נותרה רק להבה זעירה? לשמר אהבה

בנישואים זו עבודה בלתי פוסקת. זוג אנשים הריהו כזוג חבלים. אם ירצו להתחבר, יהיה על כל אחד מהם לוותר על משהו מאורכו. אם ירצה כל אחד מהם לשמור על מלוא אורכו, לא ייווצר הקשר. הקשר נוצר בתחום שבו נעשה הוויתור. זו מהות הזוגיות והאהבה. קל מאוד לעזוב, לפרק, להרוס וללכת. כדי לשמור על שלהבת הזוגיות צריך להשקיע בכל רגע.



אהבה בגיל הרך

אהבה קיימת אצל כל היונקים, בכללם בני האדם. אהבה קיימת בכל גיל. החום והקרבה הם ששומרים עלינו בהתפתחות האבולוציונית. האהבה היא רגש בסיסי, מהרגשות הבסיסיים הראשונים בחיים. התינוק נקשר מראשית חייו למי שמטפל בו –



אם או דמות אחרת. ילדים קטנים מביעים אהבה ומדברים על אהבה, וזוהי אהבה כנה ופשוטה. אהבה אצל ילדים נפוצה בגיל הגן ובאה לידי ביטוי בחברויות קרובות שממלאות את עולמם. ילדים אוהבים משחקים יחד, מתרחצים, ישנים – והכול תמים וטהור.

פרויד גרס שבשלב האדיפלי הבן מאוהב באימו והבת מאוהבת באביה. בגיל הגן ואף בגיל צעיר יותר היחס הזה עובר לדמות חיצונית שאינה אחד מההורים, והילד עובר מהאהבה האדיפלית להורה ליצירת קשר ויחסי אהבה עם אדם אחר. בגיל 3–6 ילדים נפגשים עם חברים ומגלים עניין זה בזה. הם מרגישים לא רק הנאה מהמשחק ומהחברה, אלא גם אכפתיות

ורצון להסב אושר. הם כבר מבינים לאיזה מגדר הם שייכים ויוצרים קשר עם בני המין השני. אהבה כזאת מתפתחת על בסיס משיכה לשונה ורצון להבין אותו. זוהי התנסות נפלאה וטבעית. באהבה אצל ילדים אין קונפליקטים. וכשנפרדים נשאר רק זיכרון טוב ופתוח לאהבה בוגרת בבוא העת.

אהבה, התאהבות ורגש

תמיד יש קצת שיגעון באהבה. אבל תמיד יש קצת היגיון בשיגעון. פרידריך ניטשה

התאהבות מתרחשת בבת אחת כמו פיצוץ. התאהבות היא בדרך כלל פועל יוצא של קשר חדש, וכשהיא שוככת נותרת ריקנות. אהבה צומחת לאט ובהדרגה ויכולה להישאר זמן רב. בשביל לאהוב יש צורך בבגרות נפשית. היכולת להתאהב ולאהוב קשורה לאופי ולמזג של כל אחד. טיפוסים דרמטיים נוטים להתאהבות, אנשים רגועים יותר נוטים לאהבה. אהבה כוללת ידידות, הבנה וראייה של הזולת, והיא מחזקת ומרוממת את הנפש. לאנשים שמצאו את אהבת חייהם יש תחושה של שלוה ושלוות עם העולם.

אמיר בן 22. זה שלושה חודשים יש לו חברה, והיא יפה, אינטליגנטית, מושכת ומתחשבת. אבל לצערו הוא לא מתאהב בה. הוא לא מנתק את הקשר, כי הסקס איתה הוא הכי טוב שהיה לו בחיים. יש לו רגשות אשמה. הוא מרגיש שהוא מנצל אותה בשביל הסקס, ומגיע לה הרבה יותר.

לאמיר, אתה לא מאוהב, אבל אתה אוהב. יש לך מערכת ערכים, ואתה מתחשב. יש סיכוי שהרכיב הרגשי יתפתח אצלך בד בבד עם הרכיב הפיזי. אם אומנם יש לך רגש עמוק כלפיה נוסף על המשיכה המינית, מומלץ שתישאר בקשר עוד כמה חודשים, כדי שתוכל לבדוק ולחוות את רגשותיך. יתר על כן, לא תמיד חייבים להתאהב כדי לשמור על

הקשר. לפעמים אוהבים ומעריכים בלי התאהבות, והקשר לא פחות טוב וחיובי.

הילה בת 25, וזה שנה יש לה חבר בן 23 ושמו נמרוד. שניהם תלמידי רפואה, לומדים קשה ועובדים במשמרות. מערכת היחסים סוערת, והם מקיימים יחסי מין שלוש-ארבע פעמים בשבוע. עם זה הילה סבורה שנמרוד לא מעניק לה די תשומת לב. היא לא זכתה ממנו לפינוק או למחווה כמו ארוחת ערב רומנטית, גם לא להצהרת אהבה, גם לא למחמאה (הוא רק אומר "כולם רואים שאת יפה"), וגם לא להפתעה ("למי יש זמן לזה"). נמרוד יוצא מנקודת הנחה שאם הוא מתראה איתה בקביעות ושוכב רק איתה, זה מראה שהוא כולו איתה. יש לו גם הסבר שנשמע לה פסיכולוגיה בגרוש: כיוון שהיא ילדת סנדוויץ' בין שני אחים, היא לא קיבלה די תשומת לב בילדות, ועכשיו היא רוצה למלא חסכים.

להילה, חשוב שתשוחחי עם נמרוד על רגשותיך ועל צרכיך. חשוב שתעשי זאת בדרך חיובית ולא מאשימה. אל תצפי שאחרי שיחה אחת ישתנו הדברים בבת אחת. יהיה נכון שתדונו בדברים כמה פעמים לא תכופות. אם אחרי כל הפעמים לא יהיה שינוי, ואפילו שינוי קטן, אזי תביני שזה נמרוד, תביני שהדברים לא נעשים מתוך רוע לב או זלזול, ואז תחליטי אם את מקבלת אותו כמו שהוא או אולי נפרדת, משום שאת זקוקה לקשר רגשי יותר.

אהבה ויופי

את האישה היפה ביותר שפגשתי, וזה לא אומר עלייך הרבה. האחים מרקס

על פי 'המשתה' של אפלטון, אהבה ליופי לא צריכה הסבר, והיא נתון ראשוני כמו התודעה העצמית. יופי הוא תכונה של אובייקט הגורם לאדם

חוויה של נעימות ומשיכה. על פי רוב היופי מוגדר כמבנה בעל איזון, סימטרייה, פרופורציה והרמוניה בין רכיביו. מחקר שבדק 2200 גזרי דין העלה כי במשפט על עבירות קלות אנשים יפים יותר קיבלו עונשים קלים יותר מאנשים יפים פחות שעברו אותן עבירות.

היופי ניכר בטבע. אצל בעלי החיים היופי הוא של הזכר המחזר. חלק ניכר מהזכרים מתייפים, בייחוד בתקופת הרבייה, כדי שהנקבות ירצו להמשיך את הגנים שלהם. בחברה האנושית היופי הנשי הוא הדומיננטי. יופי גברי מייצג חוסן ועוצמה שיכולים להגן על הנקבה, היופי הנשי מייצג פוריות שחשובה לזכרים להמשכת הגנטיקה שלהם. המשיכה ליופי מתחילה כבר בגיל הגן. מחקרים מעלים שילדים מתחברים לילדים יפים.

בתרבויות רבות יש אידיאליזציה של היופי. מלחמת טרויה העקובה מדם פרצה בשל יופייה האגדי של הלנה. הרומאים אימצו את חזות הגוף היפה מהיוונים. היופי זכה לעדנה בתקופת הרנסנס ובמאות שאחריו ובא לידי ביטוי באומנות, במוזיקה ובספרות. גם בתקופה המודרנית שמים דגש על היופי. בטיפוח היופי מושקעים תשומת לב, משאבים וממון רב. הטכנולוגיה הרפואית מאפשרת לעצב את גוף האדם בהזרקות וניתוחים. היופי משמש גם לקידום מכירות. שחקנים יפי תואר מושכים צופים בקולנוע. מוצרי צריכה מעוררים חוויה אסתטית. דוגמניות מקדמות מכירה של מוצרים. תחרויות יופי נשי מתקיימות כמעט בכל מדינה.

החשיפה המרובה למודלים של יופי מביאה עימה חוליים כגון רגשי נחיתות, תסכול, אנורקסיה ובולימיה, דיאטות בלתי מאוזנות, הוצאה של סכומי עתק וחשיפה לסיכונים בטיפולים ובניתוחים פלסטיים.

אהבה ובריאות

קשר רגשי, אינטימי ורומנטי ומערכת זוגית עם אהבה הדדית מחזקים את המערכת החיסונית. הקשר הזוגי והאהבה גורמים להפרשת אפפטמינים ואנדורפינים המפחיתים את הכאב, ממריצים את המערכת החיסונית ומביאים לנוגדנים נגד מחלות. מחקרים מעלים שדבר זה קורה בעיקר בתחילת מערכת היחסים. מחקר על זוגות מבוגרים מצא שהקשר הזוגי

והאהבה תורמים לבריאות הפיזית והנפשית של בני הזוג. ידוע שבדידות היא גורם לדיכאון ותחלואה. אנשים החיים בזוגיות ובמשפחה מוגבלים פחות בפעילותם בעבודה ובחברה וחולים פחות. מחקר אחר מצא שאדם אוהב ודואג לזולתו מאריך ימים. עוד נמצא שלאנשים נשואים באושר יש לחץ דם נמוך יותר משל רווקים.

אהבה יש בה תכונות של ריפוי, ולעומת זאת פרידה עלולה לפגוע בבריאות ובנפש. במחקר נמצא שאלמנים בגיל מתקדם עלולים למות בשנה הראשונה לאלמנותם, אלא אם כן מצאו אהבה חדשה. אנשים דחויים עלולים לפתח מחלות.

וגם המיניות תורמת לאיכות חיינו. ביחסי מין עולות רמות האוקסיטוצין והאנדורפין, דבר המקל על כאבים, מיגרנות, אסטמה ודיכאון קל. אצל נשים רמות האסטרואגן עולות, מה שמפחית כאבים לפני מחזור ומשפיע על בריאות העור והשיער. הסקס מחסן מפני הצטננות ושפעת עקב הפרשת אימונוגלובולין וגם מביא לרגיעה ומקל חרדות. אצל גברים יחסי המין תורמים לירידה בסרטן הערמונית, באירועי לב ובשבץ מוחי.

אווננות



אל תלעג לאוננות. אווננות היא מין עם מי שאתה אוהב.

וודי אלן

פעולה טבעית

אומרים שאוננות שייכת לרפרטואר המיני בגיל הבגרות והיא הנחמה של גיל הזקנה. אווננות היא פעולה טבעית, חלק ממהות הקיום של המין האנושי. היא נקראת על שם אונן המקראי: "וְהָיָה אִם בָּא אֶל אִשְׁתּוֹ אָחִיו וְשָׁחַת אֶרְצָה לְבָלְתִּי נֶתֶן זֶרַע לְאָחִיו" (בראשית לח 9).

לאורך ההיסטוריה התמודדה החברה האנושית בדרכים שונות ומשונות עם תופעת האוננות. אנשי דת, מחנכים ופוליטיקאים ניסו לשלוט בתופעה ולרסן אותה, אך הניסיונות לא צלחו, מאחר שיחסי מין ואוננות נעשים ברשות הפרט. לפיכך הומצאו מיתוסים שנועדו להרתיע. אמרו שהמאוננים ילקו בחירשות, בעיוורון, שיצמחו להם שערות על כפות הידיים, שאוננות מרובה תחסל את מלאי הזרע שלהם ותפגע בפיריון שלהם לצמיתות. אמרו גם שמאוננים עלולים למות.

עד שנות 1950 האמינה הרפואה שהאוננות מביאה למחלות. מאז נעשו מחקרים שסתרו את כל המיתוסים וההנחות, והיום יש לאוננות לגיטימציה. פסיכולוגים ורופאים משוחחים עם מתבגרים על האוננות, כדי למנוע מהם חוויות של אשמה, מצוקה ופחד בגיל מתקדם. כיום ידוע שהאוננות לא



מזיקה לגוף כל עוד היא נשלטת ואינה פוגעת באורח החיים של האדם ושל הקרובים לו.

יתרונות האוננות – נשים וגברים המגיעים לאורגזמה הם פחות מדוכדכים ופחות לחוצים. גברים המגיעים לאורגזמה מפחיתים את הסיכוי שלהם ללקות באירוע לב, בשבץ מוחי, ויש להם פחות בעיות בערמונית. אצל נשים האסטרונגן שמשחרר בעת האורגזמה משפר את בריאות העור ומקל כאבי ראש ואלרגיות.

האוננות היא אפוא תופעה רווחת ונורמלית, שקשורה לתהליכים התפתחותיים טבעיים של סקרנות, הכרה והפקת הנאה מגופנו. ילדים מאוננים כבר בגיל צעיר. אצל מתבגרים ומבוגרים האוננות מלווה בדרך כלל בפנטזיות מיניות ומטרתה הנאה ופורקן מיני. רבים חווים מאוננות הנאה גדולה וממוקדת יותר משהם חווים באקט המיני. כל אחד מאונן בדרכו

הייחודית ובאופן דומה להתנסויות הראשונות בהנאה האוטו-אירוטית בחיים.

גילת, בת 31, סטודנטית למשפטים, נמשכת לאוננות ושואלת למה זה קורה לה ואם זה נורמלי.

לגילת, האוננות היא פעולה טבעית, לא מזיקה לגוף ולא פוגעת באורח החיים של האדם או בסביבתו. האוננות בריאה להפחתת לחצים. יש סטודנטים המרבים לאונן בתקופת בחינות. אומנם את לומדת משפטים, אך אל תשפטי את עצמך. משיכתך לאוננות מובנת ונורמלית. הרבה נשים יקנאו בך על יכולתך לאונן.

התמכרות

ידוע שאוננות, גם אוננות יום-יומית, אינה מזיקה לגוף כל עוד היא נשלטת ואינה פוגעת באורח החיים של האדם או של הקרובים לו. באוננות כמה פעמים ביום יש משום תלות והתמכרות. הדבר נובע מחרדות או מקושי באינטימיות או מסיבות אחרות. ככל שאנו מתבגרים, איבר המין זקוק לפרקי זמן ארוכים יותר בין זקפה לזקפה, לפיכך ייתכן שבמרוצת הזמן יהיו למאונן המתמכר קשיים בזקפה.

אלון גולש מדי יום ביומו באתרי סקס באינטרנט ומאונן ארבע-חמש פעמים ביום. אלון מבקש לדעת אם ייצור הזרע שלו עלול להיפגע מכך בעתיד ואם יהיה אימפוטנט בגלל ריבוי פליטות הזרע. **לאלון**, ייתכן שהאוננות שלך נובעת מסיבות נפשיות, מחרדות או מקושי באינטימיות ולאו דווקא מהנאה מהגלישה באתרי פורנו. האוננות התכופה לא פוגעת באיכות הזרע, אך אוננות בתדירות גבוהה מאוד עלולה לפגוע בספירת הזרע. לאשכים נדרש זמן לייצר זרע ולעמוד בקצב האוננות והשפיכה שלך. ספירת הזרע תהיה טובה יותר אם תאונן פחות. יתר על כן, אם אתה רגיל לאונן בעוצמה חזקה כדי לגמור, ייתכן שתתקשה לגמור ביחסי מין מלאים.

אצבעות מענגות

ריקוד האצבעות על הדגדגן ובתוך הנרתיק הוא אומנות נרכשת. יש כאלה שמענגים את בת הזוג שלהם והיא עפה מתענוג, יש אחרת שמשתעממת מאותו מגע ומתייבשת מחוסר הנאה.

דובי, בן 25, לא מצליח לספק את חברתו שירה באופן ידני. היא אוהבת מאוד שמענגים אותה באצבעות גם בדגדגן וגם בנרתיק. דובי מרגיש שהאצבעות שלו מגושמות ולא עושות את העבודה.

לדובי, אין אדם שאצבעותיו מגושמות מכדי לענג אישה. לכן אינך צריך להתייאש. עליך להיות קשוב לשפת הגוף שלה כאשר אתה מענג אותה. ואם יש לך תקשורת טובה ופתוחה עם שירה, ואם שירה יודעת מה עושה לה טוב, הדרך לעונג המיוחל סלולה לפניכם. שירה תנחה אותך באשר לצרכיה, ועם הזמן והניסיון יוכלו אצבעותיך לפזז במיומנות על דגדגנה ובתוך נרתיקה.

אוננות במשרד

אין כללים או ספר הוראות איך לאונן ואיפה. כל אחד מאונן לפי ההתנסויות הראשונות שלו בהנאה האוטו-אירוטית בחייו ונהנה לאונן במקומות שונים ובדרכים שונות. אין רע לאונן במקום העבודה כל עוד זה נעשה בפרטיות, בלי חשיפה ובלי פגיעה בסביבה.

מיכל, בת 32, אוהבת לאונן במשרד שבו היא עובדת. לא משום שיש שם אנשים שהיא נמשכת אליהם, אלא משום שיש בסיטואציה משהו שמגרה אותה. בבית היא כמעט לא מאוננת. כל הסיפור נמשך כמה דקות ולא מפריע לעבודתה, אבל המצב הזה בכל זאת מעורר אצלה דאגה.

למיכל, אין לך סיבה לחשוש כל עוד את מסוגלת לאונן גם בבית, כל עוד את יכולה לקיים יחסי מין בלי קושי כשאת נמצאת בקשר זוגי,

כל עוד האוננות במשרד אינה הכרחית ובלעדית לביטוי הפורקן. שימי לב, החוק אוסר על אוננות במקום ציבורי, לכן חשוב שהדבר ייעשה בהסתר וביחידות, וטוב שלא יתפסו אותך על חם.

אוננות בגיל מבוגר

אין מניעה לאונן בכל גיל. בגיל מבוגר צריך לתת את הדעת על אוננות מבחינה פיזית בריאותית, פסיכולוגית, נפשית וזוגית. כמו כל איבר גם איבר המין זקוק למנוחה בין אקט לאקט, וככל שהגבר מתבגר יש צורך לחכות יותר זמן. ייתכן שהקושי להגיע לסיפוק באוננות הוא תולדה של עייפות וקושי פיזי.

מיכאל בן 69 ואשתו בת 65. לפני חמש שנים הם חדלו לקיים יחסים אינטימיים בשל התנגדותה של אשתו. לטענתה היא לא נמשכת למין בשל התרופות הרבות שהיא נוטלת. מיכאל הפציר בה שוב ושוב, אך היא סירבה, והוא התחיל לאונן כדי להגיע לסיפוק המיני שכל כך חסר לו. מיכאל טוען שאין להשוות בין יחסי מין מלאים לבין האופציה האחרת, אולם זה יותר מלא כלום.

בחודשים האחרונים הוא מתקשה להגיע לסיפוק עקב חולשה באקט ודופק בבטן העליונה. תופעות אלו מרתיעות אותו וגורמות לו להפסיק את האוננות. מיכאל מבקש לדעת מה ההסבר לתחושותיו ואיך אפשר להתגבר עליהן.

למיכאל, ראשית אתה ההוכחה שמין ומיניות אינם נחלתם של צעירים בלבד. צר לי שאין לך מין עם זוגתך. אשר לתופעה שאתה מתאר: הייתי ממליץ לך לנסות לאונן לא יותר מפעם או פעמיים בשבוע בזמן הקרוב. יש מקום לבדוק את מצבך הבריאותי. אני ממליץ לך לשים את הבושה בצד ולפנות לרופא המשפחה שלך או לאורולוג המתמחה בתחום המיני. אם יתברר שאין לך בעיה פיזית כלשהי, אין מניעה שתמשיך בהרגלך, וההנחיה היחידה תהיה לרדת בתדירות.

אורגזמה



נשים אולי יכולות לזייף אורגזמה,
אבל גברים יכולים לזייף מערכת יחסים שלמה.
שרון סטון

נתונים

25%–30 מהנשים מגיעות לאורגזמה מיחסי מין מלאים.
9% לא מגיעות לאורגזמה.
עד 30% מהנשים מתקשות לחוות אורגזמה.
רוב הנשים לא מגיעות לאורגזמה בכל פעם שהן מקיימות יחסים.
2% מגיעות לאורגזמה רק מתוך ריכוז.
נתונים סטטיסטיים אלו משתנים עם השנים ועם נתוני המחקר.

התהליך

פרויד גרס שאורגזמה נשית המושגת באמצעות הדגדגן אינה בוגרת ונשית, והדבר האמיתי הוא אורגזמה נרתיקית המושגת בחדירה. בשנות 1950 טען קינסי שנשים יכולות לחוות אורגזמה באוננות יותר מבמגע מיני עם גברים. בשנות 1960 קבעו מאסטרס וג'ונסון שהאורגזמה הנשית היא תוצאה של תהליך נירולוגי, פיזיולוגי ופסיכולוגי, דומה מאוד במהלכו אצל כל הנשים

ומושיג בעיקר בגירוי הדגדגן ולא במגע מיני מלא. חוקרים באיטליה גורסים כי לנשים המסוגלות לחוות אורגזמה נרתיקית יש דופן נרתיק עבה יותר מדופן הנרתיק של אלה שאינן מסוגלות לחוות אורגזמה כזאת.

הפות והנרתיק אצל האישה בנויים כך שמרכזי הרגישות העיקריים הם בדגדגן ובשליש החיצוני של הנרתיק, ואילו האזור הפנימי של הנרתיק לא רגיש מאוד לגירוי (כמובן, יש הבדלים בין אישה לאישה). לפיכך בזמן המגע המיני הגבר מקבל גירוי ישיר לאורך הפין, והאישה מקבלת גירוי לשליש החיצוני של הנרתיק ורק גירוי עקיף בדגדגן. רוב הנשים מגיעות לאורגזמה מגירוי ממושך של הדגדגן ושל החלק החיצוני של הנרתיק עם מגע מהנה בכל חלקי הגוף. זוגות רבים משלבים גירוי ישיר בדגדגן ביחסי המין. רוב הנשים אינן מגיעות לאורגזמה בחדירה, והן מסוגלות להגיע לאורגזמה רק בגירוי חיצוני ישיר בדגדגן. יש נשים המדווחות על הנאה ואורגזמה ממגע וגינלי, כנראה בנקודת הג'.

התחושה והעוצמה

מבחינה פיזיולוגית תגובות האורגזמה של האישה והגבר דומות, אלא שאצל הגבר האורגזמה מלווה בשפיכה. הדעות חלוקות בשאלה אם יש גם שפיכה נשית, ואם כן מה אופייה ומה עוצמתה.

עוצמת האורגזמה משתנה לא רק מאדם לאדם. גם אצל אותו אדם היא משתנה מפעם לפעם. לעיתים האורגזמה יכולה להיות פיצוץ אדיר מתוך מפולת של תחושות מלהיבות ולפעמים האורגזמה חלשה ומאכזבת.

בשלב ההתעוררות המינית של האישה חלים התרחבות הנרתיק וסיכוך, והם מובילים למתח שרירים בגוף ולגודש מקסימלי בכלי הדם. באורגזמה חל שחרור במתח השרירים ובגודש כלי הדם. האורגזמה נמשכת כמה שניות. עוצמת האורגזמה והיכולת להגיע לכמה אורגזמות משתנות מאישה לאישה. אצל רוב הנשים תחושת האורגזמה מרוכזת באזור הממוקם בשליש התחתון של הנרתיק. אזור זה תפוח וגדוש כלי דם מורחבים. ההתכווצויות סדירות ומופיעות כל 0.8 שניות בעוצמה הולכת ויורדת. יש נשים החוות גם התכווצויות בפי הטבעת וברחם. לא משנה באיזו דרך האישה חווה



אורגזמה – בגירוי חיצוני של הדגדגן או בגירוי נרתיקי או בכל דרך אחרת, אפילו בחלום – תחושת האורגזמה תהיה זהה ותקרה במשטח האורגזמי.

בדרך כלל אורגזמה הנחוות מגירוי של הדגדגן חזקה יותר בעוצמתה מאורגזמה נרתיקית, שכן ריכוז העצבים בראש הדגדגן הוא עצום – 8,000 קצות עצבים. נשים החוות אורגזמה בחדירה מוסיפות גירוי לא ישיר של הדגדגן בתנועות המשגל.

על עוצמת האורגזמה משפיעים כל אלה: גורמים גופניים כמו בריאות וחולי, טיפול תרופתי, עייפות, רגישות הדגדגן, וגורמים פסיכולוגיים כמו חרדה ודיכאון. משפיעים גם גורמים פסיכוסוציאליים: האווירה האינטימית, היחס לבן הזוג, הפתיחות המינית, הציפיות מהאהבה בכלל ומהאורגזמה בפרט.

גם באורגזמה כמו בכל דבר אחר הכול מתחיל בראש, ואם הראש לא ירצה, הגוף לא ייענה. עם זאת גירוי נכון יכול להביא כל אחד לעוצמות חזקות עם ובלי קשר לבן הזוג.

סיגלית יוצאת עם גבר כבר חודש, כיף לה איתו, אבל יש לה בעיה: היא מאוננת הרבה במקלחת עם הטוש וחווה אורגזמה הרבה יותר חזקה מהאורגזמה שהיא חווה איתו. היא סיפרה לו על כך, והוא נכנס לאמביציה ומשתדל. סיגלית שואלת אם יש להם סיכוי להגיע לאנרגייה של המים.

לסיגלית, נחמד לשמוע שכיף לך עם הבחור. אבל קשה מאוד לנצח את הטוש. זרם המים על הדגדגן מעניק גירוי יציב, ממוקד ועוצמתי, המביא נשים רבות לחוות אורגזמה מרטיטה. ייתכן שאת נהנית מזרם המים כבר מילדותך, וגופך רגיל למגע עם עוצמת הזרם כדי לחוות הנאה עילאית. אפשר שתפסיקי לזמן מה את ההרגל של הטוש. הפסקה כזאת אולי תאפשר לך חוויה מרטיטה יותר עם בן זוגך. אפשר גם שתהיי פתוחה וחופשייה עם בן זוגך ותחקרי איתו דרכים חדשות להגיע לאורגזמות מפוצצות. הכי כיף – שתפי את בן הזוג בשעשועי המקלחת. נכון גם לנסות לעשות שינוי בהרגל של האורגזמה עם הטוש כדי לשנות את העוצמה על הדגדגן.

התנוחות, חדירה ואוננות

יותר מ-75% מהנשים אינן מגיעות לאורגזמה בחדירה. הן מסוגלות להגיע לאורגזמה רק בגירוי חיצוני ישיר בדגדגן. יש נשים המגיעות לאורגזמה ביחסי מין מלאים כתוצאה ממגע בנקודת הג'י, אך אי אפשר להגיד מי יכולה לחוות אורגזמה כזאת ומי לא. לגברים – לא לכולם – קל יותר להגיע לאורגזמה במשגל. לפי התיאוריה של "הגן האנוכי", תפקיד האורגזמה והשפיכה של הגבר ביחסי מין מלאים הוא הבטחת העיבור, פיזור הגנטיקה והמשך קיום המין האנושי.

אצל האישה מרכזי הרגישות העיקריים הם בדגדגן ובשליש החיצוני

של הנרתיק. האזור הפנימי של הנרתיק לא רגיש מאוד לגירוי. בזמן המגע המיני הגבר מקבל גירוי ישיר לאורך הפין, והאישה מקבלת גירוי לשליש החיצוני של הנרתיק וגירוי עקיף בדגדגן. אצל האישה אין קשר לאורגזמה ולהמשך הקיום של המין האנושי. האישה אחראית להשבחת הגנטיקה בלי קשר להגעה או אי־הגעה לאורגזמה.

רוב הנשים מגיעות לאורגזמה מגירוי ממושך של הדגדגן ושל החלק החיצוני של הנרתיק עם מגע מהנה בכל חלקי הגוף. זוגות רבים משלבים גירוי ישיר בדגדגן ביחסי המין. כל אישה יודעת להתרכז בגירוי ובהנאה שלה ולחוות אורגזמה ממגע בדגדגן. עם זה חשוב שלא להפוך את מעשה האהבה למסע מפרך להשגת האורגזמה הנרתיקית, מה שעלול לפגוע בהנאה המינית של שני בני הזוג.

מוטי בן 26, ויש לו חברה, ציפי, בת גילו. הסקס שלהם טוב מאוד, אבל יש דבר אחד שמפריע לו: ציפי מסוגלת לגמור רק כשהיא שוכבת על הבטן ומגרה לעצמה את הדגדגן בזמן שהוא חודר לנרתיק שלה מאחור. היא גם מאוד אוהבת לשלוט בקצב ומבקשת ממנו שלא יזוז במשך כמה דקות בזמן שהיא עושה את מה שהיא צריכה כדי לגמור. רק ככה היא מגיעה לאורגזמה שמאוד מענגת אותה, אבל התנוחה הזאת מאוד משעממת אותה. הוא רוצה לראות את הפנים שלה, הוא רוצה שהיא תשכב מעליו או על הגב, או סתם לנסות תנוחות חדשות. כשרמז לה על כך היא די נעלבה, ומאז חדל. בעקבות המצב הזה ירד לאחרונה החשק המיני שלו. מוטי שואל מה עליו לעשות ואם יש תנוחות חדשות שיגרמו לה אותה הנאה. הוא מבקש לדעת אם העובדה שציפי יכולה לגמור רק בתנוחה אחת אומרת שמהו אצלה לא בסדר.

למוטי, יש רק דבר אחד שלא בסדר בציפי או באיבר המין שלה, והוא ההתייחסות שלך – "התנוחה הזאת מאוד משעממת". ציפי יודעת מהי אורגזמה ויכולה לחוות אותה באוננות בחיכוך. כל חוויית אורגזמה בדרך אחרת מצריכה מצידה השקעה, סבלנות וסובלנות. אישה שמגיעה לאורגזמה לבדה כבר עשתה את חצי הדרך ויותר. לכן מבחינה טיפולית רצוי שציפי תתחיל לאונן לבדה כשהיא שוכבת על הגב. לאחר שתצליח להגיע לאורגזמה לבדה בצורה כזאת, רצוי שתאונן

לידך, כדי שתוכל לראות מה ואיך היא עושה. אז תוכל לגרות אותה באופן דומה. כמובן, רצוי שבשלב זה תהיה היא המנחה ואתה המשקייע. ציפי תשנה בהדרגה את התנוחה שהתרגלה אליה במשך שנים להגיע לאורגזמה ותחושה אורגזמה באופן אחר ובתנוחה שונה.

אורגזמה וגיל האישה

בגיל העשרה נערות מתעוררות מבחינה מינית. רבות מהן עדיין לא ממצות את היכולת המינית שלהן ומתקשות לחוות אורגזמה. המתירנות והקדמה הטכנולוגית מעודדות קיום יחסי מין בגיל צעיר, ונערות רבות מקיימות יחסי מין בלי הבשלות הרגשית והפיזית הדרושה לכך. מצב זה עלול להשפיע על חוויית האורגזמה שלהן ועלול להשפיע לרעה על המשך חייהן המיניים. בשנות השלושים והארבעים שלה האישה בשלה מאוד מבחינה מינית. תגובתה המינית מהירה. היא יכולה ליהנות ממין ולחוות אורגזמות בלי קושי ניכר. בשנים אלו יש לה פחות מעצורים, והיא בטוחה יותר בעצמה ובמיניותה. היא נמצאת בתקשורת טובה יותר עם בן זוגה ויודעת לבטא את צרכיה. שנים של ניסיון מאפשרות לה למצות את ההנאה ממיניותה ומנשיותה.

אישה יכולה לחוות אורגזמה בכל גיל. גם בגיל מתקדם, כאשר חלה ירידה בתגובות הגופניות, נשים יכולות ליהנות ממין ולחוות אורגזמות. אבל יש נשים המפסיקות את פעילותן המינית בגלל מצב נפשי או אישי. יש שלא מקיימות יחסים כלל, ויש שמוותרות אפילו על ההנאה שבאוננות. נשים שמקיימות יחסי מין באופן סדיר ותדיר סובלות פחות משינויים גופניים בגיל מתקדם ויכולות להגיע להנאה ולאורגזמה בקלות יותר מאחרות. כמובן, הזוגיות משפיעה על החשק, על ההנאה ועל חוויית האורגזמה.

אנאורגזמה נשית

יש נשים שמעולם לא חוו אורגזמה. הדבר יוצר תחושת תסכול רבה הן אצל

אותן נשים הן אצל בני זוגן. הסיבה לכך יכולה להיות נפשית. פעמים רבות הקושי לחוות אורגזמה נובע מחוסר ידע בסיסי לגבי האנטומיה של איברי המין והשינויים הפיזיולוגיים של התגובה המינית. גם חוסר ידע לגבי מקומו של הדגדגן וחשיבותו לאורגזמה הנשית יקשה על ההגעה לפורקן.

ציפיות של שני בני הזוג שאינן עומדות במבחן המציאות יכולות לפגוע בתחושות המיניות וביכולת הריכוז המיני. כששני בני הזוג עסוקים בזמן האקט המיני בניסיונות לגרום לאישה להגיע לאורגזמה, הם מחמיצים את תחושת ההנאה והגירוי המיני באותו הרגע. במקום להתרכז בתחושות מיניות מהנות ומגרות הם עסוקים בתוצאה, וכך מחמיצים גירוי והנאה ומונעים מהאורגזמה להגיע. תקשורת מינית לקויה נוסף על חוסר ידע מיני יקשו גם הם על יחסי מין פתוחים ומשחררים מעכבות, והתוצאה הסופית תהיה אי־הגעה לחוויית האורגזמה.

לעיתים האישה חשה קונפליקט בכל פעם שהיא חווה עוררות מינית גבוהה. החרדה מאובדן שליטה ומההנאה לעומת הרצון לפרוק את המתח המיני הגובר גורמת לעיכוב האורגזמה. הפחד מאובדן שליטה נפוץ ביותר, והוא אחת הסיבות העיקריות לחוסר יכולת להשתחרר בזמן האורגזמה. לעיתים היא חוששת מהיחשפות לפני בן הזוג ונמנעת מעיסוק בפעילות מינית חושנית ומלהיבה מחשש שתיראה מופקרת, מגוחכת או מכוערת בעיני בן הזוג. עצם הביקורת העצמית גורמת לה להיות בעמדת צופה בתהליך המיני ולמתוח ביקורת על התנהגותה המינית. פחדים מיניים עמוקים מונעים ממנה לבטא את החלקים האירוטיים שבה, לאבד שליטה ולחוות אורגזמה. גם השינויים הנורמליים החלים בגוף בזמן התעוררות מינית יכולים לאיים על הרגשת שלמות הגוף ולגרום לעיכוב ההתעוררות המינית של האישה.

בטיפול מנסים להגיע לתובנות נפשיות ולמודעות לגבי הגורם לקושי בחוויית האורגזמה. תחילה מתמקדים במתן מידע בסיסי לגבי האנטומיה והפיזיולוגיה של איבר המין והתיידדות איתו, כדי שהאישה תקבל את גופה ברוח חיובית ואוהדת. המטפל עובד עם האישה על שינוי עמדותיה ותפישותיה, כדי לתת לה לגיטימציה להתגבר על המיתוסים והעכבות הפוגמים ביכולתה לחוות ריגוש מיני ולהגיע לאורגזמה. המסר הוא שאישה איננה פסיבית בתהליך ההגעה לאורגזמה. היא לא מקבלת אורגזמה, אלא

מביאה את עצמה לאורגזמה, כלומר מקבלת אחריות למיניותה. באופן הדרגתי האישה נחשפת לתחושת ההנאה שבמגע המיני. בתחילה לומדת האישה לאונן מתוך הורדת שליטת היתר שלה, מתמקדת בתחושותיה המיניות מתוך שימוש בטכניקות של הרפיה, דמיון מודרך והעלאת פנטזיות מיניות, הגברה והעצמה של התחושות, עד שהן יציפו אותה והיא תחוה אורגזמה.

לעיתים משתמשים בוויברטור כדי להשיג גירוי חזק ותדיר יותר. עוצמות הגירוי המושג בעזרת ויברטור חזקות יותר מאלה שמושגות בגירוי ידני או ביחסי מין. אישה שמעולם לא חוותה אורגזמה זקוקה לגירוי ממושך מאוד בריכוז מיני עצום עד שתחוה את האורגזמה הראשונה. משך הזמן הדרוש להגעה לאורגזמה הולך ויורד ככל שהאישה לומדת לתרגל את הטכניקה הטובה לה ולומדת טכניקות ריכוז מיני ושימוש בפנטזיות.

לאחר שהאישה למדה לחוות אורגזמה באוננות עצמית, מצרפים את בן הזוג, והאישה מתמודדת עם הפחדים ועם החשש מאובדן שליטה לידו. משתמשים בטכניקות של ריכוז, העלאת פנטזיות, הגברת התקשורת המינית והפתיחות בין השניים.

אנאורגזמה משנית

אנאורגזמה משנית היא מצב שבו אישה שחוותה אורגזמה בעבר מתקשה להגיע שוב לאורגזמה. זה יכול להיות קשור בבעיות רפואיות ונטילת תרופות, וזה קורה אצל לא מעט נשים לאחר גיל המעבר. במצב הזה דרוש בירור רפואי נוסף על הערכה פסיכו-סקסולוגית וזוגית. עוד גורמים אפשריים למצב הזה הם קשיים בזוגיות, משברים בחיי האישה, טראומות מיניות, עייפות כרונית, חוסר פרטיות.

הסיבות הרפואיות שיכולות לגרום לקשיי אורגזמה: הפרעות הורמונליות – ירידה בהורמוני המין אסטרוגן וטסטוסטרון; הפרעות בזרימת הדם – במחלות כמו יתר לחץ דם, טרשת עורקים או מחלת לב כלילית, סוכרת, ומצבים כמו עודף שומנים בדם או עישון; הפרעות עצביות – במחלות כמו טרשת נפוצה וסוכרת או בפגיעות בעמוד השדרה

וטרואומות מקומיות; ניתוחים כמו כריתת רחם ושחלות, ניתוחים בעריה או בנרתיק, טראומת לידה עקב לידות מכשירניות קשות וקרעים קשים בנרתיק; פציעות באגן; רכיבה ממושכת על אופניים. יש גם מצבים פסיכיאטריים כמו דיכאון וחרדה, ויש תופעת לוואי של תרופות נוגדות דיכאון ממשפחת הטרזיקליים או של מעכבי סרוטונין סלקטיביים SSRI שנפוצים כיום בשימוש.

אנאורגזמה מצבית

אנאורגזמה מצבית היא בעיה התנהגותית ולא גופנית. זהו מצב שבו האישה יכולה לחוות אורגזמה במצבים מסוימים ולא באחרים. למשל היא מגיעה לאורגזמה באוננות אך לא עם בן הזוג, עם בן זוג אחד ולא עם אחר, היא מגיעה לאורגזמה רק בגירוי חזק בוויברטור או בזרם חזק של מים. אישה שהתרגלה להגיע לאורגזמה בטכניקת אוננות מסוימת תתקשה להגיע לאורגזמה במצבים אחרים או בצורות גירוי אחרות.

אורגזמה מבויתת

נשים רבות מזייפות אורגזמה.

במחקר שנערך באנגליה מצאו כי לפחות אחת משלוש נשים מזייפת אורגזמה בשלב כלשהו בחייה. עוד מצאו כי אין הבדלים ניכרים בגיל, ובנות שישים מזייפות לא פחות מבנות עשרים.

מחקרים אחרים מצאו ששיעור הנשים המזייפות אורגזמה הוא 60%–70. מאחר שמדובר במחקרי עדות, קשה לדעת מה דיוקם.

בין הגורמים לזיוף אורגזמה: פחד שבן הזוג יעזוב אם ידע; רצון וצורך לרצות את בן הזוג; רצון לסיים את המשגל; רצון לחסוך מבן הזוג את השאלה אם גמרת.

רצוי שהאישה תהיה אמיתית, אחרת בן הזוג לעולם לא ידע שיש לה בעיה. אם האישה זייפה אורגזמה, עליה לספר לו על כך, לא להרגיש אשמה,

פשוט להסביר לו את הסיבה. חשוב לומר לגברים שלפעמים נשים לא מגיעות לשיא, אבל זה לא אומר שהן לא נהנות.

מלכה, בת 32, מזייפת אורגזמות בכל משגל עם בעלה. מלכה שואלת אם המצב הזה עלול לפגוע במערכת היחסים שלהם ואם לספר לבעלה. **למלכה**, לחיות בשקר כזה בזוגיות מזיק בפתיחות ובתקשורת המינית. זה מונע ממך להיות פתוחה וחופשית בהתנהגות המינית שלך במיטה ולהגיע בסופו של דבר לאורגזמה עם בעלך. נכון לפתוח את העניין עם הבעל. ההנחה היא שיש לכם קשר טוב וחברי שיש בו אמון. אם תפתחי את זה איתו ממקום המכה על חטא, מודה בטעות ומוכן לתקן, סביר להניח שבן זוגך יקבל את זה באופן בוגר. אם תחזקי אותו על כך שנעים לך איתו במיטה ושאת נמשכת אליו, זה ייתן לו מוטיבציה להירתם לשינוי. אנו יודעים כבר שגירוי נכון יכול להביא כל אחד לחווית אורגזמה. הסירי את הסוד מליבך, והדרך פנויה להתרכז בעינוגך ובהנאתך.

איבר המין הגברי



מבנה הפין

הפין מורכב משלוש עמודות של רקמות. שתי רקמות זקיפתיות (Corpora Cavernosa) בדופן העליונה זו ליד זו, וביניהן גוף ספוגי (Corpus Spongiosum) בדופן התחתונה. הגוף הספוגי משתרע החל מהבסיס ועד לקצה הפין, ושם הוא יוצר את העטרה שהיא הבסיס לעורלה. העטרה היא



קפל עור שמבוגרים יכולים למשוך לאחור ולחשוף אותה. הדופן התחתונה במקום שבו מתחברת העורלה לפין מכונה רסן או רסנית (Frenum). הבסיס המעוגל של העטרה מכונה קורונה (Corona). קו תפר חיץ הנקבים הוא רכס בולט לאורך הדופן התחתון של הפין לעבר פי הטבעת. השופכה, החלק האחרון של מערכת השתן, חוצה את הגוף הספוגי לכל אורכו. פתח השופכה נמצא בקצה העטרה. דרך השופכה עוברים השתן ונוזל הזרע. תאי הזרע מיוצרים באשכים ומאוחסנים ביותרת האשך. במהלך השפיכה תאי זרע נדחפים החוצה לאורך זוג צינורות זרע העוברים מעל ומאחורי שלפוחית השתן. עוד נוזלים שיוצרו בשלפוחית הזרע מצטרפים לתאי הזרע בצינורות הזרע המתחברים בהמשך לבלוטת הערמונית. הערמונית וגם בלוטת קאופר מוסיפות הפרשות ויוצרות את נוזל הזרע הנפלט מפתח השופכה.

הגודל

אין קשר בין גובה הגבר לאורך איברו. כף רגל גדולה או כף יד גדולה אינם מעידים על איבר גדול. רוב הנשים יכולות להגיע לסיפוק גם עם איבר מין לא גדול. עם זאת חלומו של כל גבר הוא איבר גדול וביצועים מעולים.

במחקר של חברת דורקס בשנת 2004 נשאלו 2,936 גברים מ-27 ארצות על גודל איבר מינם בזמן זקפה. נמצא שאורכו הממוצע של האיבר בזקפה הוא 16.3 ס"מ והיקפו הממוצע הוא 13.3 ס"מ. כ-70% מהנשאלים היו לבנים, השאר אפריקנים, אסיאתים והיספאנים. רבים מהנשאלים האסיאתים דיווחו על איבר בגודל 14 ס"מ ומטה בזמן זקפה. כ-12% מהנשאלים דיווחו על איבר בגודל 20 ס"מ ומעלה.

במחקר אחר דווח על גודל של 15.4 ס"מ בזקפה והיקף של 12.3 ס"מ. ידוע שאצל 90% מהאוכלוסייה הגודל 14.7–17 ס"מ. האיבר הקטן ביותר שנמצא נכון להיום אורכו 2 ס"מ, האיבר הגדול ביותר אורכו 27.9 ס"מ. המחקרים על גודל האיבר מעלים תוצאות משתנות.

המיתוס אומר שהגודל קובע – בעל איבר גדול יותר הוא מאהב טוב יותר. נשים אוהבות איבר גדול. לשחורי עור יש איבר גדול. אכן, הגודל

חשוב וקובע, בעיקר ההיקף. אבל הוא אינו קובע אם בת הזוג תגיע להנאה ולאורגזמה או לא. יש לא מעט נשים שהגודל עלול להכאיב להן ואף לאיים עליהן. הגודל לא קובע את מידת הגבריות ולא משפיע על היכולת להיות מאהב טוב. הוא קובע מה תרגיש האישה בעת החדירה. אצל גברים לפעמים הפין של השכן נראה גדול יותר. זה רק עניין של פרספקטיבה. כשגבר נמצא במלתחה הוא רואה את איברו מגובה ומזווית שונה מזו שהוא רואה את איברי הגברים האחרים, ואז האיבר הפרטי שלו נראה לו קצר יותר.

מרים מספרת שגודל איבר המין של בן זוגה במצב מנוחה הוא כ־6 ס"מ ובזקפה 13–14 ס"מ. בן זוגה חש שאיברו קטן, ועל כן קנה מכשיר פינס שאמור למתוח אותו. מרים שואלת אם תהיה לכך השפעה, ואם תהיה זו השפעה קבועה, ואם המכשיר יכול לגרום שבמהלך סקס יאבד איבר המין את הזקפה.

למרים, בחוויה של בן זוגך יש פגיעה בדימוי הגופני, המיני, הגברי ובביטחון העצמי שלו. נראה שהתסכול הוא של שניכם. אבל לא מעט נשים לא היו מלינות גם עם הנתונים האלה. הנתונים שאת מתארת הם נורמליים ונורמטיביים.

מיקרופניס

מיקרופניס או מיקרופאלוס הוא איבר שאינו עולה באורכו על 2 סנטימטרים שלא בזקפה ופחות מ־6 סנטימטרים בזקפה. היקפו בזקפה לא עולה על 7 סנטימטרים. התופעה מוכרת ב־0.6% מהאוכלוסייה וניתנת לאבחון כבר בלידה.

יש כמה סיבות לחוסר התפתחות של איבר המין. בשבוע השמיני להיריון חלה הפרשה הורמונלית הקובעת את מין היילוד. כאשר המערכת ההורמונלית והכרומוזומלית כושלת בזמן ההיריון, ייתכן שייווצר איבר מין קטן, מיקרופניס. כמו כן אם בשליש השני והשלישי להיריון הפרשת הטסטוסטרון או קליטתו בתאים לוקה בתפקודה, עלול להיווצר מיקרופניס.

ויש גם רכיב גנטי. יש תופעות של פגיעה בהתפתחות הגנטית, כמו סינדרום קליינפלטער או סינדרום טרנר, שעלולים לגרום לבעיה בהתפתחות האיבר.

כשניגשים לטיפול צריך לערוך בירור ראשוני השולל רכיב גנטי הגורם לתופעה. יש אפשרות לטיפול הורמונלי בטסטוסטרון או בהורמון אחר. יש גם טכניקות מתקדמות של התערבות כירורגית להגדלת האיבר. בכל התערבות חשוב לתת לילד ולמשפחתו ייעוץ פסיכולוגי.

מלכה מודאגת. לבנה בן ה־9 יש איבר מין שנראה לה קטן. אורכו 1–2 סנטימטר. לבנה בן ה־4 יש איבר ארוך יותר. מלכה מבקשת לדעת אם בגיל ההתבגרות יהיה אפשר להגדיל את האיבר בטיפול הורמונלי או אחר.

למלכה, גודל איבר המין בגיל 9 אינו סופי, ועם כל הדאגה שלך בעניין בנך, יהיה נכון להמתין לגיל ההתבגרות של הילד ולראות איך הוא מתפתח באופן כללי מבחינת השיער, הגובה, הקול, וגם הגודל והצמיחה של איבר המין. זה שלאחיו הצעיר יש איבר מין גדול יותר, אין בזה דבר וחצי דבר כדי להעיד שכן יהיו גם הדברים בעתיד. הכול יכול להשתנות בשנים הבאות. עם זאת, בהיותך אם הדואגת לבנה, מומלץ שתפני לייעוץ מקצועי של צוות רב־תחומי: רופא ילדים, אורולוג, אנדוקרינולוג וגנטיקאי. אם יש כאן בעיה, יימצא לה פתרון.

הגדלת איבר המין

תעשיית המין מלאה פרסומות למוצרים ומדריכים להגדלת איבר המין: גלולות, קרמים, חומרים טבעיים, משאבות ואקום, משקולות, ניתוחים כירורגיים. כולם מבטיחים תוצאות מופלאות בתוך כמה שבועות.

המחקר הרפואי עדיין לא פיתח כדורים שיכולים להגדיל את איבר המין. זה פשוט לא עובד. גם משאבת ואקום לא תגדיל את איבר המין. המשאבה יוצרת ואקום מסביב לאיבר המין וכך מביאה דם לאיבר, וכתוצאה מכך נוצרת זקפה. אבל אין שום הוכחה רפואית שמשאבת ואקום גורמת לגדילת

האיבר. יש אתרים המציעים הגדלה של איבר המין בשיטה טבעית. הבעיה היא שהכותבים אינם מומחים בתחום ואינם מוסמכים לעסוק בו. הניתוח להארכת הפין מיועד בעיקר לעבות אותו ולא להאריכו: היום השיטה המקובלת בעולם לעיבוי פין היא שימוש בשומן עצמי. לוקחים ממקום אחר בגוף ומזריקים מתחת לעור הפין. הבעיה היא שהשומן העצמי נספג כאשר הפין פעיל, וכעבור כמה חודשים הפין מאבד מעוביו והרקמה מצולקת.

מכשיר אנדרו-פניס המתלבש על איבר המין הגברי מפעיל לחץ קבוע ואמור לגרום לאיבר המין להתארך ולהתרחב. התאים מתפצלים ומתרבים, יוצרים מקום לעוד דם, מה שבסופו של דבר אמור ליצור איבר מין גדול יותר.

יש מכשיר להגדלת איבר המין המבוסס על שיטה בת אלפי שנים שמשמשים בה בשבט ארוכות הצוואר בבורמה. המכשיר מולבש על האיבר ואמור לגרום למתיחתו. יעילותו של מכשיר זה לא מוכחת, ומשרד הבריאות לא אישר את השימוש בו בארץ.

נכון להיום – מי שרוצה לשמור על איבר מינו ירחק מניסיונות להגדלתו.

עקמת הפין

אצל כל הגברים יש נטייה של הפין, וזו לא עקמת. זה טבעי. בגוף אין סימטרייה, גם לא באיבר המין. עם זאת יש תופעה של עקמת המקשה על התפקוד.

עקמת הפין תוארה כבר בשנת 1561. היא יכולה להיווצר באופן טבעי עקב אי-סימטרייה בגופים המחילתיים של איבר המין או כתוצאה מפגיעה ומחלה. בעבר כינו את העקמת 'מחלת המלכים', כי לואי ה-14 סבל מעקמת. שמו של הרופא שטיפל בו היה פיירוני, ועד היום מכנים עקמת גם בשם מחלת פיירוניה. שכיחות העקמת בגיל 50–70 היא כ-66 מקרים לכל 100,000 גברים, אך יש תיעוד לקיומה גם בגילים צעירים.

הטיפול בעקמת הוא תרופתי או בהתערבות כירורגית. יש גם מצבים

של אי-התערבות. ויטמין E משפר את מבנה הגופים המחילתיים ומרכך הסתיידויות שנוצרות סביב העקמת. התרופות Potaba, Interferon, Colchicine תורמות לפירוק רקמות קשות. מתן אחת מאלו במשך שלושה חודשים לפחות נמצא יעיל במקצת המקרים.

בניתוח על שם נסביט מיישרים את עקמת הפין ומתקנים את העיוות. תוצאות ניתוח זה טובות, ושיעורי ההצלחה כ-80% עם שיעור נמוך של חזרת העקמת. החיסרון הוא בקיצורו של איבר המין. ניתוח אחר, Penile Placation, נעשה בטכניקה שאינה מקצרת את איבר המין, אך חסרונה בתפרים שעלולים לגרום אי-נוחות וכאב. ניתוח על שם לו נעשה בטכניקה שהחלה לפני כמה שנים ואינה אמורה לפגוע בפין.

שבר בפין

מצב של שבר בפין עלול להשפיע על תפקודו המיני של הגבר. התופעה נדירה – פחות מחצי אחוז בקרב גברים הפעילים מינית – אך אין מספרים אמיתיים. במקרים רבים הגבר לא נותן את הדעת למצב ולא פונה לטיפול בגלל בושה. לפעמים הצוות הרפואי שאליו הגבר פונה פוטר את הגבר ב"הכול יסתדר", וכך נגרם לו נזק שעלול להיות בלתי הפיך. אם הטיפול נעשה בתוך 24 שעות מאירוע השבר, 70% מהגברים יחזרו ליכולת הגעה לזקפה תקינה. אם לא מוגש טיפול נכון בזמן, 70% יזדקקו לטיפול בהפרעה בזקפה.

הסיבות לשבר בפין: עיוות אנטומי כמו עקמת או מחלת פיירוניה, קיום יחסי מין עם איבר שלא בזקפה מלאה; יחסי מין אגרסיביים; בריחה של הפין מהנרתיק וניסיון להחזירו פנימה; מחלות היכולות לפגוע ביציבות הפין. הסימנים לשבר בפין הם מיידים או מאוחרים. סימן מידי – הגבר יחוש כאב פתאומי וחד בפין בזמן פעילות מינית. יהיה שטף דם באיזור השבר וסביבו. אם נגרם נזק לשופכה, יופיע דם בשתן ולא תהיה זקפה. הסימנים המאוחרים: שקע במעטפת הפין באיזור השבר, דלדול שרירי הפין בחלק מרוחק מהשבר, שינוי בצורת הפין הבא לידי ביטוי בהופעת עקמת עם או בלי זקפה וזקפה חלקית באזור המרוחק מהשבר.

בשלב הראשוני החרף אפשר להרגיש בבדיקה הגופנית את השקע שנוצר בעקבות הפגיעה. ברוב המקרים אפשר להסתפק בבדיקה גופנית, אך אם מופיע דם בשתן, צריך לעשות אורתוגרפיה, צילום של השופכה עם חומר ניגוד, כדי לבדוק אם ועד כמה נגרם לה נזק. במקרים מעטים עושים שתי בדיקות לאמת את האבחנה של השבר. הטיפול בשבר בפין הוא כירורגי. אם השבר קטן מאוד, יש טיפול שמרני. בניתוח קצר ופשוט בהרדמה שוטפים את קרישי הדם ותופרים את מקור הקרע. אם נגרם נזק לשופכה, מתקנים אותה. אחרי הניתוח ניתן טיפול אנטיביוטי. התוצאות מצוינות.

מילת העורלה

מילת העורלה היא אחת הפרוצדורות הניתוחיות הנפוצות בעולם, והיא נעשית בכ-30% מהזכרים. בארצות הברית ובעוד ארצות שיעורה גבוה. בישראל שיעורה 90%. הסיבות למילה הן דתיות, תרבותיות, אסתטיות, כלכליות ורפואיות. הוכח כי המילה מפחיתה את הסיכון להידבקות באידס.

נכון להיום אין מחקר המוכיח פגיעה בתפקוד המיני של גברים שעברו מילה בגיל מאוחר. הפגיעה יכולה להיות על רקע פסיכולוגי ולא על רקע אורגני-גופני.

המתנגדים למילה טוענים שהיא עלולה לפגוע בתפקוד המיני – לגרום ירידה בתחושה הארוגנית של הפין עקב אובדן החלק הרגיש ברירת העורלה או לגרום נטייה לשפיכה מוקדמת עקב חשיפת יתר של העטרה הרגישה לגירוי מיני.

אין מחקר המצביע על פערים בתחושה או במהירות השפיכה או בהנאה בין בוגרים נימולים ללא נימולים. קיים הרכיב הפסיכולוגי, הצורך להתרגל לאיבר המין השונה אחרי המילה. אם יש קושי מתמשך, נכון לפנות לייעוץ סקסולוגי.

איבר המין הנשי



הנרתיק (וגינה)

הנרתיק הוא איבר בצורת צינור שרירי גמיש שיכול להתכווץ, להתארך ולהתרחב לפי הצורך. פתח הנרתיק בין שפתי הערווה, בין פתח השופכה לפי הטבעת. הנרתיק משמש צינור מעבר מן הרחם אל מחוץ לגוף, וזוהי התעלה שבה עובר דם הווסת מהרחם החוצה. בנרתיק מקיימים יחסי מין, ודרכו יוצא התינוק לאוויר העולם.

אורך הנרתיק 10–12 ס"מ, אך הוא גדל כאשר רמות הריגוש של האישה מתעצמות. דופנות הנרתיק עשויות קפלים. בזמן הגירוי הן מתרחבות לקוטר של 5–7 ס"מ, והנרתיק נמתח לאורך של 15 ס"מ ומסוגל להכיל בנחות פין בכל גודל.

גודל הנרתיק תלוי בראש ובראשונה בגנטיקה. יש מקרים של שינוי קל בגודלו בגלל ירידה במשקל או עלייה ניכרת, שינוי דרמטי במצב ההורמונלי בגוף וניתוחים למיניהם. אבל הסיבה העיקרית לגידול הנרתיק היא לידות. מעבר התינוק בנרתיק יכול לגרום להתרחבות ולרפיון. זהו מצב זמני, ובמרבית המקרים יחזור הנרתיק למצבו המקורי בתוך כמה חודשים. למקצת הנשים יידרשו שעות ארוכות של תרגילי קגל לכיווץ והרפיה של שרירי הנרתיק כדי להחזיר לנרתיק את גמישותו. רק נשים מעטות לא יוכלו לחזור למצב הקודם של גמישות ושליטה.

מלכה שמעה מאישה מלאה שנשים שמנות הן צרות יותר מנשים רזות, והיא סקרנית לדעת אם נכון הדבר.

למלכה, אין אמת בדבר. אין קשר ישיר בין גובה, משקל ומבנה גוף לגודל הנרתיק. גודל הנרתיק אצל רזות ושמנות תלוי בראש ובראשונה בגנטיקה.

התעוררות, ריגוש וסיכוך

ההתעוררות והריגוש מתחילים בתגובה לגירויים פסיכולוגיים כמו פנטזיות, צפייה בסרטים אירוטיים, קריאה בספר אירוטי, גירוי גופני כמו ליטוף, נשיקה, מגע באיברי המין או באיבר רגיש אחר בגוף. בשלב זה חלים שינויים בגוף, והגירוי יכול להיות קצר או ארוך – תלוי במוכנות האישה לקבל ולהכיל את הגירוי.

התגובה הראשונית לריגוש מיני היא הסיכוך. זוהי הפרשה של נוזל המשמש לסיכה. הופעת הסיכוך מקבילה להופעת הזקפה אצל הגבר ובדרך כלל מתחילה בתוך 10–30 שניות מתחילת הגירוי. מקור הסיכוך בדליפת נוזל צלול דרך דופנות הנרתיק. בה בעת חלה התרחבות של הנרתיק, והוא מתאים את עצמו לחדירה.

שינויים גופניים אחרים בשלב ההתעוררות הם הזדקרות הפטמות, עלייה בדופק ובקצב הנשימה, אדמומיות בחזה וברום הבטן עקב התרחבות כלי הדם באיבר המין – השטחת השפתיים הגדולות, הגדלת השפתיים הקטנות והדגדגן, התארכות והתרחבות שני השלישים הפנימיים של הנרתיק. ההתעוררות המינית שונה מאישה לאישה, וגם אצל אותה אישה היא משתנה בהשפעת גורמים פיזיים, פסיכולוגיים וזוגיים.

התרחבות הנרתיק היא תהליך טבעי שחל עקב הריגוש המיני. ההתרחבות שונה מאישה לאישה. שונים גם רמת הסיכוך וכמותו, ואין באלה כדי להעיד על בעיה.

יש כמה דרכים שעשויות להיטיב עם התופעה של נרתיק רחב: תרגילים לחיזוק ולכיווץ שרירי רצפת האגן והנרתיק, תרגילי פאולה ותרגילי קגל. בתרגילים אלו מכווצים את שרירי הנרתיק כמה פעמים ביום לשם אימון השריר, ואחר כך מכווצים אותו גם בזמן המשגל. הכיווץ עוזר לחיזוק שרירי הנרתיק, והיכולת לכווץ בזמן המשגל תגרום לתחושה טובה אצל הגבר

והאישה. עוד דרך להיטיב עם התופעה היא עבודה ותרגול בעזרת ביופידבק אצל פיזיותרפיסט של רצפת האגן. ואפשר גם בניתוח.

איריס, בת 29, ספורטאית ואתלטית, פעילה ואוהבת מין, קובלת על בעיה. בקיום יחסי מין היא לא מרגישה חיכוך. לעיתים קרובות בתחילת האקט היא מרגישה שהיא מפרישה הרבה נוזלים, מה שגורם לחוסר חיכוך בחדירה. הדבר גורם לה חוסר ביטחון נוראי והיא חשה כי בן זוגה לא נהנה. שרירי רצפת האגן שלה חזקים לדעתה, ואף על פי כן כשהיא מנסה לכווץ את הסוגרים, עדיין אין מספיק חיכוך. איריס שואלת אם יש אפשרות שצוואר הרחם שלה התרחב עם השנים. העניין החל לפני ארבע שנים. עד אז הרגישה חיכוך מלא, לא חשוב מה היה גודל האיבר של בן זוגה.

לאיריס, יש לא מעט בחורות המלינות על מצב הפוך שבו הן אינן מתעוררות התעוררות מינית וחווות כאב בזמן הניסיון למגע. הכאב הוא תולדה של חוסר סיכוך וחוסר התרחבות של הנרתיק. אין קשר בין צוואר הרחם שלך לבין תחושתך. התחושה או אי התחושה היא בנרתיק בלבד. מקומו של צוואר הרחם בסוף הנרתיק, והוא הפתח לרחם. איבר גברי לא חודר דרך צוואר הרחם. מה שאת מתארת קורה ללא מעט נשים המגיבות טוב לגירוי מיני ומתעוררות למצב המתסכל אותן. אני מניח שההרטבה שעליה את מדברת אינה חלה בזמן האורגזמה אלא בזמן ההתעוררות המינית. יש נשים שברמת גירוי גבוהה מגיבות בגודש דם רב באזור האגן ובאיבר המין. דבר זה גורם להפרשה מרובה של נוזלים בנרתיק. הגירוי הרב, ההפרשה, ההרחבה וההרפיה של הנרתיק הם תופעות טבעיות שבין השאר עלולות לגרום לירידה בתחושה שעליה את מדברת. התופעה טבעית, ואין להתבייש בה. חבל שבגלל תופעה טבעית תתנהגי באופן לא טבעי ותעשי עוול לעצמך, לבן זוגך או לאחרים שרוצים ליהנות איתך. הינה הצעות ובקשות: את בחורה צעירה, אסתטית וספורטיבית. אל תחשבי ותרגישי בשביל הבחורים שאיתם את נמצאת. תהיי רגישה אליהם, תתחשבי בהם, אבל אל תפחיתי מנשיותך וממיניותך בגלל מה שקורה. אל תנסי למנוע את הגירוי ואת ההתעוררות המינית כדי להימנע מההרטבה ומהתרחבות

הנרתיק. זה רק יפגע בהנאה המינית שלך. את יכולה להיעזר בכיוון שרירי רצפת האגן וגם במגבת לניגוב הנזלים. אם תגיעי לאורגזמה לפני יחסי מין מלאים, אזי ירדו הגודש באיבר, ההתרחבות והסיכוך, ותוכלי לקיים יחסי מין מלאים עם תחושה נעימה לך ולגבר שאיתך. ואל תתלבטי אם לצאת עם בחורים או לא. בטח לא בגלל רטיבות בנרתיק.

יצחק, בן 29, מספר כי כאשר הוא מקיים יחסים עם חברתו, הנרתיק שלה מתרחב עד כדי כך שהוא בעצם לא מרגיש אותו. המצב הזה פוגע בהנאה שלו ומקשה עליו לגמור. יצחק מבקש לדעת אם זה יכול להיות בגלל יחסים קודמים שהיו לה עם גבר בעל איבר גדול משלו ואם יש פתרון לבעיה. חברתו היא צעירה שעדיין לא ילדה.

ליצחק, יש מצב שהנרתיק רחב ביחס להיקפו של איבר המין הגברי. בגלל הפער בממדים ייתכן שהגבר לא ירגיש חיכוך במהלך היחסים, וייתכן שהאישה בקושי תדע אם הוא בפנים. מצב זה של נרתיק רחב יכול להיות טבעי ולא תולדה של קיום יחסי מין עם גבר בעל איבר מין גדול משלך. איבר מין גדול לא יכול להביא להרחבת הנרתיק. בדרך כלל מצב כזה הוא תוצאה של ריבוי לידות, אבל לא אצל כל אישה שעוברת לידות יתרחב הנרתיק. יהיה נכון לבקש מחברתך לכוון את שרירי הנרתיק כשאתה בתוכה כדי ששניכם תחושו זה את זה. וגם שינוי תנוחה יכול להביא להעצמת התחושה של זוגתך להנאה לשניכם.

יובש בנרתיק

במצב של ירידה בכמות ההורמון אסטרוגן עלול להיוצר יובש בנרתיק. כך בגיל המעבר, אבל לא רק בגיל המעבר. גורמים אחרים הם שימוש ממושך בגלולות, הנקה, טיפולים כימותרפיים ועוד. הירידה ברמת האסטרוגן משפיעה על דופן הנרתיק. הדופן נעשית דקה יותר, בלוטות הריר הולכות ונעלמות, והרירית מתייבשת. הפרשת הריר והסיכוך בנרתיק יורדים בעת גירוי מיני, וקיום יחסי מין עלול להיות מלווה בכאבים.

מטרת הטיפול ביובש בנרתיק היא לתקן מצבים של נזק לאיכות החיים ולמנוע השלכות ארוכות טווח. שיטות הטיפול רבות ומגוונות: הורמונים סינתטיים הבאים להחליף את החסר שנגרם מהפסקת התפקוד של השחלות, מוצרים טבעיים, תכשירים ספציפיים לפי הבעיות המתעוררות, חומרי סיכון כמו פמינה, K-Y ג'לי ואחרים. מוצרים רפואיים המסייעים בסיכון הנרתיק ומצריכים מרשם רופא הם וגים, סופטין, ולוברין.

דיאטה צמחונית מעשירה את התזונה במזונות עשירים בפיטואסטרונגים. צריכה מוגברת של פיטואסטרונגים בתזונה מסבירה את העובדה שסימפטומים המקושרים לגיל המעבר נדירים בתרבויות שהדיאטה שלהם מתבססת על מזון מהצומח עשיר בפיטואסטרונגים.

חשובה צריכה מוגברת של סויה, המשפיעה במצבים של יובש בנרתיק. האיזופלבנואידים והפיטוסטרול של פולי הסויה יוצרים אפקט אסטרונגי. ככל שפולי הסויה מכילים פחות חלבון, הם מכילים יותר איזופלבנואידים.

יש גם תוספי מזון – ויטמין E הוא בעל אפקט מקל בגלי חום, ביובש בנרתיק ובאספקת דם מרובה לאזור הנרתיק. אפשר ליטול אותו בכמוסות, בקרם, במשחה או בנרות לשימוש מקומי בנרתיק. יש גם הרבה מוצרים אלטרנטיביים כמו צמחי מרפא, למשל קוהוש שחור וצמח אברהם.

מירי, בת 53, לא קיבלה מחזור שש שנים. היא נטלה כמה סוגים של הורמונים, והם גרמו לה לתופעות לוואי חמורות. מירי היא אם חד-הורית שרוצה לבנות את עתידה, אך בשל הנסיבות אינה יכולה לחשוב על זוגיות. יש לה יובש בנרתיק מלווה בכאבים קשים, והיא לא יכולה לקיים יחסי מין.

למירי, אומנם נכנסת לגיל המעבר והיובש גורם לה כאבים ביחסי מין, אבל אין זה סיבה להתרחק מזוגיות. יש עוד רבדים שעליהם נבנית זוגיות טובה. יחסי מין חשובים, אך לא על המין לבדו יחיה האדם. היובש בנרתיק הוא אחד ממאפייני גיל המעבר. את התחליפים ההורמונליים שקיבלת והכילו אסטרונג ופרוגסטרונ כנראה נטלת דרך

הפה. ביובש הנרתיק אפשר לטפל גם במתן הורמונים המופקים מהחי, מהצומח או במעבדה. הם באים בצורת כדורים, ג'ל ומשחות, ואפשר להכניס אותם ישירות לתוך הנרתיק.

קרום הבתולים

קרום הבתולים הוא פיסת רקמה דקה המכסה את פתח הנרתיק באופן חלקי ומאפשרת לדם הווסת לצאת מהנרתיק החוצה. הממדים והצורה של הקרום משתנים מאישה לאישה. כ-2% מהנשים נולדות בלי קרום בתולים.

הקרום הוא רקמה גמישה שמשתנה בגודל, בצורה ובעובי. קרום בתולים טבעתי (Annular Hymen) מכתר את כל פתח הנרתיק ויש פתח במרכזו. קרום מפוצל (Septate Hymen) – יש קו עור דק במרכזו. קרום בלתי חדיר (Imperforate Hymen) – ייפתח רק באמצעות ניקוב.

הבתולים עלולים להיקרע בפעילות ספורט נמרצת וכן בהחדרת טמפון, אצבע או חפץ כלשהו אל תוך הנרתיק. יש נשים הנזקקות להתערבות כירורגית להסרת קרום הבתולים, משום שאינו גמיש דיו כדי להיקרע בזמן משגל.

בכל התרבויות, בכל הדתות, בכל הזמנים תמיד היה עניין סביב קרום הבתולים. קרום הבתולים נחשב הוכחה לטוהר האישה.

שולה, בת 19, מספרת שכשאשר קיימה יחסי מין בפעם הראשונה, לא הצליח החבר שלה להכניס את איברו לתוך הנרתיק שלה. הוא עשה את זה מאחור בתנוחת דוגי סטייל, וירד לה דם. בהתחלה חשבה שקרום הבתולים שלה נקרע, אבל גם בפעם השנייה הם לא הצליחו לעשות את זה באופן רגיל, חזרו לתנוחת דוגי סטייל, ושוב ירד לה דם. שולה שואלת מה מקור הדם הזה ואם היא עדיין בתולה.

לשולה, אין דרך לבדוק אם בחורה היא בתולה או לא. מי שמעוניינת לדעת אם נשארו לה שיירים מקרום הבתולים תיגש לבדיקה גינקולוגית ותקבל תשובה חד-משמעית. הימצאות הקרום או שיירים ממנו אין בהם כדי להעיד על כך שהבחורה אינה בתולה.

לא תמיד יש דימום כאשר קרום הבתולים נקרע – לא אחרי פעם אחת ואפילו לא אחרי כמה פעמים של קיום יחסי מין. יש מקרים שלא רואים דימום על המיטה, יש מקרים של דימום בתחילת יחסי המין, יש דימומים גם לאחר כמה פעמים של יחסים מלאים.

הדגדגן

הדגדגן הוא רקמה ספוגית זקיפה שנמצאת בפתח הפות, איבר המין הנקבי. הדגדגן הוא האיבר הרגיש ביותר באיבר המין הנשי. מקומו בחיבור העליון של השפתיים הקטנות מחוץ לנרתיק. תפקידו הבלעדי של הדגדגן הוא לגרום הנאה לאישה, ומקומו המרוחק יחסית מפתח הנרתיק דורש התמקדות מיוחדת בו בזמן המגע המיני. גירוי ישיר או עקיף של הדגדגן גורם לחוויית האורגזמה.

גוף הדגדגן הוא איבר פנימי תת-עורי. אורכו יכול להגיע עד 4 סנטימטרים. ראש הדגדגן, אותו חלק הנראה לעין, הוא החלק שמורגש כמזדקר בזמן הגירוי המיני. חלק זה מכוסה בקפל עור דמוי עורלה, 'עורלת הדגדגן', המסוככת על 'עטרת הדגדגן' ומגינה על הדגדגן ממגע ישיר שעלול לגרום לכאב. עטרת הדגדגן היא אזור רגיש ביותר המכיל כ-8,000 קצות עצבים, פי שניים ממספר קצות העצבים בעטרת הפין הגברי. כדי לחשוף את הדגדגן מפשילים את קפל העורלה, ואז מתגלה ראש הדגדגן שצורתו כגרגיר אפונה וגודלו כמה מילימטרים. רגלי הדגדגן הן איבר פנימי הנמצא מתחת למבוא הערירה ומקיף את השופכה, אורכן 5–9 ס"מ.

מבחינת ההתפתחות העוברית הדגדגן זהה לפין הגברי. הוא זהה מבחינת מבנהו, כלי הדם והעצבוב. גם ההתנהגות בזמן התגובה לגירוי מיני דומה לתגובת הפין.

התרחבות הנרתיק

כמו כל איבר בגוף גם ממדי הנרתיק משתנים מאישה לאישה. מה שנכון

לכלל הנשים הוא שעם השנים, בייחוד לאחר לידות, נחלשים השרירים סביב פתח הנרתיק, הקירות הקדמיים או האחוריים (או אלה ואלה) של הנרתיק צונחים, והדבר מביא לתופעה של ההתרחבות. כ-60% מהנשים מעל גיל 45 סובלות מצניחת הקיר האחורי או הקדמי של הנרתיק.

מידת ההתרחבות של הנרתיק היא אינדיווידואלית ולא בהכרח פוגעת ביכולת ליהנות מיחסי מין. נשים שיולדות תינוקות גדולים או עברו לידות ואקום או מלקחיים וכן נשים מעשנות, נשים הסובלות מאסטמה ונוטות לשיעול תכוף המפעיל לחץ ומביא להתרחבות הנרתיק עם השנים – כל אלה חשות בהתרחבות יותר מאחרות.

יש אפשרות לחזק את השרירים שהתרופפו על ידי כיווצם במשך היום ללא קשר ליחסי מין. במקרים קשים יש מקום להתערבות כירורגית.

נאווה, בת 39, מודאגת מהתרחבות הנרתיק שלה. ידוע לה כי השריר מתאים את עצמו לגודל האיבר, והיא מודאגת מההתרחבות ושואלת מה לעשות.

לנאווה, ההתרחבות אינה קשורה לקיום יחסי מין ולאיבר מין גדול אלא לרפיון שרירי הנרתיק. מומלץ שתפני לגיניקולוגית לאבחון והמלצות.

דנה, בת 34, רווקה, שוחחה עם חברות וגם קראה בפורומים באינטרנט והגיעה למסקנה שבמערכות יחסי המין שלה בשנים האחרונות היא סובלת בגלל מבנה מוזר של השפתיים הקטנות של הנרתיק. השפתיים אצלה גדולות מאוד, לא סימטריות ומלאות גבשושיות שומניות. הדבר מונע ממנה לקיים יחסים באור אפילו חלש ובאופן חופשי. פנטזיות מיניות נשארות אצלה רק בדמיון, כי היא מתביישת במבנה שלה. דנה שואלת אם אפשר לשנות את המצב בניתוח.

לדנה, שפתיים גדולות או אסימטריות אצל אישה בגילך שלא ילדה זו תופעה מולדת. את מתארת מצב אשר עלול לגרום בושה וחשש מדחייה ונטישה וכתוצאה מכך הימנעות מהתנהגות משוחררת ביחסי מין. כיום עושים ניתוחים פלסטיים בשפתיים, בנרתיק ובקרום הבתולים. יש ניתוח להקטנת השפתיים. ניתוח השפתיים נעשה בהרדמה כללית

ואורך כשעה. מורידים את החלקים המיותרים ומעצבים את השפתיים. החזרה לתפקוד מיני אחרי חודש ימים. החזרה לעבודה אחרי יומיים. התוצאות טובות מאוד ומשנות לחלוטין את הצורה החיצונית של הנרתיק. לאחר הניתוח ישתנו חיך המיניים.

פין או פות

בשלב הראשון בהתפתחות העוברית יש מצב בלתי מוגדר בהתפתחות איברי המין. בשלב הזה אי אפשר להבחין בין עובר זכרי לעובר נקבי. עד סוף השבוע ה-9 להיריון יש דמיון בין איברי המין החיצוניים של הזכר ושל הנקבה. צורתם הסופית מעוצבת רק בשבוע ה-12 לחיי העובר. מהשבוע ה-3 לחיי העובר יש גבשושית תאים שהולכת וגדלה. עד השבוע ה-9 גדלה בעובר הזכר ובעובר הנקבה זהה. מאזור הפאלוס יתפתחו הפין של הזכר והדגדגן של הנקבה. כבר כאן מתחיל הדמיון בין השניים. מזוג הקפלים הגניטאליים יתפתחו זוג האשכים של הזכר והשפתיים הגדולות של הנקבה. ברירת מחדל של הטבע הוא יצירת פין נקבי. רק בנוכחות כרומוזום Y יתפתח פין זכרי.

אינטליגנציה מינית



האינטליגנציה היא מכלול הכישורים שבאמצעותם בני אדם פותרים בעיות הדורשות חשיבה יעילה. זוהי היכולת להבין דבר מתוך דבר ולהבחין בין דבר לדבר.

חוקרים מאוניברסיטת מסצ'וסטס בדקו את האינטליגנציה המינית של 5,000 אמריקנים בני 22–55. 75% מהנשאים טענו שחשוב להם ליהנות מחיי מין מספקים, אך הם לא זוכים להנאה סבירה. אנשים רבים שסובלים מהיעדר תשוקה, מחוסר יכולת להגיע לאורגזמה ומאיפוטנציה חלקית הודו שאין להם עם מי לשוחח על בעיותיהם המיניות, ושהם לא מוכנים לדבר על בעיותיהם האינטימיות עם בני זוגם. בדרך כלל קשה לדבר על מין, אך כיום המצב הזה משתנה, והמסר החברתי פתוח יותר.

אנשים שהאינטליגנציה המינית שלהם גבוהה מצליחים לזהות את הצדדים הבעייתיים אצלם ואצל בן זוגם בתחום ההתנהגות המינית, אזהרים אומץ ומדברים על כך. אחר כך הם פונים לייעוץ נפשי-סקסולוגי שמסייע להם לטפל בקושי המיני ולתרגל התנהגות מינית בריאה יותר.

חוויות מיניות קשות כמו פגיעה מינית, חשיפה לפורנו או מסרים מיניים של ההורים משאירים את חותמם על האינטליגנציה המינית. הקשיים עלולים לנבוע מהחינוך בגיל הילדות. חוקרים מצאו שילדים אשר חונכו באווירה נוקשה בכל מה שקשור לסדר ולניקיון דיווחו לאחר מכן על חוסר יכולת להגיע לסיפוק מיני, ובה בעת נטו למרד ולהפקרות. מחקרים מורים שגם פתיחות רבה מדי בחינוך המיני גורמת לנטייה להפקרות מינית.

בגיל ההתבגרות רמת האינטליגנציה המינית נמוכה, לא בוגרת ומבולבלת



אצל בנים ובנות. דווקא בתקופה רגישה זו בני נוער רבים מקיימים יחסי מין ללא אינטימיות. קיים בלבול בין מין לאהבה. הם צוברים ניסיון מיני בלי מוכנות רגשית, לפעמים מתוך ניסיון לחקות סרטי פורנו – אחת הטעויות של המתבגרים – או כדי לרכוש מעמד וביטחון. לפעמים בחור צעיר שמקיים יחסי מין הוא "אחלה גבר" ובחורה היא "זונה".

כשמגיעים לבגרות זוגות בעלי אינטליגנציה מינית גבוהה יתמקדו במה שחיובי וטוב אצל בן הזוג וינסו להתעלם ממגרעותיו ומשגיאותיו. הם יראו הערכה הדדית ויפרגנו זה לזה. הם ישוחחו שיחות נפש. הם יאהבו להפתיע זה את זה ביציאה מהשגרה: מקומות בילוי חדשים, טיולים, מופעים, חיבוקים ונשיקות בחיק הטבע. הם ישוחחו גם על הצרכים המיניים שלהם ויישמו את תובנותיהם.

הגיל השלישי מאופיין באינטימיות, בחברות, באמון ובנאמנות גם בתחום המיני.

א-מיניות



בשנת 2001 הקים דייוויד ג'יי, שמגדיר את עצמו א-מיני, אתר אינטרנט לאוכלוסיית הא-מיניים בעולם. ההגדרה באתר לאדם א-מיני היא "אדם שלא חווה משיכה מינית". מטרת האתר הייתה להביא לקבלה ולדיון ציבורי את נושא הא-מיניות ולאפשר את הרחבת קהילת הא-מיניים. כך הגיע הנושא לדיון ברשתות טלוויזיה עולמיות.

מבחינים בין אנשים א-מיניים לבין אנשים שמקבלים החלטה מודעת שלא לקיים יחסי מין. האחרונים חווים חשק מיני, מה שנעדר אצל א-מיניים. א-מיניים אינם חשים משיכה מינית כלפי אדם אחר, גבר או אישה. א-מיניים הודפים את הטענות שא-מיניות היא ביטוי לבעיה בתפקוד המיני. הם מסבירים שהם אינם חשים משיכה מינית, ושהדבר לא מסב להם מצוקה, ולפיכך אין מדובר בהפרעה בתפקוד המיני. חוקרים ואנשי מקצוע חלוקים בשאלה אם מדובר בבעיה בתפקוד המיני או בבעיה באוריינטציה המינית. ונראה שזוהי עוד תופעה נורמלית בספקטרום המיני של המין האנושי. שכיחות התופעה באוכלוסייה היא כ-1%.

ההבדלים הקיימים בקרב המגדירים את עצמם א-מיניים הם בעיקר בכל הקשור בהיעדר הדחף המיני והמשיכה הרומנטית או בהימצאם. הדחף המיני, אם קיים בקרב א-מיניים, איננו מכוון לאובייקט. זהו דחף לגירוי מיני או לפורקן מיני שיכול להיות בעוצמה חזקה או חלשה ויכול להופיע בתדירות גבוהה או נמוכה. יש א-מיניים המדווחים על רגשות מיניים בלי רצון לממשם. בגלל הנורמות החברתיות יש המבקשים לפרוק את הדחף המיני באמצעות אוננות או מגע מיני או שניהם.

על פי הבנתם של הא-מיניים, משיכה רומנטית נפרדת ממשיכה מינית. יש המדברים על דחף רומנטי, חשים דחף לקשר רומנטי ורוצים מערכת יחסים רומנטית. יש א-מיניים שמחבקים ומלטפים אבל אינם חשים כל דחף לקיים מגע מיני מלא. יש שמקיימים קשר רומנטי עם יחסי מין מלאים, וזאת כדי לרצות את בן הזוג. חשוב להבחין בין המתקשים ביצירת מערכות יחסים ואינטימיות לבין מי שמגדיר את עצמו א-מיני.

משה, בן 40, מספר על תקופות שבהן החיה המינית שבו חיפשה את החתולה האמיתית שלו, אישה שלא רוצה מין. הוא רצה להתפשר ולזרום, אבל עם השנים התחיל המין להיות מסובך וגם הזוגיות מסובכת. ב-15 השנים האחרונות משה עוסק בהומאופתיה, דיקור, מגע, פעילות גופנית אינטנסיבית, פסיכולוגיה, ירידה במשקל. עצוב לו להיות לבד, וזה מחלחל אל כל הדברים הטובים שהוא מייצר לעצמו ולסביבה. משה הגיע להכרה שהוא אדם נורמלי לחלוטין, בריא, נחמד ועם אמפתיה מלאה לבריות סביבו, אבל לא מוצא את החתולה שלו. הוא יודע כמה קשה וטובה וענוגה היא זוגיות בריאה כדרך הטבע, אך בחר להיות א-מיני. כך חזרה לו השליטה בחייו, הוא פעיל יותר, משהו נפתח ומגרה את חושיו, שהיו מסנוורים ומכוונים למצוא זוגיות. אחרי שפינה מקום חדש בלב ויש לו תחושת שייכות, ייתכן שפשוט יפגוש אותה במקרה, והכול יקרה.

למשה, אתה מתאר קושי ביצירת קשר ואינטימיות ולא א-מיניות. וחשוב שנבדיל בין זה לזה. הניסיונות שלך להשתנות מעידים על הקושי שלך לקבל את עצמך כמו שאתה. ההנחה שלך שמי שאתה, ללא שינויים, איננו מספיק כדי לאפשר לך לבחור, היא שגורמת שלא יבחרו בך, היא שמקשה על יכולתך ליצור קשר זוגי. אינך צריך להשתנות ואינך צריך להשתייך למסגרת שאליה אתה לא שייך. אתה לא א-מיני, אלא צריך לקבל את מה שיש לך, להשלים עם מי שאתה, ורק כך תוכל למצוא את מי שתהיה, כהגדרתך, החתולה המינית שלך. כשתאפשר לעצמך להכיר ולראות את החתול שבך, רק אז תוכל למצוא אותה.

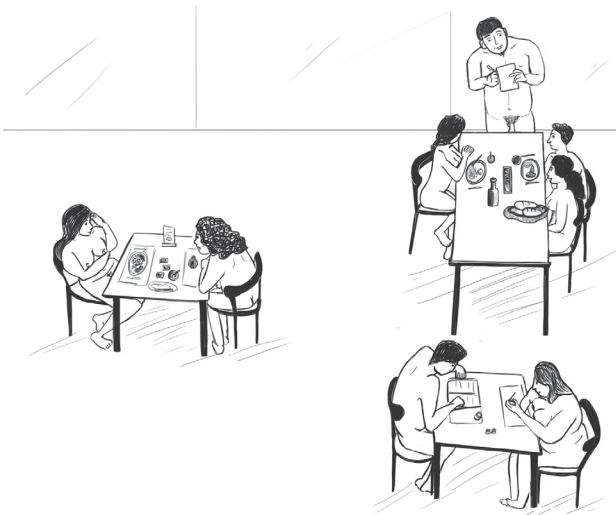
אקסהיביציוניזם



אקסהיביציוניזם הוא סוג של פאראפליה. בתרבות המערב הסרת בגדים עשויה להיחשב מעשה אירוטי או פוגעני. עירום במחיצת זרים בני אותו המין מקובל יותר מעירום במחיצת שני המינים ביחד. לפיכך יש חדרי הלבשה, בתי שימוש ומקלחות נפרדים לנשים ולגברים. בגרמניה, פינלנד והולנד יש בתי מרחץ משותפים לנשים וגברים. יש ארצות שבהן שהייה עם בני אותו המין בעירום היא בלתי מקובלת.

אקסהיביציוניזם כסטייה מינית הוא דפוס התנהגות שבו אדם משתוקק לחשוף את איבריו האינטימיים בפומבי, ומפיק מכך הנאה. לעיתים ההתערטלות מתבטאת בחשיפה של איבר המין או אוננות לפני זרים, מה

שמביא את העושה לידי גירוי מיני. בדרך כלל הסיפוק המיני מופק מעצם החשיפה, ואין לאקסהיביציוניסט צורך במגע מיני. התופעה מופיעה רק אצל גברים, אך יש גם תיאורים נדירים של אקסהיביציוניזם אצל נשים.



אתרי אינטרנט



היכרויות באינטרנט

אתרי אינטרנט הם היום מקור ראשון להיכרויות. מגוון האפשרויות הוא עצום, ואין צורך ללכת למועדון זה או אחר ולנסות להכיר גבר או אישה. שלא כמו במפגש פנים אל פנים, החשש לדחייה נמוך. יש יותר זמן לדון ולתקשר עם הצד השני, וכאב הסירוב לקשר לא גדול.

ואף על פי כן אין כמו מראה עיניים. הפגישה בארבע עיניים, שפת הגוף, המבט, הקרבה, הריח, הרגישות לאחר – הם שיביאו בסופו של דבר לקשר.

האינטרנט מאפשר להסתתר מאחורי זהויות בדויות, ורבים בו הנתונים הפיקטיביים. עם זה הוא חוסך את עוגמת הנפש של דחייה פנים מול פנים. זהו גם כלי שוויוני לגברים ונשים. במקום לצאת לבר ולצוד גבר או אישה, יושבים מאחורי מחשב מגונן.

זהו כלי משובח להיכרויות, אבל יש לו צדדים שליליים. לפעמים אנשים יוצאים לעשרות דייטים. לפעמים נתקלים בטיפוסים מפוקפקים שמסתובבים ברשת ובאנשים נשואים.

כשמקבלים הודעת חיזור באינטרנט חשוב לבדוק מי עומד מאחוריה. יש מקרים מאוד קשים של בני נוער וילדים שנפגשו עם אנשים זרים דרך המחשב, וזה נגמר רע מאוד. בני נוער ממוקדים וממהרים להגיע לחלק המיני של הזוגיות, וכמעט ולא בונים חלק רגשי ורומנטי. בנות יוזמות היום יותר מבעבר.

כשמתחילים עם מישהו צריך להביא בחשבון שיש אפשרות שיגיד לא ולחשוב על ההתמודדות עם הדחייה. צריך להבין שדחייה היא לא סוף הדרך. לפעמים צריך לחיות עם כישלון, אכזבה או תסכול. כדי להתגבר על אכזבה אפשר להיעזר במשפחה התומכת או בחברים שיתמכו ולא לנסות לרוץ מקשר לקשר. לא יזיק להיות קצת לבד, להסתכל פנימה וללמוד לקראת הקשר הבא.

גברים נאים נתפסים אצל נשים במודע ובתת-מודע כמי שיכולים להשביח את הגנים של הילדים שלהם. גברים נמשכים ליופי משום שהם מתוכננים לפזר את הגנים שלהם כדי ליצור דור המשך. הרושם הראשוני חשוב, משום שהוא טובע חותם הרבה זמן אחרי המפגש הראשון. היום יש הרבה שיטות שידוך שנקראות 'ספיד דייטינג' ומבוססות על מפגש של שלוש דקות בלבד, והם בוחרים אם להמשיך ולהיפגש על סמך הרושם הראשוני. הרושם הראשוני קובע להתחלה. פעמים רבות תבוא אחר כך האכזבה.

בני נוער היום נמשכים למותגים, למקובלות ולמראה. הם מחפשים אצל בני הזוג אפשרות לבילוי והנאה. הם לא נותנים את דעתם לעניינים של רגש, לדחיית סיפוקים ולהליכה לקראת האחר. בגיל מבוגר יותר יש יותר התייחסות לכסף, לפנאי ביחד ולחוד וגם מחשבות על ילדים. הכי חשוב שכל אדם יהיה הוא עצמו. כנות היא הדרך הטובה ביותר לפעול בה בחיזור ובכל שלבי הקשר.

אין לפסול היכרות דרך האינטרנט. לא מעט זוגות שהכירו באינטרנט חיים יחד באושר. עם זאת חשוב שלא לאפשר לאינטרנט לנהל אותנו.

זוגיות וירטואלית

התקשורת הווירטואלית מאתגרת את הזוגיות והמיניות. גלגולי הרשת הביאו את האינטרנט לשמש רשת חברתית המביאה אנשים לתקשר ביניהם וליצור קשרים וירטואליים. כיום אנו פתוחים לפורומים, צ'אטים, שיחות וידאו, פייסבוק ועוד, וכל אלה מאפשרים קשר מידי, אינטימי ולא מאיים. זה יכול להיות קשר וירטואלי לחלוטין אשר בו מצ'וטטים עם ובלי מצלמה,

זה יכול להיות שיחות אינטימיות וזה יכול להיות סקס וירטואלי ולהגיע מסייבר סקס עד סקס טלפוני ועד למפגש מיני.

מערכות יחסים וירטואליות נוצרות בעיקר בגלל יצר הרפתקה, בדידות, השלמת צרכים, חוסר סיפוק מיני, חוסר סיפוק במערכת היחסים הקבועה, צורך בחשיפה, התמכרות. אין צורך בקרבה גאוגרפית, פיזית, רגשית. לפעמים לא יודעים מי נמצא מאחורי המקלדת. צורה זו של אינטימיות מאפשרת חשיפה גדולה. המעשה לא נחשב בגידה, כי החברה מגדירה בגידה כעצם האקט המיני. כך המצב הזה מאפשר יותר בגידות וירטואליות ופחות אינטימיות ביחסים הקבועים.

יש זוגות שהאינטרנט יביא לכרסום בקשר שלהם. המיניות שלהם תדעך, לא יהיה משחק מקדים, המין יהיה טכני וקצר. יש זוגות שהאינטרנט יעצים ויחזק את הזוגיות והמיניות שלהם.

ייתכן שיבחרו בזוגיות באינטרנט גם אנשים בעלי מאפיינים סכיזואידיים, שנסוגים ונרתעים ממגעים רגשיים וחברתיים ישירים.

הזוגיות האינטרנטית נפוצה אצל צעירים שנולדו בעולם האינטרנט. התופעה רחבה, וכנראה עונה על צורכיהם של רבים. לעיתים דווקא השימוש במחשב כמתווך וסוג של חיץ מקל על בני הזוג להיחשף זה לזה עמוק יותר מבמפגש פנים אל פנים.

החיסרון הגדול של קשר מסוג זה הוא החוסר בקרבה אינטימית ורגשית, במגע, בחום אנושי ובתחושת הביחד. יש מידע שאוספים במפגש בין-אישי – התנהגויות, הרגלים, טמפרמנט. זוגיות אינטרנטית יכולה להיות מספקת לזמן קצר, אך היא בעייתית כאשר היא נמשכת לאורך זמן ואינה מגיעה למפגש בעולם האמיתי.

בגידה



שבירת האמון

סקר שנערך בארץ בשנת 2010 מצא כי 85% מהישראלים הנשואים בגדו, בוגדים, או אינם שוללים אפשרות של בגידה בבני זוגם. כ-20% מספרים לחבר או לחברה על הבגידה, פחות מ-8% מספרים על כך לבני הזוג.

בגידה היא מעשה החורג

מהנורמה שבני זוג קבעו

לעצמם. לכל זוג יש הגדרה

אישית משלו לבגידה.

בגידה יכולה להיות

שיחה אינטימית עם גבר

או אישה, צ'ט באינטרנט,

רומן עם מישהו אחר, סטוץ

ועוד. גם נורמות חברתיות

משחקות כאן תפקיד.

בחברה שלנו אישה

נשואה המקיימת יחסים

עם גבר שאינו בעלה



נחשבת לבוגדת, אך לא כך הדבר בכל תרבות. אצל האסקימואים הבעל יכול לכבד אורח ביחסי מין עם אשתו.

הבגידה, בייחוד בגידה מינית, גורמת לשבירת האמון. הנבגד חש פגיעה בתחושת השייכות שלו, בביטחון שלו. הגבולות סביב הקשר המשפחתי והזוגי נפרצים, לעיתים עד מצב בלתי ניתן לשיקום.

למה אנשים בוגדים? לא בהכרח מאין אהבה. לעיתים הגורמים הם צורך בגיוון, שיעמום, צורך בחיזוקים, בתחושה של כוח, בתחושת עצמאות, הגנה, פיצוי על תסכולים של צרכים לא מסופקים, בריחה, הפגת מתחים בחיי הנישואים, מצוקה. יש מקרים שהפתרון של גירושים לא בא בחשבון, ואחד מבני הזוג מחפש מין מחוץ לנישואים.

פגיעה בתא המשפחתי

בגידה היא פעולה הרסנית לקשר הזוגי ופוגעת בתא המשפחתי, בעיקר אם יש ילדים. מצד הנבגד החוויה קשה מאוד. ואולם לפעמים הבגידה היא מנוף לשיקום הזוגיות. לפעמים פונים לטיפול זוגי ומיני, שיוכל לעזור לבני הזוג לבנות מחדש את האמון זה בזה וגם לחדש את המיניות.

אסתר פרל, פסיכולוגית ומחברת *אינטליגנציה אירוטית*, גורסת שהמילה 'בגידה' טעונה משמעויות שליליות, ולכן אולי מומלץ להשתמש במילים אחרות לתיאור רומנים מהצד במערכות יחסים. בין השאר מציעה פרל לא להתעלם מההתאהבות שעלולה להתרחש בבגידה בעקבות החיפוש, הריגוש, הכמיהה והתשוקה של הבוגד למשהו חדש. לדבריה, במשך שנים ניסתה להבין את המניעים של אנשים לבגידות, עד שהבינה שלפעמים אין לבגידה כל קשר לזוגיות. "מצאתי בני זוג שהיו במערכת יחסים טובה וגילו יום אחד בהפתעה שבן הזוג מנהל רומן מחוץ למערכת, לפעמים אפילו בתקופות הכי טובות שלהם כבני זוג. הבוגד יכול להיות בעל ערכים מונוגמיים, אבל ההתנהגות שלו יכולה להיות מאוד רחוקה מכך", מסבירה פרל. "לעיתים יש בבגידה דרישה מחודשת למשמעות, יש בה שאיפה לעזוב את מה שנהיינו במשך הזמן ולנסות למצוא את עצמנו מחדש." דווקא מתוך המציאות הזאת יכולים בני זוג למצוא דרך למנף את הזוגיות שלהם, ולא

רק לשקמה. לדעתה, ברוב הבגידות אין רצון של הבוגד לפרק את מערכת היחסים. להפך. הן מתקיימות בד בבד עם מערכת היחסים ומפרות אותה – בהרבה מקרים באלמנטים שליליים, אבל לעיתים גם באלמנטים שיכולים להיחשב חיוביים.

ברוך, בן 47, מספר שהוא במשבר קשה הקשור לבגידה שלו באשתו. עם אשתו אין לו שום בעיה בסקס, והסקס בסדר. יש לו שתי חברות, ואיתן יש לו בעיה של גמירה מיידית או שלא עומד לו. הוא מחבב מאוד את שתיהן.

לברוך, נראה שפנייתך נובעת מהפליאה על עצם העובדה שבבית עם אשתך אין לך כל קושי בתפקוד המיני, אך מחוץ לבית אתה נתקל בקושי. ברוך, אין לך בעיה כלשהי בתפקוד המיני. כנראה הקשר שלך עם זוגתך הוא כזה, שלמרות חיבתך לחברותיך, עדיין אתה מאוד קשור אליה. נכון שיש נטייה להכללה שאצל הגברים אין בעיה רגשית, אין להם בעיה לקיים יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואים. הכללה זו חוטאת לגברים רבים, ואתה ביניהם, שהם אנשים רגישים, בעלי חוש אחריות ורגש רב לבת זוגם ולמשפחתם. הם נושאים את זוגתם לכל מקום בליבם ומתקשים לבגוד בה.

לשאלתך איך תוכל לממש את יחסי המין שלך מחוץ לבית: אתה יכול לנסות לשנות את אישיותך, ואולי זה בלתי אפשרי; אתה יכול לקחת כדור לזקפה לפני שאתה נפגש עם ידידה (ויאגרה, סיאליס לויטרה או תרים); אתה יכול להמשיך כמו עכשיו ולהסתפק במה שיש. איבר המין שלך בעצם מבהיר לך מהו מקומך האמיתי.

בגידה של גברים ונשים

הגדרת בגידה במובן החברתי היא קיום יחסי מין מחוץ לקשר הזוגי. מחקרים מצאו ש-50%–80 בוגדים לפחות פעם אחת. במחקר אחר הודו 60% מהנשים בארץ בבגידה בבן-זוגן. בשנת 1940 נערכו מחקרים שבהם נלקחו בדיקות דם שהשוו בין הורים

לילדיהם, ונמצא שיותר מ-10% מהילדים היו מאב ביולוגי זר. באנגליה נמצא לפני שני עשורים שכ-15% מהילדים לא נולדו מאביהם המוצהר. כיום מדובר ב-17%.

אצל הגברים הבגידה באה לכסות על צורך מיני ביולוגי. הפנטזיות של הגברים הן מיניות. הם מחפשים גירויים מיניים, מפנטזים על נושא המין. יש גברים שבוגדים כדי להוכיח לעצמם שהם מתפקדים וכדי להגשים פנטזיות. ויש גם סיבות אחרות. הגן האנוכי של הגבר ישאף להרבות את זרעו. האישה תשאף להשביח את הגנטיקה, ולכן תחפש זכר אלפא לקיים איתו יחסי מין.

נשים סולחות יותר ומקבלות גברים שבגדו. גברים נוטים לפרק את התא. נשים מאמינות יותר במונוגמיה וסבורות שלא כדאי לסכן את הקשר בשביל הנאה רגעית. כאשר הבגידה מתגלה, זוגות רבים נפרדים. זוהי הסיבה העיקרית לגירושים בארץ.

מחקרים מצאו כי יש מעין טאבו חברתי על פרסום הבגידה של נשים. חקר הבגידות בארצות הברית בשנות 1950 העלה שיש טאבו חברתי בנושא של נשים בוגדות, ובגידה נחשבת למעשה זנות ופגיעה בתא המשפחתי. לעומת זאת בגידה של גברים היא הוכחה לגבריות. בעשורים האחרונים חלו שינויים בתפישה הזאת, והמעשה נחשב לפחות טאבו. בעולם המערבי יותר נשים מגברים יוזמות גירושים. לנשים יש לגיטימציה לבגוד, ויש עלייה בתעוזה של נשים לפרק את המשפחה. אישה תפרק את הקשר הזוגי כשיש לה רשת ביטחון.

גם נשים וגם גברים נעים בין הצורך בביטחון וחיים במוכר לבין הדחף לחידוש, לריגוש, לכיבוש. נשים עצמאיות, אסרטיביות, קרייריסטיות, שאינן תלויות בבן הזוג מבחינה כלכלית – נחשפות לגברים חדשים. הן פחות חוששות מפירוק המשפחה ולפעמים מחפשות את החידוש מחוץ לבית.

התיאוריה על בגידת נשים גורסת שזהו צורך ביולוגי. רוב הנשים בוגדות בזמן הביץ, הזמן שבו הן יכולות להיכנס להיריון. כאשר אישה מקיימת יחסי מין עם שני גברים, הזרע החזק והטוב יותר מנצח. יש נשים שבוגדות בגלל אכזבה מהשגרה, חסך רגשי בקשר הזוגי, חוסר אהבה. יש גם נשים שבוגדות בלי סיבה מיוחדת. יש נשים שבוגדות בבן הזוג מתוך כעס, נקמה

ורצון לזעזע אותו ואת הקשר איתו. נשים בוגדות גם כשאין להן פנאי ואין להן אינטימיות.

אפקט קולידג'

אפקט קולידג' הוא מונח המתאר דפוס תגובה מינית וקובע שסקס עם נקבה חדשה בכל פעם מגביר את האון המיני של הזכר. אפקט קולידג' קרוי על שמו של נשיא ארה"ב. בשנת 1927 סיירו הנשיא קלווין קולידג' ואשתו גרייס בחוות בקר ממשלתית. השניים סיירו במסלולים נפרדים, והחוואי הראה לאשת הנשיא פר הרבעה משובח ואמר לה שהפר מסוגל להזדווג עשר פעמים ביום. "תגיד את זה בבקשה לבעלי כשהוא יגיע לפה," ביקשה אשת הנשיא מהחוואי. כאשר בא הנשיא לאותו מקום שמע גם הוא מהחוואי על ביצועיו של הפר. שאל הנשיא את החוואי: כל פעם עם אותה פרה? ענה החוואי: "לא, כל פעם עם פרה אחרת." "אז תגיד את זה לאשתי," ביקש הנשיא.

לספר או לא לספר

איננו יודעים מהי התשובה הנכונה. יש אומרים שכאשר בן הזוג לא כל כך פגיע, חשיפה של סטוץ יכולה לשמש מנוף לצמיחה מחודשת של קשר מעורער. גילוי הבגידה יכול ליצור קרבה הדדית, להכניס תשוקה חדשה אל תוך הקשר ולחיי המין. החשיפה יכולה להיות נקודת מפנה שמחייבת את שני בני הזוג להשתנות, לצמוח ולהשקיע בקשר יותר משאבים רגשיים. לא פחות חשובה העובדה שהחשיפה יכולה להביא את הנבגד לשאול את עצמו מה תרומתו, אם בכלל, לכך שהצד השני בחר ברומן חיצוני.

התשובה לשאלה אם לספר או לא לספר תלויה בטיב הקשר, מורכבותו, עומקו, תוצריו ועולם ומלואו המרכיב ומחבר בין בני הזוג. כל אחד יחליט לעצמו.

יעקב יוצא עם מירי חודש וחצי. מירי סיפרה לו שהייתה לפניו עם שנים-עשר גברים. הוא היה רק עם שלוש נשים לפניו. זה לא יוצא לו מהראש, והוא אפילו חושב לנתק את הקשר. הוא לא מפסיק לעשות השוואות בינו לבין האחרים, אך לא סיפר לה איך הוא מרגיש. הוא מקנא בגברים שהוא לא מכיר. לא יכול להפסיק לחשוב על העבר שלה ומרגיש נבגד.

ליעקב, אין דרך להוציא לך מהראש את עברה של מירי. כדי להילחם במחשבות על העבר, מומלץ שתחשוב על ההווה ועל העתיד. טבעי ונורמלי לקנא במשהו שאתה לא מכיר, אך בין קנאה זו לניתוק הקשר עוד ארוכה הדרך. ייתכן שמירי הייתה עם שנים-עשר גברים מתוך חוסר ביטחון וקושי לשים גבולות או דווקא מתוך פתיחות וניסיון חיים. אולי היא סיפרה לך את זה כי רצתה להרשים אותך, אולי מתוך יושרה ואמינות. אולי היו לה הרפתקאות שנבעו מסקרנות גרידא. אולי חוותה מספיק גברים ולא תרצה עוד גברים, ואולי אתה שהיית רק עם שלוש נשים תרצה בהמשך הקשר עם מירי עוד נשים. אין בהתנהגותה המינית של מירי כדי להעיד על אופייה או על נטיותיה. נסה ליהנות מניסיונה ולהיטיב את מינותכם. אם תתמיד ותשקיע בקשר, המחשבות ידעכו והקשר יפרח.

יואב: ידעתי שזה הסוף רק כאשר אשתי היקרה, זו שחייתי איתה עשרים שנה, באה ואמרה לי: "זהו, נגמר לי." עד אז אפילו לא הבנתי שאשתי עזבה אותי בראשה עוד הרבה לפני. היא התבשלה במבון הרגשי, ורק לאחר חודשיים של רומן סוער החליטה להכריז שהיא רוצה להתגרש.

יובל: רומן מחוץ לקשר בשביל גברים זה אומר סוף, לא בהכרח בשביל נשים. נשים נשארות בקשר גם אם הן נבגדות. אני הרגשתי שהקשר מסתיים כשהפסקנו יחסי מין, לא יצאנו לבלות יחד, ולא היו לנו נושאי שיחה משותפים. ניסינו לשקם, היינו בתהליך טיפולי שבו כל אחד מאיתנו חשף את פצעי הילדות שלו והבין מה הביא אל תוך הקשר שחיבל בו. נתנו לנו מטלות ומשימות, אך בסופו של תהליך עם כל

התובנות הגענו למסקנה שזה נגמר. הבנת הדרך אינה מעידה בהכרח על צעידה בדרך משותפת, ולכן נפרדנו.

עירית: בלי מין זה לא עובד, אלא אם כן יש ביניהם הסכמה על מערכת יחסים פתוחה. אם המין רע, חבל על הזמן. אז בואו נגמור את זה יפה ונסגור עניין.

קשר סודי

מחקר חדש גורס שקשר רומנטי סודי משפיע לרעה על המצב הבריאותי והנפשי של בני הזוג המעורבים. בניסויי "פלירטוטים" התבקשו המשתתפים ליצור מגע פיזי ברגליים מתחת לשולחן, מקצתם בחשאי ואחרים בגלוי. התוצאות הראו כי אלה שעשו זאת בחשאי חשו התרגשות רומנטית חזקה יותר מאלה שעשו זאת בגלוי. במחקר בארה"ב השתתפו מעל 360 גברים ונשים בני 18–57 שנמצאו בקשר רומנטי סודי כשנתיים בממוצע. המשתתפים דירגו את הסכמתם או אי-הסכמתם לגבי כוונתם להמשיך קשר סודי. נבדקה ההערכה העצמית של כל אחד מהם ותואר מצבו הבריאותי-נפשי על פי רשימה של תסמינים אפשריים (כאבי ראש, בחילות, חוסר תיאבון, דפיקות לב, תחושת בדידות). נמצא כי קשר רומנטי סודי גורם לרמה נמוכה יותר של מחויבות ולתחושה מופחתת של חיבור בין בני הזוג לעומת קשר רומנטי גלוי. עוד נמצא כי סודיות רומנטית גורמת למצב בריאותי ונפשי פחות טוב לעומת קשר רומנטי גלוי. אנשים הנמצאים בקשר סודי סובלים לעיתים קרובות יותר מכאבי ראש, כאבי בטן ותסמינים גופניים אחרים. מסקנת החוקרים הייתה כי שמירה על סודיות של קשר רומנטי מלווה במגוון בעיות ומכשולים, אשר גורמים נזק לקשר ומשפיעים לרעה על מצבו הבריאותי והנפשי של כל אחד מבני הזוג.

ביסקסואליות (דו-מיניות)



ביוון העתיקה לא הייתה הפרדה בין הטרוסקסואלים להומוסקסואלים. לפעמים עודדו גברים צעירים להיכנס למערכות יחסים עם גברים מבוגרים כדי לרכוש ניסיון וחוכמה. כמה מהגיבורים המפורסמים ביותר של יוון היו דו-מיניים.

ביסקסואליות הייתה חלק מהחברה היפנית העתיקה ונפוצה בקרב סמוראים. נערים צעירים הוכשרו אצל סמוראים מבוגרים להיות מאהבים. ביפן העתיקה היו שלושה מינים: אישה, גבר, גבר צעיר נאה. יחסי מין עם נשים וגברים צעירים היו מקובלים. ביסקסואליות הייתה מקובלת יותר מהומוסקסואליות.

הומוסקסואליות הייתה נפוצה במנזרים בודהיסטים. אנשי דת מבוגרים קיימו יחסים עם עוזרים צעירים. בקרב האינדיאנים יש תפישה ביסקסואלית של "שתי רוח" (two-spirit). מנהיגים בעלי תפקידים גבריים ונשיים בחברה זוכים לכבוד רב.

את המונח ביסקסואליות טבע צ'ארלס גילברט בשנת 1892. באנגליה היה חוק נגד מה שנקרא "מעשה סדום". מעשים הומוסקסואליים בהסכמה לא היו מחוץ לחוק בשנים 1861–1967.

אמריקה לא הייתה גן עדן לביסקסואלים. בשנת 1779 ביקש תומס ג'פרסון לנסח חוק שאיים בסירוס גברים הנמשכים לנשים וגם לגברים ונאשמים במעשה סדום. ביסקסואליות נתפשה כהפרעה נפשית, והטיפול היה סירוס, טיפול בהלם חשמלי, היפנוזה, מתן תרופות. תעשייה שלמה שגשגה סביב הנושא הזה.

בשנת 1920 הגה זיגמונד פרויד את הרעיון של ביסקסואליות מולדת. ההבנה הראשונה של ביסקסואליות כחלק מספקטרום של נטייה מינית אנושית באה מאלפרד קינסי. הדוחות של קינסי היו פריצת דרך. הם התבססו על אלפי ראיונות שנערכו בשנים 1947 ו-1953. קינסי תיאר התנהגות מינית אנושית כספקטרום שיש בו שישה רכיבים: החל בהטרוסקסואליות מלאה וכלה בהומוסקסואליות מלאה.

ב-1976 נוסד המרכז הדו-מיני בסן פרנסיסקו, והיו בו כוכבות קולנוע ביסקסואליות רבות.

בארץ נמצא כי ל-30% מהאוכלוסייה יש משיכה לביסקסואליות. הנושא המרכזי שבא לידי ביטוי באירועי יום הגאווה בשנת 2017 היה הביסקסואליות, ועלה הקושי של הביסקסואלים לקבל מענה רפואי ופסיכולוגי מהשירות הציבורי בלי להירתע מחשיפת העדפתם המינית.

אדריאן, נשוי בן 34, אוהב את אשתו ואת חיי המין איתה ומודאג ממשיכתו לגברים, שעליה לא ידע לפני נישואיו.

לאדריאן, כנראה יש בך ביסקסואליות. אתה אינך סולד ממגע עם אישה או גבר. אתה נהנה ממיצוי ומביטוי מיניותך עם שני המינים. אין מחלה, סטייה או כל פסול במשיכה לגברים ולנשים. החברה שבה אנו חיים מכתובה לנו לחיות עם בן זוג אחד או בת זוג אחת. אתה תבחר עם מי לקיים יחסי מין כל עוד אינך פוגע או נפגע.



גיל המעבר



הפסקת המחזור החודשי

גיל המעבר אצל נשים, הנקרא גם מנופאוזה או גיל הבלות, הוא התקופה בחיי האישה שבה נפסק המחזור החודשי. בגיל המעבר יש ירידה בהורמונים הנשיים, שינויים במחזור הווסת, גלי חום ועוד שינויים גופניים ונפשיים. יש נשים שחשות עייפות, עצבנות, מתח ודיכאון, וכל אלה משפיעים על התפקוד המיני. טיפול מתאים משפר את איכות החיים, את העניין במיניות ואת ההנאה והאורגזמה. בגיל זה עלולים להיות גם קשיים בתפקוד של בן הזוג.

הפסקת המחזור החודשי היא תהליך של שלושה שלבים: פרה-מנופאוזה – בשלב המקדים הביוץ לא תקין, ולכן המחזור לא סדיר. חלה ירידה הדרגתית בכמות האסטרוגן שהשחלות מייצרות ובה בעת ירידה בייצור ההורמון פרוגסטרון. שלב זה מאופיין בגלי חום ועוד תופעות לוואי.

מנופאוזה – לאישה אין וסת במשך שישה חודשים רצופים או יותר. השחלות מפסיקות לתפקד באופן תקין, והאישה כבר לא יכולה להיכנס להיריון.

השלב המשלים – נפסקות תופעות הלוואי של הפסקת המחזור ומסתיימים גלי החום.

גיל מעבר טבעי, בטרם עת ומלאכותי

גיל מעבר טבעי מופיע בהדרגה בגיל 45–55 ונמשך עד שלוש שנים. בתקופה זו הווסת עלולה להיעלם ואחר כך לחזור ארוכה עם דימום חזק או קצרה עם דימום חלש ודלוח. יש נשים שתהליך זה יהיה אצלן קצר מאוד. יש נשים שהתהליך אצלן יהיה הדרגתי ומלווה בתופעות של גלי חום, עייפות, קשיים בריכוז, עצבנות, קשיים בשינה, בריחת סידן. אישה שעוברת גיל מעבר טבעי ייתכן שתזדקק לטיפול הורמונלי חלופי כלשהו – לפי מצבה הגופני ובריאותה הכללית.

גיל מעבר בטרם עת מופיע אצל אחת ממאה נשים בגיל 30–40. הוא עלול להופיע כתוצאה מפגיעה בשחלות, ניתוח, טיפול כימותרפי, הקרנות ושימוש בתרופות, למשל תרופות להצטמקות שרירן ברחם. זה יכול להיות על רקע מחלה אוטו-אימונית, מתח, חרדה וגם פעילות גופנית מופרזת. הוא נמשך שנה עד שלוש שנים. יש סבירות גבוהה שהאישה תזדקק לטיפול הורמונלי חלופי כחלק מתהליך ההסתגלות לשינוי בחיים.

גיל מעבר מלאכותי עלול להופיע עקב פגיעה בשחלות, ניתוח, טיפול כימותרפי, הקרנות ושימוש בתרופות המזרזות את הופעת גיל המעבר, למשל תרופות להתכווצות שרירן ברחם. בארה"ב מעריכים כי לאחת מכל ארבע נשים יהיה גיל מעבר מלאכותי. הסימפטומים עלולים להיות חזקים ומפריעים. ברוב המקרים בגיל מעבר כזה ניתן טיפול הורמונלי חלופי.

הטיפול

על פי מחקר וסקר של ארגון הבריאות העולמי, 47% מהנשים נתקלות בקשיים מיניים וירידה בתשוקה המינית בגיל המעבר. חשובה תקשורת זוגית של פתיחות, הבנה וקבלה הדדית. אפשר לפתח יחסי מין חלופיים המתאימים לקושי. חשוב לשמור על הרגלי חיים בריאים: דיאטה מתאימה, פעילות פיזית קבועה, חוויות זוגיות משותפות. מוצע טיפול הורמונלי חלופי, ויש גם תרופות, משחות ותכשירים העוזרים לסיכוך ושימון איברי המין.

מחקר עדכני מצא כי טיפול טרנסדרמלי באסטרדיל וגם טיפולים אחרים עשויים לשפר תפקוד מיני בנשים פוסט־מנופאוזליות עם תפקוד מיני נמוך. מחקרים מלמדים שהמנבא למיניות טובה ולשיפור המצוקות בגיל המעבר הוא טיב הקשר בין בני הזוג. קשר טוב יביא לזוגיות ומיניות טובה גם בגיל הזהב. ה־FDA האמריקני אישר תרופה לחשק מיני לנשים לא רק בגיל המעבר.

בני וזהבה נשואים 23 שנים, והם בני 56. חיי המין שלהם היו בסדר גמור עד לאחרונה, כשזהבה החלה לטעון שהחדירה מכאיבה לה. רופא הנשים שלה אמר שהפתרון הוא הורמונים, אבל היא מסרבת, בטענה שיש לזה תופעות לוואי. בני שואל מה לעשות.

לבני, סביר להניח שההורמונים שהציע רופא הנשים לא מיועדים רק למנוע את הכאב ביחסי מין אלא לעוד תופעות של גיל המעבר. התחושה המלווה את גיל המעבר היא שאין שליטה על הגוף. חלה עלייה במשקל, פיזור השומן משתנה, יש הפרעות במתן שתן, יובש נרתיקי, כאבים ביחסי המין, ירידה בחשק המיני, בהתעוררות המינית וביכולת האורגזמית. לא רק ההורמונים משפיעים על התגובה המינית של האישה בתקופת גיל המעבר, אלא גם כעס ותסכול בקשר הזוגי. מומלץ שתשתמשו בג'ל סיכה על בסיס מים כדי להקל את רמת הסיכון של הנרתיק ובכך להפחית את הכאב בחדירה. את הג'ל מורחים בפתח הנרתיק ועל איבר המין לפני יחסי המין. אפשר להשתמש גם בהורמונים עם ספיגה מקומית, ובכך למנוע את החשש מפגיעה של הורמונים סיסטמיים.

ירדנה בת 61, נשואה ואם לבוגרים. לפני שבע שנים עברה כריתת רחם ובעקבותיה דעך היצר המיני שלה לגמרי. גיל המעבר נחת עליה באופן פתאומי לאחר הכריתה. זה היה משולב בדיכאון נפשי ובהרגשה של תום הנשיות. כיוון שבן הזוג עבד רוב השנים בחו"ל, לא נוצר עליה לחץ מיוחד לקיים יחסי מין. עתה שניהם לפני פרישה מהעבודה, ויש לה כמיהה לשוב להרגיש אישה. היא לא רוצה לקבל תרופות של אסטרון.

ירדנה שואלת אם מדבקת טסטוסטרון או השתלת חומר טסטוסטרוני מתחת לעור תעזור לה לחוש שוב נשיות ותשוקה מינית?

לירדנה, חשוב לוודא שהירידה בחשק המיני שלך אינה קשורה ביובש בנרתיק, אינה נגרמת בעקבות מערכת יחסים בלתי תקינה עם בן זוגך או מתוך דיכאון. אם אומנם הדבר נובע משינויים הורמונליים בעקבות ההתערבות הכירורגית שעברת, אזי הניסיון מראה שטיפול בהורמון המין הזכרי טסטוסטרון עשוי לפתור את הבעיה, לפחות ברובה. חשוב שתבררי עם עצמך או עם בעל מקצוע אם יש לך רכיב של בעיות עם המיניות שלך, אם יש קושי בדימוי הגוף שלך או אי-שביעות רצון כללית שלך מעצמך. אם אומנם יש לך קושי אישי, אזי נוסף על טיפול בטסטוסטרון יש מקום לתת את הדעת גם לכל אלה. פני לרופא מומחה לגיל המעבר ודוני איתו באופציות הטיפוליות אשר יוכלו לעזור לך להחזיר את נשיותך למקומה.

גיל המעבר בגברים

עם העלייה בגיל אנשים סובלים ממחלות כמו סוכרת, מחלות כלי דם ומחלות לב. המחלות האלה פוגעות במנגנוני התפקוד המיני גם אצל גברים וגם אצל נשים. אצל גברים אפשר לראות פגיעה בזקפה, בעיות בשפיכה וירידה בחשק המיני.

עד לפני שנים לא רבות כמעט לא זכתה התופעה להכרה ציבורית או רפואית, ועדיין היא נחקרת. אצל גברים יש בעיה בהגדרת הזמן של גיל המעבר. אין אירוע ספציפי המציין את הגיל הזה, אך נמצא שגברים רבים עוברים תופעות המאפיינות את גיל המעבר בגיל 45–50. בין התופעות: גלי חום, קשיי שינה, ירידה ברמה הקוגניטיבית, ירידה בתפקוד המיני.

לא ברור לחלוטין מה מקור התופעות. מחקרים מלמדים שמדובר בירידה ברמת הטסטוסטרון, ולכן מכנים תקופה זו בשם 'אנדרופאזה'. כמובן, התפקוד המיני בגיל הזה קשור לא רק במחלות ולא רק בטסטוסטרון, אלא גם בשינויים פיזיולוגיים והורמונליים.

ככל שגיל הגבר עולה זמן ההגעה לאורגזמה הולך וגדל, והוא צריך

לפעמים הפסקה של יום שלם בין אורגזמה
לאורגזמה. בכל עשור יש ירידה
בחשק המיני ויש רפיון
כלשהו בזקפה. בגיל מבוגר
עושים התאמה למצב הפיזי, ואפשר
להתמקד באינטימיות בבילוי משותף,
ליטוף, מגע ועיסוי.
כאשר יש לגבר בעיה פיזיולוגית,
הרפואה נותנת מענה בכדורים,
במשחות, במכשירי ואקום ובזריקות כדי
לעזור לו בתפקוד בכלל ובתפקוד
המיני בפרט. חשובה מאוד
הפתיחות בין בני הזוג.



אלדד, בן 64, מקיים יחסי מין

טובים עם זוגתו. היא מעוניינת

בכמה פעמים זו אחר זו, והוא לא מסוגל ליותר מפעם אחת. אלדד
שואל אם זה טבעי ומה לעשות.

לאלדד, ידוע שהיכולת המינית של האישה עולה על זו של הגבר.
ככל שהגבר מתבגר נדרש לו יותר זמן בין זקפה לזקפה. משך ההמתנה
בין פעם לפעם שונה מגבר לגבר וגם משתנה אצל אותו גבר. יש כמה
דברים שאפשר לעשות כדי שלא להשאיר את אשתך בלתי מסופקת:
אפשר להשתמש באצבעות, אפשר להשתמש בצעצועי מין, אפשר
ליטול כדור לזקפה – ויאגרה, סיאליס או לויטרה או תרים. הכדור
יכול לקצר את הזמן בין זקפה לזקפה. ואפשר לקיים יחסי מין מהנים
גם בלי חדירה.

גיל שלישי



תחושת אושר

תהליך ההזדקנות פוגע בפעילויות הפיזיולוגיות של המערכות בגוף, אבל הפעילות המינית משפיעה על הרגשת הבריאות הכללית של האדם והיא חלק מזהותו בכל גיל. מיניות ופעילות מינית נחשבות נחלתם של צעירים, ושילוב המושגים מיניות וזקנה מעורר לעיתים גיחוך ותמיהה. לעיתים קרובות מתייחסים אל הפעילות המינית בזקנה כאל פעילות חריגה, וכך מציגים את הקשישים באור שלילי.

מחקרים מלמדים שאנשים החיים בזוגיות טובה לאורך שנים יזכו לתוחלת חיים ארוכה יותר מזו של אחרים. גם בריאותם תהיה טובה יותר, וחויית האושר הסובייקטיבי שלהם תהיה גבוהה יותר.

חשוב להבין מה גורם לאנשים תחושת אושר בשלב המאוחר של חייהם. מחקרים מראים כי המצב הבריאותי והתפקוד החברתי משפיעים על מידת האושר. גם לקשרים חברתיים יש השפעה על המצב הבריאותי והנפשי.

במחקר בארה"ב השתתפו 47 זוגות נשואים בני 80 ומעלה שחיו יחד יותר מ-40 שנה בממוצע. כל הזוגות השתייכו למעמד סוציו-אקונומי בינוני ומעלה, כלומר לא היו להם דאגות קיומיות שעלולות להשפיע על המצב הנפשי. נאספו נתונים על אודות מצבם הבריאותי, והזוגות מילאו שאלון כדי לקבוע את מידת הסיפוק שלהם מחיי הנישואים. לאחר מכן עבר כל משתתף בנפרד ריאיון טלפוני יומי במשך שמונה ימים. כדי להעריך את

התפקוד החברתי התמקדו החוקרים בזמן שמבלה כל אחד עם אנשים אחרים ובסיפוק מחיי הנישואים.

השערות החוקרים היו: כאבים או מגבלות פיזיות משפיעים על מידת האושר; הזמן שמבלים בחברת אנשים אחרים מביא לידי תחושת אושר מוגברת; מי שנשוי באושר שם לב פחות למצבו הבריאותי המציק לו וחש מאושר יותר; הזמן הרב שמבלים עם אחרים מגביר את תחושת האושר גם כאשר המצב הבריאותי ירוד.

התברר שהמשתתפים בילו יותר מ-70% מהזמן שבו הם היו ערים בחברת אחרים, ויותר מ-50% בחברת בני הזוג. בממוצע דיווחו כולם על בילוי של יותר משמונה שעות ביום בחברת בן או בת הזוג. ניתוח הנתונים הראה כי חיי נישואים טובים ומספקים משפיעים בצורה מובהקת על תפישת המצב הבריאותי, וכתוצאה מכך גם על מידת האושר. מי שנשוי באושר שם לב פחות לתנודות היומיות של כאבים או מגבלות פיזיות, שהם חלק מחיי היום-יום של רבים מבני השמונים פלוס. עוד התברר כי חיי חברה ערים עם אחרים נוסף על בני הזוג לא משפיעים הרבה על תפישת המצב הבריאותי ועל מידת האושר. אצל זוגות שלא חיו יחד בהרמוניה מצב הכאבים והמגבלות הפיזיות היומי השפיע באופן ניכר על תחושת האושר.

יחסי מין פעילים

מיניות בגיל השלישי זוכה לתשומת לב עם התארכות תוחלת החיים ומאז הופעת הגלולות להשגת זקפה ולשימורה.

מחקרים בארה"ב העלו כי גברים נוטים לקיים חיי מין פעילים יותר מנשים, והבדל זה היה בולט במיוחד בקבוצת הגיל 75–85. בגיל זה 40% מהגברים עדיין פעילים מבחינה מינית, לעומת 17% מהנשים. החוקרים הגיעו למסקנה כי הערכת תוחלת חיי המין הפעילים היא אמצעי להארכת תוחלת החיים ויכולה לשמש גורם צפי של בריאות הציבור. החוקרים הגיעו למסקנה כי המבוגרים בארה"ב יכולים לצפות לשנים רבות של פעילות מינית.

על פי הערכת התנהגות הציבור בתחום הפעילות המינית בשנים המאוחרות בחיים אפשר לתכנן את המשאבים הדרושים לבריאות הציבור, במה כדאי להתמחות ובאילו שירותי בריאות להשקיע.

סקר העלה כי 90% מהגברים בישראל ו-70% מהנשים בני 60–80 קיימו יחסי מין בשנה שקדמה לסקר. 62% מהנשים ו-86% מהגברים העידו שחיי המין חשובים להם עד חשובים מאוד לשימור הזוגיות בגיל הזהב. 33% מהגברים ו-5% מהנשים קיימו יחסי מין בתדירות של פעמיים בשבוע ויותר. כאשר מדובר ביחסי מין פעם אחת בשבוע השיעור הוא 51% מהנשים ו-21% מהגברים. אצל 25% התדירות היא 1–3 פעמים בחודש. גם נשים שאינן פעילות מינית מרוצות מחיי המין שלהן. עוררות מינית והגעה לאורגזמה נמשכות למרות הירידה בחשק המיני.

במחקר שהשתתפו בו נשים בנות 67 בממוצע כמחצית הנשים שיש להן בן זוג דיווחו על פעילות מינית בארבעת השבועות שקדמו לריאיון. רוב הנשים הפעילות מינית הגיעו לאורגזמה תמיד או ברוב הפעמים. 40% טענו כי אינן חשות חשק מיני אף פעם או כמעט אף פעם. שליש מהנשים הפעילות מינית סיפרו על חשק מיני נמוך.

61% מהמשתתפות – עם או בלי בן זוג – הביעו סיפוק מחיי המין שלהן. כמחצית מהנשים מעל גיל 80 דיווחו על סיפוק מיני. המשתתפות המבוגרות ביותר היו המסופקות ביותר. נשים שאינן פעילות מינית נשאלו לגבי רמת הסיפוק שלהן מבחינה מינית, ואלה שדיווחו על סיפוק מיני השיגו אותו ככל הנראה בנגיעה או בצורות אחרות של הבעת אינטימיות.

בשנים האחרונות התרבו העזרים הרפואיים המאפשרים לגברים ונשים לשמור על פעילות מינית טובה ומהנה. עם זאת הגורם העיקרי בשימור החשק והרצון לקיום יחסי מין בגיל הזהב הוא איכות הקשר הזוגי.

צבי, בן 66, סובל מבעיות זקפה. קשה לו לדבר עם הרופא שלו על הבעיות בתפקוד המיני שלו. שום רופא שאצלו הוא מטופל בשל מחלות אחרות – סוכרת ויתר לחץ דם – לא שואל ולא מדבר איתו על השפעת המחלות על תפקודו המיני, וצבי שואל מה לעשות.

לצבי, לרפואה המודרנית יש כיום מענה למצוקתם של גברים רבים בתחום התפקוד המיני. רוב הגברים שמבקרים אצל רופא אינם נשאלים על תפקודם המיני. גם לרופאים יש קושי לדבר על התחום המיני. הרופא לא שואל ולא מדבר בגלל חוסר זמן וגם משום שהוא לא רוצה להיתפש כחטטן וסקרן. ואולי גם לו יש עכבות בתחום. המטופל לא מפתח את הנושא כי הוא חושב שהבעיה המינית היא חלק טבעי מהמחלה ואין מה לעשות. ייתכן שהוא מתבייש וחושב שהבעיה לא רפואית או מצפה שהרופא ישאל. מומלץ שתפנה לרופא המטפל ותבקש אבחון וטיפול מתאים למגבלותיך ולצרכיך. אל תתבייש, ותקבל מענה.

הקן המתרוקן

את הזמן ביחד וגם לחוד צריך לבנות כל השנים, ולא לחשוב שכאשר הילדים יעזבו את הבית, הכול יסתדר מעצמו. חשוב להתמקד בפנאי ולמצוא תחביב משותף. כאשר הילדים גדלים ועוזבים את הבית ייתכן שיפרצו קונפליקטים שהיו קיימים קודם לכן בזוגיות ובני הזוג לא נתנו עליהם את הדעת. החיים בלי הילדים מעלים הבדלים על פני השטח ויוצרים חיכוכים. נשים רבות



רוצות לצאת החוצה מהבית ולהגשים את עצמן. זוגות מתקשים למצוא עניין משותף. לפעמים זה מביא לגירוש.

כשהקן מתרוקן בני הזוג כבר בגיל מתקדם למדי, וצריך לתת את הדעת על שינויים פיזיולוגיים – גם מבחינת חיי היום-יום וגם מבחינה מינית. אצל הגבר יהיו בעיות של זקפה ושפיכה. אצל נשים יהיו שינויים הורמונליים ייתכן כאב במגע המיני עקב ירידה בסיכוך הנרתיק וירידה בחשק.

אם הזוג יודע לחשוב ביחד, למצוא עיסוק לשעות הפנאי ביחד, להיכנס חזרה לתחומי עניין שהיו קיימים בעבר – למשל לימודים, תחביבים – זה יעבור טוב יותר. אפשר אפילו לחוות פריחה מחודשת ולגלות מחדש את הזוגיות.

בשנים האחרונות הילדים נשארים בבית כשהם כבר גדולים, ואז מדובר על תסמונת הקן המזדקן. גם אז יש חשיבות גדולה לזוגיות ולתקשורת, להשקפת העולם בקשר לילדים וליחס אליהם.

עם העלייה בתוחלת החיים והתפתחות הרפואה גוברים הקונפליקטים והקשיים בגיל המבוגר. אבל הגירוש לא רבים, וגם אם הילדים עזבו את הבית – ההרגל, הזוגיות והתלות ההדדית הרבה פעמים משאירים את בני הזוג ביחד, בייחוד אם הזוגיות הייתה טובה.

גירושים



הסיבות והרקע

אחד משלושה זוגות בארץ מתגרש. ואלה הסיבות לגירושים:

- 46% – בגידת אחד מבני הזוג.
- 13% – בעיות בתפקוד המיני.
- 12% – מחלוקות בענייני כספים ורכוש.
- 11% – קשיים עם המשפחה המורחבת.
- 10% – מחלוקות לגבי חינוך הילדים.
- 6% – קריירה שפגעה במערכת היחסים.
- 2% – סיבות אחרות.

בכל זוגיות בני הזוג עוברים את השלבים האלה: ירח הדבש – שבו כל אחד מהשניים מקריב ומוותר כדי לבנות את הקשר; שלב מאבקי הכוח – שבו כל אחד מבני הזוג מנסה להשליט את דעותיו ואת הנורמות שלו על האחר; שלב ההכרה – שבו מכירים בשוני של בן הזוג; שלב ההשלמה – שבו בני הזוג משלימים עם השוני ביניהם ולומדים לחיות יחד ולקבל זה את זה. זוגות שהתבצרו בשלב מאבקי הכוח יישארו תקועים בזוגיות שלהם כל החיים, ואם לא ישכילו להבחין בשוני ולקבל אותו, תתפרק החבילה או יימשכו המאבקים לאורך שנים.

לפעמים הפרידה לא קשורה לבן הזוג אלא טמונה בפסיכולוגיה האישית של הפרט. לפעמים מגלים שאדם שנמשכנו אליו בתחילת הקשר דוחה

אותנו לאחר פרק זמן, ולפעמים אנשים שאנו לא נמשכים אליהם מתגלים כמושכים עד מאוד לאחר היכרות נוספת. לעיתים תכונה שנמשכים אליה בתחילת הקשר היא התכונה המרחיקה בהמשך הקשר. לכל אדם יש מניעים משלו לסיים קשר ויש לו הסבר הגיוני או לא הגיוני.

עלית שיעור הגירושים נובעת מכך שאנשים פחות מחויבים לקשר הזוגי ופחות משקיעים בו. תפישת הזוגיות נעשתה נזילה – "מקסימום נתגרש". שיעור הגירושים עולה בגלל השינוי בנורמות ובערכים החברתיים. החברה הישגית ומטפחת אינדיווידואליזם. קשה לאנשים להתפשר ולעמוד בקשיים שהמערכת הזוגית מציבה. שלא כבעבר, עוד ועוד נשים יוזמות פרידה וגירושים.

כשמתחתנים חושבים לחיות באושר לנצח. עדיין לא מבינים שזוגיות היא עבודה לכל החיים, ויש בה הרבה פשרה וויתורים. לפעמים השגרה שוחקת. לעיתים קרובות יש תחושה של בדידות, כל אחד מרגיש שהוא עובד על המערכת לבדו ואין עם מי לדבר. זוגות מגיעים למצב שהם לא יכולים יחד ולא יכולים לבד, נעים בין תקווה לייאוש, בין כעס לחמלה, בין אהבה לשנאה. לא יודעים אם להישאר או ללכת. ונשארים כדי לא לפגוע בילדים, מסיבות כלכליות ובגלל הפחד להישאר לבד.

המשבר

החינוך המערבי להישגיות, לתחרותיות ולאינדיווידואליות פותח פתח למשברים בחיי הנישואים, בייחוד בנקודות של שינוי לאורך החיים. משברים יכולים להתרחש כשהקן משנה את תכולתו – גם כשנולד תינוק חדש וגם כשאחרון הילדים עוזב את הבית.

כבר מהשנה הראשונה לנישואים מתנפצות פנטזיות רבות, אנשים שאינם די בוגרים ומגובשים ברגשותיהם לא יוכלו להתמודד עם התנפצות הפנטזיות. מתברר כי בן הזוג הוא לא בדיוק מי שחשבו שהוא. כשנולדים ילדים והזוג הופך למשפחה, למערכת הזוגית נכנסים מתח ועייפות. יש קשיים בתקשורת וויכוחים בשאלת חינוך הילדים ובנושאים שוליים. ויש גם משבר אמצע החיים. כשהילדים כבר גדולים יותר חלה שחיקה

בחיי הנישואים. בני הזוג הזניחו את ההפריה ההדדית. נמאס להם זה מזה. קורה שהכול מתפוצץ כרעם ביום בהיר על רקע רומן של אחד מהם. ואם לא מטפלים בזוגיות, החבילה עלולה להתפרק. לאו דווקא גירושים אלא התפרקות רגשית מרחיקה.

הסיבות הכלליות לגירושים תלויות כסף, חינוך ילדים, סקס, חלוקת התפקידים בבית, בילוי פנאי ביחד ולחוד. למשל: "אשתי לא יכולה לספק את כל הצרכים שלי, אני יוצא עם החברה." יש זוגות שלא מאפשרים פנאי לכל אחד מהם לחוד. יש בעיות של יחס למשפחות המוצא. למשל, "אני אומר לחמותי בכל פעם שהיא מתקשרת שהיא מפריעה." יש ויכוחים על אמונה, דת ופוליטיקה.

יש גם סיבות אישיות, חוסר אמון ותחושה של אובדן הזהות העצמית בתוך הקשר, חוסר שביעות רצון, חוסר הבנה וחוסר תקשורת. מעגל קסמים אכזרי של חוסר הסכמה והבנה נותן לבן הזוג להרגיש שהוא לא מספק או לא מספיק טוב. משברי חוסר אמון.

הפתרונות רבים ומגוונים. חשובה המודעות שבן הזוג שלנו שונה מאיתנו וחשובה גישה של חיה ותן לחיות.

טיפול זוגי עוזר לבני הזוג להכיר זה את זה טוב יותר, להבין ולרכוש מיומנות תקשורת. הטיפול עוזר לכל אחד להבין מה הוא מביא ממשפחת המוצא שלו שמחבל ביחסים. טיפול זוגי מוודא שגם אם בני הזוג ייפרדו, הם עדיין יוכלו להישאר בקשר. לפעמים הזוג מגיע להבנה עם המטפל, ובכל זאת הקונפליקטים מחמירים. ואם אחד מבני הזוג רוצה ללכת, עדיף לסיים את הקשר ולהיפרד באופן בוגר ומבוקר.

פרידה, אובדן והבראה

הפרידה היא חוויה קשה, אירוע משברי בכל מערכת יחסים. גם בן הזוג היוזם את הפרידה חש כאב ואובדן. הפרידה שוברת את גבולות הביטחון ומשאירה תחושת חלל וריקנות שיש בה סערת רגשות, חוסר ודאות, בדידות, כעס ולעיתים אף רצון לנקום. גם אם אין ילדים בקשר, הפרידה עלולה להשפיע על מצב הרוח ועל תפקודו של הפרט במציאות חדשה.

כל אחד מתמודד עם הפרידה באופן המתאים לאישיותו, בדרכו ובקצב שלו, לפי כוחותיו, לפי התמיכה מהסביבה הקרובה לו, לפעמים בעזרת טיפול פסיכולוגי תומך.

התגובות בחוויית האובדן שבפרידה יכולות להיות דיכאון, בכי, תופעות פסיכוסומטיות, בעיות קיבה, נשימה ואחרות. הן נובעות מהגעגוע והכמיהה לבן הזוג או מאדישות ויציאה מיידית עם בני זוג אחרים כדי להרים את האגו שנופץ.

תהליך ההבראה תלוי במשך הקשר, במה שהיה בו, באופן הפרידה ובמבנה האישיות של הפרודים. אין הבדל בהתאוששות בין נשים לגברים. מחקרים מלמדים שיותר נשים מגברים יקומו ויעזבו כשיש להן רשת ביטחון, כלומר לאן ולמי ללכת.

בתהליך ההבראה יש תסכול ותחושת חלל, אך במרוצת הזמן כאב הפרידה חולף ומפנה מקום לקשר חדש.

דילדו



דילדו היא שיבוש של המילה האיטלקית Diletto, שפירושה עונג. מקובל לכנות בשם זה כל אביזר לא רוטט הדומה לפין בצורתו ובגודלו. יש דילדואים שמולבשים על רצועות הנקשרות למותניים, וכך מאפשרים לדמות משגל. אביזרים רוטטים עם מנוע חשמלי נקראים ויברטור. הדילדואים הראשונים היו עשויים אבן, עץ, עור, שעווה או חרס. דילדואים של עור עם מילוי כותנה נמצאים בשימוש עד היום, אולם החומר המקובל ביותר כיום הוא גומי סיליקוני. חומר זה קל לניקוי ונטול ריח, תכונות חשובות בייצור אביזרי מין. לסיליקון יש גם רעידות והולכה טובה של חום, וזה יתרון בשימוש משולב עם ויברטור. לאחרונה יצאו לשוק דילדואים של פירקס. אפשר לחמם אותם לטמפרטורת הגוף במים חמים ואפשר לחטא אותם בהרתחה.

לציפי, בת 38, יש בעל מקסים, מוכשר ואוהב. אבל כל ניסיון לחזק את הזקפה שלו נכשל. הוא נבדק בידי אורולוג ואנדוקרינולוג, נטל ויאגרה, סיאליס ולוויטרה – וללא הועיל. מדובר כנראה בהפרעה פיזיולוגית נדירה. הוא לא מסכים להשתיל תותב, וציפי שואלת אם אפשר שיחגור דילדו (עם בטרייה), כדי שיוכל לספק אותה.

לציפי, אל לכם לוותר על ההנאה המינית, ואם הבעל מסכים, אין מניעה לשימוש בדילדו. אם אומנם אובחן כלוקה בזקפה באופן המצריך תותב ולא רוצה תותב, זוהי החלטה אמיצה. אם שניכם תוכלו להסתגל לשינוי הדילדואי, אזי תיהנו ממיניות חדשה ומענגת.

דימוי הגוף



חינוך וחברה

הדימוי הגופני הוא פונקצייה של שלושה גורמים: החינוך בבית – מה שראינו ומה שקיבלנו ועד כמה העירום היה טבעי ומקובל בבית; המסרים החברתיים – החברה בימינו מאדירה גוף חטוב; האישיות – יש לא מעט אנשים, גברים ונשים, הסבורים שהם מלאים או שמנים ולא עומדים בסטנדרטים החברתיים.

במחקר בשנות 1990 הביעו מחצית מהנשים רגשות שליליים כלפי גופן וכלפי חלקים בגופן. בסקר של המגזין *Psychology Today* בקרב 4,000 משתתפים נמצא כי 40% מהגברים ו-56% מהנשים שנסקרו הביעו שביעות רצון נמוכה ממראה גופם. במחקרים המערבים שינויים בכימייה של המוח נמצא שאצל נבדקות שצפו בתמונות של נשים כבדות משקל (השמנת יתר) נצפו שינויים כימיים באזור האמיגדלה המקושר לחרדה ובקורטקס הפרה-פרונטלי המקושר לירידה בדימוי העצמי.

אצל גברים דימוי הגוף חשוב פחות בגיל צעיר, והולך ונעשה חשוב במרוצת השנים. אצל נשים – להפך. דימוי הגוף בקרב נודיסטים חיובי יותר מדימוי הגוף של אחרים.

סקס באור או בחושך

יש האוהבים לקיים יחסים באור ויש כאלו האוהבים את המגע בחושך.

הכול תלוי בדימוי הגופני ובטיב הזוגיות. בזוגיות טובה כל אחד ילך עם ההעדפה של האחר למקום, לתנוחה, לאור או לחושך.

יש גברים שאוהבים ונמשכים לבנות זוגן דווקא בחושך. המסתוריות והלבוש הפחות זמין ומזמין מעוררים אצלם את הורמוני המין ורצון להפשיט את האישה.

המחקר מצביע שהעדפת סקס באור או בחושך תלויה בדימוי הגוף של האדם שנכנס למיטה ונחשף בעירום למי שאיתו. סקר העלה ש-60% מהאנשים מעדיפים לקיים יחסים באור כלשהו, 40% מעדיפים את החושך. הדעות בעניין רבות ומגוונות ואינן תלויות מגדר. כל אחד והעדפתו הוא, ועם זאת אנשים שיש להם דימוי גוף לא חיובי יעדיפו את החושך. הינה כמה תגובות:

עומר, בן 23, נהנה כשיש לו אפשרות לראות את בת הזוג שלו, לא רק כדי להעריך את הגוף שלה, אלא גם כדי ליהנות מרגעים של אינטימיות שמגיעים עם קשר עין וכדי לקרוא את תגובותיה.

יעל, בת 25, רוצה לראות את האדם האחר, בייחוד את הפנים שלו, במצב האינטימי. היא חושבת שהרבה יכול לעבור דרך מבט אחד. התקשורת בזמן שהיא מפתה ומשדלת אותו היא מפתח לתענוג אמיתי.

דליה, בת 30, אומרת שאם הוא נראה ביישן, מתקשה להוריד את בגדיו ולהתפשט או מחפש סביב החדר את מתג האור, היא פשוט נותנת לו להוביל ולכבות את האור. היא רוצה שהוא ירגיש נוח, אבל רוצה הכול באור עד שנכנסים למיטה.

רועי, בן 26, סבור שזה במודעות העצמית ובדימוי הגוף. הוא די בטוח במראה שלו, ולכן אוהב שיש אור כלשהו. אם אתה אוהב את הגוף שלך וזה נראה לעין, אז זה עושה את כל המצב יותר סקסי.

הומוסקסואליות



העדפה מינית

השימוש במונח הומוסקסואליות החל בגרמניה בשנת 1870 (הומו = אחד, סקסואל = מיני).

בשנת 1948 ערך קינסי מחקר בנושא ופיתח סולם של 6 דרגות: דרגה 1 היא הטרוסקסואל לחלוטין ודרגה 6 היא הומוסקסואל לחלוטין. בשלב ההתפתחות המינית כמעט לכל אדם יש מחשבות או פנטזיות על בני מינו. נמצא כי 2%-10 מהאוכלוסייה מעדיפים את בני מינם.

המונח הומוסקסואליות כולל גם לסביות – משיכה מינית של אישה כלפי אישה. מקור המונח לסביות בשמו של האי היווני לסבוס, שבו חיה המשוררת סאפפו שכתבה שירי אהבה לנשים.

הומוסקסואליות היא העדפה מינית, ולא כל גבר או אישה שמתנסים בקיום יחסי מין עם בני מינם הם הומוסקסואלים. בגיל ההתבגרות יש ניסיונות חד-מיניים. בבתי כלא אסירים שוכבים זה עם זה. נשים חוות התנסויות עם נשים. כל אלה לא מעידים בהכרח על נטייה. ההעדפה המינית היא הקובעת.

כיום בטלפונים סלולריים יש אפליקציה ובה תשובה חד-משמעית לכאורה הקובעת את העדפתו המינית של האדם מתוך מענה על עשרים שאלות.

מחקר שנערך בארץ בשנת 2009 העלה שרוב הציבור מחזיק בעמדה

חיובית לגבי האוכלוסייה ההומוסקסואלית. (כולל לסביות). ברמה האישית אמרו 62% שיהיה קשה להם עם ילד הומוסקסואל, אך ישתדלו לתמוך ולשמור על הקשר. 32% אמרו שיקבלו את הילד בהבנה ובאהבה ללא תנאי. 13% אמרו שמערכת היחסים עם הילד תיפגע. 3% אמרו שינתקו כל קשר עם הילד. 42% מהנשים אמרו שיקבלו את היציאה מהארון באהבה ובהבנה, לעומת 22% מהגברים.

גלעד שואל אם להיות הומו זאת בחירה או גנטיקה ואם טיפול פסיכולוגי או טיפול כלשהו יכול לשנות את הנטייה המינית.
גלעד, בתחילת הדרך המינית יכול להיות בלבול בהעדפה ובנטייה. אבל מי שהוא הומוסקסואל בגיל ההתבגרות המאוחר יודע שהוא כזה ויישאר כזה. הבלבול בהתחלה מאופיין בהכחשה ובהדחקה, ובסופו של התהליך יש קבלה עצמית.

לא ידוע למה אדם מפתח העדפה לבני מינו. הגורמים העיקריים הם תורשה וסביבה. יש הרואים בכך נטייה ביולוגית גנטית, ויש הסבורים שזוהי נטייה התפתחותית נרכשת.

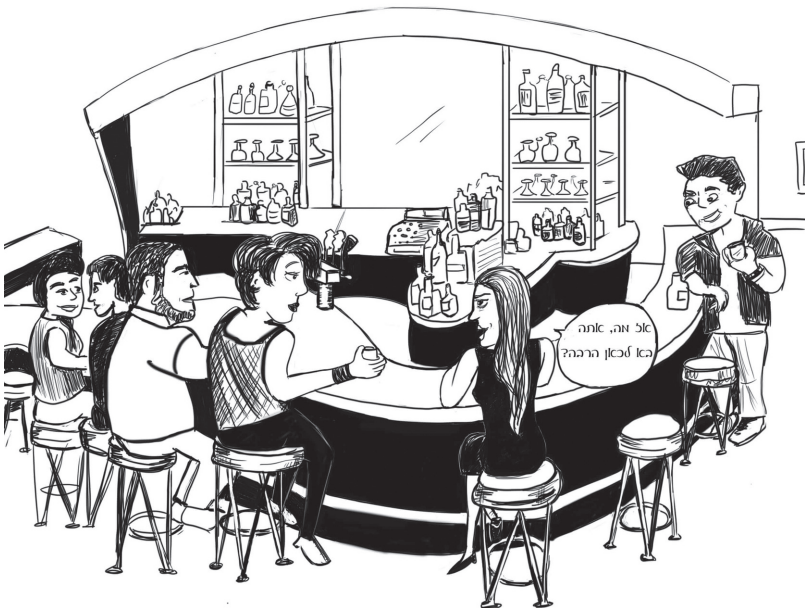
פרויד גרס שהומוסקסואליות היא נטייה התפתחותית נרכשת. גבר יהפוך להומוסקסואל אם אימו הייתה דומיננטית מדי ואביו היה פסיבי. אישה תהפוך לסבית אם אביה היה דומיננטי מדי ואימה הייתה פסיבית. על פי תיאוריית הלמידה החברתית, מי שנחשף בתקופת ההתפתחות המינית שלו להתנהגויות הומוסקסואליות וקיבל חיזוקים חיוביים על כך, יהפוך בבגרותו להומוסקסואל.

מחקר במשפחות שבהן נולדו תאומים שנמסרו לאימוץ וכל אחד גדל בבית אחר העלה שאם אח אחד הומוסקסואל, 85% סיכויים שגם אחיו התאום הוא הומוסקסואל. המחקר מצביע על קיומו האפשרי של גן שאחראי להומוסקסואליות. מחקרים אחרים מצביעים על בלוטת יותרת המוח גדולה אצל גברים הומוסקסואלים וגם רמות טסטוסטרון גבוהות.

נשים המעדיפות גברים הומוסקסואלים

מחקר אמריקני בשנות 1980 מצא ש־20% מנישואי ההומוסקסואלים הם לנשים היודעות טרם החתונה על העדפתם המינית ומקבלות אותה בהבנה. נראה שנשים הנמשכות לקרבת הומוסקסואלים בעצם רוצות קרבה לגבר רגיש ועדין המגיב לצרכים הרגשיים שלהן. משערים שנשים אלו מחפשות את אשר אינן יכולות להשיג, וזהו מעין מאזוכיזם בהיבט של כרוניקה ידועה מראש, שסופה בדחייתה ונטישתה של האישה מצד הגבר ההומוסקסואל.

השערה אחרת היא שנשים בוחרות קרבה עם הומוסקסואלים בגלל פחד וקושי באינטימיות פיזית. החיבור הסימביוטי עם הומוסקסואל מספק את צורכיהן הרגשיים ומגן עליהן ממתח מיני ומיחסי מין. אישה בחברת הומוסקסואל תקבל את מלוא תשומת הלב בלי תחרות ותשלוט באופי מערכת היחסים. הוא ילך איתה, יבדר ויפנק אותה, יהיה נגיש ורגיש בכל עת שתחפוץ. הוא יהיה מאוד נאמן לה, שומר סודה, ובוודאי לא יבגוד בה עם נשים אחרות.



תמר בת 48, נשואה ואם לשני ילדים גדולים, עורכת סרטים במקצועה. את נישואיה היא מגדירה כחסרי משמעות. בעלה והיא חיים זה לצד זה, אבל למעשה הם חיים בעולמות נפרדים מבחינה מינית ורגשית. מאז שהיא זוכרת את עצמה היא מעדיפה להיות בחברת הומוסקסואלים, והם חבריה הטובים ביותר. בכל פעם שגבר מוצא חן בעיניה היא מגלה שהוא הומוסקסואל. היא מעולם לא קיימה יחסי מין עם הומוסקסואל. חברה סיפרה לה שבאנגלית קוראים לנשים כמוה פאג האג (Fag Hag).

לתמר, אינך מתארת דבר חריג. נשים רבות מעדיפות את חברתן של הומואים. ההגדרה של פאג האג רחבה וכוללת נשים שנהנות מחברת גברים הומואים, נשים שמתאהבות בגברים הומואים, נשים שמנסות להמיר הומואים להיות סטרייטים. מקור הביטוי במועדון 54 בניו יורק, שהיה להיט בשנות 1980 ונסגר. במועדון הזה נהגו לייזה מינלי, ביאנקא ג'אגר ואחרות לחגוג עד אור הבוקר עם חובבי הגברים. לפי פנייתך את לא בהכרח נמשכת להומוסקסואלים אלא מחפשת אדם רגיש שיחיה איתך בעולמך.

התייחסות ההורים

הורים רבים מתחבטים ומתייסרים בשאלת הנטיות המיניות של ילדיהם. בתהליך הגידול של הילד ההורים שואלים את עצמם עד כמה הם נמצאים שם למען ילדם, עד כמה הם מודל חיובי, עד כמה הם מודל גברי או נשי, ומה מתוך כל ההשקעה שלהם ייקח הילד לעתידו. כאשר הילד מגיע לבגרות, אחת השאלות והחרדות העולות היא העדפתו המינית. כאשר מתברר להורה שילדו נוטה להומוסקסואליות, וההורה פוגש בילדו העדפה מינית שונה משלו, העדפה שאינה מוכרת לו, עלול להיווצר משבר בתהליך ההורות. ההורה עלול לחוש שאינו יודע עוד כיצד להיות עם ילדו ובשבילו, ושהדרך שבה נהג טעות ביסודה. ההורה רוצה להמשיך ולהיות עם ילדו, אך מרגיש חוסר אונים ולא בטוח ביכולותיו כהורה.

גילוי הנטייה המינית עלול ליצור תחושת שבר, בגידה ובעיקר כעס מאוד גדול הבא לידי ביטוי ברצון להתנתק מהילד, ביקורת על התנהגותו ועד רצון

לתקן ולרפא אותו. במצוקתם יפנו הרבה הורים לפסיכולוג או לרב או יגידו לילד שיקיים יחסי מין עם בני המין השני ואז יבין שטעה וידע מה באמת טוב ונכון עבורו. כל זאת על מנת לעשותו סטרייט. לצד הכעס צצה ומופיעה האשמה: איפה טעיתי? מה עשיתי לא נכון? איזה מודל נתתי? אולי זה גנטי, ואם כך זה ממני או מבן הזוג? ובתוך כל בליל הרגשות יעלו גם פחדים מאידס, מבדידות, מדחייה, מסטייה, ממחלה, מפדופיליה ועוד. מתוך כך עלול להתעורר קושי בזוגיות ההורים, וגם היא תעמוד במבחן, במיוחד אם כל אחד מהם תופס את הנטייה המינית של ילדם בדרכו שלו.

ויש גם התמודדות עם החברה. הרבה הורים לא מוכנים רגשית לספר לחברים קרובים, לחברים לעבודה, לקרובי משפחה. הורים חשים בושה ומתלבטים איך, מתי ומה להגיד לסביבה ומה לעשות אל מול התגובות. התייחסות ההורים חשובה לילד ומשמשת בסיס חדש לדימוי העצמי שלו, לערך ולביטחון העצמי. הורה שלא יקבל את ילדו כמו שהוא יגרום לו תחושה של אכזבה, תסכול, חוסר אהבה וחוסר ערך. הורה המבין ומקבל את העדפתו המינית של ילדו יביא את הילד ואת עצמו לקבלה ואהבה עצמית.

היריון ולידה



יחסי מין לפי הביוץ

תאריך הביוץ הוא כשבועיים לפני תחילת הווסת הבאה. אם לאישה יש וסת כל 30 יום, היא מבייצת ביום ה-16 מתחילת המחזור. אם יש לה וסת כל 24 יום, הביוץ ביום ה-10. אם הווסת לא סדירה, 26-31 יום, הביוץ ביום ה-12-17. לעיתים מחזורים לא סדירים מסמנים הפרעה בביוץ. כשרוצים היריון עדיף שהזרע ימתין לביצית ולא להפך. לכן כדאי לקיים יחסים ביתר אינטנסיביות כיומיים לפני מועד הביוץ המשווער ובמשך כשבוע ימים.

בימי הביוץ מקובל להנחות זוגות לקיים יחסי מין יום כן יום לא, וזאת כדי לשמר את איכות הזרע, אך אין חשיבות לכך. עדיף לנסות לקיים יחסי מין בתכיפות גבוהה, לפחות פעם ביומיים, כדי לכסות על תקופת הביוץ. עדיף שלא להיכנס למשטר נוקשה של קיום יחסי מין לפי לוח השנה ביום ובשעה, כי הדבר היוצר מתחים זוגיים, קשיים וליקויים בתפקוד המיני אצל האישה ואצל הגבר. והעיקר, רצוי לקיים יחסים כשמתחשק. חשוב לשמור על חדוות המין.

התנוחה

אין חשיבות לתנוחה, כי אפשר להרות בכל תנוחה. כאשר הרחם קדמי

(וצוואר הרחם אחורי), עדיף לאישה לשכב על גבה בזמן יחסי המין או אחריהם. אם הרחם אחורי (וצוואר הרחם קדמי), עדיף לה לשכב על הבטן. בשני המקרים ההיגיון הפיזיקלי הוא שבתנוחה הספציפית צוואר הרחם יטבול באמבט הזרע הנקווה בקצה הנרתיק. יש לציין שרחם אחורי (אצל כ-15% מאוכלוסיית הנשים) אינו גורם לתת-פוריות.

לאחר סיום היחסים רצוי לשכב זמן קצר. הזרעים זריזים, ובתוך כמה דקות כבר נמצאים בתוך נקבוביות צוואר הרחם והחצוצרות. לכן נשים המנסות להימנע מהיריון בשטיפה מהירה של הנרתיק נכשלות בכך לעיתים קרובות. נשים שעוברות הזרעה במהלך טיפולי הפוריות לא צריכות לשכב כלל, כי הזרע לאחר ההזרעה כבר נמצא ברחם ואינו זולג בחזרה לנרתיק כשהאישה עומדת. יש מחקרים המראים שיפור בסיכוי להיריון, אם האישה נשארת לשכב 5–10 דקות לאחר ההזרעה.

ואלה התשובות לסקר שבדק מהי האמונה הטפלה של נשים הקשורה להגברת הסיכוי להיכנס להיריון אחרי יחסי מין: לשכב על הגב ולעשות תנועות של רכיבה על אופניים, לאכול שוקולד מריר, לשתות מיץ אננס; לגרוב גרביים ולשמור על רגליים חמות בשכיבה במיטה; לאכול צ'יפס.

גברים בחדר הלידה

המגמה להכניס את הגבר לחדר הלידה עלולה ליצור זן של גברים "קורבנות" לידה. נשים רבות מצפות שהבעל יהיה חלק בלתי נפרד ממסע הלידה עד סופו, ויש גברים שאינם עומדים בלחץ, מתביישים להגיד שמעמד חדר הלידה מעורר בהם חרדה וקושי. רק זמן רב לאחר הלידה הם מודים שהחשיפה ללידה לא גרמה להם שמחה והם היו מעדיפים להימנע מהמחזה של התפתלות מכאבים, דימום, קריעת איברים, ידיים נדחפות, שליה היוצאת מהמקום שנישקו בשפתיהם. לעיתים זה טראומתי.

המחקר מלמד שכ-2% מהגברים הנחשפים ללידה מפתחים פוסט-טראומה. אי אפשר לחזות מראש מי מהגברים יחוה חוויה קשה בחדר הלידה. רוב הגברים יעמידו פנים שהכול כשורה. כתוצאה מהחשיפה גברים עלולים לפתח קשיים בתפקוד המיני. יש גברים שיפתחו קשיים בזקפה

מחשש להכאיב ולפגוע באם שלא מכבר חוותה טראומה באיבר מינה. הקשיים בזקפה יהיו מלווים בדרך כלל בדחייה ממין. יש גברים שיפסיקו להימשך לרעייתם, זו שעד לא מזמן השתוקקו אליה.

בייעוץ מקצועי מתמקדים בעיבוד החוויה הקשה – תחילה הגבר לבדו ואחר כך עם בת הזוג. הטיפול מתמקד בחשיפה הדרגתית של בני הזוג לקיום יחסי מין מלאים בהתאם למוכנות ולפתיחות שלהם בתקווה לחזור למה שהיה לפני ההיריון והלידה.

חזרה לחיי מין

בעקבות ההיריון והלידה האישה עוברת שינויים גופניים ופסיכולוגיים. הגוף נחלש ומאבד ויטמינים ומינרלים, חלים שינויים הורמונליים, שינויים במשקל ובמבנה הגוף. ויש גם עייפות, שינויים במצב הרוח ולעיתים דכדוך עד כדי מצב של דיכאון. הגבר גם הוא עובר שינויים פסיכולוגיים וחברתיים. תשומת הלב עוברת ממנו לתינוק, וייתכן שירגיש דחוי. עכשיו, כשיש ילד במשפחה, מוטלת עליו אחריות לדאוג לכולם.

בין הטרדות והשאלות הרבות שבהן מתעסקים ההורים הטרדים עולה הנושא של חזרה לקיום יחסי מין. מחקר בקרב 246 זוגות העלה שחיי המין נפגעו אצל 74% מהם. מתברר שהחשק המיני, הרצון והתפקוד נפגעים בחצי השנה שלאחר הלידה. תלוי באופי הלידה, אופי הילד, ההנקה ואיכות החיים האישיים והזוגיים. ניכרת ירידה בחשק המיני, בעוררות המינית וביכולת הסיכון. ייתכנו כאבים במגע ופגיעה ביכולת ההגעה ובעוצמת האורגזמה. הפגיעה בחיי המין היא תולדה של גורם פיזי הורמונלי ושל גורם פסיכולוגי. בעקבות הלידה עלולה להיות פגיעה ברצפת האגן ובאיבר המין, אפילו אם הייתה זו לידה רגילה. גם התחושה בדגדגן עלולה להיפגע. בגלל ירידה באסטרוגן יש יובש בנרתיק, והדבר מקשה על יחסי המין ופוגם בהנאה. ומקשים גם העייפות והשחיקה כתוצאה מהטיפול הבלתי פוסק בתינוק וקונפליקטים ומריבות בין בני הזוג.

נוראל בת 33 ובעלה בן 40. יש להם שתי בנות קטנות. שניהם עובדים

מהבוקר עד אחר הצהריים. המטלות בבית מתחלקות ביניהם, אבל בשעה תשע הם מותשים ואין להם כוח ליחסי מין. הם מניחים את הראש על הכרית ופשוט נרדמים. לפעמים כשהם שוכבים, אחד מהם מתעייף ואז מפסיקים באמצע. אם אחד יוצא מסופק, מתארגנים והולכים לישון. העייפות גוברת על התשוקה. הבעל אוהב שהם שוכבים בבוקר, אבל לא תמיד יש לה זמן, כי היא צריכה לארגן את הבנות ולצאת לעבודה.

לנוריאל, נכון. כשיש ילדים קטנים, חיי המין עלולים להיפגע. אצל 70% ויותר מהזוגות עם ילדים קטנים יש נפילה בתדירות המין. למי בכלל יש ראש לסקס? אבל אם לא תישמר החברות והאינטימיות, ייווצר ריחוק שאחר כך יהיה קשה לגשר עליו. תקשורת טובה היא כלי חשוב לשימור החברות. חשוב למצוא זמן איכות ביחד כדי לטעון את הבטריות הרגשיות המרוקנות. חשוב גם שלכל אחד יהיה פנאי משלו. ואפשר לתכנן זמן למיניות.

יחסי מין ללא חדירה מותרים ואפילו חשובים. המגע חשוב לשני בני הזוג, כדי שלא ירגישו דחויים ובלתי מושכים. ליטוף, התעלסות ומגע באיברי המין חשובים מאוד לקשר הזוגי האינטימי החדש שנוצר בין בני הזוג לאחר הלידה.

מהרגע שהאישה מפסיקה לדמם, כמה שבועות לאחר הלידה, אפשר לחזור לקיים יחסי מין מלאים. רצוי שהדבר ייעשה רק לאחר בדיקת רופא, 3-6 שבועות לאחר הלידה. נשים שילדו בניתוח קיסרי עלולות להתקשות זמן רב יותר בקיום יחסי מין מלאים.

בתקופה זו צריך להימנע מיחסי מין אוראליים, כדי למנוע דלקת בנרתיק וברחם. יש סיכון שהגבר ינשוף אוויר לנרתיק, וחדירת האוויר לכלי הדם ברחם תגרום תופעה קשה המכונה "תסחיף אוויר".

בתחילת היחסים מומלץ לא לבצע חדירות עמוקות, והתנוחה המומלצת היא תנוחת כפיות. אפשר להשתמש במסכת על בסיס מים, כדי להקל את החדירה.

אין חשש למגע בחזה של אישה מיניקה, וגם אין להיבהל מיציאת חלב בזמן המגע.

התמכרות למין



התלהבות ממין יכולה להיות דבר חיובי, אם המין משמש מקור ליצירתיות ולביטוי עצמי. במצבים פתולוגיים האיזון מופר ונגרמת הפרעה בתפקוד. ההתנהגות הכפייתית פוגעת בדימוי העצמי ואפילו במהלך התקין של החיים. התמכרות למין או התנהגות מינית אובססיבית מוכרת כיום כבעיה ביולוגית פסיכולוגית הדורשת טיפול. מדובר בחוסר שליטה על הדחפים. מקורה בבעיות פיזיולוגיות וביולוגיות הקשורות במוח ומצריכות בין השאר טיפול תרופתי.

הסימפטומים הם חיפוש מתמיד אחר פרטנרים חדשים, שימוש לא נשלט בחומרים אירוטיים והשקעת כספים רבים בנושא, הסתרה ואגירה של חומרים פורנוגרפיים, שימוש מוגזם באינטרנט לגירוי מיני ולמציאת פרטנרים, דרישה בלתי פוסקת למין במערכת יחסים, שימוש בכוח או במניפולציות להשגת מין. המכורים מקיימים יחסי מין בלי הפסקה ובלי אבחנה גם עשר פעמים ביום ובלי הנאה.

מדובר בצורך עמוק במגע, ולאו דווקא בסיפוק המיני. במחקר אמריקני משנת 2003 נמצא כי 3%–5% מהאמריקנים מכורים לסקס, וכיום השיעור הוא 6% מכורים. הועלתה ההשערה שההתמכרות היא תולדה של התעללות בתקופת הילדות, אך מחקרים עכשוויים תולים את ההתמכרות בגורמים שבהווה ולא בעבר. רבים מהמכורים הם אנשים מצליחים מבחינה מקצועית, והקושי שלהם הוא ליצור מערכת יחסים ולהישאר בה לאורך זמן. יש להם צורך בכיבוש, בריגוש, בחידוש, בהוכחות חוזרות ונשנות של גבריות או נשיות. הם חווים פחד עמוק מקרבה, מאינטימיות, מזוגיות. מאפייני המכור למין: הזנחה של רכיבים חשובים בחייו; שיבוש מערכות

יחסים; תגובה מתגוננת או מבוהלת לנוכח ביקורת על התנהגותו; תחושת אשמה; חרדה; חוסר יכולת להפחית במינון של יחסי המין וצורך מתמיד להעלות את המינון כדי להגיע לתחושת הנאה; בריחה מהמציאות; נסיגה פיזית ורגשית כאשר נעשה ניסיון להפסיק את ההתמכרות.

הקושי העיקרי בטיפול במכור הוא הבושה והסודיות סביב הנושא, המונעים ממנו וממשפחתו את היכולת לחפש עזרה. כך גם הסטיגמה החברתית והסלידה ממיניות לא ראויה. למכור יש צורך לשכנע את עצמו שהכול בסדר כדי לדכא את הכאב והבושה שלו.

הטיפול בהתמכרות הוא פסיכולוגי ותרופתי. בשונה מהתמכרות לאלכוהול וסמים, שבהם הטיפול מכוון לגמילה מוחלטת, מטרת הטיפול בהתמכרות למין להביא ליכולת לתעל את המין לאפיק חיובי ובריא במסגרת זוגית אינטימית. תפקיד הפסיכולוגיה הוא ללמד את המכור לחיות עם הדחף. מלמדים את המכור לא להתנזר ממין, אלא ליהנות ממנו. ליהנות מהמגע, מהליטוף, מהחיבוק, מהחום, מהאנושיות. ללמוד את מהות המין ואת משמעותו, ולראות בו הרבה מעבר לאקט הטכני. שיעור ההצלחה בטיפול תלוי במוטיבציה של המכור לשנות את מצבו. מתוך ההכרה בבעיה והטיפול בה יש למכור תקווה לראות את האור הרומנטי והאינטימי בקצה המנהרה. שיעור ההצלחה הוא 70%–80. נוסף על תרופות נגד חרדה משתמשים בתרופות נוגדות אפילפסיה כמו למיקטל, טופמקס וגבפנטין. בשיטה זו מסתכלים על הדחף כעל התקף אפילפטי, פעילות לא סדירה של המוח. בגישה טיפולית אחרת נותנים תרופות ממשפחת SSRI, אשר מורידות את החשק והדחף המיני.

וגיניזמוס



לא מעט נשים סובלות מווגיניזמוס, התכווצות בלתי רצונית של פתח הנרתיק. יש בהן שלא קיימו מעולם יחסי מין, אחרות חוו טראומות. על הבעיה הזאת לא מדברים, אבל מפתיע לגלות עד כמה היא שכיחה: על פי ההערכות סובלות מווגיניזמוס 10-15% מהנשים. התופעה תוארה לראשונה בעולם המדעי בשנת 1834. כיום ידוע שהסיבות לווגיניזמוס הן בעיקר פסיכולוגיות ולא פיזיות.

ההתכווצות הבלתי רצונית של פתח הנרתיק לא מאפשרת כניסה לתוכו. אי אפשר להחדיר טמפון, אצבע של גיניקולוג, אצבע של בן זוג, וכמובן איבר מין. לעיתים הכיווץ אינו רק בפתח הנרתיק, אלא משולב בהתכווצות הגוף כולו: הרגליים נסגרות והגוף לא מאפשר התקרבות לאזור הנרתיק.

וגיניזמוס ראשוני – מעולם לא הייתה כניסה לנרתיק. וגיניזמוס משני – מתרחש לאחר אירוע: ניתוח, מחלה קשה, פגיעה באיברי המין, חוויית אונס, כל חוויה אחרת הגורמת לאישה לכווץ באופן בלתי נשלט את הנרתיק.

במקרים קלים של וגיניזמוס נשים מצליחות לקיים יחסי מין חיצוניים ומגיעות לאורגזמה. בדרך כלל הן בוחרות פרטנר מתחשב ומשתף פעולה. הסקס החיצוני מהנה דיו לשני בני הזוג. הנשים יגיעו לטיפול בדרך כלל רק כשירצו להביא ילד לעולם.

במקרים קשים האישה לא מאפשרת לבן הזוג להתקרב אליה. פעמים

רבות היא נותרת לבדה. היא תבוא לטיפול רק לאחר שתבין שמחסום הווגיניזמוס יותיר אותה לבדה.

מקובל לחשוב כי הסיבה העיקרית לווגיניזמוס היא פחד עמוק הנגרם מחוויה קשה. נוסף על טראומה מינית, פגיעה, ניצול, אונס וכיוצא באלה משפיע גם החינוך בבית והמסרים לגבי מיניות. וגם מסרים על זוגיות, על ניקיון, ניסיון מיני טראומתי, בדיקה גינקולוגית קשה – כל אלה יכולים לגרום וגניזמוס.

האבחון נעשה על סמך סיפורה של המטופלת. בדרך כלל האישה הסובלת מווגיניזמוס חוששת מכל קרבה אל איבר המין, לכן אין מושיבים אותה על כיסא הגינקולוג בתחילת הטיפול.

ראשית היא לומדת להתייחד עם איבר המין שלה. המטרה היא הכרת האיבר ממש כמו שמכירים את הפנים. המטופלת לומדת על מערכת השרירים, כיצד לשלוט בהם, לכווץ אותם ולשחרר כרצונה.

אותה היכרות כוללת נגיעה, תחושה של השפתיים החיצוניות, הפנימיות, הדגדגן, שער הערווה, פתח הנרתיק ופנים הנרתיק. בשלב מאוחר יותר עובדים על היכולת להפעיל את שרירי הנרתיק בטכניקות עבודה שרירית, תרגילי קגל. תרגילים אלו דומים לתרגילי שיטת פאולה של השרירים הטבעתיים, שבהם לומדים לכווץ, להרפות ולחזק את השרירים.

גם הפיזיותרפיה של רצפת האגן מסייעת. בקופות החולים ובבתי החולים יש הדרכות לטכניקות תרגול במכשיר ביופידבק, שבו אפשר לראות את השינוי השרירי באזור האגן, שהאישה לומדת לשלוט בו. כל זאת עושה פיזיותרפיסטית מומחית בטיפול ברצפת האגן.

לאחר שהמטופלת למדה להפעיל ולשחרר את שרירי רצפת הנרתיק, עושים סדרת אימונים בעזרת "מאמני נרתיק": מכשירים בצורת איבר מין קטן בכמה עוביים. בדרך ובקצב שלה האישה לומדת להחדיר את המכשירים לנרתיק, החל במכשיר זעיר ועד מכשיר בגודל איבר המין של בן זוגה. כך היא רוכשת ביטחון שהיא מסוגלת לשלוט בנרתיק ולהחדיר לתוכו את האיבר.

אם יש בן זוג, גם הוא חלק מהטיפול ויש לתת את הדעת לצרכיו. עם הבחורה יחד הוא נחשף לקיום יחסי מין ומתרגל עימה. לאט לאט הם מתקדמים יחד עד קיום יחסי מין מלאים.

טיפול מוצלח אורך 4–6 חדשים. שיעור ההצלחה 95%. טיפול אפשרי נוסף הוא הזרקת בוטוקס לרצפת האגן. הבוטוקס משתק שרירים, מונע את הכיווץ הלא רצוני של שרירי רצפת האגן ומאפשר יחסי מין.

יוסי, בן 21, ביחסים עם חברתו יותר מ-8 חודשים, והם מנסים לקיים יחסי מין. שניהם בריאים ואוהבים מאוד, אלא שבכל פעם שהם מנסים לשכב היא נסגרת ומפחדת מכאבים. ליוסי יש זקפה חזקה ואיבר מין עבה, ובכל פעם שהוא מנסה לחדור היא נראית מפוחדת והוא מפחד להכאיב לה, ובשל כך יורדת לו הזקפה. הוא אוהב אותה מאוד ולא יודע מה לעשות.

ליוסי, לפי מה שאתה כותב סביר להניח שחברתך לוקה בוגיניזמוס. רצוי שלא תנסו חיי מין מלאים כדי שלא להחמיר את החוויה ואת הקושי. פנו יחד לייעוץ מקצועי.

ויברטור



המאה ה־21 הביאה עימה שינויים בביטוי המיניות של האדם. החידושים, ההמצאות, הכדורים והמשחות קוראים לנו לתת דרור לתשוקות ולמאוויים המיניים. כחלק מהקדמה המינית חלה עלייה בשימוש באביזרי מין. רוב הזוגות יעידו ששימוש בעזרים תורם לשכלול ולגיוון חיי המין, שומר על חיוניות ומונע שקיעה לשגרה משמימה. לעומתם יש שילינו כי הכנסת האביזרים לחיי המין שלהם מביאה קללה יותר מברכה. המחקר מלמד ש־23% מהאנשים בעולם נעזרים בוויברטור לגיוון חיי המין. נשים וגברים יעידו שהוויברטור עוזר להגיע לריגוש מיני שלא חשבו שיש כמוהו. עם זאת השימוש במכשיר עלול לגרום לנטישת ההתמקדות בדבר האמיתי, הריקוד המשותף, הביחד.

יש מצבים שבהם למרות ההשקעה במשחק המקדים נשים מאבדות את חדות המין בדרך לאורגזמה האולטימטיבית. הרדיפה אחר אורגזמה מדהימה הפכה למרתון. לכאורה

נראה שהשימוש בצעצוע הרוטט הוא הפתרון המושלם להנאה מיידית, אך חסר בו שיתוף הצרכים הפיזיים והרגשיים של שני בני הזוג. אולי נכון שלא להשתמש בו בכל פעם שבני הזוג יחד ולהתאים את המינון להוספת גיוון ולא לקיבוע.



לא רק נשים, גם לא מעט גברים נהנים משימוש בוויברטור. גם אם הוויברטור מוחדר לפי הטבעת, אין בשימוש הזה כדי להעיד על העדפה מינית הומוסקסואלית.

כל מיני ויברטורים משמשים לגירוי איבר המין ולעינוג הגוף. הנפוצים הם ויברטור חיצוני לגירוי הדגדגן, ויברטור פנימי לגירוי הנרתיק, ויברטור לגירוי הדגדגן והנרתיק בעת ובעונה אחת. הוויברטור מייצר גירוי על הדגדגן ובתוך הנרתיק בעוצמה חזקה וממוקדת, המביאה לידי עוררות וגירוי מיני, שבסופו של דבר גורמים לתחושת הפורקן, אורגזמה.

הדרך לחוויית האורגזמה עם בן הזוג מצריכה השקעה וסבלנות. יש מקום לכמה פעולות: (1) האישה יכולה לאונן ביד עם ובלי גירוי של הוויברטור, עד שתגיע לאורגזמה. (2) האישה יכולה לאונן ליד בן הזוג, והוא יוכל לראות מה היא עושה כדי להגיע לאורגזמה המיוחלת. (3) האישה יכולה להניח לבן הזוג לגרות אותה בדומה למה שראה. היא תנחה אותו, והוא ישקיע מאמץ. חשובה הסינכרוניזציה בריקוד המיני הזה.

גילי, בת 25, מקיימת יחסים זה שבע שנים, ורק בחצי השנה האחרונה הבינה מהי אורגזמה. היא לא הצליחה להגיע לאורגזמה עם בן זוג, ואז קנתה לה ויברטור – ונפקחו עיניה. עולם חדש נפתח לפניה. גילי שואלת אם תמיד תהיה תלויה במכשיר הזה.

לגילי, ויברטור מנצח כל גבר – עד שנגמרות הבטריות. אילו לגברים הייתה יכולת לתפקד כמו ויברטור, אזי לא היה מקום לתעשייה של צעצועי המין. עכשיו כשאת יודעת מהי אורגזמה ויכולה לחוות אותה בעזרת ויברטור, זה הזמן להתשמש בידע החדש, להשקיע וללמוד להגיע לאורגזמה בעזרת אצבעותיך ובעזרת בן־זוגך. כך לא תהיי תלויה בוויברטור.

וסטיבוליטיס-וולוודניה



וסטיבוליטיס היא תסמונת כאב כרוני באזור הווסטיבולום, הפתח שבעריה. הטיפול מזכיר טיפול בתסמונות כאב אחרות כמו למשל תסמונת כאב הגב הכרוני. ההמלצה לאישה הסובלת תהיה מנוחה, משחות מחממות או משחות נוגדות דלקת באזור הכאב, ואם הכאב נמשך, פונים לרופא לקבלת טיפול פומי אנטי-דלקתי. אם הכאב לא חלף, פונים לטיפול פיזיותרפי. מי שתמשיך לסבול תפנה לרפואה אלטרנטיבית או משלימה. ניתוח מומלץ רק למטופלות שסובלות ומוגבלות באיכות חייהן למרות כל הטיפולים. זו התפיסה בטיפול במרפאת הנשים הסובלות מווסטיבוליטיס.

במפגש הראשוני האישה נשאלת אם חוותה טראומה מינית בעבר, אך בדרך כלל המידע על כך יתקבל רק בהמשך הטיפול. טיפול התנהגותי מיני משפיע בכמה מישורים. קודם כול הוא מקטין את רמת החרדה מהחדירה באמצעות הרחבה הדרגתית של הנרתיק ושימוש בדמיון מודרך. כמו כן הוא נותן כלים להתמודדות נפשית עם הכאב. הכאב לא נרפא, אבל האישה לומדת להתמודד איתו. הטיפול פועל על שיפור דימוי גוף והביטחון העצמי, נותן כלים לשיפור התגובה המינית, ההנאה מהמין, הגברת הריכוז המיני בזמן יחסי מין ויכולת השימוש בפנטזיות מיניות. ברור שככל שהאישה חושבת יותר על הכאב בזמן יחסי המין כך כואב לה יותר. לכן מנסים להציף אותה בתחושות, בפנטזיות ובחוויות מיניות. גם בן הזוג סובל מהמצב, והשניים זקוקים לסיוע ולעזרה נפשית. הטיפול יכול להיות פרטני, זוגי או קבוצתי.

האטיולוגיות הן זיהומים עוריים, אלרגיות, הפרעות בשרירי רצפת האגן, הפרעות במערכת החיסונית, גנטיקה, הפרעות הורמונליות. כשאישה מגיעה

למרפאה ומאובחנת כסובלת מווסטיבוליטיס, הטיפול הראשוני יהיה מקומי, ומטרתו להקטין גורמים מגרים מקומיים. למשל מניעת שימוש בתחתוניות ריחניות, מניעת שימוש בדאודורנטים מקומיים, בסבונים ריחניים, במרככי כביסה, בנייר טואלט ריחני. ואז משמנים ומעסים את האזור הרגיש כדי להקטין את תחושת היובש ולרכך את העור. מומלצים שמן שקדים, שמן ויטמין E, שמן אובליפיחה ושמן קלנדולה. מומלצת ישיבה באמבטיות עם שמן עץ התה ולבנדר, שמן אמול, אבקת עמילן-תירס. כל רופא ימליץ על פי בחירתו והעדפתו ולפי מה שמתאים למטופלת. במקרה של קרע באזור הפורשט אחרי קיום יחסי מין ההמלצה תהיה מריחה של משחת ויטמין A, שמנים, ולפני קיום יחסי מין שימוש במאלחשים 2% או 5%.

אצל נשים עם היסטוריה של דלקות וטיפולים חוזרים אנטי-פטריותיים חשוב לקחת תרבות נרתיקית. בחלק מהמקרים התרבות תהיה שלילית לקנדידה או למזהם אחר. אם תימצא קנדידה חוזרת, תקבל האישה טיפול פומי אנטי-פטריותי לכמה חודשים, כמו כן תקבל הנחיות לשמירה על היגיינה מקומית, וכן תיטול פרוביוטיקה פומית ונרתיקית כדי להעלות את ריכוז פלורת החיידקים התקינים בנרתיק. אין הוכחה מדעית שהדיאטה עוזרת לקנדידה, אך יש נשים שמגיבות טוב לדיאטה, ורצוי לנסותה אצל נשים עם קנדידה כרונית עמידה לטיפול.

דיאטה דלת-אוקסלט הייתה אופציה טיפולית מקובלת בשנים האחרונות, אבל מחקר עדכני מלמד שאין צורך בדיאטה לנשים עם וסטיבוליטיס, אלא אם כן הן סובלות מהיפר-אוקסלוריה.

בבדיקות גינקולוגיות של נשים עם וסטיבוליטיס הנוטלות גלולות נמצא עור דק ואטרופי באזור הווסטיבולום הנראה כמו עור של אישה מנרפאוזלית. נשים אלו מדווחות על תחושות של יובש נרתיקי תמידי או בזמן קיום יחסי מין.

יש עדויות על קשר בין שימוש ממושך בגלולות עם מינון אסטרואידי נמוך ובין עלייה בסיכון היחסי להתפתחות וסטיבוליטיס. שינוי הסביבה ההורמונלית יכול לשפר או להעלים את הכאב. מומלץ להפסיק לקחת גלולות, לעבור לגלולות עם מינון אסטרואידי גבוה יותר או לקבל תוספת של אסטרואידי מקומי במשחה או בטבליות תוך-נרתיקיות. האטרופיה תעבור אחרי תקופה של טיפול, ותחושת הכאב תקטן עד כדי היעלמותו.

179 נשים הסובלות מווסטיבוליטיס ענו על שאלות אחידות, ואלה הממצאים:

- 76% טענו שהכאב משפיע לרעה על הקשר הזוגי.
- 61% דיווחו על ירידה בחשק.
- 92% דיווחו על פחד מכאב.
- 81% תיארו תגובת התכווצות לא רצונית לקראת החדירה.
- 43% דיווחו על תחושת יובש, ירידה בסיכון, ירידה בהתעוררות המינית.
- 58% אמרו שהן נמנעות מלהגיע למצבים אינטימיים עם בן הזוג.
- 51% דיווחו על פגיעה בדימוי הגוף וההערכה העצמית.

בעקבות טיפול התנהגותי קבוצתי חלה ירידה בפחד מהכאב, עלייה בחשק המיני, נצפתה יכולת ליהנות יותר מיחסי מין ולקבל אחריות למצב. נשים דיווחו על פתיחות מינית רבה יותר בקשר עם עצמן ובתקשורת עם בן הזוג. הן שידרו יותר בשלות, יותר ביטחון עצמי ואסרטיביות, יותר נשיות ומודעות עצמית. רוב הנשים הצליחו לשמר את ההישגים ודיווחו על שביעות רצון מתוצאות הטיפול ההתנהגותי.

במחקר שהשווה במהלך שנים עשר שבועות טיפול קבוצתי, טיפול בביר-פידבק וניתוח וסטיבולקטומיה – נמצא יתרון חד-משמעי מבחינת תוצאות הטיפול לווסטיבולקטומיה, אך החוקרים הביעו הסתייגויות לגבי התוצאות של הקבוצה המנותחת. גם הקבוצות האחרות דיווחו על שיפור ניכר בתפקוד המיני וירידה בעוצמות הכאב.

הטיפולים בווסטיבוליטיס רבים ומגוונים. יש דיווח על תוצאות טובות לזריקות מקומיות של בוטוקס בנשים שסובלות מוולודיניה. סקלת הכאב הייתה בירידה במעקב של שנתיים. היו מחקרים של טיפול בלייזר שלא הצליחו. נעשה מחקר על טיפול בכאב הכרוני על ידי גירוי חוט השדרה בתדר חשמלי גבוה של 10 קילוהרץ.

Pregabalin, Gabapentin, Amitriptyline עזרו להקלה ולהורדת הכאב.

ירידה בעוצמת הכאב דווחה גם במריחה של קאפסיצין, צ'ילי פפר.

ויש גם טיפול במאלחשים, שהרי ההגדרה של וסטיבוליטיס היא פרוליפרציה של קצות עצבים באזור הווסטיבולום. תוצאות טובות יש לתהליכים של בלוקים עצביים – אפידורל, קאודאל או בלוק של עצב הפודנדל והזרקת לידוקאין מקומית. ויש גם טיפולים בהיפנוזה המראים ירידה בסף הכאב גם בבדיקה וגם בזמן קיום יחסי מין.

אין הצלחה מלאה בשום טיפול. ממוצע ההצלחות הטיפוליות הוא כ-50%.

- זהו אופן הטיפול באישה במרפאה לטיפול מיני בבית החולים ליס:
- טיפול מקומי ופומי לכל אישה החל בפגישה הראשונה.
 - אם יש עדות להפרעה הורמונלית, אם נמצא אטרופיה ויובש באזור הווסטיבולום, מפסיקים גלולות או נותנים תוספת של משחה או נרות אסטרוגנים לנרתיק.
 - אם האישה ברמת חרדה מאוד גבוהה ומדווחת על השלכות רגשיות קשות ברמה האישית הזוגית, היא מופנית גם לטיפול התנהגותי מיני.
 - אם היא שוללת קושי רגשי מיני ויש טונוס גבוה של שרירי רצפת האגן או תגובה וגיניזמית לכאב, מפנים את האישה לפיזיותרפיה של רצפת האגן. נשים שמעוניינות מופנות לשני סוגי הטיפולים בה בעת ומוזמנות למעקב בכל כמה חודשים.
 - אם הטיפול נכשל מפנים לטיפול ניתוחי. אם האישה לא מעוניינת בניתוח, היא מופנית לטיפול אלטרנטיבי, אוסטאופטי, טיפולים מקומיים אחרים, משחות וזודילטוריות או לקבלת זריקות מקומיות של סטרואידים ולידוקאין.
 - נשים שיש להן כאב תמידי באזור הווסטיבולום בלי קשר ליחסי מין מופנות למרפאות כאב לטיפול בתרופה אנטי־דיכאוניות או אנטי־אפילפטית כמו בטא־גאלן, דולוקסטין (סימבלטה) או גבאפנטין להעלאת סף הכאב המקומי.
 - הטיפול יכול להיעשות בליווי בן הזוג ומתוך התחשבות בו.

זוגיות



על תפיסת הזוגיות

הזוגיות בנויה מתפישות ומערכים משותפים בתחומי מין, כסף, חלוקת תפקידים בבית, גידול וחינוך ילדים, פנאי ביחד ולחוד, התייחסות למשפחות המוצא, התייחסות לחופשות ועוד. כל זוג עובר שלבים: ירח הדבש, מאבקי הכוחות, ההכרה בשוני, קבלת השוני. אצל זוגות שאינם משכילים לעבור את שלב מאבקי הכוח ולהביא בגרות לתוך הקשר, במוקדם או במאוחר אחד מבני הזוג או שניהם ירגישו אי־מיצוי ותסכול בקשר. כשאין הסכמה על רוב הנושאים, יחולו כרסום בקשר וחווייה של סוף. ייתכן שבני הזוג ייפרדו או ימשיכו לחיות בסבל.

בעולם המערבי הזוגיות עוברת שינוי ומפנה את מקומה לזוגיות אחרת: זוגרים, זוגות הגרים ביחד, בני זוג המגדלים ילדים ביחד וכל אחד מהם גר בבית משלו, זוגות חד־מיניים החיים יחד ומגדלים ילדים.

זוגיות בישראל

הישראלים מקפידים על ארוחות ימי שישי בחיק המשפחה, על מפגשים ובילויים בחג בחיקה של זוגיות חמימה ומשפחה מחבקת, ועל טקסים משפחתיים בכל הזדמנות המאפשרת לאחד את המשפחה. וכך הזוגות והמשפחות חיים יחד ולחוד. רוב האוכלוסייה בישראל רואה בהרחבת

הזוגיות למשפחה עם ילדים דבק שמחבר בין בני הזוג, תוספת נדרשת וחותם לזוגיות טובה.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2013 חיו בישראל 1.87 מיליון משפחות של 3.7 נפשות בממוצע.

6% מכלל המשפחות חד-הוריות עם ילדים עד גיל 17.

96% מהזוגות נשואים, 4% זוגרים, כלומר חיים יחד בלי נישואים.

מספר האימהות הרווקות החד-הוריות הולך וגדל. בשנת 2013 16% מהאימהות החד-הוריות היו רווקות.

זוגיות שנייה

בימינו זוגיות שנייה נחתמת לא רק בנישואים אלא גם בחוזה. זוגיות שנייה היא בוגרת יותר ומבוססת על התחברות מחושבת. לא שאין בה התאהבות, אבל מתאהבים בצורה מבוקרת יותר. אם בגיל עשרים צעירה יכולה להתאהב בגבר שאין לו מקצוע או שאינו עובד למחייתו, בזוגיות שנייה זה לרוב לא יעבוד. זוגיות שנייה יכולה להיבנות על הדברים המשותפים של שני אנשים שידועים מהם הצרכים שלהם, ורבים יתרונותיה. זו זוגיות שקולה יותר עם רכיב של אינטרסים ומחשבה בוגרת.

בזוגיות שנייה חשוב לעשות תיקון עצמי, חשבון נפש, לקבל אחריות. גם המין יהיה בוגר יותר. בני הזוג מגובשים יותר בהרגלי החיים – מתי קמים, איפה אוכלים או מבלים – הדברים ידועים ומבוססים. לכל אחד יש מקצוע משלו ועבודה משלו. יש חשיבות רבה להתבוננות פנימה ולעבודה עצמית על קשיים מן הזוגיות הראשונה.

הקושי העיקרי הוא הילדים: חשוב לתת לבן זוג החדש את המקום שלו עם ילדיו. לעיתים קרובות קשה לילדים לקבל את בן הזוג החדש, ויהיו התנגדויות. הילדים עלולים לא להסכים לחיות עם ההורה החדש.

מרחב מחיה

הצורך בביטחון דוחף לעבר יחסי מעורבות וקשר קבוע. הצורך בהרפתקה, בריגוש ובכיבוש חזק באותה מידה, ודוחף למערכות יחסים נוספות. הרומנטיקה המודרנית מבטיחה שאפשר לספק את שתי מערכות הצרכים האלה. כאשר פונים אל אדם שישפק ביטחון, משמעות, רומנטיקה, מיניות, ביחד של עשרים וארבע שעות ביממה – זוהי מערכת יחסים שאין בה הפרדה ונבדלות, ובסופו של דבר היא תקרוס. אותו זוג שעל פניו נראה מושלם כי "הם עושים הכול יחד" מתפרק בסופו של דבר, וזאת משום שאין להם פנאי כל אחד לעצמו, אין מסתוריות, געגוע ותשוקה. הכול מובן מאליו.

חשוב לשמור על מרחב מחיה או לתת מרחב מתוך הכרה בעובדה שאף אחד מבני הזוג לא יכול לספק את כל צרכיו של האחר. לא משנה עד כמה בני הזוג נפלאים, מסורים, אוהבים, רגישים, חכמים, מצחיקים, מאהבים. הזוגיות זקוקה למרחב שיש בו ביטוי עצמי, פיזי, רגשי ושכלי שאינו קשור ותלוי בה. האישה אולי רוצה ללכת למפגשי ספרות, לשיעורי פילטיס, לבלוי עם החברות שלה. הגבר אולי ירצה לרכוב על אופניים, להעיף דאוניס או לשבת בפאב עם חבריו מימי הרווקות. לא תמיד אפשר לעשות את זה ביחד. כל אחד גם זקוק לפנאי ולזמן איכות פרטי.

מרחב מחיה שומר על זוגיות בריאה לאורך שנים. אותה התרגשות שקיימת בתחילת קשר, אותה אי־ודאות המביאה תשוקה היא שמחזיקה את הזוגיות, וכל עוד משכילים להיות יחד וגם לחוד, לחיות באי־ודאות בריאה שיש בה מסתוריות וביטחון – אפשר לחיות בזוגיות טובה.

מגורים נפרדים וחדרים נפרדים

כיום הרבה זוגות בארצות אירופה בוחרים לחיות בזוגיות שבה כל אחד מבני הזוג מחזיק בדירתו שלו, וכך הם מנהלים חיים משותפים לכל דבר ועניין. מדובר בחיים זוגיים מאושרים, ושיעור הגירושים בהם קטן יותר מהשיעור בזוגיות רגילה. התופעה אינה נדירה גם בארצנו. יש גם זוגות רבים שחיים בבית אחד בחדרים נפרדים. על פי ההלכה

אישה נשואה שקיבלה מחזור אסורה על בעלה לפחות שנים עשר יום. במקרה הקל מדובר באי־קיום יחסי מין, ובמקרה הקיצוני היא לא תיגע בו אפילו נגיעה שאינה מינית, לא תוריד את כיסוי הראש שלה בנוכחותו, לא תעביר חפצים (למשל מפתחות) מידה לידו, לא תישן איתו באותה המיטה ובוודאי לא תתפשט מולו. השיטה הזאת מחלקת את החודש לשני חלקים – כשבועיים שבהם בני הזוג מקיימים יחסי מין וכשבועיים שבהם הם מתרחקים זה מזה.

בעולם החילוני הבחירה בחדרי שינה נפרדים באה מסיבות אחרות. אישה תאמר: אני הולכת לישון בסביבות עשר בלילה, הוא אוהב להישאר ער עם הטלוויזיה, המחשב והעיתונים שלו, ואז כשהוא מגיע למיטה אני



מתעוררת ונגמרה לי השינה. אישה תאמר: הוא ישן ונוחר נחירות רועמות ואני עם אטמי אוזניים – נשברתי ועברתי לחדר אחר. גבר יאמר: בחודש אוגוסט בחום אימים היא מתכסה בפוך, אני מרגיש כמו בסאונה טורקית, והיא לא מסכימה שנשאיר מזגן פתוח בלילה. עברתי לחדר השני וככה שנינו לא סובלים. גבר יאמר: אני לא יכול לישון עם חלון פתוח. כל בוקר היא מנמנת לה בהנאה ואני מתעורר מקרני השמש החודרות פנימה. עברתי חדר ואני ישן כמו תינוק.

הסיבות לשינה בחדרים נפרדים רבות ומגוונות. בדרך כלל עושים זאת בהסכמה. הפרדת חדרי שינה יכולה להיות צעד בדרך לניתוק קשר ויצירת ריחוק בין בני זוג, אך יכולה להיות גם פתרון לחיזוק הקשר וליצירת מתח מיני חיובי. המעבר לחדרים נפרדים אמור להיעשות בהסכמה לגבי המפגשים המיניים בין בני הזוג. הסכמה כזאת ועמידה בה שומרים על הזוגיות, על האינטימיות ועל המתח המיני.

אם אין קשיים אמיתיים הפוגעים באיכות השינה, טוב לישון באותו חדר ובאותה מיטה. הקרבה, המגע, והאינטימיות מביאים לידי קרבה אמיתית, לא בהכרח מינית. ואולי די בשתי שמיכות נפרדות.

זוגרים – חיים בלי חתונה

עוד ועוד אנשים בוחרים לחיות היום יחד כזוג לכל דבר בלי שעמדו תחת חופה. מגורים משותפים בלי נישואים – קוהביטציה – הם נוהג רווח, שנפוץ בישראל בקרב צעירים שמתנסים בחיים משותפים, מפני שאינם בטוחים שהם רוצים להינשא. כך חיים גם זוגות מבוגרים יחסית שהתגרשו או התאלמנו ואינם מעוניינים בנישואים נוספים, וגם זוגות של בני אותו המין וזוגות שאינם יכולים להתחתן כדת וכדין לפי חוקי הרבנות המחמירים. ויש גם זוגות שבוחרים שלא להתחתן.

תופעת הלגור־יחד מאוד נפוצה ומקובלת כיום. לפני כמה עשרות שנים זוגות שרצו לחיות יחד לפני החתונה זכו לקיתונות של רותחין. כיום הגישה החברתית שונה. זוגות רבים עוברים לגור יחד מייד לאחר ההיכרות ביניהם, ואפילו ממסדים את הקשר ומביאים ילדים לעולם בלי חתונה.

התופעה נפוצה באירופה. במדינות סקנדינוויה מחצית התינוקות נולדים להורים לא נשואים.

כיום כבר לא מצמידים אות קלון לזוגות שבחרו לחיות יחד בלי נישואים.

התופעה נתפשת כשלב מעבר טבעי בדרך לחופה או בלי קשר לחופה.

הנתונים מצביעים על עלייה במספר הזוגות המעדיפים לגור יחד ללא

נישואים באופן זמני או קבוע. לפי סקר עדכני, 26% מהישראלים הנשואים

התגוררו עם בן זוגם לפני החתונה ו-19% מהם חיו עם בן זוג בלי להינשא לו.

שיעור הזוגות החיים כיום בלי נישואים הוא 3.7% מהאוכלוסייה היהודית

בארץ, והוא עולה בקצב קבוע של כ-1% בשנה.

ידוע שבין אנשים משכילים ובעלי מעמד תעסוקתי יש יותר זוגרים. גם

זוגות בקשר שני לאחר נישואים מעדיפים את צורת החיים הזאת. מחקר

אמריקני קבע כי הסיכוי של זוגות שחיו יחד לפני הנישואים להתגרש בחמש

השנים הראשונות גבוה ב-29% מזה של זוגות שלא חיו יחד.

זוגיות פתוחה מוסכמת

התופעה הזאת קיימת משחר ההיסטוריה. בתרבות יוון ורומי היה מקובל

שלגברים יש בנות זוג חלופיות ולנשים יש גבר אחד בלבד. בשנות 1960,

כשהופיעו ילדי הפרחים שביקשו לעשות אהבה במקום מלחמה, ניתנה

לגיטימציה גם לנשים להחליף בני זוג, ועד שנות 1980 הייתה הזוגיות

הפתוחה נפוצה למדי. בעולם המערבי היו מועדונים מיוחדים שדרשו מכל

גבר לבוא עם בת זוג ונתנו לנשים להיכנס חינם. כשהתחיל עידן האיידס

איבדו המועדונים האלה את קהליהם.

היום הדברים נעשים ביתר דיסקרטיות. באינטרנט יש עשרות פורומים

המזמינים זוגות אל החוויה המינית של ביחד זוגי בשיתוף זוגות אחרים. יש

גם לא מעט מועדונים שיש בהם מפגשים זוגיים פתוחים. בזוגיות הפתוחה

כל אחד מבני הזוג רשאי לקיים קשרים ומערכות יחסים מחוץ לזוגיות בלי

לדווח לאחר עם מי הקשר, אבל כן לדווח מתי, והכול לפי החוקים והגבולות

המוסכמים על שני בני הזוג.

יש זוגות שחיים יחד בקומונה ומקיימים יחסים זה עם זה. יחסי המין

מתקיימים מחוץ לקשר הזוגי, ושני בני הזוג יודעים ובוחרים בזה. צריך להביא בחשבון שהקשר הפתוח יכול להביא לסגירת הקשר הבסיסי, ואחד מבני הזוג יכול לקום ולעזוב, ללכת אל אחר. מחקר מראה שבזוגות שהגבר יזם את ההרפתקה, הגבר הוא שיבקש בהמשך להחזיר את זוגתו הנהנית הביתה, כי מה שהציע מאיים עליו.

המטיפים בעד זוגיות פתוחה טוענים שהאדם אינו בעל חיים מונוגמי, ובני זוג – גבר או אישה – לא יכולים לספק זה לזה את הצרכים ואת הסקרנות המינית לאורך השנים. יש מחקרים על השינויים הכימיים שמתרחשים במוחנו בקשר הזוגי באשר לתשוקה ולמשיכה המינית. מחקרים מלמדים שכעבור ארבע שנים של זוגיות (בממוצע) אנחנו נעים מתשוקה למשיכה, ממשיכה לאהבה, מאהבה לאחריות בקשר, ומשם לתשוקה ולרצון לאחר. רבים טוענים שנישואים פתוחים הם צורך בסיסי לספק סקרנות. אנחנו נעים בין הצורך הבסיסי למוכר, לביטחון, לשלווה ולשגרה ובין הדחף הטבעי לחידוש, לריגוש ולכיבוש. זוגיות פתוחה מספקת את כל הצרכים. היא גם מונעת את מוטיב הבגידה ומסלקת חשדנות וקנאה. הפתיחות יכולה לתרום לזוגיות, להוסיף לה צבע, לרענן את חיי המין, הרגש והאינטלקט של הזוג המקורי.

המקטרגים יגידו שזוגיות פתוחה כן מעוררת קנאה וחשדנות, מורידה מערך הזוגיות המקורית ומייחודיותה, פוגמת באינטימיות. נמצא שאנשים שעוסקים בחילופי זוגות באים מרקע קשה, והקשר ההתפתחותי שלהם להוריהם חלש. רובם בתהליך פרידה מבני זוגם. עוד נמצא שאנשים שבעי רצון מאיכות החיים, מאורח החיים ומרמת הבריאות שלהם – חיים במשפחה סגורה.

יש גם זוגיות פתוחה שהיא פשוט כזאת בלי רקע כזה או אחר. לא לכל התנהגות יש סיבה חד-משמעית. הבה לא נפיל סטיגמה על מי שבוחר לחיות בזוגיות פתוחה.

קנאה בזוגיות

איום על מערכת היחסים מעורר קנאה. קנאה היא תגובה המשלבת רגשות,

מחשבות והתנהגויות. המקנא חש כאב, פגיעה, עלבון והשפלה, ואלה מעלים אצלו כעס וזעם, פחד מפני אובדן הקשר ומשאלות לפגיעה ונקמה. קנאה היא הפחד מאובדן האהבה, מאובדן האני העצמי, והיא עלולה להרוס את האהבה.

זוגיות מחייבת כללי יסוד שבלעדיהם אינה יכולה לתפקד במיטבה: אמון וביטחון וידיעה שהאינטימיות היא בלעדית ואין לה שותפים, אלא אם כן החליטו שני בני הזוג אחרת. גבולות המערכת הזוגית צריכים להיות ברורים. עם זה קנאה בריאה יכולה לעורר מחדש את התשוקה המינית בין בני הזוג ואף לחזק את הנישואים. יש שרואים את בן הזוג עם אחר וחשים קנאה בריאה, שגורמת להם לרצות שיעשה איתם מה שעשה עם האדם הזר. רגש כזה מעורר מחדש את התשוקה המינית.

ג'ורג' וננה א'נל תיעדו בספרם "נישואים פתוחים" (1972) את מערכת הנישואים הממושכת שלהם. השניים האמינו כי אפשר לאהוב כמה אנשים בו בזמן וכי המונוגמיה היא גזירה שהמין האנושי לא יכול לעמוד בה. הם טענו כי בנישואים אין מקום לקנאה רומנטית, כי קנאה היא הפחד מאובדן האהבה והיא הורסת את האהבה עצמה.

אילנה, בת 47, נשואה לעדי, ויש להם שני ילדים. עדי מצויר עירום לפרנסתו. בכל יום-יומיים מדגמנות בסטודיו שלו יפיפיות בשנות העשרים. אילנה חוששת שהוא מפנטז עליהן כשהוא שוכב איתה. היא בוערת מקנאה ומחרדת נטישה עד שקשה לה לתפקד. פעם הייתה היא המודל שלו, וכיום כבר לא. היא מוטרפת מייאוש ושואלת מה עושים.

לאילנה, מי שמקנא פוחד לאבד את בן הזוג. והפחד שלך גדל כשמושא הקנאה נמצא בסטודיו של בעלך בעירום. נוסף על הפחד יש גם אי-אמון, והקושי שלך מתבטא אצלך בחשש מבגידה רגשית. ציור העירום הוא פרנסתכם, לכן ראוי שתספרי לבעלך על מצוקתך ועל חששך. שיחה כנה ועמוקה תתקבל בברכה, והתשובה תוכל להביא את סערת נפשך לרוגע, וחיי המין שלכם יהיו חופשיים יותר ונטולי חששות. פתחי את ליבך מול בעלך כדי לחזק את ביטחונך ואת זוגיותך.

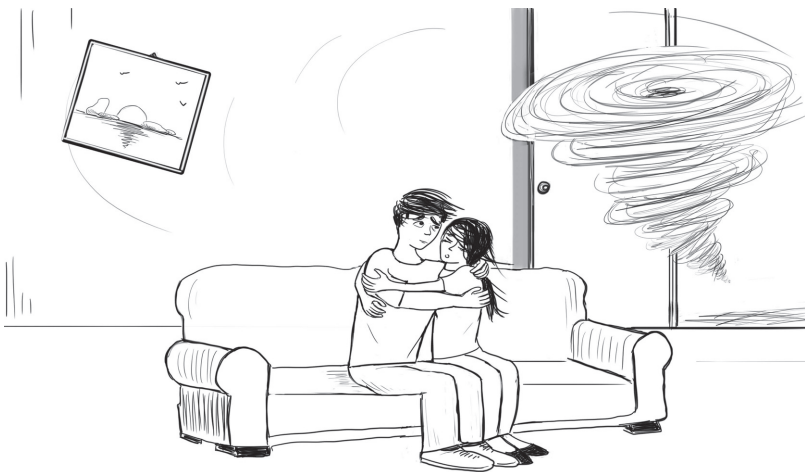
זוגיות וכסף

מערכות יחסים כרוכות גם באינטרסים. זוגיות היא יחידה כלכלית, ואפשר לראותה כשותפות עסקית לכל דבר. בתחילת הדרך, כאשר הזוגיות רק נבנית, עולות פנטזיות הקשורות להתבססות הכלכלית של בני הזוג. במקרים של חוסר ודאות או משבר כלכלי חל איום על שותפות זו, והמחויבות ההדדית והנאמנות עומדות במבחן.

יש קשרים המסתיימים למרות האינטרס המשותף. לא הכסף ישאיר בזוגיות את הצד המתוסכל והסובל. לא היופי לבדו ישאיר גבר כרוך אחרי אישה. אבל יש גם מקרים שהכסף הוא שמנחה את הנפש ואת הזוגיות.

ריבים בזוגיות

מערכת יחסים בין בני זוג חווה עליות ומורדות. ריבים הם בדרך כלל מצב נפשי וחוויתי לא נעים התורם בעקיפין גם לבעיות בריאות. שלושה נושאים מובילים הם סלע המחלוקת: כסף, מין וחינוך ילדים. יש גברים שיטענו כי נשותיהם מקיימות יחסי מין הרבה פחות מהדרישה



ומהצורך שלהם. שהן מבזבזות כסף. יגידו שהנשים קשות וקשוחות מדי בחינוך הילדים.

יש נשים שחשות ההפך. יגידו שגברים מתקמצנים כשצריך לקנות מגפיים חדשים אבל לא מהססים להוציא סכומי עתק על גאדג'ט חדש ומלהיב. יתלוננו על מיעוט שיחות ועל מיעוט בילויים רומנטיים שמובילים לסקס. יחוו שגברים לא משקיעים די זמן ואנרגייה במשחק המקדים. בחינוך הילדים ילינו שהן נאלצות לשחק את תפקיד השוטר הרע בהיותן הדמות המטפלת בילדים בבית, והגבר בא בסוף יום העבודה ומבלה עם הילדים בסופי השבוע וכך זוכה בכל ההנאה. הקשבה, הבנה והליכה לקראת חשובים לקשר זוגי מאריך ימים.

לימודי זוגיות

בארה"ב מכינים את הדור הצעיר למערכות יחסים זוגיות לפי תוכנית לימודים חדשה, שבה בני הנוער לומדים כיצד מנהלים מערכת יחסים בריאה. התלמידים דנים בסוגיות כמו ניהול סכסוכים זוגיים, ניהול סיכונים, פרידות, גירושים ושיח זוגי.

חשוב שמיומנויות הקשורות לניהול מערכת יחסים זוגית יירכשו בגיל בית הספר. שיעור בזוגיות מעניק לתלמידים את האפשרות להתנסות, לתרגל, להטמיע, להפנים וליישם את הנלמד במסגרת חברויות ויחסים זוגיים שלהם. ולא רק הזוגיות שלהם נשכרת מכך, אלא גם ההתנהלות הכללית שלהם בחברה, בעבודה, במשפחה.

שקרים בזוגיות

לפעמים שקרים משרתים מטרה במערכת יחסים. הם מסייעים לגשר על פערים בין פנטזיה למציאות, בין ביחד ללחוד, בין האני הפרטי לאני הנבלע בקשר הזוגי.

איך נדע שבן [בת] הזוג משקר? לפי כל אלה: הוא מדבר בצורה רשמית

רחוקה מעצם הנושא המדובר ומתחמק באלגנטיות. יש שינויים בנימת הקול. נדרש לו זמן כדי לענות על שאלה; תשובות על שאלות פשוטות מסובכות וארוכות; הוא מנסה להסיח את הדעת; שפת הגוף שלו משתנה; הוא מעליב ולא מכבד את השיחה. בדרך כלל האינטואיציה שלנו מספיקה, אבל צריך לשמור על מידתיות.

בזוגיות כל אחד משקר מדי פעם. משקרים על אירועים קטנים חסרי חשיבות. משקרים כאשר יש קושי בתקשורת ובקשר הזוגי, דבר היוצר פחד, חשד וחוסר אמון. ויש גם שקרים פתולוגיים המסתירים התנהגות בעייתית. לכל אחד מאיתנו יש קווים אדומים משלו.

זקפה



התהליך

הזקפה היא חלק מתהליך טבעי המתרחש אצל הגבר כתוצאה מתהליכים נפשיים וגופניים מורכבים. תהליך היווצרות הזקפה מבוסס על שילוב ותזמון של מנגנונים פסיכולוגיים, נוירולוגיים, הורמונליים, מערכות כלי דם, גירוי החושים, גירוי מחשבתי, גירוי ישיר ועקיף של הפין ועוד. במצב הרפיה של הפין השרירים וכלי הדם בגופים המחילתיים שבו נמצאים במצב מכווץ, ולכן כמות הדם הזורמת בעורקים קטנה יחסית (2-8 מיליליטרים בדקה). בעקבות גירוי מיני גוברת פי 3-7 זרימת הדם בעורקים הפודנדליים (המקור הראשי להספקת הדם לאיבר המין), מה שגורם לעלייה בלחץ הדם בגופים המחילתיים. הגדלת הנפח והלחץ בחללים האלה יוצרת לחץ מכני על הוורידים, וכך נחסמת זרימת הדם מהפין חזרה לגוף, מה שיוצר זקפה וקשיחות. מבחינים בשלושה סוגי זקפה: זקפה רפלקסוגנית, שהיא תוצאה של גירוי באזור אברי המין; זקפה פסיכוגנית, שהיא תוצאה של גירויים חזותיים, שמיעה או פנטזיה; זקפה לילית – מתרחשת בשנת REM (rapid eye movement), והיא זקפה תת־הכרתית.

זקפה לילית

יש כמה השערות באשר לתופעה של זקפה לילית או זקפת הבוקר. במשך

הלילה השלפוחית מתמלאת, והשלפוחית המלאה יכולה ללחוץ על עצבים באזור האיבר ולגרום לו זקפה. כל גבר חווה בלילה גם כמה זקפות ספונטניות שאינן קשורות לגירוי מיני. ברובד שנת REM מתרחשת זקפה בלי כל קשר לחלום או לכל גירוי חושני מעורר אחר. התרחשות זו נובעת עקב הצורך בהספקת דם סדירה ותדירה לאיבר המין. הספקת הדם הסדירה שומרת על ויטליות האיבר ועל כושר הזקפה.

אדריאן, בן 38, מתעורר כל בוקר עם זקפה כמו טיל ורוצה להתחיל את היום ברגל ימין. זוגתו לעומת זאת מסתובבת לצד השני וממשיכה לחלום. טוענת שבבוקר, היא עייפה וחסרת חשק. הם שוכבים רק בלילה, אבל אז הוא כבר עייף ונהנה פחות ואין לו הרבה כוח להשקיע בבת זוגו. אדריאן שואל מה לעשות כדי לא לבזבז את הזקפות הטובות שלו ואיך לשכנע את זוגתו להסכים לאהבה על הבוקר.

לאדריאן, נכון שיחסי מין יכולים להיות פתיח ליום מלבב, אך זקפת הבוקר אינה מעידה על חרמנות, על משיכה או על עניין בסקס. יש גברים שזקפת הבוקר מציקה להם והם משתוקקים להשתחרר ממנה, בדרך כלל בהטלת מימיהם בנחת מעל האסלה.

לגופו של עניין, חשוב בראש ובראשונה להדגיש שחברתך היא כאחד האדם ואין בהתנהגותה סימן לכך שאינך סקסי מושך ומיני. לכל אחד מאיתנו צרכים משלו, וביחסים זוגיים דרושים הקשבה, תשומת לב, משא ומתן ובעיקר גמישות. כל אלה יביאו למיניות טובה ומספקת. אם תשקיע בבת זוגך בתבונה בלילה, אין לי ספק שמדי פעם היא תבוא לקראתך בבוקר.

הפרעה בזקפה

לגברים רבים בגיל מתקדם יש הפרעות בזקפה. ידוע שבגיל ארבעים כ-40% מתחילים ללקות בתפקודם, בגיל חמישים כ-50%, וכך זה עולה. לא מדובר בחוסר זקפה אלא בהפרעה, שהיא חוסר יכולת להשיג זקפה או לשמור

על זקפה המאפשרת מגע מיני מלא. יש הפרעה ממקור רגשי ויש הפרעה ממקור גופני.

ההפרעה הרגשית השכיחה ביותר היא חרדת ביצוע. היא מופיעה בעיקר בתחילת הקשר המיני, כאשר הגבר מרגיש שבת הזוג מצפה ממנו לנווט את העניינים או משום שהוא מאוד נמשך אליה וחושש שלא יתפקד טוב. יש גם מקרים של קושי בזקפה בגלל קשיים במערכת היחסים הזוגית.

הגורמים הגופניים העיקריים הם גיל ומחלות. בחלוף השנים ניכרת ירידה הדרגתית בתפקוד הפיזיולוגי של הגבר וחלה גם עלייה בשכיחות המחלות הכרוניות אצל הגבר ואצל האישה. עם זה אצל גברים רבים מאוד הגיל לא גורם לבעיות בזקפה. גברים רבים בני שמונים מקיימים יחסי מין סדירים. יש מחלות הפוגעות בזקפה בגלל המחלה עצמה ובגלל הלחץ הנפשי הכרוך בה: סוכרת, מחלת לב, דיכאון, יתר לחץ דם ועוד. מחלת הסוכרת למשל פוגעת בכלי דם קטנים בכל הגוף וגם באיבר המין, וכך היא אחד הגורמים השכיחים להפרעה בזקפה. משפיעים לרעה גם סמים, סיגריות ואלכוהול הנצרכים בכמות גדולה. ניתוחי אגן וניתוחים להסרת הערמונית כתוצאה מגידול ממאיר עלולים לפגוע בעצבים שבאזור איבר המין וכך להפריע לזקפה.

עוד גורמים: תרופות לטיפול ביתר לחץ דם, תרופות להפרעות בקצב הלב, תרופות נגד דיכאון. הנוטלים תרופות כאלה צריכים להיוועץ ברופא המטפל ולנסות למצוא תרופות שמפריעות פחות לתפקוד המיני.

אריאל בן 22 ויוצא עם בת 26 כבר שנה וחודש. מערכת היחסים טובה מאוד ופתוחה. הבעיה היא שבכל פעם שהם מנסים לשכב הם לא מגיעים למצב של חדירה, לרוב בגלל שהזקפה לא קשה מספיק זמן. אריאל מרגיש שהחברה שלו ממש צרה, והוא לא מצליח לחדור. הם ניסו כבר כל מיני תנחות, ושום דבר לא עוזר. זה לא קרה לו עם בנות אחרות. בזמן אוננות ומין אוראלי הזקפה שלו נמשכת הרבה יותר זמן. אין בעיה של יובש בנרתיק אצל החברה. אריאל שואל אם יש משהו שהם יכולים לעשות.

לאריאל, השאלה היא היכן הבעיה – אצלך או אצלה. אין לי ספק שהתסכול אצל שניכם הוא רב, וכל אחד שואל את עצמו שאלות לגבי

חלקו ואחריותו בקושי התפקודי. טוב שאינכם עוסקים בהאשמות הדדיות אלא בניסיון להבין ולתקן. כדי להגיע לאבחון נכון באשר למקור הקושי צריך לתשאל ולבדוק את שניכם. בעיית זקפה בגיל צעיר היא בדרך כלל על רקע פסיכולוגי, וייתכן שזהו המקרה אצלך, במיוחד לאור העובדה שיש לך זקפות טובות בזמן אוננות ובמין אוראלי. הקושי הפסיכולוגי בא לידי ביטוי בחרדת ביצוע. יכול להיות שהיית בלחץ בפעמים הראשונות שבהן ניסיתם לקיים יחסי מין מלאים, ועד היום אתה בלחץ ומתקשה לתפקד. אבל קשה לחשוב כך, כי אתה מתאר מערכת יחסים פתוחה וטובה וממושכת. במערכת כזאת סביר להניח שאם הכול היה בסדר, כבר הייתם מצליחים לקיים יחסי מין מלאים. ייתכן שמקור הקושי הוא אצל החברה, והיא לוקה בווגיניזמוס. בעיות הזקפה הן על רקע פסיכולוגי, אך הן למעשה בעיה משנית שהיא תוצאה של הקושי של בת הזוג לקיים יחסי מין מלאים. אצל זוגות צעירים יש מקרים לא מועטים שבת הזוג מכווצת את שרירי פתח הנרתיק מסיבה זו או אחרת, אי אפשר לחדור אליה, ואז הגבר עלול לפתח בעיות זקפה. בלי לפגוע באף אחד מכם, ידוע שאיבר המין של הגבר בדרך כלל יוותר ולא ייכנס למקומות שקשה לו להיכנס. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בקשר רגשי, שיש בו אהבה ופתיחות, שהרי אין ברצונך לגרום כאב ואי־נוחות לחברתך. במצב הזה אין יחסי מין מלאים לאורך כל תקופת הקשר. מומלץ שתפנו יחד לייעוץ מקצועי. לאחר אבחון תקבלו תשובה ודרך נכונה לטיפול.

המטופל והרופא

מחקר שנעשה בארץ מצא שרק 11% מהגברים דיווחו שבביקור אצל הרופא הם נשאלו על תפקודם המיני. 8% לא דיברו עם הרופא כי לא רע להם עם מצבם. 38% חשבו שזה חלק טבעי מהמחלה ואין מה לעשות. 23% קיוו שהמצב זמני וייעלם עם הזמן. 20% התביישו ולא חשבו שהבעיה רצינית. 18% חשבו שהבעיה לא רפואית. 11% טענו שאין להם רופא קבוע וקיוו שהשאלה תבוא מצד הרופא שפגשו.

בדרך כלל למטופל יש קושי לדבר על התחום המיני, וגם הרופא מתקשה בכך מכמה סיבות – לעיתים מחוסר זמן, לעיתים אינו רוצה להיתפס כמטריד בשאלות מחוץ לתחום התמחותו. וייתכן שגם לרופא יש עכבות בפתיחת התחום המיני. כשמין הרופא אינו מינו של המטופל, לא נעים למטופל לדבר על בעיותיו. ויש קושי לפתוח את הנושא המיני גם מעוד סיבות מסיבות שונות.

התרופות

אין כדור לטיפול בזקפה שנכון להמליץ עליו עם או בלי מרשם רופא. כל גבר מגיב אחרת לכדור זה או אחר. כל גבר מעדיף כדור מסוים. הכדורים סיאליס, לויטרה, ויאגרה ותרם הם כדורים המיועדים ליצירת זקפה מחקרים מלמדים שהם עוזרים ל-78% מהגברים שיש להם בעיית זקפה על רקע גופני.

הכדורים אינם מיועדים לעזרה בשפיכה מוקדמת, אבל יש מחקרים הגורסים שנטילת כדור לזקפה משפרת גם את התפקוד ואת עיכוב השפיכה.

התרופה גורמת גירוי קצות העצבים בתא ומעלה את רמת NO, המפעיל את המערכת האנזימטית. התרופה גורמת לעיכוב האנזים פוספודיאסטרזא PDE5, אשר דרך שרשרת של פעולות ביוכימיות גורם לעיכוב פירוק האנזים cGMP ומעלה את רמת הסידן בתא, מה שגורם להרחבת השריר החלק בכלי הדם ולזרימת דם מוגברת לאיבר המין בעקבות גירוי מיני. כתוצאה מכך מתרחשת זקפה.

יש גם תכשירים טבעיים רבים, שתכליתם להעצים את החשק המיני ואת הביצועים. תכשירים אלו מכילים תערובת של עשבים שנמצא שיש בהם בכדי לתרום לתפקוד המיני. בין הרכיבים העיקריים: יוהמבין, ל-ארגינין, ג'ינסנג, ליסידיום, אנגליקה, מגנזיום. כל אלה בצורת אבקות, כדורים ומשקאות. יש לא מעט תכשירים – כדורים, ג'לים ומשחות – שנמכרים בשוק השחור במיליוני שקלים כל שנה, ואסור להתפתות לתכשירים אלו בגלל מחירם הזול.

רועי זקוק מאוד לכדורים לזקפה, אך מחירם יקר והוא מתבייש לבקש מהרופא מרשם עבורם. רועי שואל אם יוכל להשיג בבתי המרקחת בלי מרשם רופא תרופה לא יקרה או צמחי מרפא שייעילותם דומה לזו של הוויאגרה לשיפור האון הגברי.

לרועי, לרפואה המודרנית יש כיום מענה למצוקתם של גברים רבים בתחום התפקוד המיני. חבל להסתיר, לחשוש ולסבול כאשר אפשר לשפר את התפקוד המיני ומעצם פעולה זו לשפר גם את איכות החיים. קשה להעריך את יעילותם של תוספי המזון וצמחי המרפא. מומלץ שתפנה לרופא המטפל בך לקבלת תרופה לשיפור תפקודך המיני.

ישעיהו שואל אם כאשר יש זקפה ורצון לקיים יחסי מין, אך לא מקיימים אותם בגלל עייפות בת הזוג, זה פוגע בתפקוד המיני ובפוריות. כלומר, זוהי זקפה לא ממומשת.

לישעיהו, התשובה היא לא. אין פגיעה בתפקוד המיני ולא בפוריות. כאשר הזקפה לא ממומשת אין כל נזק – לא לתפקוד המיני ולא לפוריות. כשאין מימוש של הזקפה חל תהליך טבעי של כיווץ השרירים וכלי הדם המחילתיים, ואיבר המין עובר שינויים בסדר הפוך לתהליך הזקפה עד להרפייתו המלאה.

חיזור



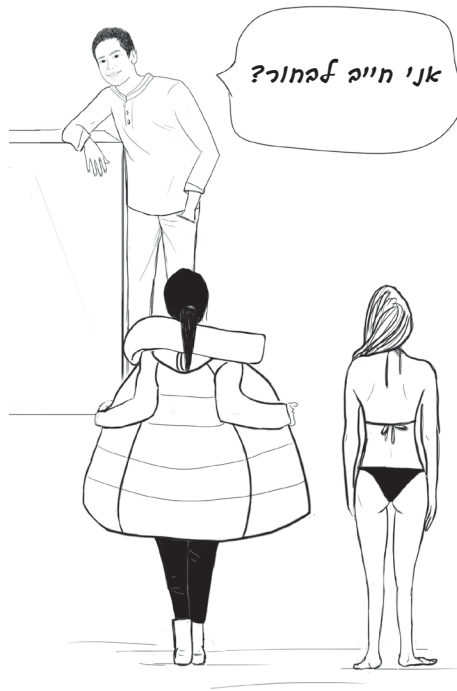
בעולם בעלי החיים הזכרים מוקפדים ומקושטים יותר בהופעתם מהנקבות. כל ההשקעה נועדה למשוך את הנקבה ולפתות אותה כרכיב ראשון בריקוד החיזור. האריה ורעמתו, התרנגול וכרבולתו, הטווס וזנבו – עטורים כל השנה במראה חיצוני מושך. קרני האיילים צומחות לקראת האביב. נוצותיו החמות של ברווז המנדרין נושרות, ואחרות צבעוניות צומחות כאשר מתחילה עונת החיזור. אותו לבוש כלולות מיוחד אצל בעלי החיים הזכרים בא לידי ביטוי ביתר תשומת לב במראה הגופני של הגברים. כל השינויים באים לבטא את היותנו מוכנים לרבייה. הגברים קרוצים מזן משובח אשר ישביח את הגנטיקה של הנקבה. כמו בעלי החיים גם הגברים מתהדרים בגינוני עמידה והליכה בהפגנת הגוף כדי להרשים ולמשוך את תשומת ליבה של הנקבה.

נקבות בעלי החיים מושכות בני זוג באביב באמצעות הפרשת פרומוני מין, שהם הבושם של הטבע. באמצעותם הנקבה מודיעה לזכרים שהיא בשלה מבחינה מינית ומזמינה אותם אליה. הזכרים המריחים את הפרומונים יודעים שהנקבה מוכנה להזדווגות.

בני האדם נוטים דווקא להסוות את ריח גופם בשימוש בבשמים, בסבונים ובדאודורנטים ריחניים. יצרני הבשמים מבטיחים שהבשמים יעניקו לנו נוסף על ריח טוב גם את היכולת למשוך את נסיכי החלומות שלנו. נשים וגברים מתבשמים באביב וגם פושטים את פרוות החורף ומאפשרים לריח הטבעי ולריח המוזלף על הגוף למשוך בני זוג שיחזרו אחריהם בטירוף חושים.

בני אדם מתבשמים ומתעוררים מינית בכל עונות השנה. הם משילים

את הבגדים, ומיעוט הבגדים משפיע על המשיכה. היופי בחיזור הוא המסתוריות והעובדה שלא יודעים אם החיזור באמת יצליח.



המחקר מלמד שגברים נמשכים יותר למראה עיניים ונשים למשמע אוזניים. יש נערות שנמשכות יותר לנערים שמקרינים ביטחון וכוח, אבל על פי רוב אם נערה תשמע דברים שנעימים לה, היא תיעתר להמשך החיזור הוורבלי. רכיבים של משיכה בקרב בני נוער פעמים רבות הם מקובלות ולחץ חברתי.

שם המשחק בחיזור הוא סבלנות וסובלנות. חשוב להיות רגיש לצד השני, לצרכיו, לא לצפות לסיפוק מיידי, לראות מה הצד השני אוהב, למה הוא זקוק. חשוב לדבר בשפה מכבדת. והכי חשוב שהמחזר יהיה הוא עצמו. התנהגות לא אמיתית תתגלה. חשוב לא להיות ישיר מבחינה מינית, לא להיות יהיר מבחינת הצגת העצמי, להיות גמיש. חשוב חוש הומור אבל לא התחכמות. צריך להיות מצחיק עד גבול מסוים ולא לפגוע. חשוב לא להקטין את היושב ממול.

חילופי זוגות



יש בני זוג המנהלים מערכת יחסים פתוחה מתוך אמונה כי אפשר לאהוב כמה אנשים בו בזמן וכי מונוגמיה היא גזרה שהציבור אינו יכול לעמוד בה. סקרים מלמדים שכ-300,000 זוגות חיים בארץ בזוגיות פתוחה. חילופי זוגות (swinging) – החלפת בני זוג למטרת מין. בני הזוג מכירים את בני הזוג האחרים, וחילופי הזוגות נעשים תמיד באותו הזמן. בדרך כלל הם נעשים בבתי פרטיים, ויש גם מועדונים מיוחדים לשם כך. באינטרנט יש עשרות פורומים ואתרים המזמינים חילופי זוגות. בחילופי זוגות מבחינים בין מין רומנטי שהוא חלק מחיי

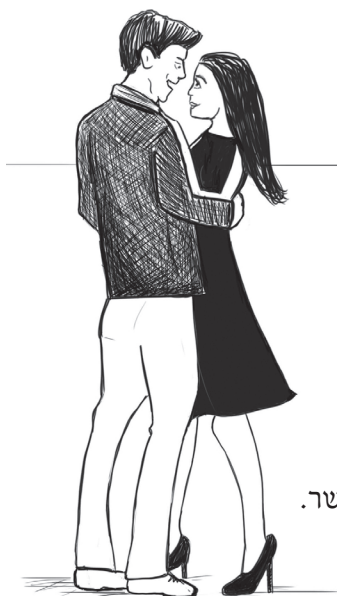
הנישואים, לבין מין גופני,

שהוא הנאה פיזית בלבד. הזוגות מגוננים על עצמם מפני הסיכונים האפשריים בנישואים פתוחים בקביעת נורמות ברורות נגד הבעת רגשות רומנטיים ונגד התאהבות מחוץ לנישואים.

האקט המיני אמור להיות שעשוע

בלתי מזיק, שאינו "בגידה" ואינו מוביל לפירוק הקשר.

החילופים הם לצורך מין בלבד בלי כל רכיב רגשי ובלי שום מחויבות. זוגות נכנסים להתנהגות מינית זו



מתוך צורך בחידוש וברענון חיי המין. הם נכנסים לעניין בראש צלול. במועדונים אוסרים על צריכת אלכוהול וסמים, ומקפידים לשמור על מין בטוח.

המניעים הם פסיכולוגיים וחברתיים. אפשר לדבר על דחפים ביולוגיים ועל כמיהה להוסיף חוויות. הבעיה היא שלפעמים לא מוצאים את הדרך חזרה. האגו עלול להתנפץ אל מול הביצועים של המחליף. לפעמים דווקא זה שהפציר להיכנס לעניין הוא שחוזר בו.

ברוב המקרים ההצעה לפתיחת הנישואים באה מהבעל. כשהאישה נותנת את הסכמתה, עומדות לפני הזוג שלוש אפשרויות: מפגשים עם מאהב או מאהבת (בגידה בהסכמה); חילופי זוגות; צירוף של פרטנר אחד או יותר למיטה הזוגית. בגידה בהסכמה מחייבת הסכם המגדיר את טיב היחסים שבני הזוג ינהלו עם השותפים האחרים.

היחסים הפתוחים מבוססים על הסכמה שלא תהיה כל מעורבות רגשית עם הפרטנר המיני ושכל אחד מבני הזוג יחזור לישון בבית. בגלל המורכבות של מערכת יחסים שכזאת, הצורה הנפוצה יותר של קשר מיני מחוץ לנישואים היא מפגשים לצורך חילופי זוגות.

אחייעד, גבר שהשתתף עם אשתו באירוע חילופי זוגות, מספר שלא היה מסוגל להתרכז באישה ששכבה עירומה לידו. אוזניו היו כרויות לשמוע כל רשרוש וצחקוק שהגיע מהפינה שבה שכבה אשתו עם גבר אחר. נראה שאשתו נהנתה מאוד, וזה היה נורא. שבה ועלתה בו תחושת חוסר הביטחון שחש בהיותו מתבגר רזה וביישן. הוא לא היה מסוגל לסבול את ההשפלה.

חינוך מיני



בעידן המודרני חשוב שהחינוך המיני יהיה חלק מתוכנית הלימודים, אבל ב-40% מבתי הספר בארץ אין שיעורי חינוך מיני. לכן עדיין יש צורך בהתערבות ההורים בחינוך המיני של ילדיהם. כשאין דיבור בבית ואין הדרכה בבית הספר, הילד יקבל הדרכה מפוקפקת באינטרנט. מגיל צעיר מאוד הילדים חשופים בטלוויזיה לסרטי אלימות, מין ופגיעה מינית. הם חשופים לחומרים פורנוגרפיים ואירוטיים ולמסרים מיניים בוטים, וכך אינם לומדים להבחין בין התנהגות מינית נאותה ובין התנהגות לא טבעית ולא תקינה. תפקיד ההורים להדריך ולכוון את הילדים, להעביר להם מסר שיחסי מין מתקיימים מתוך אהבה וכבוד ולעודד אותם ליצור קשרי חברות. ילדים שירכשו את הידע המיני שלהם מסרטי מין באינטרנט יפתחו התנהגות מינית לקויה ובעייתית, ולימים, לא מעט מהם יזדקקו לטיפול מיני.

הורים רבים מתקשים לדבר בפתיחות עם ילדיהם על מין, והסיבות הן אלה: מבוכה, לא מוצאים את הזמן המתאים, לא יודעים איך לפתוח בנושא, חוששים שעצם הדיבור על הנושא יכניס לילד רעיונות שהוא לא חשב עליהם מראש. ויש גם סיבות הקשורות לתפיסת החיים של ההורים ולרקע שבו גדלו.

אפשר לפתוח שיחה בנושא כשיש בטלוויזיה סצנה מינית. אפשר לשוחח בזמן נסיעה עם הילד (או הילדה) לבד במכונית. שילוב של הומור תמיד ישבור את הקרח. חשוב שהילד יהיה בטוח שתמיד ובכל מצב ההורה הוא הכתובת לבעיות, להתלבטויות ולשאלות בנושא המין. יש צורך ביצירת

אמון בין הילד להורה. כשהילד נבוכ מהשיחות עם ההורה או כאשר להורה לא נוח לדבר עם ילדו על מיניות אפשר להביא לילד ספרות בנושא. הילד הוא יצור מיני. ההנקה, החיבוק והמגע החם בחודשים הראשונים לחייו מעניקים לו ביטחון, חום ואהבה. ילד שיקבל חום ואהבה ומגע גופני ידע להיות יצור חברתי שיודע לתקשר בגופו.

כבר בגיל צעיר מאוד ילדים מתחילים לאונן. בגיל שנה הם נוגעים באיברי המין שלהם, ובגיל שלוש הרבה ילדים מאוננים, כי זה נעים להם. אסור שהתגובה תהיה קיצונית ושוללת. צריך להסביר לילד שמגע באזורים אינטימיים לא נהוג לעשות בפומבי. תגובה קיצונית של ההורה יכולה להתפרש אצל הילד כמסר שלילי על הנאה ותחושות עונג גופני, דבר שעלול לפגוע בתפקוד המיני שלו בעתיד. משחקים מיניים של רופא-חולה-אבא-אימא ומגע באיברי המין הם ביטוי של סקרנות להבדלים בין המינים, וזוהי תגובה נורמטיבית לחלוטין.

אחת השאלות המטרידות אימהות כשלבנותיהן המתבגרות יש חבר היא אם לדבר איתן על יחסי מין, אם עצם העלאת השיחה לא תעודד אותן לקיים מוקדם יותר יחסי מין. לא נכון ולא צריך לשלול פעילות מינית בקרב המתבגרות והמתבגרים ולא נכון לחנך אותם להתנזרות. חשוב ללמד את המתבגרים לדחות את תחילת קיום יחסי המין עד שירכשו בגרות פיזית, קוגניטיבית ורגשית כדי שיצליחו לפתח קשר מיני אינטימי. חשוב ללמד את הבנות להימנע מהתנהגויות שמסכנות אותן מבחינת כניסה להיריון לא רצוי או הידבקות במחלות מין. הורה יכול לא להסכים או לחשוב שהנערה צעירה מדי להתחלת קיום יחסי מין. עם זאת עליו לכבד את החלטתה ולהדריך אותה בקיום יחסי מין אחראיים ומוגנים. חשוב שלא יהיה שיפוטי וביקורתי. ההורה צריך לנסות ולהבין את נקודת המבט של הנערה. מלחמה רק תעורר התנהגות של דווקא. צריך להכין את הנערה לקבלת המחזור החודשי ולהדריך אותה איך להתנהג כשמגיע המחזור. נכון גם לשקול חיסון נגד וירוס הפילומה, שהוא גורם משפיע על התפתחות סרטן צוואר הרחם. מתברר שדווקא בבתים שבהם יש פתיחות מבחינה מינית ושיח חופשי הורים-ילדים בנושא, הנערות לא ממהרות לקיים יחסי מין. כל נער ונערה צריכים לדעת שההורה תמיד נמצא כדי לקבל אותם כמו שהם ולעזור להם בכל בעיה או שאלה. וההורים

צריכים להימנע מלהכניס אותם ללחצים ולמתחים ולספק להם רק מידע אובייקטיבי נקי מהאמונות והחרדות שלהם. למעורבות ההורים יש אפוא השפעה עצומה על ההתנהגות המינית של ילדיהם. ככל שההורים פתוחים יותר ומעורבים יותר, כך הם יכולים למנוע התנהגות מינית המסכנת את ילדיהם.

חשק ותשוקה



תשוקה

מחקר חדש מייחס הבדלים אינדיבידואליים בתשוקה המינית של בני אדם לשונות הגנטית ביניהם. לא מן הנמנע שבמאה העשרים ואחת ינותבו בעיות מיניות מן הפסיכולוגיה הקלסית אל הרפואה הגנטית ואל מדעי המוח.

המחקר מספק נתונים המראים כי הבדלים פשוטים ברצף הדי־אן־איי משפיעים על התשוקה המינית, על העוררות ועל התפקוד המיני ומובילים להבדלים ולגיוון בתכונות הגנטיות הנראות לעין (פֶּנוּטִיפּ).

במחקר בחנו החוקרים את הדי־אן־איי של סטודנטים ישראלים בריאים, נשים וגברים, והשוו את התוצאות לשאלוני הערכה עצמית שמילאו הנבדקים על תשוקה מינית, עוררות מינית ותפקוד מיני. התוצאות הראו מתאם בין המשתנים בגנים לבין דיווחיהם של הנבדקים על מיניותם.

החוקרים סבורים שהמשתנים הקובעים את התשוקה המינית הם המוטציה המגבירה אותה והמוטציה המדכאת אותה.

ליבידו

הליבידו או הדחף המיני מביע את עוצמת החשק המיני, ויש בו רכיב גנטי מולד. בלי קשר לגנטיקה, ליבידו נמוך יכול להיות קבוע או תלוי מצב.

משפיעים עליו מצבי דחק וחרדה, חוסר בהורמון טסטוסטרון, עודף בהורמון פרולקטין, דיכאון, נטילת תרופות, סיבות פסיכולוגיות, שיעמום ושגרה במערכת היחסים ומשברים בזוגיות.

פער בצרכים המיניים של בני זוג הוא מנת חלקם של רוב הזוגות. התפיסה הרגילה בחברה היא שהגבר הוא שנשאר עם חצי תאוותו בידו, ואולם גם לא מעט נשים מלינות על בן זוג חסר חשק ותאוה.

בזוגיות הכול אמור להיות פתוח לשיחה ולדיון. זוגיות מוצלחת מחייבת הבנה של צורכי כל אחד מבני הזוג, הליכה לקראתו, ויתור והתפשרות. החיים מביאים אל הזוגיות עומס של עבודה, גידול ילדים, דאגה למשק הבית ועוד. כל אלה יש בהם כדי להביא למצב שאין בו סקס, ומצב זה מפתח כעסים ותסכול מיני של אחד מבני הזוג.

אורנה התחילה לצאת עם בחור נאה, והוא נראה מתלהב, מתקשר ומכרכר סביבה. אבל המין איתו די מאכזב מבחינת התכיפות. די לו בפעמיים בשבוע, והיא רוצה פעם ביום. אורנה שואלת אם נכוננו לה חיים של רעב מתמיד כאשר יתחתנו, או אפשר לגשר על הפערים. **לאורנה**, שאלתך עוסקת גם בליבדו וגם בפער בצרכים המיניים. ייתכן שבחורה אחרת תמצא את רמת הליבדו של הבחור גבוהה ומספקת. ראי, החיים דינמיים ומלאי שינויים. עדיין את לפני שלב גידול ילדים, כניסה לעומס החיים, שגרה ושחיקה, שהם גורם לירידה בחשק וברצון לתדירות יום-יומית של היחסים. מומלץ שתדוני בעניין עם הבחור. פתחי את ליבך וספרי לו על צרכיך ממקום חיובי, וייתכן שיסכים לקיים איתך יחסים תכופים יותר ממקום אוהב ומתחשב.

חשק וירידה בחשק

נוסף על גנטיקה ארבעה רכיבים תורמים לחשק מיני: בריאות גופנית, נינוחות וגמישות רגשית וזוגית, הגשמה אינטלקטואלית ומעשית, שביעות רצון אישית וזוגית.

מושיקו מספר: עוד לפני שהטלתי את מימי, מבעד לקורי העכביש המרקדים על ריסי עיניה המצועפות משנת הלילה היא מתריסה: "תגיד, כשהחשק שלך עולה אז אתה רגיש, מפנק, מוכן ללכת איתי לקצוות תבל ולתת הכול. אבל בבוקר אתה מתנהל כאילו כלום לא קרה."

מיהרתי לענות לה: "תראי, לפי התיאוריה שלך הייתי מוכן ללכת איתך לכל מקום כל הזמן. כי בא לי עלייך כל יום כל היום." ואז שאלה: "אז איך אתה מסביר שאתמול כל כך חזרת אחריי, ואחרי יחסי המין אתה כאילו לא מכיר אותי?" הסברתי לה: "ככה אנחנו בנויים. המניע של אישה לקיים יחסי מין קשור ברצונה לקרבה רגשית, למחויבות ועוד. כשטוב לכן במערכת יחסים, מיניותך יורדת פלאים. אצל הגברים מה שמניע זה הצורך הסוציו-ביולוגי לפזר את זרעם. אנחנו הצייד הקדמון."

בלי סטיגמות מגדריות – יש הבדל בין תגובותיהן של נשים לתגובותיהם של גברים כמעט בכל תופעה של ההתנהגות האנושית. יש שוני בין אישה לאישה ובין גבר לגבר בתגובות לאירועי החיים, קל וחומר יש שוני בהתנהגות המינית.

מיניות האדם היא אניגמה של רכיבים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים, חברתיים, תרבותיים ועוד.

לכל אישה יש מעגל תגובה מיני משלה. ואפילו אצל אותה אישה המעגל הזה משתנה במהלך חייה, והחשק המיני מקבל בכל פעם פן אחר. יש נשים עם תשוקה, משיכה, דחפים ועוררות מינית חייתית. יש נשים שנהנות מצפייה באתרי סקס וסרטי פורנו. יש נשים שמביעות את מוכנותן האובייקטיבית לקיום מגע מיני. יש נשים שרוצות את הגברים יפים, גבוהים, חתיכים ומוצקים. יש נשים שישמחו להיות עם כל גבר. יש נשים שמאוננות בתשוקה והנאה.

יש גברים שיש להם תשוקה גדולה ויש גברים שאין להם תשוקה גדולה, ובת זוגן מלינה על כך. יש גברים שלא נהנים ואף מאוימים מצפייה באתרי סקס ובסרטי פורנו. יש גברים שנמשכים לנשים מלאות, עגלגלות ולא חתיכות. יש גברים שלא ששים לאונן.

אומרים שהחשק המיני של נשים תלוי בטיב הקשר עם בן הזוג. כאשר יש חיזור, תקשורת, הבנה, חברות, הכלה ובגרות בקשר – יש לאישה חשק. אומרים שמצבים של יש או אין חשק הם טבעיים כל עוד לא מתלוננים על כך. כל אחת עם רמת החשק שלה. וציניקנים יגידו שהתרופה הכי טובה לחשק מיני של אישה היא להחליף גבר או להוסיף גבר.

הסיבות לירידה בחשק

30%-40 מהנשים סובלות מפגיעה בחשק המיני. תופעה דומה קיימת אצל גברים. ירידה בחשק המיני היא ההפרעה המינית השכיחה ביותר בנשים. מחקר שנעשה בארה"ב על 31,000 נשים בנות 18-65 מצא שכ-40% מהנשים דיווחו על ירידה בחשק המיני. שיעורן עולה אחרי גיל המעבר. רק 10% מהנשים דיווחו על מצוקה עקב כך.

חוסר חשק מיני יכול להיות קשור להשפעות של תרופות או סמים, למחלה גופנית כללית, למערכת היחסים בין בני הזוג, לדימוי העצמי ולדימוי הגוף, וכן לאירועי חיים כמו היריון ולידה, גיל המעבר, חרדה ודיכאון. נשים מדווחות שמה שפוגע בחשק המיני שלהן הוא שהגבר אינו רגיש וקשוב. אבל בקשרים חדשים בן הזוג משקיע יותר, מחזר וקשוב לצורכי האישה. מה שחשוב לתפקוד המיני של נשים הוא ההשקעה הרגשית מצד בן הזוג. אצל נשים מחוזרות לא נצפית ירידה בחשק המיני ובתדירות קיום יחסי מין, גם לא בגיל הזקנה. תקשורת זוגית פתוחה, חברות, תמיכה והכלה לצד הסרת המגבלות הקשורות בתקשורת על ענייני המין, בכלל זה השינויים והמגבלות, הם הדרך הטובה לשמירת הפעילות המינית גם בגיל הזקנה. הקרבה הרגשית והגופנית חשובה יותר מחוויית האורגזמה.

הסיבות הפיזיולוגיות – כדי לשלול רכיב אורגני גופני דרושות בדיקות של חוסר או עודף הורמונלי. כך למשל עודף הורמון הפרולקטין אצל נשים מיניקות יכול לגרום לפגיעה בחשק מיני. אצל גברים רמה גבוהה של הורמון זה היא רכיב של חוסר החשק. ירידה ברמת הטסטוסטרון, הורמון המין הגברי, תשפיע על ירידת החשק של הגבר. הטסטוסטרון המופרש בנשים

בשחלות יורד באופן הדרגתי אצלן כמו אצל גברים. אצל האישה הוא מתחיל לרדת כבר בגיל 30–40. לקראת גיל המעבר הרמה יכולה להגיע עד 50% מהרמה אצל נשים בנות 20 ולהתבטא בירידה בחשק המיני. על רמת החשק המיני משפיעים גם כל אלה: הפרעה בפעילות בלוטת התריס ומחלות סיסטמיות כגון סוכרת; טרשת נפוצה או בעיות לב ולחץ הדם; גלולות למניעת היריון; תרופות הרגעה; תרופות לבעיות בקיבה ועוד. כמעט לכל תרופה יש תופעות לוואי המשפיעות על התפקוד המיני. גם עישון, סמים ואלכוהול בשימוש תדיר עלולים לפגוע בחשק.

דימוי הגוף והדימוי העצמי – המודל הנשי והמודל הגברי מוצגים כיום במדיה במיטבם, ואין מקום לשונה ולאחר. הדבר מציב קשיים, שהרי המודלים כמעט בלתי אפשריים לחיקוי. כשהאישה משווה את עצמה למודל האולטימטיבי היא לא מרגישה נוח עם מראה גופה ועם מה שהשיגה בחייה. התחושה שגופה לא מגרה ולא חושני יכולה לגרום לה לירידה בחשק המיני. גבר שאין לו קוביות בבטן, שרירי זרועות וגוף משולש מוצא את עצמו לא די טוב לספק את הסחורה, והחשק המיני שלו יורד.

התעללות וניצול מיני – אישה או גבר שחוו בעבר טראומה מינית עלולים לפתח תסמינים פוסט-טראומתיים ובעקבותיהם חוסר חשק מיני. תגובה זו תגרום להם להימנע מלחווה שוב את האירועים הטראומתיים שחוו בעבר.

דיכאון – במצבים קשים של דיכאון יכול האדם להגיע לתחושה של חוסר אונים וחוסר חשק ואנרגייה לתפקד, בכלל זה חוסר חשק ותשוקה למין. לפעמים חוסר החשק מבשר את הדיכאון. גם הטיפול בתרופות נוגדות דיכאון עלול לפגוע בחשק.

הקשר הזוגי – מערכת זוגית שמתפתחת ובנויה על תחושות של כעס, תסכול, אכזבה, פחד מבן הזוג, קונפליקטים לא פתורים – יכולה לקבל ביטוי בירידה בחשק מיני. כתוצאה מתחושות אלו יתפתחו חוסר משיכה לבן הזוג וירידה בחשק.

אירועי חיים – לעיתים הירידה בחשק המיני יכולה להתרחש לאחר

לידה בשל סיבות גופניות ונפשיות. האישה-האם נדרשת למאמץ רגשי ופיזי רב מאוד. אין לה זמן ואנרגייה לצרכיה, והחשק המיני נמצא אצלה בעדיפות אחרונה. גם מחלה של אחד מבני הזוג יכולה להיות גורם לירידה בחשק המיני מתוך מקום של דאגה והזדהות או מתוך מקום של כעס. קריירה ותחרות הם נדבך המביא חוסר חשק. כך גם מסגרות תעסוקתיות תובעניות ועמדות בכירות וכן השקעה רבה של שעות עבודה ואנרגייה בקידום המקצועי וחלוקה בלתי שוויונית של מטלות הבית והמשפחה. שגרה במערכת היחסים ולאו דווקא בתנוחות האקט המיני היא אויב המערכת הזוגית. פער בצרכים הוא עוד אבן נגף.

נחום בן 40 ואשתו נילי בת 33. מאז הולדת בתם הבכורה לפני שמונה שנים הם כמעט לא מקיימים יחסי מין. נחום מרגיש שבהדרגה נילי מאבדת בו עניין. היא טוענת שהיא אוהבת אותו מאוד אבל "באופן שונה". נחום מרגיש שהאהבה שלה היא כאהבת אם לבנה ולא כאהבת אישה לבעלה. הוא רוצה לשכב איתה לפחות פעמיים בשבוע, והיא לא רוצה אפילו לגעת בו, שלא לדבר על ההנאה מהאקט המיני. גם ללכת לטיפול היא לא מוכנה, והיא אף אומרת: "אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה – רק שאני לא אדע."

לנחום, נראה שאצל נילי חלה פגיעה בחשק המיני בעקבות הלידה או בעקבות השגרה במערכת היחסים. וייתכן שיש עוד גורמים שזוגתך אינה חולקת איתך המעיבים על החשק המיני שלה או על הרצון שלה לקיים איתך יחסי מין. יהיה נכון שתנסה לקחת אחריות על הדברים. עזור לה, חזר אחריה, היה שם בשבילה, ואז אולי תתעורר המיניות.

נטלי בת 34, ומאז גיל 20 יש לה חברים פחות או יותר ברציפות. בחודשים האחרונים לא היה לה חבר והיא לא קיימה יחסי מין. בהתחלה זה חסר לה מאוד, אבל פתאום זה כבר לא מפריע לה, אפילו לאונן לא מתחשק לה. נטלי שואלת אם איבדה לתמיד את החשק או אולי הוא יתעורר שוב.

לנטלי, במבט על נראה שאין לך שום בעיה שגורמת לירידה בחשק. כנראה חסר לך הקשר שייצור אצלך אינטימיות רגשית ומינית. עוד

יגיע הגבר שיחזיר לך את הניצוץ שדעך. אל תוותר על עצמך ועל קשר זוגי אינטימי שיחזיר תשוקה לליבך ולגופך.

האבחון והתרופות

הקריטריונים לאבחנה בירידה בחשק המיני הם העדר פנטזיות מיניות והעדר חשק לקיום יחסי מין באופן קבוע או חוזר. הבעיה גורמת למצוקה נפשית קשה וקשיים בקשרים הבין-אישיים. באבחון עושים הערכה קלינית של העדר החשק ומתחשבים בגורמים המשפיעים.

ההורמון DHEA מגביר את החשק המיני וחיוני למערכות בגוף. ההורמון מנרמל את לחץ הדם, מווסת את רמת הכולסטרול, מחזק את המערכת החיסונית, מגביר את החיוניות והריכוז, מווסת מצבי רוח. DHEA הוא הורמון המסונטז מכולסטרול ביתרת הכליה, והוא למעשה פר-הורמון המפורק בהמשך לטסטוסטרון ואסטרוגן. יש עדויות של שיפור ברווחה הנפשית בקרב נוטלי DHEA, ונמצא גם שיפור בתפקוד המיני, בעוררות המינית ובתחושת הסיפוק המיני בקרב נוטלי ההורמון.

התרופה Addyi, בשמה הגנרי Flibanserin, נועדה לטיפול בהפרעה שנקראת "תסמונת החשק המיני ההיפואקטיבי" (HSDD) – ירידה בחשק המיני או חוסר חשק מיני אצל נשים בגיל הפוריות.

חברת פאלאטין מייצרת כדור PT-141 המבטיח חשק מיני לנשים. מיועד גם לגברים.

כדור ליביג'ל מבטיח חשק מיני לנשים. לא כל כך הצליח במחקרים, אך יש נשים שעזר להן.

החשוב מכול לחשק המיני – שילוב של פנאי, זוגיות טובה ובריאות.

שינה וחשק מיני

מחקר על הפעילות המינית של 171 נשים העלה שעל כל תוספת של שעת שינה גדלה הפעילות המינית ביום שאחרי ב-14%. נשים שישננות יותר

מתגרות מהר יותר ומביעות עניין רב יותר בקיום יחסי מין. מחסור בשינה יכול אפוא לגרום לירידה בחשק ובעוררות המינית של נשים. גם גברים שלא ישנים מספיק חווים רמות נמוכות יותר של עוררות מינית בשל ירידה בטסטוסטרון. נמצא שבקרב גברים שישנו פחות מחמש שעות בלילה במשך שבוע נמדדו רמות טסטוסטרון נמוכות מהרמות אצל אלה שישנו. ולפעמים העייפות חזקה מהחשק.

פעילות גופנית וחשק מיני

בדרך כלל הירידה בחשק קשורה לאינטנסיביות ולעומס של החיים וגם לירידה בהורמון הטסטוסטרון. עם זאת ידוע שיש קשר ישיר בין פעילות גופנית לחשק מיני. יש קשר ישיר בין הכושר הגופני, זרימת הדם בגוף והחשק מיני. כל מה שקשור בספורט – ריצה, רכיבה על אופניים, אגרוף תאילנדי ועוד – מעלה את רמת האנדורפינים, מעלה את רמת הטסטוסטרון, מעלה את מצב הרוח, משפר את הדימוי הגופני והדימוי העצמי, וכך גם מעלה את החשק המיני. כאשר אנו בכושר, חטובים ונראים טוב, אנחנו מרגישים מיניים ונחשקים.

טיפול מיני



הטיפול המיני והמצב בארץ

בטיפול מיני מקובל להתייחס למין כמעגל. מין הוא כל מגע גופני של חיבוק, ליטוף, נשיקה, התעלסות, נגיעה באיברי המין וחדירה – בכל סדר שהוא. כל אחד מאלה חשוב בדיוק כמו החדירה והאורגזמה. בכל נקודה במעגל אפשר לצאת ולהיכנס ואפשר לוותר על חלקים במעגל בלי לפגום בו. אפשר ליהנות מהמין גם אם אין חדירה ואם אין אורגזמה. לעומת זאת כשמתייחסים למין כאל מטרה, והמטרה היא הביצוע והציפייה להגיע לחדירה ולאורגזמה, אזי כל השלבים בדרך לאורגזמה מאבדים מחשיבותם. במקרים כאלה כאשר נפגם אחד השלבים אי אפשר להגיע לחדירה או לאורגזמה, כל ההנאה מהמין נפגמת, והמגע המיני מאבד מחשיבותו.

חשוב ללמוד פתיחות ותקשורת מינית טובה, לא להתבייש לדבר על צרכים וקשיים ועל דברים שאוהבים ועל דברים שלא אוהבים. בני הזוג צריכים להיות קשובים זה לזה ולדעת שכל אחד הוא עולם שלם בעל צרכים משלו. אין נכון או לא נכון, אין נהוג ולא נהוג. גם שימוש בעזרי מין יכול לתרום להנאה המינית ולהעצים אותה, כל עוד הדבר מקובל על שני בני הזוג.

סקר העלה כי התדירות הממוצעת של קיום יחסי מין בארץ היא פעם או פעמים בשבוע במשך 12–15 דקות. הליקויים בתפקוד המיני רבים ומגוונים,

ושיעור ניכר מהאוכלוסייה בכל הגילים לוקה בהם על רקע רפואי, נפשי, זוגי או שילוב של אלה.

הטיפול המיני ניתן במרפאות ברוב בתי החולים, וגם כל קופות החולים מאפשרות למבוטחים לפנות למטפל מיני, אבל לא מעט אנשים חוששים לפנות לטיפול מיני בגלל הסטיגמה.

כיום יש מענה לרוב הקשיים המיניים באמצעות טיפול תרופתי, טיפול פסיכולוגי-סקסולוגי, טיפול זוגי, טיפול פיזיותרפיה של רצפת האגן, טיפול סרווייט, טיפולים אלטרנטיביים או שילוב של כמה סוגי טיפולים.

המרפאות פועלות כדי לשפר את התפקוד המיני והזוגי ולהיטיב את איכות החיים של בני הזוג. הצוות המטפל הוא רב־תחומי, ויש בו גינקולוגים, אורולוגים, פסיכולוגים, מטפלים זוגיים, פיזיותרפיסטים ומטפלים אלטרנטיביים.

סוגי הטיפולים

אצל נשים מטפלים בבעיות האלה: וגיניזמוס – חוסר יכולת לקיום מגע מיני מלא, ירידה בחשק המיני וחוסר חשק, העדר אורגזמה, כאבים במגע המיני – דיספּראוניה, וולוודיניה־וסטיבוליטיס, אברסיה – דחייה ממין, עוררות מינית מתמדת, ירידה בתפקוד עקב טראומה גופנית או נפשית, ועוד.

אצל גברים מטפלים בבעיות זקפה, שפיכה מוקדמת, שפיכה מעוכבת, ירידה בחשק המיני וחוסר חשק, כאבים במגע המיני, ירידה בתפקוד עקב טראומה גופנית או נפשית, ועוד.

הבעיות העולות בטיפולים הזוגיים הן חוסר התאמה מינית, פער בצרכים המיניים, קשיים לאחר לידה, קשיים בחיי המין על רקע קונפליקטים זוגיים, שינויים בחיי המין על רקע אובדן ושכול.

הטיפול הרפואי כולל מתן כדורים, משחות, מכשירים שעוזרים לתפקוד המיני, זריקות, פיזיותרפיה לרצפת האגן, ניתוחים באיברי המין.

הגישה הטיפולית צריכה תמיד לשלב גוף ונפש. גם אם הבעיה היא גופנית,

יש מקום לתת את הדעת להשפעה הרגשית שהיא גורמת לאדם הלוקה בתפקודו ולהשפעה על בני הזוג.
 רצוי לבחור מטפל מיני שקיבל הכרה ממשרד הבריאות לאחר שהוכשר בתחום הטיפול המיני.

התמקדות בתחושות

המונח 'התמקדות בתחושות' (sensate focus) נקבע לפני כחמישים שנה. מדובר בפעילות מהנה שהיא הבסיס לטיפול מיני בכל הבעיות המיניות של נשים וגברים בלי קשר למקור הבעיות ולטיבן.

בטיפול הזוגי הפעילות נעשית בהתאם למקום הרגשי שבו נמצא כל אחד מבני הזוג ובהתאם לתקשורת ולפתיחות שבין השניים ולמהות הקשר ביניהם. בודקים כמה זמן נמשך הקשר, אם בני הזוג התגוררו יחד, אם יש להם פרטיות, פנאי ועוד.

הפעילות מותאמת לסוג הבעיה בתפקוד המיני ולחומרתה. התרגילים וההוראות ניתנים מתחילת הטיפול או רק לאחר התקדמות רגשית ומעשית בתהליך הטיפולי.

הדינמיקה בפעילות של ההתמקדות בתחושות עוזרת לשני בני הזוג, בייחוד לזה הלוקה בתפקודו, להתגבר על הקשיים הרגשיים. ההנחיה להתמקד בתחושות – ולא באיברי המין ובתפקוד – מפיגה את המתח במפגש. כל אחד מבני הזוג חופשי מהציפייה לתפקד, להגיע לאורגזמה, לעסוק בחדירה, זקפה ושפיכה. מאחר שאין חובת תפקוד, אין לחץ פסיכולוגי ואין כישלון. יש אפשרות ללמידה הדדית מהנה ומתגמלת ולהפחתת החרדה בהדרגה עד הכחדתה, ונוצר פתח לתפקוד מיני טוב יותר ומהנה.

בתרגילי ההתמקדות בתחושות יש רכיב לימודי. הפעילות מקנה לבני הזוג את ההזדמנות לתקשר, לגרום הנאה זה לזה ולעבור חוויה חושנית המלמדת על הצרכים, המקומות הרגשיים בגוף ואופן ההנאה מהמגע. התוצאה היא העמקת הקשר הרגשי, תקשורת פתוחה, אינטימיות ומעורבות אישית גדולה יותר.

טיפול פוריות



בעיות בתפקוד המיני

אצל רוב הזוגות המגיעים להחלטה משותפת להיות הורים התהליך פשוט ודומה: הבאת ילד דרך קיום יחסי מין מלאים. הקשר המיני יכול להיות מלווה ברגשות עמוקים ובעלי משמעות, רצופים ימים מיוחדים, רגעים רומנטיים ומחוות של אהבה. כל אלה כדי ליצור חוויה משותפת וזיכרונות נעימים מההיריון והלידה.

אצל זוגות עם בעיות פריון הרגעים האינטימיים המספקים והמרגשים ביותר של קיום יחסי מין כדי להיכנס להיריון מוחלפים בטכנולוגיה מודרנית, והקשר עם אמוציות ואנרגיות מיניות מאבד מאיכותו. חיי המין הספונטניים מוחלפים בעבודה מייגעת. הטיפולים החודשיים פוגעים בביטוי המיני הטבעי של בני הזוג, וכך נוצרים קשיים בזוגיות בכלל ובתפקוד המיני בפרט. זוגות עם בעיות פריון מדווחים על ירידה בחשק המיני, ירידה בתדירות יחסי המין, קושי להגיע לאורגזמה אצל האישה ובעיות זקפה ושפיכה אצל הגבר. הקשיים האלה משפיעים גם על תוצאות הטיפול.

המעקב, הצורך בתזמון יחסי המין, מתן הזרע – כל אלה משפיעים לרעה על קיום יחסים בדרך ספונטנית וטבעית. בני הזוג סובלים גם מהחוויה האישית הקשה של בגידת הגוף, אובדן השליטה והפגיעה בדימוי ובערך העצמי, והקשיים בחיי המין ובזוגיות משפיעים על תוצאות הטיפול. חשוב שבני הזוג יבינו מה צפוי להם במסגרת הטיפול ויקבלו הסברים. חשוב לבדוק אם יש להם קשיים בזוגיות. לפעמים מגלים שהיעדר הפוריות

נובע מבעיה תפקודית ולא פיזית. יש מקום לעבודה על הזוגיות ועל המיניות, כיוון שהיחסים נעשים מכניים, טכניים וממוקדי מטרה. יש מקום גם לתמיכה חברתית.

גבר הלוקה בפוריותו

גבר הלוקה בפוריותו עלול להרגיש פחות גברי, פחות מיני, פחות תורם למערכת היחסים הזוגית. הוא יסבול מפגיעה בדימוי העצמי ובביטחון העצמי שלו. הצורך להגיע לזקפה בזמן שנקבע מראש יכול לגרום לו חרדת ביצוע. גם הלחץ לשפוך לתוך כוסית פלסטיק באוננות בחדר קטן בבית חולים יש בו כדי להביא למצב של חוסר יכולת או קושי לשפוך. ומקשים על הגבר גם המתח והלחץ לתפקד ביום מסוים בשעה מסוימת במקום מסוים.

תופעה רווחת בקרב גברים העוברים טיפולים עקב בעיות פריון היא ירידה בחשק המיני. מופיעה גם תחושת דיכאון. אצל שיעור קטן מהגברים המטופלים החוסר בהורמון הגברי, הטסטוסטרון, והתהליך המלאכותי של ההפריות גורם לירידה במצב הרוח, ברצון ובתדירות המין.

אישה הלוקה בפוריותה

בעיות פוריות אצל אישה משפיעות על מצבה הנפשי. הדימוי העצמי שלה נפגע, תפישת הנשיות שלה מתערערת, היא מתקשה לתפקד מבחינה מינית, וכל אלו מעלים תחושות של עצב, מתח, דיכאון וכעס. במגע המיני האישה היא עלולה לחוש כאבים ולהגיע למצב שלא תרצה לקיים יחסי מין.

האישה עלולה לסבול מקושי לחוות אורגזמה על רקע נפשי או כתופעת לוואי של ההורמונים שהיא נוטלת בתהליך עידוד הפריון, וכך היא תגיע גם למצב של חוסר חשק. בגלל התנודתיות ברמות האסטרוגן היא עלולה גם לסבול מדיכאון, וישפיעו גם הציפייה והאכזבה הקשורים לכל טיפול שהיא עוברת.

הטיפול

בתהליך טיפולי הפוריות יש מקום לתת את הדעת על הזוגיות בכלל, על התפקוד המיני ועל ההנאה ממין. תשומת לב למיניות תתרום לחוסן הנפשי של בני הזוג. הפגיעה הקשה שהם חווים יכולה להיות מנוף למיניות ולחושניות מהנה התורמות לתחושת הביטחון והדימוי העצמי שלהם.

יש מענה לכל הקשיים בתפקוד המיני של גברים ונשים העוברים טיפול פריין: טיפולים לזקפה – זריקות, כדורים, משחות, משאבות ואקום; טיפולים לשפיכה מוקדמת – משחות השהיה וכדורים; טיפולים פסיכולוגיים סקסולוגיים; טיפול בנשים במרחיבים ואגינליים, במשחות וניתוחים, הכול לפי הקושי והצורך.

לאחר הלידה חשוב לחזור לשגרת חיי מין טובים ומהנים. וכמובן יש להתחשב במצב האישה, באופן הלידה ובהנחיות הרופא המטפל.

טרנס־סקסואליות



המקרה הראשון של חשיפה לטרנס־סקסואליות היה בשנת 1953, כאשר כריסטין יורגנסן, איש חיל הנחתים האמריקני, עבר ניתוח לשינוי מינו והופעתו והפך מגבר לאישה. מאז ועד היום רבים משנים את מינם. נכון להיום יש גברים הרוצים לשנות את מינם יותר מנשים.

התהליך ארוך ורב־שלבים. הוא מתחיל בטיפול פסיכולוגי שמטרתו לעמוד על עוצמת המצוקה הנפשית של המבקש לשנות את מינו ולהכין אותו להמשך הדרך הטיפולית והניתוחית.

הגבר הטרנס־סקסואל מקבל כל יום אסטרוגנים (הורמונים נשיים), ואלה גורמים להתפתחות שדיים ולירידת מסת השרירים. הטיפול גורם גם לירידה בזקפה, להצטמקות בלוטת הערמונית וצינור עילית האשך (מוביל הזרע). בניתוח מסירים את הפין ואת האשכים ויוצרים נרתיק מלאכותי. האישה הטרנס־סקסואלית מקבלת טסטוסטרון כדי לדכא את מערכת המין הנקבית ולגרום לצמיחת שיער. הניתוח קשה יותר מהניתוח של הגבר. הפין לא יוכל להגיע לזקפה, ואין פעילות של יצירת זרע ונוזל זרע.

טרנסווסטיזם



זוהי העדפה של הגבר או האישה ללבוש את הבגדים של המין השני, אבל לא לשנות את הזהות המינית (טרנס־סקסואליות). התופעה נחשבת לסטייה רק אם היא גורמת פגיעה בלוקה בה או מסבה לו נזקים כמו למשל קשיים בקשר הזוגי ופיטורים ממקום העבודה. לעיתים הטרנס־וסטיסט מחליף את לבושו כדי להירגע ולא רק למטרת גירוי מיני.

ילדים ומיניות



ילדי הגן

ילדי הגן הם מיניים מאוד. מגיל שלוש עד גיל חמש הם מתחילים להכיר את מינם – בנים או בנות – ולהבין מהי משמעות הזהות הזאת להם ולסובבים אותו. הילדים לומדים מהר שלבנים ולבנות איברי גוף שונים. הם סקרנים לגבי גופם ולגבי הגוף של אחרים. הם שואלים "מאיפה באתי". הם מתחילים לשחק במשחקים מיניים.

הם סקרנים מאוד לגבי הגוף של בן המין השני. הם גם מחקים התנהגויות של אנשים מבוגרים כאשר הם משחקים באימא ואבא, ברופא וחולה. הם מנסים תפקידים והתנהגויות. וכאשר מחברים סקרנות ומשחק התפקידים מגיעים פעמים רבות למשחק מיני של ילדים. במשחק הזה הילדים יכולים לגלות את נעימות המגע. בדרך כלל ההתנהגות הזאת היא בלתי מזיקה, ורק אם ניכרת התנהגות חריגה, צריך לתת עליה את הדעת.

בחינוך המיני של ילדים בגיל צעיר אין חוקים ברורים. חשובים ביותר הערכים המשפחתיים, התגובות הלא-מילוליות שההורים מקבלים מילדיהם ותגובות ההורים כלפי ילדיהם.

עירום ופרטיות

יש הורים שיפשטו את בגדיהם רק במקלחת. יש שמסתובבים בבית בלי

בגדים. יש שחשים לא בנוח להחליף בגדים או להתקלח כשילדיהם בחדר. כך ההורים מעבירים לילדיהם מסרים על גופם בכלל ועל עירום בפרט. ילדים לא יתעוררו מינית ממקלחת משותפת, אף שהם סקרנים לגבי גופם ולגבי ההבדלים ביניהם.

אם הילדים נראים רגועים ונוח להם להתקלח יחד, אין סיבה להפריד ביניהם בזמן המקלחת. אך אם הם חשים לא בנוח או מתחילים לצחקק, הם כנראה מעבירים מסר שהגיע הזמן להפסיק עם המקלחות המשותפות. הדברים אמורים לשני ילדים מאותו מין או משני המינים. חשוב להיות רגיש לילד.

כבר בגיל שלוש או ארבע אפשר ללמד ילדים את נושא הפרטיות. הורים חשים שלא בנוח כשהילדים רואים אותם במצבי עירום. אפשר להסביר לילדים שיש התנהגויות שנעשות רק בפרטיות.

אוננות ילדים

הורים רבים נבהלים ומתקשים להבין ולקבל את תינוקותיהם כיצורים מיניים מאוננים. חקר הגוף הוא חלק מהגדילה ומההתפתחות הטבעית של כל ילד. כמו שהוא לומד לעמוד, ללכת, לרוץ, לצייר, לקרוא – הוא לומד להכיר את גופו, ואיברי המין הם חלק מהסקרנות וההתפתחות הבריאה והטבעית שלו. ילדים מאוננים מגיל צעיר מאוד, וההורים רואים ותוהים אם זה נורמלי.

זה נורמלי ואין מה לדאוג. אין בזה פגיעה פיזית או נפשית. אין בזה סיכון בריאותי ואין זה מעיד על התפתחות לא תקינה או טרם זמנה. האוננות בגיל הילדות איננה מינית. זהו אמצעי להשיג הרגשה טובה ומרגיעה. בגיל מתקדם יותר יגלה הילד את ההנאה שבאוננות ויחזור לענג את עצמו.

מחקרים על אולטרסאונד טרום-לידתי חושפים עוברים זכריים מאוננים. בנים מגלים את איבר המין שלהם בסביבות גיל חצי שנה, בנות בסביבות עשרה חודשים. המשחק מתחיל כאשר הם בלי חיתול וכמובן בזמן הגמילה. זה בא לידי ביטוי בשפשוף בידיים, חיכוך בחפצים, אצל בנות גם החדרה

של חפצים לפתח הווגינה. ההתנהגות הזאת היא אמצעי מרגיע בלי קשר למיניות.

חשוב לכוון את הילד להתנהלות בריאה בעניין האוננות ולכוון אותו לעשות זאת בפרטיות בחדר השינה או באמבטיה ולא ליד אנשים. לא לאסור עליו לשכב על הבטן עם ידיו בין רגליו. חשוב לנסות להסיח את דעתו על ידי משחק או צעצוע. חשוב ליידע את הגננת שלא תגער בילד אלא תכוון אותו. חשוב למצוא זמן איכות עם הילד ולתת לו חיבוק, מה שמוריד את תדירות המגע העצמי. ילדים בני 4–5 נעשים רגישים לתחושות של אנשים אחרים ומבינים שהם צריכים לאונן רק כשהם לבד, לכן אין לנסות למנוע אוננות. זה חוסך מאבק כוחות, שבו ההורים בהכרח יפסידו בסופו של דבר. ילדים לא צריכים להיענש פיזית על אוננות. חשוב לא לתייג את האוננות כאקט רע, מלוכלך או חטא. כל הגישות הללו מובילות רק להתנגדות ואולי אחר כך לעכבות מיניות.

ילדים ופורנו

כ-60% מהילדים ובני הנוער נחשפים לפורנוגרפיה. איננו יודעים מה ילדינו רואים באינטרנט, בטלפון ובאמצעים אחרים. מחקרים בעולם קובעים ש-80% מהילדים בני 12–17 נחשפים לפורנו. הם מגיעים לפורנוגרפיה במקרה וגם בחיפוש מכוון. ילד שנכנס לאתר פורנו רואה אקטים מיניים ממשיים בפרטי פרטים ובעוצמות גרייה גבוהות. הוא רואה שימוש בכוח, יחסי מין עם בני משפחה, אורגיות, הכול חוץ ממיניות נורמטיבית ובריאה. גיל החשיפה לפורנו הולך ויורד, ולא בהכרח מדובר בבני נוער. כשילד נחשף לפורנו עוד לפני שגיבש לעצמו את המיניות שלו, החוויה מפחידה ומבלבלת, התמונות נצרבות, ואלה הזיכרונות המיניים הראשונים של הילד. המקור העיקרי של החשיפה לפורנו, האינטרנט, זמין וממכר, עולם של פנטזיה שאין בו דחייה.

ההשפעה על הילדים קשה. הם מפגימים מסרים מיניים מעוותים, הפרדה בין מין לרגש, התרכזות בטכני, השפלה של נשים. מבחינתם, זה מה שצריך להיות, וכשזה לא קורה במציאות, הם מרגישים רע עם עצמם. בנים לומדים

לאונן מול מסך ולא להתגרות מהנערה שהם אוהבים. הם חווים רגשות של פחד, חרדה, גועל, עצב, וגם גירוי גופני. קשה להם להפסיק, לעצור ולקרוא לעזרה. ויש ילדים שמתמכרים, קמים באמצע הלילה וצופים בפורנו. הדבר מביא גם לידי התחלת קיום יחסי מין בגיל צעיר יותר. מתפתחים דפוסים אלימים בפעילות המינית. יש קשיים בפיתוח קשרים אינטימיים בבגרות. ילדים מוותרים על פעילות חברתית ועל קשרים עם חברים כדי לצפות בפורנו. העולם הווירטואלי הופך להיות העולם האמיתי.

למעורבות ההורית יש חשיבות מכרעת. דרושים חינוך מיני וגם בקרה ופיקוח.

החינוך המיני בבית צריך להתחיל כבר מגיל צעיר. חשוב שההורים ישוחחו עם ילדיהם, יסבירו וידונו בערכים. בגיל ההתבגרות חשוב להסביר מה זה קשר, מה מקום הרגש ומה מקום המין. חשובה תקשורת פתוחה. חשוב להוציא מחדר הילדים את המחשב והדיווידי ולמקם במקום מרכזי בבית. לפעמים לשים חסמים במחשב, לבדוק את היסטוריית הגלישה ואת האתרים המועדפים.

יש מקום גם לדבר על פורנו, להסביר במה מדובר.

בנות רבות מדווחות גם על ניהול צ'טים בעלי תכנים פורנוגרפיים. יש שהופכות את עצמן לאובייקטים מיניים בשליחת תמונות וסרטים ביתיים שלהן בתנוחות מפתות. דרושה השגחה. דרושה תשומת לב מיוחדת לילדים בעלי קשיים רגשיים, התפתחותיים, משפחתיים וחברתיים ולילדים במצבי לחץ. גם לילדים שעברו טראומות של אובדן או אלימות, גם לילדים בעלי לקויות למידה ולילדים שנמצאים שעות רבות בלי השגחת מבוגר.

כאב ראש ויחסי מין



כאב ראש משמש לפעמים תירוץ לחוסר רצון לקיים יחסי מין. הרקע הוא עייפות, מתח, דיכאון ובעיות בין בני הזוג. הטיפול אינו בתרופות נגד כאב אלא בירידה לשורש הבעיה. אבל יש מצב של כאב ראש בזמן יחסי מין. כאב הראש מופיע עם העלייה בריגוש המיני, כאשר בגוף מתחוללים שינויים רבים במתח השרירים, בלחץ הדם ובמערכות אחרות. אצל מקצת האנשים הכאב נגרם כתוצאה מעליית המתח בשרירי הצוואר והעורף, וכאבים אלו יהיו עמומים ויתרכזו בצוואר ובחלק האחורי של הראש. אצל אחרים הכאב ייגרם מעלייה בלחץ הדם בעורקים או בוורידים שבמוח, וככל שיעלה הריגוש המיני ויגבר לחץ הדם, כך יגבר הכאב ויגיע לשיאו בזמן האורגזמה.

קטגוריה מיוחדת של כאבי ראש המופיעים בעת אורגזמה אובחנה בשנות השבעים וכוונה Benign Orgasmic Cephalgia, אך עד מהרה התברר שהיא עלולה לצוץ בכמה שלבים של קיום יחסי המין. מאז מדברים על כאב ראש המקושר ליחסי מין.

במחקר בגרמניה בשנת 2003 נבדקו אנשים שהתלוננו על כאבי ראש בזמן יחסי מין. הם עברו בדיקות נוירולוגיות והתבקשו למלא שאלונים מפורטים על מאפייני כאבי הראש. כאבי הראש סווגו לשלוש קבוצות: כאב עמום בראש ובצוואר (24%); כאב פתאומי כמו התפוצצות בעת האורגזמה (69%); כאב ראש המתפתח לאחר קיום יחסי המין (7%). התברר כי כאב הראש אינו נוגע רק לקיום יחסי המין. אצל 35% התופעה התרחשה גם בעת אוננות. 94% השיבו כי על פי רוב מופיעים כאבי הראש בעת קיום יחסי מין.

40% מהמשתתפים במחקר העידו כי יכלו להפסיק את הכאב על ידי הפסקת הפעילות המינית. 51% טענו כי תפקיד פסיבי ביחסי המין מבטיח הקלה מסוימת לאחר שמופיעים כאבי הראש. החוקרים מאמצים שתי אבחנות אלו כהמלצות לטיפול בבעיה. גם טיפול תרופתי הוא חלופה אפשרית להתמודדות עם הכאב. כמובן, אם המקרה חד-פעמי או נדיר, אין מקום לדאגה ואין צורך ברופא.

מחלת לב ומיניות



מחקרים מלמדים שיחסי מין בתדירות של שלוש פעמים בשבוע מקטינים את הסיכון ללקות בהתקף לב. גם הליכה ואימון בחדר כושר שלוש פעמים בשבוע מקטינים את הסיכון.

אנשים לאחר התקף לב נמנעים מיחסי מין מחשש שיחוו תעוקת לב. לחץ בחזה, קוצר נשימה, כאבים בחזה – יקרו ל-4% מהאנשים שחוו אירוע לב, אבל הרוב יחזרו מהר מאוד לשגרת היום-יום וגם ליחסי מין.

אם אדם שלקה בהתקף לב יכול לעלות לאחר מכן שתי קומות או לצעוד קילומטר ברבע שעה, מותר לו גם לקיים יחסי מין בלי חשש, ובלבד שישמור שלחץ הדם שלו לא יהיה מעל 130 דיאסטולי, 160 סיסטולי.

חולים לא יציבים, חולים עם תפקוד לב ירוד, חולי לב עם סיבוכים רפואיים אחרים וגם חולים שאינם מקיימים פעילות מינית קבועה רצוי שיימנעו מיחסי מין.

החזרה ליחסי מין אמורה להיות מבוקרת והדרגתית. יש בה כדי להוסיף לבריאות, למיניות ולזוגיות.

מין אוראלי



במין אוראלי מעורבים הפה והלשון ואיברי המין של האחר. בשפה עממית הם נקראים "ירידה", "מציצה", "ליקוק", "גרון עמוק" ועוד. בשפה המקצועית: Fellatio – אישה לגבר, Cunnilingus – גבר לאישה. יחסי מין אוראליים הם חלק מהרפרטואר המיני, והם נורמליים בכל אופן המקובל על שני בני הזוג. במין אוראלי יש הרבה עונג. מין אוראלי אהוב על 95% מהגברים. רוב הנשים נהנות ממגע אוראלי בדגדגן. יש נשים המתקשות לקבל מין אוראלי בגלל התחושה שהן לא נקיות.

הסיכונים במין אוראלי נמוכים, אך יש סיכון של הידבקות במחלות מין: איידס – שפיכה בפה מגבירה את הסיכון, ועל כן מומלץ להימנע ממין אוראלי כאשר אחד מבני הזוג נגוע.

כלמידה – מגע אוראלי של נוזלי גוף נגועים יכול לגרום להידבקות בחיידק. אפילו נגיעה בהפרשה ואחר כך נגיעה בעיניים עלולה להדביק את העיניים.

הרפס – מגע מיני אוראלי באיבר הנגוע יגרום להדבקה כאשר ההרפס פעיל.

זיבה (גונוריה) – מגע ללא הגנה מסוכן. יבלות באיברי המין (קונדילומה) – ההידבקות אפשרית במגע מיני אוראלי.

סרטן הפה – הנגיף HPV המועבר בדרך כלל ביחסי מין קשור בהתפתחות סרטן צוואר הרחם. מתוך כ-90 תת־זנים של הנגיף רק סוגים אחדים קשורים להתפתחות סרטן צוואר הרחם. סרטן זה נדיר יחסית בישראל, ולאחרונה



פוחת חיסון המונע הדבקה באחד הזנים שלו. במחקר נמצא כי אנשים שחלו בסרטן הפה ונשאו את הנגיף נטו לעסוק במין אוראלי בשיעור גבוה פי שלושה מאלה שאצלם הגידול הסרטני לא הכיל את הנגיף. בשנים האחרונות חלה עלייה בשיעור מקרי סרטן הפה בקרב צעירים, ומשערים כי הנגיף HPV הוא אחד הגורמים העיקריים לכך.

כדי להפחית את סיכון ההידבקות רצוי שלא לקיים יחסי מין אוראליים כאשר יש חתכים, פצעים או זיהום בפה ומסביב לו. יש אומרים שרצוי לקיים יחסי מין אוראליים בלי שנוזל זרע או הפרשת הנרתיק יגיעו לחלל הפה. הדבר כמעט בלתי אפשרי. השימוש בקונדום לא נוח ופחות נעים לשני הצדדים.

גלי ובן זוגה אלדד חיים יחד כעשר שנים. שניהם היו בתולים כשהכירו, וגלי למדה על מין מסרטי הדרכה ומספרים. אלדד למד את הדברים רק מגלי, ולכן גדול הקושי שלו להתנסות בדברים חדשים. כשגלי רצתה

להוסיף ליחסיהם מין אוראלי, גילה אלדד התנגדות גדולה, ומאז יש להם מעין ויכוח בנושא, כי לגלי זו פנטזיה גדולה שלא מתממשת. לאלדד האקט הזה גורם עונג, אבל גם רתיעה.

לגלי, מומלצת חשיפה הדרגתית, לאט לאט באופן לא מאיים להגיע לאיבר המין באופן ישיר. כדי שהריח והטעם לא יפחידו וירתיעו, מומלץ להתרחץ קודם, אפשר גם יחד. ויכוח יפעל לרעה וירחיק את אלדד מהדגדגן שלך. לא חייבים להגיע מייד לדגדגן: אפשר להתחיל בבטן, לעבור לירכיים, ולאט להגיע לאיבר המין. כך יוכל אלדד להתרגל בהדרגה ולא יחוש דחייה. אם הבעיה היא הטעם והריח, אפשר לקחת מעט גלידה בפה, משקה או סוכריות מנטה, סוכריות קופצות – כל דבר המקובל על שניכם שיכול להקל בתחילת המגע. ויש עוד הרבה הצעות, אבל כל זוג מוצא את הדרך המתאימה לו.

נאווה מספרת שהחבר שלה משתוקק שהיא תלמד לעשות לו גרון עמוק. איבר המין שלו לא גדול במיוחד, כ-13 ס"מ. נאווה שואלת אם אפשר ללמוד לעשות זאת ולמה זה כל כך מדליק אותו.

לנאווה, ייתכן שהוא מפנטז על מין אוראלי כמו בסרט "גרון עמוק". ייתכן שהוא רוצה שתכלי אותו לגמרי והחיבור ביניכם יהיה טוטלי. למעשה הוא פשוט רוצה מין אוראלי טוב. חשוב שתהיה גישה פתוחה וחיובית מצד שניכם. חשובה חשיפה הדרגתית ממרחק כלשהו מהיעד, ולאט לאט להגיע לאיבר המין. כדי להגיע עמוק אפשר למלא את הריאות באוויר ואז להחדיר לפה את כל האיבר. אם נושמים רק דרך האף, בדרך כלל נמנע רפלקס ההקאה. חשוב ביותר שתעשי זאת מתוך רצון ולא מתוך פחד או הכרח.

מיכאל הכיר בחורה "מהממת ביופייה", והוא נמשך אליה מאוד. היא מגדירה אותו כידיד. הם ישנים מחובקים, אבל היא לא רוצה סקס ומבקשת ממנו רק ללקק לה. כל העניין מתסכל אותו. היא מחמיאה לו, והוא נשאר מבואס אחרי שהיא גומרת.

למיכאל, כאשר הקשר בנוי ומובל מתוך גחמה רגעית ואנוכיות המתמקדת רק בצרכים של האישה, זהו קשר זמני וחולף. אין בו

התחייבות הדדית, הקשבה ונתינה גם לצרכיך, וזה תסכול מתמשך. לא די במחמאות ופרגונים. נכון שיש המון עונג במתן מין אוראלי, אך דרושה רגישות גם לצרכים ולמאווים המיניים שלך. מומלץ שתפתח בשיחה מלב אל לב. עליך לחשוף לפניה את הקושי והמצוקה שלך ולהביא אותה להבנה שאינך מעוניין בידידות אוראלית אלא בחברות שלמה על כל המשתמע מכך.

מין אנאלי



יחסי מין אנאליים הם דרך טבעית לביטוי המיניות. נשים רבות נהנות ממין אנאלי. המגע והחיכוך באזור פי הטבעת גורמים להן עונג שונה מהעונג הנרתיקי, והגירוי האנאלי מזרז להן את האורגזמה. גם לא מעט גברים מעידים על הנאה מרובה ממגע מסביב לפי הטבעת ובתוך החלחולת. עד שנת 1988 היו יחסי מין אנאליים אסורים בישראל, גם אם נעשו בהסכמה. בשנה זו שונה חוק העונשין ביוזמת שולמית אלוני.

במחקר משנת 1977 דווח כי 25% מהנשים ניסו לקיים מין אנאלי. בשנות 1980 דווח על 43% מהנשים, אך רובן ציינו שפעילות זו אינה חביבה עליהן. "מאחורה", "באגוז", "בתחת", "מעשה סדום", "שלא כדרך הטבע" – כל אלה ועוד מבטאים את המגע המיני האנאלי. הישבן, החלחולת, ובעיקר פי הטבעת, הם אזורים ארוגניים רגישים למגע. הגירוי יכול להיות במגע באצבע, בליקוק, בהחדרת איבר המין, בהחדרת חפצים כמו דילדו וסטרפ-און. המין האנאלי אינו ייחודי לאוכלוסייה ההומוסקסואלית, והוא חלק מהרפרטואר המיני ומקור גירוי והנאה גם אצל זוגות הטרוסקסואלים.

אין הכרח בהכנות לקיום יחסים אנאליים, ודאי לא במערכת יחסים קבועה שהמין האנאלי הוא חלק מהרפרטואר המיני בה. המקפידים יעדיפו לקיים מין אנאלי כמה שעות לאחר ארוחה ולאחר התרוקנות בשירותים. בשלב ההכנה חשוב ורצוי לשטוף את פי הטבעת. המהדרים יעשו חוקן. יש חוקן ביתי של פירוק ידית הטוש והשארת הצינור בלבד. מקרבים את הצינור אל פי הטבעת ונותנים לזרם מים בטמפרטורה מתאימה לחדור פנימה, עד שאי אפשר עוד להחזיק, והמים יוצאים עם צואה. על פעולה

זו חוזרים כמה פעמים, עד שהמים יוצאים נקיים. יש גם חוקן שקונים בבתי מרקחת – אמפולה עם נוזל המוחדר לחלחולת דרך פי הטבעת וגורם להוצאת הצואה החוצה מייד.

אפשר להשתמש בחומר סיכה, עדיף על בסיס מים. רצוי שבחומר הסיכה יהיה מעט סיליקון כדי שלא יתייבש, כי תמיד תישאר לחלוחית כלשהי של נוזלי הצואה בחלחולת. רצוי להרחיב את פי הטבעת בהדרגה. לא ביום אחד. רצוי להתחיל להחדיר לפי הטבעת אצבע עם הרבה חומר סיכה ולעשות זאת לאט לאט. משאירים את האצבע כמה דקות בתוך הרקטום בלי להזיזה, כדי לתת לשרירי פי הטבעת להתרגל לחדירה. לאחר שנוח עם האצבע אפשר להכניס עוד אצבע ולהמשיך עם חפץ גדול יותר, וכך הלאה. חדירה בלי אימון ומתיחה קודמים של הרקמות עלולה לגרום כאב ואפילו פציעה של פי הטבעת. אפשר להשתמש בחומר אלחוש כדי להקל את הכאב הראשוני בחדירה. מורחים אותו על פי הטבעת כרבע שעה לפני היחסים.

ביחסים הטרוסקסואליים, כאשר הגבר הוא האקטיבי, אין לקיים יחסים אנאליים ומייד לאחריהם יחסי מין בנרתיק. איסור זה קיים מחשש לזיהום. קודם צריך לנקות היטב את איבר המין הגברי, ורק אחר כך לקיים יחסי מין בנרתיק.

ייתכן שבזמן המגע או מייד אחריו יהיה לחץ לרוץ לשירותים, ועלול להתרחש שחרור נפיחה. ייתכנו כאבים בישבן כמה ימים לאחר היחסים. לא רצוי לקיים מין אנאלי למי שסובל מטחורים.

עלמה, בת 28, זה שלושה חודשים יש לה בן זוג חדש שמאוד אוהב מין אנאלי. עלמה בחורה פתוחה מבחינה מינית, אבל בפעם הראשונה שהוא עשה לה את זה היא הייתה מאוד מופתעת. ברגע הראשון הרעיון הרתיע אותה. הוא הרגיע ואמר שהוא לא דורש ממנה לעשות לו את זה בחזרה, ושהתענוג שלו נובע מלעשות את זה לבת הזוג. היא הסכימה, ולתדהמתה הרבה אף נהנתה מאוד. לאחרונה הוא התחיל לבקש שתעניק לו מין אוראלי בפי הטבעת, והיא מפחדת ממחלות. עלמה שואלת אם זה נורמלי לקיים מין אוראלי-אנאלי.

לעלמה, אכן, יחסי מין אוראליים הם חלק מהרפרטואר המיני, והם נורמליים בכל איבר בגוף ובכל אופן המקובל על שני בני הזוג.

חשובה גישה פתוחה וחיובית מצד שני בני הזוג והתחלה הדרגתית. אשר למחלות, כל עוד מקפידים על היגיינה אין מניעה לקיים מין אוראלי-אנאלי (רימינג).

מין, בריאות ומחלות



המתנזרים מיחסי מין יאמרו בביטול שאין שום מחקר אשר יוכיח כי אי-קיום יחסי מין מזיק לבריאות. ואולם מחקרים מלמדים כי לפעילות מינית יש יתרונות בריאותיים, והיא מאריכה את תוחלת החיים. יתר על כן, יחסי המין תורמים לאיכות החיים. משחררים מתחים. בדידות מביאה לידי דיכאון ותחלואה.

האהבה שומרת על הבריאות. מערכת זוגית עם אהבה הדדית מחזקת את המערכת החיסונית. הקשר הזוגי והאהבה גורמים להפרשת אמפטמינים ואנדורפינים המפחיתים את הכאב ומייצרים נוגדנים נגד מחלות, אפילו סרטן. הסקס מביא לידי חיסון טוב יותר מהצטננות ושפעת ולידי רגיעה בחרדות. לאנשים נשואים באושר לחץ דם נמוך יותר מלחץ הדם של רווקים. במחקר שהשתתפו בו 94 זוגות נמצא שאצל הזוגות שהיו בקשר אוהב יותר נמצאה בדם רמה גבוהה יותר של נוגדני מחלות.

חיי מין טובים לאורך שנים תורמים אפוא לבריאות ולאריכות ימים. ליחסי מין בתדירות נאותה – פעמיים בשבוע בממוצע – השפעה גופנית, רגשית וחברתית. נמצא שגברים המגיעים לשתיים-שלוש אורגזמות בשבוע מפחיתים את הסיכוי ללקות באירוע לב, בשבץ מוחי ובבעיות בערמונית. האורגזמה מביאה לידי שחרור של ההורמונים אוקסיטוצין, אנדורפיין ואחרים, המקילים כאבי ראש, כאבי מפרקים, דכדוך ודיכאון, תופעות של אלרגיה. אצל נשים משתחרר הורמון האסטרוגן המשפר את בריאות העור ואת מראה השיער ואף תורם לשרירי הבטן והישבן. ההורמון פרוסטגלנדין הנמצא בזרע נספג בגוף האישה, מווסת את ההורמונים הנשיים וגורם למצב

רוח טוב יותר. הסקס גם מנחה את ייצור האסטרוגן, שיכול להפחית כאבים קדם-וסתיים, כאבי ראש, מיגרנות, דלקת מפרקים.

היתרונות הפיזיולוגיים ניתנים למדידה. סקס נחשב לפעילות גופנית נמרצת היכולה לשרוף עד 200 קלוריות, שווה לרבע שעת ריצה. פעילות מינית מעלה את הדופק אצל נשים וגברים. הדופק עולה מ-70 פעימות לדקה ל-150.

לעומת זאת מחלות גוררות בעיות בתפקוד המיני. אנשים חולים צריכים להתאים את עצמם למגבלה שלהם. מה שמשפיע על התפקוד המיני הוא אופי המחלה, הטיפול בה (תרופתי או ניתוחי) והרכיב הפסיכולוגי והזוגי. אחרי מחלה יש ירידה בדימוי העצמי והגופני. כך למשל אחרי כריתת שד ואחרי התקף לב. לנכים שמאבדים תפקוד באיבר כלשהו אפשר לסייע בתהליך החזרה לתפקוד מיני בעזרת טיפול משקם עם סרוגייט – מטפל מיני חלופי. במקרים קלים יותר יינתנו תרופות מתאימות עם הטיפול המיני התומך שיעזור להתנהל במציאות החדשה. פרידה עלולה לפגוע בבריאות ובנפש. נמצא שאלמנים בגיל מתקדם עלולים למות בשנה הראשונה לאלמנותם, אלא אם כן מצאו אהבה חדשה. אנשים דחויים עלולים לפתח מחלות. מחקרים מלמדים כי כאשר אחד מבני הזוג מפתח מחלה ויש לו קושי בתפקוד המיני, גם בן הזוג האחר עלול לפתח ליקוי כלשהו בתפקוד מתוך הזדהות.

מין בשלישייה



לא מעט זוגות מנסים לחוות מין בשלישייה. הוספת צלע שלישית היא דרך לגוון את חיי המין ולפעמים גם להימנע מבגידה.

לפעמים כאשר הכללים נקבעים מראש, צירוף צלע שלישית מחזק ומעמיק את הקשר, והזוגות נתרמים מהניסיון ומהחוויה. חייבים לקבוע מראש את כללי המשחק. חשוב שבני הזוג ידעו מה לעשות, עד כמה, איך, איפה ומתי בכל הנוגע לצלע הנוספת. למרות הכללים יש מצבים של קנאה. יש מצבים שאחד מבני הזוג נשאר בחוץ והזוגיות מתפרקת. בכל מקרה הזוגיות לא תהיה כמו בעבר.

לפי דו"ח קאהן שהתפרסם בשנות 1980 בארה"ב ובקנדה, נשים רבות בחרו במקום השני של ההעדפות המיניות להיות במיטה עם שני גברים. אצל הגברים זו הייתה שאלה מיותרת, כי רבים קפצו על המציאה להיות עם שתי נשים.

סקר שנערך בשנת 2005 העלה כי 15% ממשתתפיו גיוונו לפחות פעם אחת בחייהם את חיי המין שלהם במין בשלישייה או יותר. אלופי העולם בתחום הם האוסטרלים, ש-28% מהם הצהירו על התנסות כזאת. אחריהם האיטלקים, הניו זילנדים והדרום אפריקאים (26%), האמריקנים (24%), הנורווגים והקנדים (23%). בישראל 20%.

עדינה, בת 26, מספרת שבעלה הציע לה שיוסיפו עוד גבר למיטה – רק כדי להתנסות. עדינה קצת חוששת. לא כל כך ברור לה מה זה אומר על היחסים ביניהם ועל הצרכים המיניים שלו, והיא שואלת אם כדאי לה להסכים.

לעדינה, הוספת פרטנר נוסף מאותו מין למיטה אין בה כדי להוכיח על נטיות מיניות מודחקות של בעלך ואין בה כדי להעיד על מערכת היחסים המינית שלכם בפרט ועל הזוגיות שלכם בכלל. רצונו של בעלך להוסיף גבר לריקוד המיני שלכם מוכר בספרות המקצועית ויכול לנבוע מסיבות רבות ומגוונות. למשל הוא סבור שאם יראה אותך מתנה אהבים עם גבר זר, הדבר יעצים את הריגוש המיני שלו ושלך, וגם תהיה לו חוויה משותפת עם גבר. כיום החברה שלנו מצויה במצב של מבוכה באשר למין ובאשר להעדפות המיניות. היום לא מוגדר מה נכון ומה לא נכון, מה מותר ומה אסור. נכון שהוספת גבר למיטה שלכם יכולה להעצים את הגירוי והחוויה המינית, אבל צריך לקבוע מראש חוקים וקודים אשר יאפשרו לך ולבעלך להפסיק ולצאת מהסצנה בלי שהתנסות תביא לאסון.

מין ואלכוהול



האדם הוא יצור חברתי שזקוק לקרבה וחום. יש אנשים המבקשים להיות משוחררים, פתוחים ומיניים יותר וזקוקים לשם כך לסמים ואלכוהול.

האלכוהול המשמש לשתייה הוא כוהל המכיל אתנול ונוצר מתסיסה של סוכר באמצעות שמרים. האתנול מדכא את פעילות מערכת העצבים המרכזית. שתיית מעט אלכוהול תגרום להורדת עכבות וקיום יחסי מין באופן משוחרר ופתוח יותר, אך ערבוב של כל מיני סוגי משקאות ושתייה מרובה יביאו לידי דיכוי המערכת העצבית באופן כזה שייפגע התפקוד המיני. זהו גורם ישיר לבעיות זקפה ועיכוב שפיכה אצל גברים ולעיכוב אורגזמה בנשים.

שמחה בן 42, גרוש. בסופי שבוע הוא לוגם בירה וקוקטיילים. אחר כך קשה לו להגיע לזקפה וגם קשה לו מאוד לגמור. שמחה שואל אם הסיבה לכך שאינו מתפקד היא היותו גרוש ומה השפעת האלכוהול על הפעילות המינית. דווקא החשק המיני שלו חזק כשהוא שותה.



לשמחה, לפי דבריו אין קשר בין תפקוד המיני לבין היותך גרוש. כאמצעי להשתחרר ולהיות פתוח ומיני יותר יש אנשים הזקוקים לתדלק את עצמם בחומרים כמו סמים ואלכוהול. ידוע שצריכה מרובה של אלכוהול היא גורם ישיר לבעיות בתפקוד המיני.

מיניות בישראל



תפישת המיניות והזוגיות בישראל השתנתה מאז קום המדינה וקיבלה ביטויים חדשים. על תפישה זו השפיעו במיוחד השינויים שהגדירו את מעמדן של הנשים בחברה.

עוד לפני קום המדינה, כשהמפעל הציוני היה בשיאו ונשים לקחו בו חלק פעיל בהיותן לוחמות, חקלאיות וכובשות את השממה – נוצרה כאן דמות האישה העצמאית. זו הייתה קשוחה עם תספורת קצרה ובגדי חאקי, לצד הגבר הצבר, הלוחם הקשוח הלבוש גם הוא בגדי חאקי ועל כתפו רובה צ'כי. נשים קראו את פושקין על הגורן, וכך פיתו גברים להצטרף אליהן ולהתעלס איתן בחשאי. זוגות רבים נוצרו בין ערימות קש ובשדות העמק.

עם קום המדינה, הקמתו של צה"ל והתגייסות הגברים אליו להגנה על המדינה הצעירה, נוצרה דמותו של הגבר הלוחם והג'נטלמן, יפה הבלורית והתואר. לצידו עמדה האישה המחכה לאהובה שישוב משדה הקרב. היא פשטה את בגדי החאקי ועברה לשמלות אופנתיות. הנשים היו עקרות בית, דאגו לחינוך הילדים. נשים שעבדו מחוץ לבית עסקו בהוראה, בגננות, בטיפול בילדים, בסיעוד. הגברים עסקו בהקמת התעשייה, בבנייה, בחרטות, במסגרות, בסלילת כבישים. במיניות הגבר היה היוזם, המעודד וגם המוציא לפועל.

ילדי הפרחים, ההיפים של שנות השישים, ביקשו להחליף את המלחמה במוזיקה, אהבה וסמים. תפישת המיניות השתנתה. צעירים וצעירות חשו עצמם שוויוניים בדרישה למין ולאהבה. גילויי המיניות הפכו מוחצנים, הלבוש זרוק ומרושל, והסמים הפסיכדליים היו חלק מהאווירה החברתית. במאי 1960 אושרה לשימוש הגלולה, המצאה שהייתה מהפכה ענקית בחיי נשים וביכולתן לשלוט בגופן ובתכנון המשפחה.



הנשים החלו לתת ביטוי למיניותן. הדיסקוטקים והברים פתחו פתח למיניות לצאת מהארון. בשנת 1973 הוציאה האגודה הפסיכיאטרית האמריקנית את ההומוסקסואליות מרשימת ההפרעות הנפשיות. הומוסקסואלים ולסביות החלו לתת דרור להעדפתם המינית באופן מוחצן. כך בארצות הברית וכך גם בישראל.

פריצה מחודשת של התנועה הפמיניסטית חלה בשנות השמונים. הגבר אמור להתחבר לצד הנשי והרך והרגשי יותר באישיותו. האישה מחליטה. המיניות ישירה, עניינית, תקופת החיזור עד המין מתקצרת. מתחילים לתת את הדעת על ליקויים בתפקוד המיני של נשים וגברים. קמות מרפאות לטיפול מיני ונוסד האיגוד הישראלי לטיפול מיני. בשנות התשעים השתנה מעמד האישה. נשים התחזקו, החלו להתערות בכלכלה ולתפוס תפקיד מפתח. נחקק החוק למניעת הטרדה מינית. בזכות האינטרנט העולם נעשה גלובלי, זמין, נגיש ומיידי. גם מגפת האיידס החוצה גבולות זכתה לטיפול תרופתי המאפשר תוחלת חיים ארוכה ואיכותית.

בשנות האלפיים העולם פתוח לרווחה. הגבולות היטשטשו. הקהילה ההומו-לסבית מקבלת הכרה. גברים ונשים נחשפים ומגלים את נטיותיהם המיניות. נוצרות משפחות שבהן ההורים הם רק גברים או רק נשים. עידן תקשורת האינסטנט ממליך גברים ונשים לכוכבים ולדמויות התייחסות וחיקוי. ילדות ונערות מעריצות את הדוגמניות השדופות ומנסות לחקות אותן.

המיניות בישראל בימינו דומה למיניות בעולם המערבי, יש הרבה אתרים באינטרנט שדרכם אפשר להגיע בקלות למין וירטואלי ומעשי. המיניות איננה בהכרח חלק מזוגיות אינטימית ורגשית, ויכולה להיות מזדמנת וחפזה. ועדיין הרומנטיקה והאינטימיות מביאים לקשר זוגי ומיני השומר על עצמו ומאריך ימים.

מיניות במלחמה



מצבים של פוסט־טראומה, דיכאון ומצבים נפשיים אחרים גורמים בעיות בתפקוד המיני.

חיילים קרביים סובלים מבעיות של זקפה כמעט פי שלושה מאזרחים בני גילם. בזמן מלחמה רמת החרדה עולה ומציפה. הפעילות ההורמונלית מוגברת. הלחץ מוריד את החשק המיני ופוגע ביכולת התפקודית. למרות הלחץ והחרדה חשוב לנסות לשמור על קרבה, חום, אינטימיות ומגע. אף שהלחץ עלול להוציא אגרסיות ותוקפנות והחרדה מורידה את התשוקה ואת הזקפה, יש כאן גם הזדמנות ומנוף לבנייה ולחיזוק של הקשר הזוגי.

הזוגות החיים בעורף מבליים פתאום 24 שעות ביחד, וזהו מבחן זוגיות אמיתי. כך המלחמה יכולה לעשות טוב לזוגיות. במקרה של התקפי חרדה אפשר לעזור. המצב קשה יותר כשיש תינוקות וילדים. יש זוגות שהלחץ גורם להם מתח בקשר הזוגי וכל אחד מבני הזוג מנסה להתמודד לבדו. כשמתמודדים עם משברים ביחד גדול יותר הסיכוי לצאת ממשבר. מומלץ לדבר, להקשיב לבני הזוג ולהצטייד בהרבה סבלנות. חשוב לחבק וללטף. המגע יכול להיות גורם מרגיע. חשוב לתת ביטוי לרגשות ולמחשבות. לא להגיע לוויכוחים. במקלט או בממ"ד לעודד משחקים ופעילות גופנית ולעבוד על החשיבה החיובית.

במלחמה ידועה תופעת הבייבי־בום, לידת תינוקות רבים מעל הממוצע בזמן רגיל. מתברר שהלחץ של הגברים היוצאים לקרב והחשש מהמוות גורמים להם לקיים עם נשותיהם יותר יחסי מין מכווני היריון. התופעה נצפתה לראשונה לאחר מלחמת העולם השנייה.

מציצנות



סטייה זו מתאפיינת בהופעת גירוי מיני בהתבוננות מכוונת באדם אחר בעיצומו של אקט מיני בשלב של התפשטות או עירום. עצם ההצצה היא הגורם לגירוי ולא האקט המיני הנצפה. בכל אדם יש יצר מציצני ברמה כזאת או אחרת. אצל נערים צעירים זו תופעה נורמלית. אם היא הופכת להיות הפעילות המינית המועדפת ורק בדרך זו נוצרים גירוי מיני ויכולת לתפקוד מיני, זו סטייה המצריכה טיפול. רוב המציצנים הם גברים.

משיכה מינית



משיכה מינית מורכבת חמישים אחוז ממה שיש לך
ועוד חמישים אחוז מה שאנשים חושבים שיש לך.
סופיה לורן

גברים ונשים

רזי המשיכה המינית עלומים. אי אפשר לנבא מי יימשך למי וכיצד.
באורגייט המשיכה משתתפים כל החושים. לפעמים היא עלולה להוליד
שולל.

ההבדל בהתנהגות המינית בין נשים לגברים הוא ביולוגי-פיזיולוגי-הורמונלי
וגם פסיכולוגי-חברתי.

מבחינה פסיכולוגית-חברתית נשים מחונכות מגיל צעיר לצניעות
ולכיבוש היצר. הגברים מחונכים לכיבוש. וגם מבנה המוח שונה, והתפישה
המינית שונה ביסודה בין המינים. הגבר רוצה לקיים יחסים עם כמה שיותר
נשים, האישה רוצה לקיים יחסים עם הגבר האטרקטיבי ביותר בעיניה.
בדרך כלל גברים נמשכים למראה עיניים. נשים נמשכות למשמע אוזניים
יותר משהן נמשכות למראה. בדרך כלל אצל הגברים המשיכה היא מיידית.
אצל נשים זהו תהליך מתמשך. עם זאת יש גברים שזקוקים לקשר רגשי כדי
לקיים יחסי מין ויש נשים שיכולות לקיים יחסי מין בלי רגש.
הורמון הטסטוסטרון הוא הורמון החשק העיקרי, ויש עוד הורמונים



המשפיעים על החשק. רמת ההורמונים הגורמים לחשק אצל האישה משתנה בכל חודש, ואצל הגבר היא משתנה מדי יום ביומו. אצל האישה יש בדרך כלל עלייה בחשק בזמן הביז.

על החשק משפיעים מצבים של דיכאון, מתח, חרדה, משברים בחיים, קונפליקטים בזוגיות ועוד.

משפיעים הנתונים הפיזיים: נשים יימשכו לגברים בעלי גוף סימטרי. גברים יימשכו לנשים יפות עם גוף יפה. ומשפיעים גם הפרומונים, המעמד, המצב הנפשי-רגשי, המצב הכלכלי, החברתי והסוציו-אקונומי, וגם גורמים שאיננו מודעים להם. לפעמים יש משיכה למישהו שמזכיר את אחד ההורים שלנו, לפעמים לחזק וכוחניות. משפיעים ריח הגוף, המראה, הדיבור, המגע, הכסף או הכוח. לעיתים מגלים שאדם שנמשכנו

אליו בתחילה דוחה אותנו כעבור פרק זמן ולפעמים אנשים שאנו לא נמשכים אליהם מתגלים כמושכים מאוד לאחר היכרות נוספת. המשיכה לא נמשכת לנצח.

נאווה, בת 59, עובדת ועסוקה. היא ובעלה המבוגר ממנה בשנים רבות חדלו לקיים יחסי מין. נאווה נגמלה מהצורך. היא נרשמה למכון כושר, ושם החלה להימשך מינית ורגשית למאמן כושר בן 43, גרוש. נאווה כל כך במבוכה ממה שקורה לה, עד שהיא נמנעת מלהגיע למכון. המאמן שולח לה מסרונים, והיא מתעלמת ורוצה לצאת מהפלונטר הזה. נאווה שואלת איך יוצאים מזה.

לנאווה, לא רק את ובעלך. זוגות רבים מדווחים על ירידה בלהט וביצר המיני עד חידלון מוחלט. אין תשובה חד-משמעית לשאלתך. ייתכן שאין במסרונים שהמאמן שולח לך שום רמז מיני והוא שולח אותם מתוך רצון לדאוג לפרנסתו. מוצע שתלכי אחר רחשי ליבך ותחליטי אם להמשיך להתאמן שם או לעבור למאמן אחר. מכל מקום, האם את יכולה לקבל את התיאבון מחוץ לבית ואז לחזור הביתה ולאכול? האם מה שקורה עם המאמן יכול להשפיע על היחסים המיניים עם בעלך? נסי. זה לא אומר שאת אמורה לפרק את הקשר עם בעלך. אולי יהיה רווח נוסף מזה שנרשמת למכון כושר.

מירב שואלת אם מומלץ לאישה ללבוש לבנים סקסיים. **למירב**, יש גברים שהפנטזיה שלהם היא להיות עם בת זוגם הלבושה בתחתונים ובחזייה הכי סקסיים ומפתים. יש גברים שלגביהם הלבנים הסקסיים הם איום וגורמים להם להיסגר. בררי עם איזה סוג נמנה הגבר שלך. אם קשה לך לשאול, נסי ותרגישי.

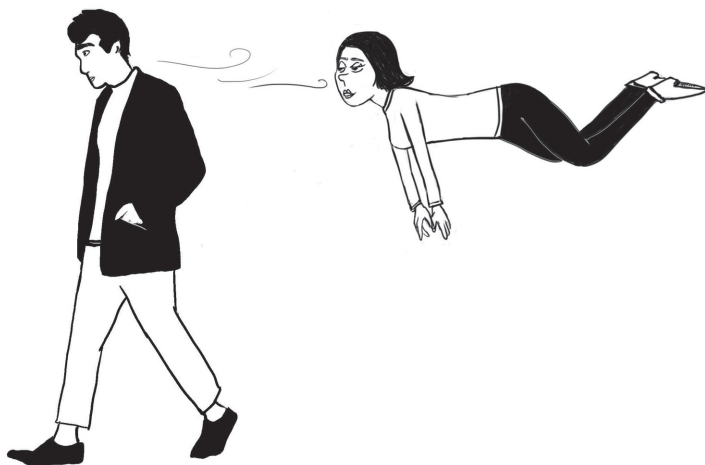
גורמי משיכה

הריח הכי טוב בעולם הוא הריח של הגבר שאת אוהבת.

ג'ניפר אניסטון

הריח (פרומונים) גורם לנו באופן מודע ולא מודע להימשך לאדם אחר או לסלוד ממנו.

הריח הוא אחד הרכיבים החשובים ביותר במשיכה המינית. קשה מאוד להתגרות מינית מאדם שאנחנו לא סובלים את הריח שלו. רבים מטשטשים את הריח הטבעי של הגוף בניחוחות מלאכותיים של בשמים, קרמים וסבונים. אלה מושכים אותנו בהתחלה, אך דוחים כאשר ניחוחם פג. הפרומונים הם מולקולות שבעלי חיים מפרישים לצורך איתות לבעלי חיים אחרים מאותו המין. בני אדם מסוגלים לזהות ולהגיב לפרומונים מסוימים. זיעה, הבל פה, שתן, רוק, חלב אם, הפרשות מיניות – כולם



מכילים כימיקלים ריחניים. תינוק בן יומו נמשך לריח השד של אימו. לזיעה הגברית יש השפעה מרגיעה על נשים. האסקימואים משפשפים אף באף, ובאותו זמן גם מריחים. בנשיקה המקובלת בעולם המערבי חשים בריכוזים הנגישים ביותר של בלוטות הריח בגוף, והאף לפני הפה חש באיכותו של האדם האחר. לחוש הריח יש גם תפקיד ביולוגי למצוא את בן הזוג המתאים לנו ביותר מבחינה גנטית ולהזהיר אותנו מפני בני זוג לא מתאימים.

המראה גורם למשיכה. גם המגע. גם משמע אוזניים. פעמים רבות נמשכים למי שנתפס כאדם אסרטיבי עם יכולת דיבור רהוטה ויודע להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון. משפיעים גם כסף וכוח. רבים נמשכים למי שנתפס כבעל כוח ובעל הון. נמשכים לאדם אחרי מגע איתו ותחושה שנוצרה כימיה. כמובן, יש עוד גורמים רבים. מקצתם אישיים ומובנים לאדם הנמשך לאחר. אחרים לא מובנים לנו, ולא נוכל לתת הסבר מדוע אנחנו נמשכים לאדם מסוים.

משיכה לשדיים

השדיים הם איבר נחשק. בכמה תרבויות הם סמל לפרייון. ציירים, פסלים וצלמים לא מסתירים את רגישותם לשדיים ומעלים על נס נשים בעלות

חזה שופע. בכתב העת 'ניו אינגלנד ג'ורנל און מדיסין' התפרסם מאמר הקובע כי גבר הנועץ מבט בשדיה של אישה מפחית ב-50 אחוז את הסיכון שלו להתקף לב.

ידוע שגברים אוהבים נשים עם חזה שופע וזקור. בשנת 1883 יצרה מרי טוסק את תומך החזה – שני כיסים מחוברים לכתפיות ונשרכים בקרסים. בשנת 1913 יצרה מרי ג'קובס חזייה משתי ממחטות בד שנקשרו יחד. החזייה עוזרת לנשים להרגיש נוח יותר עם כובד החזה. השדיים חשובים לדימוי העצמי של האישה. נשים רבות עוברות ניתוחים של הקטנה או הגדלה.

משיכה לנשים בהיריון

נשים בהיריון יכולות להיות יפות ומושכות: הפנים קורנות, הישבן והחזה גדלים והעור מתוח וחלק.

חוקרים אבולוציוניים סבורים כי גברים נמשכים לנשים בהיריון בגלל האינסטינקט הטבעי, שראשיתו בימי אנשי מערות שנמשכו לאישה הפורייה.

לאבי, בן 33, רווק, יש משיכה לכל אישה בהיריון. אם אישה בהיריון עוברת לידו ברחוב או על שפת הים, המראה יכול לגרום לו זקפה. הוא מרבה לאונן באינטרנט מול תמונות וסרטים של נשים הרות ואפילו מגיע לחיפוש של מין בתשלום בתחום הזה. אבי שואל אם משיכה לנשים בהיריון היא נורמלית.

לאבי, זה תלוי. יש גברים שמאוד נמשכים לנשים בהיריון, אבל המשיכה היא בעיקר לאישה שאיתם. אחרים לא יימשכו לבת זוגם המעוברת ויחששו לשכב איתה בזמן ההיריון מחשש לפגיעה בעובר. אם אתה נמשך רק לנשים בהיריון ומסוגל לקיים יחסי מין רק עם נשים בהיריון, זהו מצב פתולוגי המצריך התערבות מקצועית. אם זה רק חלק מהפרטואר שלך, אתה יכול להמשיך ולקיים יחסי מין גם עם נשים בהיריון.

כאשר המשיכה נגמרת

יש אומרים שיש מקום לעבוד על המשיכה, וזוהי עבודה יום-יומית. פעולות של הקשבה וחיזור ייצרו משיכה וישמרו על הגחלת. יש אומרים שאם אחד מבני הזוג לא יהיה מובן מאליו ותמיד ישמור על מתח מיני בתוך הקשר, הצד השני ירצה אותו ויימשך אליו. במקרים רבים של בגידה ייווצרו משיכה ותשוקה שימנפו את הקשר. יש אומרים שאם נגמרה המשיכה, אין מה לעשות, אבל לא רק על המשיכה תתקיים הזוגיות.

משפחה



הכלה והחמות

במחקר שנערך באנגליה ובדק כ-250 זוגות – כ-70% מהנשים דיווחו על קושי עם החמות. אכן, יש אימהות המנסות להשפיע על בניהן גם אחרי החתונה, ולפעמים מתחולל מאבק סמוי על השליטה בחיי הבן. היחסים בין הכלה לחמות לא נועדו להיות יחסים קשים, תחרותיים, לא מכובדים ולא מכבדים. מובאות כאן המלצות שאמורות לעזור לזוגות ובייחוד לכלה ולחמותה:

- קבעו מראש את דפוסי התקשורת והביקורים, אך היו גמישים לגבי שינויים וביטולים. אל תפתיעו בביקורים בלתי מתואמים. לכלה – שיתוף בן זוגך ביצירת הגבולות המשפחתיים עם משפחת המוצא שלו יקל על הקושי הרגשי שלהם לקבל זאת.
- השתדלו להימנע מביקורת ודברי גנאי. התייחסו לכל סוגיה לגופה בלי לגרור לתוכה זיכרונות וכעסים ישנים.
- אל תנסו לשנות זו את זו. הניסיון לשנות גורם לריב ולמתח.
- לכלה – אל תתלונני על בעלך באוזני אימו. לחמות – אל תליני על כלתך באוזני בעלה או באוזני אימה. דברי איתה ברגישות, ישירות ובגלוי.
- אל תהפכו את הילדים לכלי מאבק.
- לחמות – אל תזכירי בנוסטלגיה לפני כלתך את חברותי המיתולוגיות של בנך. גם אל תפארי לפנייה את נכדיך מצד בתך או נכדים של חבר.

המחותנים



עוד לפני החתונה יש לפעמים חיכוכים על רקע סוציו-אקונומי – ההורים רוצים שבנם האקדמי יתחתן עם אישה משכילה. יש חיכוכים על רקע דתי ויש חיכוכים על רקע עדתי. זה יכול להיות גם על רקע כספי או על כל דבר חשוב או זניח לחלוטין. לאחר החתונה זה יכול להיות על חלוקת התפקידים כשנולד הנכד הראשון. יש מתיחויות אצל מי לחגוג חגים. ויש עוד קונפליקטים למיניהם.

יש קושי גם במפגש בין מחותנים. לעיתים היחסים ביניהם טעונים ומתוחים. בני הזוג צריכים להקים לעצמם משפחות גרעיניות משל עצמם ולמדר את המשפחות. הנאמנות צריכה להיות קודם כל זה לזה.

המשפחה בחגים

תקופת החגים יכולה להיות מאחדת ומהדקת, כאשר היחסים בין בני הזוג טובים, אבל כאשר יש מתח בין בני הזוג, תקופת החגים מלחיצה. ייתכן שאחד מבני הזוג מגיע עם איזושהי סכמה שתקופת החגים היא קשה ולא טובה, ויתנהג בהתאם בתא המשפחתי שלו. יכול להיות שאצל אחד מבני הזוג ארוחת חג עם המשפחה היא סוג של מעמסה, ואז מתחילים לצאת דברים לא טובים. גם אצל מי להתארח זו בעיה.

יש שאחד מבני הזוג בא ממשפחה חמה ואחד ממשפחה קרה, ועל זה יש ביניהם סוג של מאבק.

יש משפחות שבהן הדברים קיצוניים והחיכוך גדול. המריבות יכולות להיות בשאלות איפה לחגוג, מי יכין מה, איך ישבו ליד השולחן, מי יעזור ואיך יעזור וכמה, מה ללבוש, איך להתנהג ועוד. כשיש מחלוקת בשאלה אצל מי לחגוג את החג, צריך לגשת למשא ומתן בלי מטענים וכעס ולמצוא פתרון שוויוני ומרגיע. רצוי שמוקד ההזדהות, הרגישות וההבנה יעבור לזוג עצמו ויתרחק ממשפחת המוצא. שני בני הזוג צריכים לדבר לפני שהולכים לארוחה ולסכם ביניהם מה עושים בכל מקרה. צריך לנסות לאמץ גישה חיובית ולהשתדל לראות רק את הדברים החיוביים, לעיתים להתעלם ולא להיעלב.

חופשה משפחתית

חופשה משפחתית מאפשרת בילוי זמן איכות נעים וקסום עם הילדים. ובכל זאת אין לוותר על האינטימיות הזוגית. ההורים מחויבים להצלחת הזוגיות, ואינטימיות טובה אינה מתרחשת מעצמה, ודרושה תתייחסות רצינית של שני בני הזוג לקשר. טוב שימצאו זמן להיות ביחד, ירשו לעצמם להשאיר את הילדים במלון. אם צריך, ימצאו שמרטף, ויוכלו לצאת בשניים לארוחה רומנטית במסעדה או לטיול בסמטאות של עיר. יפה שההורים יסיפו להיות החברים הכי טובים גם בחופשה עם הילדים, ועם זאת ימצאו לכל אחד מהם זמן איכות משלו. הוא יכול ללכת עם הבן למשחק כדורגל, הוא יכולה לצאת לסיבוב קניות עם הבנות (או להפך). בכל עת דרושה עבודה מוקפדת ואיכותית על הרומנטיקה. גם אחרי החופשה יש חשיבות לפתיחות ולרגישות לצורכי בן הזוג. וגם בחופש הגדול כשהילדים בבית וסדר היום משתנה.

ההורים

בכל עת חשוב לשמור על החברות והאינטימיות, שמא ייווצר ריחוק שאחר כך קשה לגשר עליו. דרושה תקשורת טובה ומספקת. חשוב למצוא זמן

ביחד, לשוחח ולא רק לדווח. חשוב למצוא זמן לפנאי מחוץ לבית שיש בו קרבה ואינטימיות זוגית, וחשוב שלכל אחד מבני הזוג יהיה פנאי לעצמו. כל אחד יתמוך בשני כדי שיוכל לפנות זמן לתחביביו ולעניינים שאינם זוגיים. חשוב לתכנן זמן למין לא חפוז ולעשות ארוחת גורמה. הילדים יכולים לצאת מהבית לחברים, לסרט או כל פעילות מאורגנת אחרת שתשאיר זמן למיניות. חשוב להיות יצירתיים וגמישים ולא לקיים יחסי מין רק כשבא. עם כל העייפות והטרדות אפשר להידלק מתוך החלטה. כמובן, במלאכת המיטה רצוי לשמור על ווליום נמוך בשעה שהילדים בבית.

נקודת הג'י



המקום

נקודת הג'י נקראת על שם ד"ר ארנסט גרפנברג, הגינקולוג הגרמני שגילה ותיאר אותה בשנת 1950. מקומה משתנה מעט מאישה לאישה. היא נמצאת במרכז הנרתיק, 4-5 סנטימטרים לכיוון דופן הבטן, בזווית של 45 מעלות ימינה או שמאלה. גירוי האזור מסב הנאה וגורם לאורגזמה אצל מקצת הנשים.

קיומה של נקודת הג'י שנוי במחלוקת בין אנשי מקצוע. עד היום לא הוכיחו את קיומה באופן חד־משמעי מבחינה אנטומית. בשום אטלס אנטומי בלימודי רפואה לא מוצאים את נקודת הג'י כחלק מהאנטומיה של גוף האישה.

אומרים שזהו למעשה עצבוב – ריכוז של עצבים – שהמשכו הוא הדגדגן. אחרים אומרים שמדובר בבלוטות המייצרות סיכון בנרתיק, מה שאולי לא התפתח להיות בלוטת הערמונית של הגבר. יש נשים שחשות את אזור נקודת הג'י, אחרות מחפשות אותה.

מוצאים את הנקודה בהחדרת אצבע לנרתיק. כריות האצבע מופנית אל הטבור, והאצבע נעה ב־45 מעלות אנה ואנה. כאשר מוצאים את הנקודה מפתלים את האצבע בתנועת "בוא הנה" כדי לעורר גירוי. הזזת האצבע בעדינות תביא נשים להרגיש גבשושית שהמגע בה נעים להן מאוד. לחלופין תרגיש האישה רצון לתת שתן, כיוון שנקודה זו קרובה לשלפוחית השתן. הרבה נשים לא מוצאות הנאה במגע הידני הזה.

רוב הנשים מגיעות לאורגזמה ממגע בדגדגן. מקצתן מגיעות לאורגזמה מיחסי מין מלאים, אך אי אפשר לומר בוודאות אם האורגזמה הנרתיקית נגרמת בזכות מגע בנקודת הג'י.

עיבוי נקודת הג'י

עיבוי נקודת הג'י נועד לפתור בעיות בתפקוד המיני וחוסר יכולת להגיע לאורגזמה. אין שום מחקר מדעי המוכיח את יעילות הזרקת חומצה היאלורונית, רסטילן, לעיבוי נקודת הג'י ולהגברת ההנאה של האישה. הזרקת חומר לעיבוי נעשתה בידי גינקולוגים בארץ, שחיקו רופאים בארצות הברית. בשנת 2007 הודיע האיגוד האמריקני לגינקולוגיה ומיילדות שאין כל הצדקה רפואית לניתוחי עיצוב הנרתיק או להזרקות לעיבוי נקודת הג'י, והופסקו ההזרקות.

נקודות הג'י של הגבר

נקודת הג'י של הגבר קרובה לבלוטת הערמונית. הנקודה נקראת גם נקודת ה'פי' בשל המגע בפרוסטטה. למעשה היא נמצאת בתוך פי הטבעת. יש גברים שיחושו הנאה כאשר מחדירים אצבע לתוך פי הטבעת שלהם כארבעה סנטימטרים פנימה לכיוון הבטן. יש גברים שיוכלו לחוות אורגזמה מחיכוך בנקודת הג'י. בפועל רק מעט גברים מתנסים בזה, כי לא כל גבר פתוח להתנסות מענגת במעלה החלחולת ולא כל אישה ששה להחדיר את אצבעה לפי הטבעת של הגבר. אם האישה תעשה זאת ותחדיר אצבע בתנועת "בוא הנה", יש סיכוי שהגבר יגמור וישפוך. חשוב שהאצבע תהיה מסוככת ובלי ציפורן. אם יש קושי אסתטי או רגשי להחדיר את האצבע לפי הטבעת, אפשר לשים עליה קונדום.

נשים מבוגרות וגברים צעירים



רוב הנשים המבוגרות משוחררות מגידול ילדים, והן פתוחות ועצמאיות מבחינה כלכלית ונפשית, והגברים הצעירים נמשכים אליהן גם מסיבה זו. הנשים נמשכות למראה החיצוני של גברים צעירים, לאון המיני שלהם, למשך הזקפה וליכולת להמשיך מייד לסיבוב שני. הן אוהבות את הגמישות, את הספונטניות ואת ההרפתקנות שלהם. הגבר הצעיר כאילו שומר אותן צעירות. הגברים, מצידם, אוהבים את התחכום ואת ההישגים שצברו הנשים המבוגרות יותר.

הנשים המבוגרות של היום נראות טוב הודות להתפתחות הרפואה ולמודעות הגוברת לחיים בריאים ותזונה נכונה. הן נוטות לחזור לשוק הפנויים-פנויות בגלל גירושים ותוחלת חיים ארוכה.



יש נשים שמחפשות גבר עם קריירה לא כל כך משגשגת, ובלבד שיבלה איתן זמן רב. לפעמים גבר צעיר רוצה להיות עם אישה מבוגרת משיקולים כלכליים. לפעמים הוא רוצה להיות עם סלבריטאית, כדי ליהנות מזוהר הפרסום. ויש גם מניעים אדיפליים: גבר נמשך לאישה בדמות אימו ומצפה שתסעד אותו ותדאג לו כמו אימו. זאת כאשר מדובר באם דומיננטית בחייו. המפתח הוא התאמת האנרגיות של בני הזוג, הדינמיות והאינטנסיביות שלהם בחיים. ואנרגיות אינן עניין של גיל.

דווקא המשפחות של בני הזוג עלולות להקשות, בייחוד כאשר האישה בגיל אימו של הגבר. למשפחה כולה ולילדיה של האישה יהיה קשה לקבל את מערכת היחסים, והם עלולים שלא לתמוך, להתנגד ולהחרים. קושי נוסף הוא פערים במנטליות, רצונות מנוגדים ותחומי עניין שונים. לפעמים יש פער בצרכים החברתיים, ואישה מבוגרת לא תרצה ללכת עם גבר צעיר לדיסקוטק.

בדרך כלל החברה מסתכלת על זוגיות מסוג כזה בהרמת גבה, בביקורתיות, במחשבה שיש אינטרסים, בייחוד אינטרס כלכלי.

אבל פער הגילים יכול גם לפעול לטובת הקשר. כל אחד מבני הזוג מביא איתו את היתרונות ואת הערך המוסף של גילו, וכך הם משלימים זה את זה. בת הזוג המבוגרת תתרום מניסיון החיים שלה, תתרום את הביסוס הכלכלי, תתרום ידע ויציבות. בן הזוג הצעיר יתרום את הרעננות, את הסקרנות ואת השובבות.

נשים מגיעות לבשלות מינית מאוחר יותר מגברים. בגלל פער הגילים סביר ששני בני הזוג יהיו בשיא פריחתם המינית, והסקס יהיה משוחרר, נטול עכבות ויצירתי.

בשנת 2000 בארה"ב היה שיעור מערכות הנישואים בין נשים מבוגרות לגברים צעירים 12%. בישראל נפוצות יותר מערכות יחסים של גברים מבוגרים ונשים צעירות.

נשיקה



בשבח הנשיקה

נשיקות אירוטיות תועדו כבר לפני שלושת אלפים וחמש מאות שנה. אצל הרומאים הנשיקה הייתה ברכת שלום, והם היו מנשקים את תכשיטי מנהיגיהם ואת דשי גלימותיהם. אמונה עתיקה אומרת שהנשיקה מאחדת את הנשמות באמצעות הנשימות. אמונה עתיקה אחרת אומרת שהנשמה נישאת בנשיקה.

בתקופה הפרה-היסטורית לעסו אימהות את המזון בעבור התינוקות שלהן ודחפו להם את העיסה ישר לתוך פיהם בעזרת הלשון. ייתכן שזה המקור לנשיקה. ייתכן שהמקור לנשיקה הוא היניקה מהשד וההנאה שמפיק ממנה היונק. קשר הלשון והשפתיים עם השד של האם, מבט פנים-אל-פנים ומגע קרוב יוצרים תחושה נעימה, ואת התחושה הנעימה הזאת אנו מבקשים לשחזר בנשיקה.

נשיקות הן המפתח לסקס משובח, לקשר טוב ולאהבה. נשיקה טובה יכולה להוביל להורדת בגדים מהירה. המחקר מלמד שנשים



מדרגות נשיקה אירוטית טובה מעל חיבוקים, ליטופים ומסאז'ים. אומרים שאם רוצים לעורר אישה, הדרך הטובה ביותר היא נשיקה טובה. הנשיקה עוזרת לבחור את בן הזוג הפוטנציאלי הטוב לנו ביותר מבחינה גנטית-כימית. בזמן הנשיקה אנו מפעילים חמישה עצבים באזור הפה, השפתיים, הלחיים, הלשון והאף. בנשיקה מופרש הורמון האוקסיטוצין המביא לתחושת קרבה ועוררות מינית.

הצד הפיזיולוגי

בנשיקה משתמשים ב-34 שרירים בפנים. המגע בשפתיים העמוסות בקצות עצבים מגרה איזור במוח שהוא גדול יותר מהאזור המגורה בזמן המגע באיברי המין. בנשיקה רומנטית ומעוררת עולה קצב הלב לאותה רמה שבה הוא פועם בעת ריצת 100 מטר מהירה. המוח מפריש אדרנלין, והמערכת החיסונית שולחת לעורקים עוד ועוד תאי דם לבנים.

במוח עולות רמות הנוראפינפרין, הדופאמין ופנילאטילאמין – מוליכים כימיים שרמה גבוהה שלהם במרווחים הסינפטיים יוצרת תחושה של הנאה ואופוריה. כמו כן משתחררים במוח חומרים דמויי מורפין ודמויי חומרי הרגעה – אנדורפינים ואנקפלינים – הנוסכים רגיעה ומפחיתים כאב. אחרי הנשיקה הראשונה, כשהשפתיים והלשון הזרות כבר מוכרות, המוח מפריש בנשיקה אוקסיטוצין, הורמון האהבה, המגביר את העונג המיני ותורם לחיבור ולהתעוררות מינית.

נשיקות וזוגיות

נשיקות הן מדד טוב לבריאות הקשר מבחינה אינטימית. נשים לא נוטות להתפתות לגבר שמתחיל קשר בנשיקה רק כדי להשכיב אותן. בזוגיות פורה ככל שמתנשקים יותר, כך ייטב. מחקר מעלה שגם נשיקה קצרה על השפתיים טובה לזוגיות. בני זוג שמתנשקים חולים פחות, מעורבים פחות בתאונות דרכים בדרך לעבודה, ומשתכרים 20%-30 יותר

מהלא מנשקים, כי יש להם יותר אסרטיביות אחרי שהרגישו נחשקים בבוקר.

בתקופה שלא יכולים לעשות סקס מסיבה רפואית או נפשית נשיות יכולות לשמר את האינטימיות ולהציל את חיי המין. המגע של פנים אל פנים בנשיקה מעניק ליחסים את הקרבה הנחוצה להמשך הקשר ומאפשר לזוגות להיזכר איך היו בתחילת הקשר. הנשיקה יכולה להצית את האש מחדש או לפחות לשמר את הקשר.

כללי התנשקות

התאימו את עצמכם לצד השני. אם האישה באה בעדינות, יבוא גם הגבר בעדינות. אם הוא תופס חזק ומצמיד את הפה שלו בעוצמה, האישה תעשה זאת באותו האופן. אם לא ברור באיזו עוצמה הצד האחר רוצה את הנשיקה, רצוי לנהוג בעדינות.

לפי סקר אינטרנטי, 56% מהגברים והנשים חושבים שהגבר צריך ליזום את הנשיקה הראשונה. גברים צריכים להתנשק גם כשברור שהנשיקה לא מובילה לסקס, שאם לא כן יהיו נשים שיפסיקו להתנשק איתם. אם המהלך הברור לגבר הוא נשיקה <מזמזם> סקס, הוא מסתכן באיבוד היכולת להתנשק רק בשביל הכיף.

מומלץ להשמיע קולות במהלך הנשיקה – זה טוב ומגרה. מומלץ לספר זה לזה לפני או אחרי כמה אתם נהנים. לגבר מומלץ להחזיק את ראש האישה בידיו בזמן שהם מתנשקים – זה מסעיר ומשרה הרגשה של ביטחון ופינוק.

מתנשקים נשיקה צרפתית עמוקה. מנשקים את הפנים, מנשקים את העיניים, מביטים זה בזה וחוזרים לעוד נשיקה עמוקה. אחר כך הכול פתוח. כל אחד והנשיקה המתאימה לו. והכלל החשוב ביותר הוא שכל זוג יתנשק כפי שנעים לו וטוב לו.

אורית, בת 18, יוצאת עם גבר שמנשק מאוד מוזר. הוא אוהב לנשוך לה את הלשון, תופס אותה מוצץ ונושך, וזה ממש לא נעים לה, אבל

אורית לא יודעת מה ואיך להגיד לו כדי לצאת מזה. אורית שואלת איך היא יכולה ללמד אותו לנשק כמו שהיא אוהבת בלי להעליב אותו. לאורית, חבל שנשיקתו של הבחור לא נעימה לך, אך אין ספק שהוא מנסה ככל יכולתו להפליג בנשיקות חושניות. כל שעלייך לעשות זה להחמיא לו על עצם היותו מאהב טוב, לחזק אותו באמירות שניים לך במגע שלו ובקרבה הפיזית שלכם, ותוך כדי כך לכוון אותו לפן העדין של הנשיקה הנעימה. את יכולה להגיד לו שפעם אחת את רוצה להראות לו מה ואיך עושה לך טוב, ואז לנשק אותו באופן שידגים לו מה נעים לך. בגישה כזאת אין ביקורת או העלבה, והיא תביא את הנשיקה המיוחלת.

סאדו-מאזוכיזם



מאזוכיזם

המונח 'מאזוכיזם' נקרא על שמו של ליאופולד פון זאכר-מאזוך. בספריו הדמויות מפיקות הנאה מינית מעינויים בידי אדם. מאזוכיזם היא הנאה מינית הנגרמת מכאב או התעללות. מאזוכיזם קיים במידה במערכות יחסים בריאות, ובעלי נטיות למאזוכיזם יחפשו בני זוג בעלי נטיות המתאימות להם ולצורכיהם. בצורה הקיצונית זו סטייה העלולה להסב נזק גופני ונפשי ואף לגרום למוות. המאזוכיסט מרגיש צורך להיות מאוים, מושפל ומוכה עד כאב. הוא מבקש מהפרטנר להכותו, לדקרו ולהשתמש במכשירים ועזרים להשגת המטרה ולהשגת ההנאה המינית.

סאדיזם

המונח 'סאדיזם' נקרא על שמו של המרקז דה-סאד (1740–1814), אציל צרפתי שאושפז בבתי חולים לחולי נפש ואף נכלא בגין התנהגות מינית אכזרית. בזמן שירותו הצבאי הוא כתב ספרים מלאים תיאורים של אכזריות מינית.

זו הסטייה ההפוכה או המשלימה למאזוכיזם, כלומר זוהי הנאה מגרימת סבל פיזי או נפשי לשותף. במקרים רבים הסאדיסט יתחבר למאזוכיסט כדי שיסופקו צורכי שניהם. סאדיזם בצורתו הקלה יכול להיחשב חלק

נורמלי מיחסי מין בין בני הזוג. הסאדיזם מתבטא לרוב בפנטזיות בלבד, אך במקרים הקיצוניים הסאדיסט ישתמש בכוח ובכלים מכאיבים לסיפוק צרכיו המיניים.

ההתנהגות הסאדו־מאזוכיסטית נעה בין השתתפות בפעילות מתונה ואפילו סמלית שאין בה אלימות וכאב ממשי ובין פאראפיליה – אסופה של נטיות לעוררות מינית שיש בה קשירה, עינוי, עיסוק במין פטישיסטי ואף פעילות מינית שיש בה סכנת חיים.

האנשים העוסקים בפעילות מינית שיש בה רכיבים סאדו־מאזוכיסטיים משתייכים לכל השכבות הסוציו־אקונומיות. מחקרים מדווחים ש־10% מהגברים ו־6% מהנשים נהנים מפעילות מינית שיש בה מגע מכאיב.



הפסיכיאטר ריכרד פון קראפט אבינג קבע בשנת 1885 שסאדו־מאזוכיזם הוא תופעה פתולוגית מוגזמת של הפסיכולוגיה הנורמלית של האדם. הוא ראה בסאדיזם הפרעה מינית בגברים, ובמאזוכיזם ראה הפרעה מינית בנשים.

לפי פרויד (1938), סאדיזם הוא רכיב אגרסיבי של האינסטינקט המיני שנעשה עצמאי ומוגזם. הוא נוצר בשלב פוסט־אדיפלי, כאשר ההזדהות עוברת מהאם לאב. מאזוכיזם נוצר בשלב פרה־אדיפלי, כאשר האם חזקה ודומיננטית.

רבים נהנים מפעילות מינית שיש בה מגע מכאיב. מחקרים מלמדים כי בקרב גברים יש רבים הנוטים לגרום כאב, ורבות הנשים המקבלות כאב. אך למרות הנטייה לייחס התנהגות מינית סאדיסטית לגברים והתנהגות מינית מאזוכיסטית לנשים, ידוע שנשים וגברים מתנהגים באופן סאדיסטי ומאזוכיסטי בלי קשר למגדר.

אביטל מתכוונת לנסות ללכת למועדון סאדו-מאזו רק כדי לראות מה זה, כי זה מאוד מסקרן אותה. אולי אפילו תתנסה קצת. היא תוהה אם זה אומר שזה טבוע בה וחלק ממנה או זה רק יצר סקרנות.

לאביטל, סקרנות וחקרנות מינית היא תופעה טבעית. יש רמות ודרגות שונות להתנהגות מינית סאדו-מאזוכיסטית. יש שעושים "סאדו-מאזו לייט" ומכניסים לרפרטואר המיני שלהם מעט כוחניות, קשירות, מכות קלות, אך אין זו הדרך היחידה שלהם כדי להגיע להנאה ולסיפוק מיני. את רשאית לספק את סקרנותך כל עוד הסקרנות הזאת אינה דרך חיים.

מיקי בת 31, ובן זוגה מבוגר ממנה בכמה שנים. הם אוהבים להשתעשע בסאדו-מאזו לייט. הבעיה היא שלפעמים הוא נושך לה את הפטמות עד זוב דם, והיא חוששת שזה עלול להזיק לה בהנקה בעתיד. מיקי שואלת אם הדאגה שלה מוצדקת ואיך אפשר להמשיך לשחק בלי לפגוע בו ובלי להיפגע.

למיקי, בשעשוע שלך ושל ובן זוגך השאלה העיקרית היא אם את חווה הנאה מהנשיכה עד זוב דם או רק מממשת את צרכי הסאדיסטיים של בן זוגך מחשש שיעזוב אותך. גם אם את נהנית, טוב שתביעי באוזניו את דאגתך באשר לדימום התכוף מהפטמות. ואולי יש מקום לסאדו-מאזו לייט שלא מביא לדימום כלשהו. אם זה קורה רק כמה פעמים, אין סיבה לדאגה, אך אם זה שגרתי, נכון לפנות לרופא כדי לעבור בדיקה ולשלול זיהומים והצטלקויות שעלולים לפגוע ולהזיק ואף לפגוע בהנקה בעתיד.

סוכרת ומיניות



המחלה

סוכרת היא מחלה מטבולית המתאפיינת בריכוז גבוה של גלוקוז בדם ובשתן. המחלה נפוצה למדי. יש לה רכיב גנטי, אך שכיחותה עולה עם השנים בעיקר בגלל תופעת ההשמנה וסגנון החיים חסר הפעילות הנפוץ במערב. סוכרת היריון יכולה להסתיים עם הלידה, אך לא מעט נשים נשארות חולות בה כל חייהן. בארצות הברית כ-6% מהאוכלוסייה לוקים בסוכרת. שכיחות המחלה בארץ עולה משנה לשנה.

הגבר הסוכרתי

ליקויים בתפקוד המיני מופיעים אצל מחצית הגברים חולי סוכרת מתחת לגיל 60. הליקויים באים לידי ביטוי בבעיות חשק, בעיות עוררות, בעיות באורגזמה וכאב. הם עשויים להיגרם בשל סיבות וסקולריות, הורמונליות, עצביות, וגם בשל גורמים נפשיים, תופעות לוואי של תרופות ועוד. תיתכן מעורבות מעבר להפרעות רפואיות אלו, שכן תפקוד מיני לקוי משפיע בדרך כלל גם על המצב הרגשי, הנפשי והזוגי. אצל חולי סוכרת הסובלים ממחלה קרדיווסקולארית וגם מעשנים יותר מעשרים שנה יש הפרעת זקפה קשה.

מחקרים מצאו קשיים בזקפה של 39% בקרב סוכרתיים לעומת 10%

בקרב בריאים. נמצא שסוכרת דומיננטית בהתפתחות קשיים בזקפה יותר מגורמי סיכון אחרים (עישון, דיסליפידמיה – הפרעה בשומני הדם, לחץ דם). כשליש מהגברים הסוכרתיים מדווחים על קשיים בשפיכה. הקושי עלול להופיע לפני הקושי בזקפה או בתחילת הכשל בזקפה. ויש גם השלכות פסיכולוגיות – פגיעה בדימוי הגברי והמיני וכרסום בביטחון העצמי. כאשר יש פגיעה בתפקוד המיני, לא מעט גברים ילקו בדיכאון ויחוו חרדה. יש רק מעט מידע לגבי יעילות ההתערבות הפסיכולוגית. יש חשיבות גדולה לטיפול משולב, תרופתי ומיני.

תרופות מקבוצת חוסמי פוספרדיאסטראז 5 (PDE5 inhibitors) – ויאגרה, סיאליס לויטרה ותרים – הן בטוחות לשימוש, למעט במקרים של שילוב עם תרופות מקבוצת הניטראטים או במקרים של חולי לב לא מאוזנים. שיעור ההצלחה 60–75%. טיפול תרופתי אחר הוא הזרקות של prostaglandin E1 (PGE1) ישירות אל הגוף המחילתי בפין או שימוש במכשיר ואקום.

בשל השינוי הצפוי בחיי המין דרוש שינוי באורח החיים. דרוש ייעוץ מיני זוגי והדרכה לקראת יחסי מין שאינם מחייבים חדירה. כאשר למטופל חשובה היכולת לקיים יחסי מין מלאים ואין לכך מענה רפואי, אפשר לשקול השתלת תותב. הפגיעה משפיעה גם על בת הזוג ועל התא הזוגי. דרוש טיפול רב-תחומי – רפואי, מיני, זוגי.

האישה הסוכרתית

מחלת הסוכרת משפיעה על מיניות האישה ועל תפקודה המיני. אצל גברים השינויים הפיזיולוגיים והתפקודיים נראים לעין, ולא כך אצל נשים. המחקרים מתבססים על שאלונים אישיים ולא על ממצאים אמפיריים. ההפרעות הבולטות בתפקוד המיני של הנשים הן פגיעה בחשק המיני, ירידה בעוררות המינית, כאבים במגע המיני, יובש בנרתיק, כרסום באורגזמה. הקשיים הם תולדה של המחלה, של הטיפול במחלה, חוסר האיזון ברמת הסוכר בדם והפגיעה בדימוי הגופני. סביר להניח שהפגיעה בתפקוד המיני דומה אצל נשים ואצל גברים סוכרתיים. ככל הנראה ההפרעה העיקרית

הפוגעת בתפקוד המיני של נשים סוכרתיות היא פסיכולוגית, ואחד הרכיבים העיקריים הוא דיכאון. הדיכאון שכיח בעיקר בנשים סוכרתיות שאינן מאוזנות. עליית הסוכר בדם, בין אם היא קבועה או זמנית ומשתנה, גורמת לתגובה רגשית דיכאונית הפוגעת בתשוקה ובחשק המיני. יתר על כן, נשים סוכרתיות עלולות לסבול מעודף משקל, וכתוצאה מכך יש כרסום בדימוי הגוף ובאופן ישיר פגיעה בנשיות ובזוגיות. הבנה ועזרה מצד בן הזוג יביאו לשיפור בדימוי העצמי של האישה, בתפקודה היום-יומי בכלל ובתפקודה המיני בפרט.

לפעמים הליקוי בתפקוד המיני הוא הסנונית המבשרת את הסוכרת. חשוב לעשות בדיקות דם שגרתיות. חשוב להקפיד על פעילות גופנית סדירה ועל דיאטה מתאימה כדי לשמור על הגוף ועל הנפש ועל תפקוד מיני בריא.

סרטן ומיניות



סרטן השד

סרטן השד הוא סוג הסרטן הנפוץ ביותר בנשים. הפרעות בתפקוד המיני אצל נשים עם סרטן השד נגרמות עקב מכלול של השפעות גופניות, נפשיות, זוגיות ותודעתיות. הגורמים לירידה בתפקוד המיני בנשים שלקו בסרטן השד לא נחקרו דיים, אולם יש כמה גורמים שיכולים לנבא את הופעת הבעיה, ובהם קיום הפרעה בתפקוד המיני קודם לאבחון הסרטן, שינויים תלויי גיל בתפקוד המיני, מידת החוסן הנפשי והפרעות בקשר הזוגי.

ההתמודדות עם המחלה מפילה על האישה את הצורך להתמודד עם הפגיעה בנשיות ובדימוי הגוף שלה. בעקבות המחלה 20%–30 מהנשים מגלות קשיים נפשיים, וסביר להניח שפעילות מינית היא הדבר האחרון העובר בראשה של האישה החולה בסרטן השד. המחשבות על הטיפול והסכנה לחיים הם הממלאים את התודעה, ונושא המין נדחק לפינה. עם זאת ככל שהאישה מרגישה טוב יותר וככל שהביטחון שלה עולה בזמן הטיפול ואחריו, יכול להופיע רצון לחזור לאינטימיות ולחיי מין עם בן הזוג.

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר הן קושי בהגעה לאורגזמה, ירידה בחשק, כאב בחדירה, שינויים בגודל ובמרקם הנרתיק ויובש בנרתיק. הבעיות בתפקוד המיני אינן נוטות להיפתר מעצמן במהלך השנה או השנתיים הראשונות לאחר גילוי המחלה, אלא נוטות להחמיר. לכריתת השד יש השפעה רבה על הרצון לעסוק במין. לכימותרפיה יש השפעה רבה על איכות המין. טיפול הורמונלי משפיע על שכיחות גלי חום, הזעות לילה,

הפרשות נרתיקיות וסימנים מוקדמים של גיל מעבר. טיפול זה משפיע גם על הפחתה בגירוי המיני וביכולת להגיע לאורגזמה.

ההשפעות על האישה

השד הוא סמל של נשיות, משיכה מינית ואימהות. חשוב שבן הזוג יהיה שותף בתהליך ההחלמה לאחר ניתוח. נשים רבות מגלות כי בני זוגן מודאגים פחות מהן ממראה השד ומהשפעותיו העתידיות. פחד מדחייה לאחר ניתוח שד הוא תופעה נפוצה.

אזורי ההקרנה אצל נשים שעוברות הקרנות עלולים להיות רדומים, כואבים ופצועים. על האישה להדריך את בן זוגה לגבי עוצמת המגע הרצויה לה. ההקרנה גם עלולה לגרום לתחושות המפחיתות את החשק לעסוק במין.

כימותרפיה גורמת לירידה בחשק המיני ולירידה בתדירות יחסי המין הן בגברים הן בנשים. תרופות הניתנות במהלך הטיפול הכימותרפי יכולות לגרום חולשה, בחילות, הקאות, דכדוך, כאבי שרירים, נשירת שיער ושינויים במחזור החודשי. נשים בגיל הפוריות צריכות לדעת כי לעיתים צפויים שינויים קשים במחזור החודשי ויחלוף זמן רב עד שהמצב ישוב לקדמותו. לחלק מהנשים מופיעים סימנים של גיל מעבר בזמן הטיפול הכימותרפי בגלל הירידה בתפקוד השחלתי והפחתה בהפרשת האסטרוגן, מה שמפחית את הלחלוחית בנרתיק ועלול לגרום כאבים ביחסי המין. שימוש במסככים על בסיס מים יכול להקל במצב זה. כך גם הארכת המשחק המקדים. חשוב לצייד את הזוגות במידע מהימן לגבי הצפוי להם ולגבי הדרכים להתמודדות.

כחלק מהטיפול ההורמונלי נשים רבות נוטלות את התרופה טאמוקסיפן למשך חמש שנים לאחר השלמת הטיפול בסרטן השד, וגם לטיפול ההורמונלי השפעה שלילית על דימוי הגוף. צבירת משקל, יובש בנרתיק, ירידה בליבידו, גלי חום והפרעות בשינה הם רק חלק מהתופעות שעשויות להופיע ולהפחית את העניין במין ואת הריגוש המיני. חשוב לגלות התחשבות ורגישות בשלבים אלו.

התפקוד הזוגי

השינויים בזוגיות יכולים לבוא לידי ביטוי בחלוקת התפקידים. במחקרים רבים נמצא כי המחלה משנה את מערך התפקידים במערכת הזוגית. בנוסף להתמודדות עם המחלה הקשה מרובות המטלות. אנשים שמילאו לפני שחלו תפקיד דומיננטי, תומך ומייעץ במערכת הזוגית שלהם הופכים לדמויות נתמכות, נזקקות ותלותיות, והיפוך התפקידים גורם לנטייה של החולה להתרחק רגשית מבן הזוג.

כשהאישה חולה, גברים רבים מדווחים על תחושה קשה של חוסר אונים ופחד מהעובדה שלא ידעו איך לתמוך בה בצורה נכונה ולספק את צרכיה. לעיתים הם חשים צורך לדבר על חששותיהם, וחשוב ביותר לתת להם מענה פסיכולוגי ותמיכה שיאפשרו להם לבטא פחדים ותסכולים. יש גברים שחווים קשיים בתפקוד המיני בעצמם לאחר הטיפול בבנות זוגם. בעיות נפוצות הן פחד מאיבוד בת הזוג עקב מחלתה, כעס על השינוי הפתאומי בחיי המין, ירידה בחשק ובעוררות המינית, חרדת ביצוע, שפיכה מוקדמת ואיך-אונות.

סטומה

סטומה היא פתרון חלופי לפעילות של הגוף. סטומה למעי היא פתח שדרכו תצא הצואה לאחר ניתוח במקום דרך פי הטבעת. להוספת הגוף החיצוני יכולות להיות השפעות שליליות קשות על דימוי הגוף. המחלה, ההתערבות הכירורגית ההקרנות וההשפעות הפסיכולוגיות הנלוות עלולות לפגוע בתחושות באיברי המין ובמיניות עצמה, ולהשפיע על הרצון לעסוק בפעילות מינית.

על הפגיעה בתפקוד המיני משפיעים אופי הניתוח ומיקום הסטומה. יש אנשים שיחוו קשיים בתפקוד המיני תקופה מסוימת לאחר הניתוח, ואחר כך תפקודם יהיה תקין. אחרים יחוו פגיעה חלקית בתפקוד. לעיתים הפגיעה תהיה קבועה ותצריך התאמה מחודשת לחיי המין שלהם. יש

שילקו בתפקודם באופן חמור ויהיה צורך בשיקום ושינוי בכל מה שהכירו בתפקודם המיני.

אבל החיים עם סטומה לא חייבים בהכרח לכרסם ולפגוע בזוגיות וביחסי המין. היסוס וחששות בתחילת החזרה ליחסי מין הם תהליך טבעי ונורמלי. הרוב המכריע של החולים חווים שינוי במשיכה של ואל בן הזוג, שינוי בתשוקה, ובעיקר דואגים להתנהלות עם מגבלתם הגופנית.

תקשורת היא מילת המפתח. פעילות מינית לא תפגע בסטומה. כדי ליהנות מהמגע המיני כאשר משתמשים בערכה המורכבת משני חלקים, אפשר לכסות את הפאון' הקטן, וחשוב לרוקן אותו לפני קיום יחסי מין. אפשר להדביק את הפאון' לגוף כדי למזער את תנועתו ולמנוע רעשים. חשוב לדבר עם בן הזוג ולחלוק איתו את החרדות המתעוררות עם החזרה לקיום יחסי מין. לפני המגע האינטימי הראו לו כל שינוי שחל בגוף. חפשו את המקומות הנעימים והחושניים למגע. היו פתוחים לשינויים בדפוס המין.

סרטן הערמונית

הערמונית, הפרוסטטה, היא בלוטה בגוף הגבר הממוקמת באגן, באזור הבטן התחתונה, מתחת לשלפוחית השתן. צורתה דומה לפרי הערמון. הבלוטה מקיפה את הצינור המוביל את השתן מהשלפוחית החוצה, ותפקידה קשור לייצור נוזל הזרע בגבר. היא אחראית לשילוב הזרעונים המיוצרים באשכים בנוזל הזרע. כ-50% מהגברים מעל גיל 50 סובלים מבעיית הערמונית המוגדלת. הם מתעוררים לעיתים תכופות בלילה, רצים לשירותים, חשים אי-נעימות ויש להם בעיות בתפקוד המיני.

בעבר חשבו שגברים החווים שפיכה תדירה ביחסי מין או באוננות נוטים לחלות בסרטן הערמונית, מאחר שיחסי מין תדירים חושפים גברים לחידקים ולוירוסים. מצאו גם שפעילות מינית בתדירות גבוהה עם פרטנרים רבים מגדילה ב-40% את הסיכון ללקות בסרטן הערמונית. אבל בשנים האחרונות נערכו מחקרים אשר הגיעו למסקנה הפוכה. במחקר אמריקאי שנמשך 8 שנים השתתפו 29,342 מומחים מתחום

הבריאות בני 46–81, והם נשאלו על הרגליהם בשנים קודמות. 1,449 מהם פיתחו סרטן ערמונית. הגבר הממוצע דיווח על 7 פעמים בחודש יחסי מין או אוננות. לא נמצא סיכון מוגבר לסרטן הערמונית בקרב גברים אשר דיווחו על תדירות גבוהה יותר, ונראה כי הסיכון הלך ופחת בקרב גברים אשר דיווחו על התדירות הגבוהה ביותר. שתי הרמות הגבוהות ביותר – 13–20 בחודש ולפחות 21 בחודש קושרו לסיכון פוחת לחלות במחלה.

מחקר שפורסם באוסטרליה בשנת 2005 מצא שאוננות משנות העשרים לחיים מפחיתה במידה רבה את הסיכוי לחלות בסרטן הערמונית בגיל מבוגר. ככל שאדם מאונן יותר בגיל 20–50 כך קטן הסיכוי שיחלה בסרטן הערמונית.

עוד נמצא שאנשים שעשו פעולת שפיכה בתדירות של 5 פעמים בשבוע בשנות העשרים לחייהם הקטינו ב־ 33% את הסיכון לפתח סרטן ערמונית אלים בגיל מבוגר יותר. החוקרים טענו ששפיכה בתדירות גבוהה מגינה מפני התפתחות הסרטן, שכן היא מונעת את הצטברותם של החומרים המסרטנים בבלוטה.

עוררות מינית מתמדת



עוררות מינית מתמדת היא תופעה נדירה השייכת להפרעות בתפקוד המיני של נשים. זהו מצב עקבי וממושך של גודש בכלי הדם, רגישות ועוררות תמידית של איברי המין בלי קשר לגירוי פסיכולוגי או גופני. העוררות איננה ביטוי של חשק, צורך או רצון לקיים יחסי מין. היא יכולה להתקיים עם תסמונת רגליים חסרות מנוחה או עם תסמונת שלפוחית שתן רגיזה, ויש כמה קווי דמיון. היא יכולה גם להיות קשורה לנורופתיה סנסורית של העצב הגבי של הדגדגן.

זה מצב לא קל זה שנמשך פרקי זמן משתנים, משעות אחדות ועד ימים ושבועות. עוצמת הגירוי יכולה להיות נסבלת, ואז האישה יכולה לתפקד ולהתנהל בחיי היום-יום, אך יש גם עוצמות קשות המלוות בדיכאון ובמחשבות אובדניות.

הגעה לאורגזמה אין בה בכדי להביא לפורקן ולרגיעה. האורגזמות הנחווות יכולות להיות מינוריות ובלתי משחררות, ויש גם אורגזמות שיכולות להכאיב.

הנשים הלוקות בעוררות מינית מתמדת סובלות מאוד מבחינה נפשית. הן עסוקות כל היום בגירוי המציק, מוצאות את עצמן מנסות להגיע לפורקן באוננות כפייתית במשך שעות בכל יום, וכל זאת בלי גירוי אובייקטיבי או סובייקטיבי שהוא תולדה של חשק או פעילות מינית מגרה.

מקור התופעה אינו מובן. בעבר חשבו שמדובר בקושי פסיכולוגי וניסו לטפל בתופעה באמצעות פסיכותרפיה. אחר כך חשבו שזו השפעה של התרופה האנטי-דיכאונית טרזודון. חשבו שהפסקת טיפול בכדורים אנטי-דיכאוניים וחרדתיים גורמת לתופעה. מחקרים חדשניים מעלים ששימוש

בתרופות אנטי־דיכאוניות יכול לעזור בהקלה ובצמצום התופעה. נמצא שלנשים הלוקות בעוררות מינית מתמדת יש תפקוד מיני טוב פחות מנשים אחרות, שביעות הרצון שלהן מיחסי מין נמוכה יותר והן סובלות יותר מכאבים במגע המיני.

מחקר העלה שטיפול בנזעי חשמל יכול להעלים לחלוטין את העוררות המינית ואת הדיכאון. כמו כן התדירות והעוצמה של הסימפטומים מגיבים לטיפול ב־Pramipexole (תרופה שנועדה לשימוש בפרקינסון).

עירום פומבי



אנתרופולוגים מעריכים שבני אדם קדמונים עברו את חייהם בעירום מלא באופן טבעי. ההסבר השכיח לכיסוי הגוף בעורות בעלי חיים ובצמחים הוא הגנה משינויי אקלים. ויש גם מטרות אחרות כמו כישוף, קישוט, פולחן. אין עדויות ישירות להתפתחות הבגדים הראשונים. בגדים החלו להיות נפוצים בחברה האנושית לפני כ-70,000 שנה. לא ידוע מתי החלו טעמי הצניעות להשפיע על מנהגי הלבוש האנושיים. ספר בראשית ג 7 מתאר את השינוי שעבר על אדם וחוה בגן עדן: "וַתִּפְקְחָה עֵינֵי שְׁנֵיהֶם וַיֵּדְעוּ כִּי עֲרֻמָּם הֵם וַיִּתְּפְרוּ עֲלֵה תְּאֵנָה וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם חֲגֹרֹת".

ביוון העתיקה התפתח אידיאל של גוף האדם היפה והעירום ביופיים של גברים צעירים ולעיתים גם ילדים, נשים וילדות. בתחרויות ספורט התחרו המתמודדים בעירום מלא, אך לא הותרה בהן השתתפות וצפייה של נשים. בעת ההיא היו מקובלים ציורים המתארים עירום ויחסי מין בין נערים למבוגרים.

ברומא העתיקה עירום פומבי נחשב לא ראוי, אבל בתי מרחץ נועדו לשני המינים. גלדיאטורים בתחרויות היו עירומים וחמושים בכלי נשק ובמגינים. במאה הרביעית, כשהחלה הנצרות להתפשט, נעלמו תחרויות הגלדיאטורים, והרומים החלו לראות בעירום חטא.

בתקופה הוויקטוריאנית עירום בציבור נחשב למגונה. חופי הרחצה הופרדו. במקומות רחצה ציבוריים הסתירו את הגוף העירום.

עירום מקושר למיניות ברוב התרבויות שבהן מקובלת צניעות הגוף. בתחילת המאה ה-20 חשיפת פטמות הגבר נחשבה לא ראויה בחלק מחופי הרחצה. יש לא מעט שבטים באפריקה המסתובבים בעירום מלא או בגוף

עליון חשוף בלי קשר למיניות. בכמה ארצות חשיפת שדיים על שפת הים היא מעשה חוקי. במדינות רבות באפריקה חשיפת פטמות מותרת. בארצות הברית חשיפת פטמות האישה בפרהסיה היא מעשה פלילי. ברוב מדינות אירופה מקובל שיזוף בחזה חשוף, אך חשיפת החלציים אסורה. הנקה בפומבי זוכה ליחס סלחני, אך לא בכל מקום. יש הטוענים כי איסור חשיפת פטמות הנשים פוגע בשוויון הזכויות בין המינים. נודיסטים נוהגים לבלות באתרים המיועדים לעירום. ויש אומרים שדימוי הגוף של נודיסטים חיובי ובריא יותר מהדימוי הנורמטיבי. בכמה תרבויות מרובים מופעי החשפנות.

העירום הוא תלוי תרבות. לאורך ההיסטוריה הצגת עירום ביצירות אומנות התאימה למוסכמות החברה לגבי עירום פומבי. מקצת התרבויות סלחניות כלפי עירום באומנות יותר משהן סלחניות כלפי עירום ממשי.

וראו גם אקסהיביציוניזם – סטייה הנובעת מדחף להיות בעירום במקומות ציבוריים.

פאראפיליה



סטייה מינית

סטיות קיימות בפנטזיות המיניות של גברים ונשים. כשקיימת הסכמה בין בני הזוג לגבי פעילות מינית חריגה, וזו אינה מזיקה, היא יכולה להיות חלק ממערכת יחסים אוהבת. ואולם חריגה קיצונית שהיא תנאי לקיום יחסי מין בלי הסכמה של שני הצדדים, זוהי פאראפיליה – סטייה העלולה לפגוע ביכולת לקיום יחסי מין תקינים ומהנים. לעיתים בני הזוג של הלוקים בסטייה עלולים לחוש שהם חסרי חשיבות. רוב הלוקים בפאראפיליה הם גברים, ולעיתים הם לוקים ביותר מסטייה אחת.

סוגים והגדרות

משמעות המילה פאראפיליה ביוונית היא משיכה לדבר אחר. מדובר על התעוררות מינית בתגובה לחפצים, מצבים או פריטים שאינם חלק מגירוי נורמטיבי, התעוררות אשר גורמת למצוקה או לבעיות קשות לאדם ולבני הזוג שלו ומפריעה לקיום יחסי מין אוהבים. אפשר לטפל בכל פאראפיליה, אם הלוקה בה רוצה בכך.

סטייה מינית מוכתבת למעשה מתוך הנורמה בחברה או בתרבות מסוימת. מה שיכול להיות מוגדר כסטייה בחברה אחת יכול להיות התנהגות נורמטיבית בתרבות אחרת.

פאראפיליה נחשבת לעבירה אם הייתה פגיעה בזולת ואם הפעילות המינית הייתה בלי הסכמה מוחלטת של בן הזוג.

עד שנת 1973 הומוסקסואליות הוגדרה כסטייה מינית, ואילו היום היא מוגדרת כהעדפה מינית. גם אוננות הוגדרה בעבר כסטייה מינית, והיום היא נחשבת לפעילות מבורכת כל עוד היא נעשית בצנעה. אוננות בציבור מוגדרת כסטייה.

הגדרת פאראפיליה: משיכה מינית הכוללת פנטזיות והתנהגות שאינה מקובלת במשך שישה חודשים לפחות. התנהגות לא מקובלת: שימוש בעצמים לקיום יחסי מין, גרימת סבל והשפלה של הפרט או שותפו בקיום יחסי מין, יחסי מין עם ילדים, יחסי מין עם אנשים חסרי יכולת החלטה (למשל הסובלים מפיגור שכלי).

הפאראפיליות ימצאו בטווח נרחב בין מיניות כמעט נורמטיבית ובין מיניות הרסנית ומסוכנת לאדם ולסביבתו. המשיכה וההתנהגות הן מקור לחץ ופוגעות בתפקודים הפסיכו-סוציאליים של האדם, פוגעת בסביבה ומתקיימת ללא הסכמה.

550 סוגי פאראפיליות אובחנו בציבור. שכיחותן באוכלוסייה כ-5%. רוב הפאראפיליות פורצות בגיל ההתבגרות. יחס נשים:גברים הוא 20:1.

פאראפיליות מוכרות הן **פדופיליה** (משיכה לילדים קטנים) ו**נקרופיליה** (משיכה לגופות מתים). ויש גם **אגוראפיליה** (משיכה לסקס במקומות פתוחים), **זואופיליה** (משיכה לבעלי חיים), **אופידיופיליה** (משיכה לנחשים), **אולפקטופיליה** (משיכה לריחות). יש משיכה לאסונות כמו תאונות דרכים. ויש **פלאשופיליה** (תשוקה לצעצועי פרווה), **אקסהיביציוניזם**, **פטישיזם**, **פרוטאוריזם** (התחככות באנשים לבושים), **מאזוכיזם**, **סאדיזם**, **ויוריזם** (צפייה באנשים ערומים), **טרנסביזם**. ויש עוד רבות.

הטיפול

הצלחת הטיפולים תלויה בהיענות לקבל את הטיפול. הטיפול ההורמונלי הוא סירוס לדיכוי הצורך המיני. נוטלים

אנטיאנדורוגנים כמו פרוגסטרון או מדכאים ברמה היפופיזרית ב-GNRH Agonist.

שיעור הצלחת הטיפול הכימי 60–80%, אך יש הרבה תופעות לוואי כגון אוסטאופורוזיס, השמנה, כאבי ראש וצמיחת שדיים בטיפול הפרוגסטיבי.

טיפול פסיכודינמי והתנהגותי כולל טיפול קבוצתי או פרטני. תרופות פסיכיאטריות ניתנות כדי לטפל בתופעות או במחשבות כפייתיות. נותנים גם סטימולנטים, כמו ריטלין, שבאופן פרדוקסלי מגבירים את השפעת SSRI.

מומלץ לשלב טיפולים פסיכולוגיים וטיפולים פסיכיאטריים והורמונליים. בפאראפיליות קשות דרוש טיפול של שנים.

פדופיליה

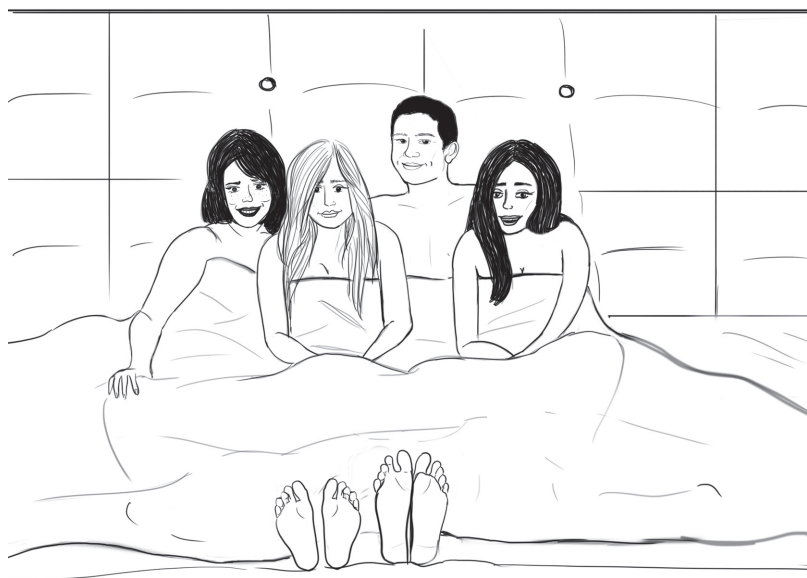


ההגדרה: פדופיל הוא אדם בן שש עשרה לפחות, מבוגר בחמש שנים לפחות מהילד שהוא חומד. מי שלוקה בפדופיליה נתון במצוקה בחיי היום-יום ושקוע בפנטזיות על ילדים. במקרים רבים מדובר בפנטזיות בלבד ולא במגע מיני. גם גברים וגם נשים עלולים להיות פדופילים, והקורבנות הם ילדים או ילדות. הפדופיל עלול להשתמש בכוח כדי לכפות על ילד מגע מיני או להשתמש באיומים על הילד כדי שלא יחשוף אותו. הטיפול הוא פסיכותרפיה בשילוב טיפול תרופתי לדיכוי הדחף המיני. לא תמיד מצליחים בטיפול.

פוליאמוריה



פוליאמוריה – אהבה של יותר מאדם אחד – היא מערכת יחסים רומנטית בעלת מעורבות גבוהה. היא יכולה להיות מינית, רגשית, רוחנית או כל שילוב אחר לפי רצון והסכמה בין יחידים. יש קומבינציות ודרגות של יחסים, ולא נפקד גם מקומה של הקנאה. אם קשה לחיות בשניים לאורך זמן, קל וחומר בריבוי שותפים. מילת המפתח היא הידברות. יחסים פוליאמוריים אינם מחייבים מעורבות של סקס, ותופעה זו שונה מתופעת הסווינגינג – חילופי זוגות – המתמקדת בהיבט המיני. יכולה



להיות מערכת יחסים שבה לשני משתתפים יש קשר חזק למשתתף שלישי וקשר חלש יותר ביניהם. יכול להיות טריאד – כל אחד מהמשתתפים קשור לשני האחרים בקשר בעל עוצמה שווה. ויכול להיות קוואד – מעורבים שני זוגות ראשוניים, וכל זוג מחשיב את הזוג השני כזוג שניוני.

בין בני זוג ראשוניים, למשל בני זוג נשואים עם ילדים, יש קשר חזק מבחינה רגשית. לכל אחד מהם יכולים להיות בני זוג שניוניים, שההתקשרות אליהם פחותה מאשר לבן הזוג הראשוני. הדבר הבסיסי בפוליאמוריה הוא התקשורת הכנה. את מערכות היחסים בונים לפי הצורך. לפעמים צריך לשנות מקום, וכמובן, אין הכרח להסביר את הקשר לאנשים מסביב. חשוב מה מרגישים. כל אחד יכול לספר מה הוא מרגיש ולמה הוא מאושר. למשל, גבר מספר את האמת לשתי הנשים, או אישה מספרת לשני הגברים על אהבתה לשניהם. אהבה של יותר מאדם אחד היא אהבה טבעית. אנשים מביאים לעולם יותר מילד אחד ומגלים שהם אוהבים אותו בדיוק כמו את אחיו.

אריאלה גורסת כי לשני אנשים קשה לאהוב לאורך זמן. היא שואלת אם זה לא קשה יותר בפוליאמוריה ואם לאהוב אדם אחד זה לא יותר טבעי.

לאריאלה, דברים שנראים פעוטים בזוגיות ואפשר להחליק אותם עלולים להיות הרסניים ביחסים של יותר משניים. דווקא טבעי יותר לאהוב יותר מאדם אחד, כמו שהורים אוהבים במידה שווה את כל ילדיהם. מונוגמיה היא מיתוס. אלפרד קינסי מצא של-70% מהאנשים שחקר היו רומנים מהצד. מחקר עכשווי מצביע על 85% רומנים מחוץ לנישואים – בעיקר רגשיים ולא דווקא מיניים. רוב התרבויות היו ועדיין פוליגמיות ולעיתים נדירות פוליאנדריות. תמיד היו לאנשים מאהבים ומאהבות. אנחנו איננו חיות מונוגמיות. אנחנו מונוגמיים בכפיפות להוקעה ולסטיגמה חברתית. בלי קשר לפיזיות ולמיניות – טבעי לאהוב יותר מאדם אחד.

פורנוגרפיה



הגישות

פורנוגרפיה או פורנו היא הצגה של גוף האדם או של התנהגות מינית שמטרתה לעורר גירוי מיני. מקור המילה ביוונית, ומשמעותה "לכתוב על יצאניות". סרטי הפורנו נקראים סרטים כחולים או X-rated.

מבחינים בין פורנוגרפיה לבין אירוטיקה, שהיא תיאור של גוף האדם או ההתנהגות המינית האנושית בצורה בוטה פחות, מוכוונת פחות לגרימת עוררות מינית ולעיתים בעלת ערך אומנותי.

גברים צופים בפורנו וגם לא מעט נשים. כיום פורנוגרפיה היא תחום בדיוני, פנטסטי, סוג של תרבות פופולרית. בעידן האינטרנט אנשים משקיעים שעות בעולמות וירטואליים. מאחר שהחברה אינה רואה בעין יפה סקס מחוץ לזוגיות, פורנו עלול להיחשב כזה. אבל כדאי להסתכל על הפורנוגרפיה כעל מייצגת קדמה מינית, גישה תרבותית לבעיית הליבידו של הגבר, ופתרון או אמצעי לא בעייתי במערכת יחסים מונוגמית. פורנו הוא הרע במיעוטו מבין אופציות בעייתיות אחרות. גבר הצופה בפורנו לא מערב את עצמו במערכת יחסים רגשית עם גורם זר, והוא גם נמנע מסיכונים הכרוכים בקיום יחסי מין בפועל – היריון בלתי רצוי ומחלות מין.

הביקורת המסורתית נגד הפורנוגרפיה באה מהכיוון המסורתי-שמרני. אנשי דת סבורים כי הפורנוגרפיה מנוגדת למוסר ורואים בה כפירה בדת והתנהגות בלתי מוסרית בחברה. גם כמה זרמי פמיניזם טוענים

שהפורנוגרפיה משפילה את הנשים המשתתפות בה, רואה בהן כלי וחפץ לשימוש מיני בלבד זמין בכל עת. אכן, יש מקום לתת את הדעת לפורנוגרפיה שנעשית מתוך כפייה והשפלה. יש זרמים המעודדים פורנוגרפיה כחלק מהמאמץ להגדרה מחדש של המיניות בצורה שוויונית ומתן לגיטימציה למיניות הנשית.

המשפט בישראל עוסק בהסדרת הביטוי הפורנוגרפי במסגרת דיני העונשין. בערוצי הטלוויזיה מסדיר את הביטוי הפורנוגרפי חוק משנת 1982. יש סעיף האוסר על שידורים שיש בהם "תועבה" כמשמעותה בחוק העונשין, לרבות הצגת יחסי מין שיש בהם אלימות, התעללות, ביזוי, השפלה או ניצול; הצגת יחסי מין עם קטין או עם אדם הנחזה לקטין; הצגת אדם או איבר מאבריו כחפץ זמין לשימוש מיני.

שולי ובן זוגה חיים יחד כארבעה חודשים. לאחרונה גילתה כי לפעמים, כאשר היא נעדרת מהבית לשעות ארוכות, הוא מענג את עצמו מול אתרי סקס באינטרנט. שולי אומרת שאין לה בעיה עם כך שהוא מספק את עצמו בלעדיה, אך יש בזה משהו קצת מעליב. כשהיא גילתה זאת הרגישה נבגדת, כאילו הוא בוגד בה עם הנשים באינטרנט. מבחינתה הוא צרכן של תכנים מלוכלכים שיש בהם פגיעה בנשים, והתכנים האלה מעוררים בה דחייה. כשדיברה איתו על כך הוא טען שכל הגברים עושים זאת ואין בכך שום דבר רע או לא מוסרי. שולי שואלת מאין נובעת הבעיה שלה. האומנם הוא לא בסדר או היא צדקנית וחסודה מדי.

לשולי, את תוהה על פורנו ועל תעשיית המין: האם זה אנושי, האם זה טבעי, האם אין בזה החפצה של האישה, האם אין בזה הטעיה של אנשים בהצגה של מיניות ללא רגש, האם זו בגידה. יש נשים החוות את צפיית בן הזוג בפורנו כבגידה, יש הרואות בכך חלק מהפרטואר המיני שבזוגיות, ויש שישמחו בכך, כי הצפייה תשחרר אותן מהדרישה של בן הזוג למין. במה שבן זוגך אמר לך אין טענה אישית כלפיך. כמובן, את תחליטי איך לנהוג, וטוב שתדברי על כך עם בן זוגך.

צפייה זוגית

כשזוג יודע להשתמש במה שאתרי הפורנו מציעים בצורה מכבדת ומכובדת, באופן מוסכם שעונה על הצרכים ועל המאווים של שניהם – ביחד או לחוד – אפשר להפיק מהכלי הזה תרומה רבה למיניות ולזוגיות. לצפייה משותפת בפורנו יכול להיות היבט חיובי. לפעמים מתגלות פנטזיות, ובני הזוג מכניסים אותן לרפרטואר יחסי המין שלהם. זהו מתאבן ומעורר חשק ומיניות. צפייה משותפת מעידה על פתיחות ובגרות בקשר. זו אינה מטרה כשלעצמה, ואם אחד מבני הזוג לא מעוניין, רצוי לוותר, כדי לכבד אותו ולא לפגוע בו ובזוגיות.

פורנו ויצר מיני

נמצא כי גברים שמרבים לצפות בפורנו הם בעלי יצר מיני חזק יותר. לא נמצא קשר בין בעיות בתפקוד המיני לבין צפייה בפורנו כל עוד זה נעשה באופן סביר ושפוי. פורנו יכול להיות טוב לגברים ולעזור לחיי המין. אומנם יש לצפייה בפורנו רכיב רע והרסני היוצר התמכרות וריחוק ממגע אינטימי עם בת הזוג, אבל כאשר הצפייה מידתית ולא על בסיס תחליפי, קבוע ויומי, היא יכולה לתרום לחשק המיני ולרצון לגיוון המיניות עם בת הזוג. גם אצל נשים הצופות בפורנו במידתיות עולה החשק המיני.

מחקרים מעלים כי 6% מהאוכלוסייה הבוגרת בארה"ב מכורה לאינטרנט – אתרי פורנו וצ'אטים מיניים וירטואליים. המכורים עלולים להיות במצב דיכאוני-חרדתי. אצל רובם אופיין קושי ביצירת אינטימיות, דימוי וערך עצמי נמוכים. רובם לא מרוצים מעיסוקם המקצועי. אנשים אלו חיים בחוויית בדידות קשה מרופדת בסיפוק צרכים מידי ואשליה של קרבה, אינטימיות ופתיחות מינית.

פטישיזם



המונח והסוגים

המונח פְּטִישִׁיזְם, כישוף, נטבע במאה ה־18. זוהי נטייה לייחוס תכונות מדומות לעצמים במציאות. העצם שהוא מושא לפטישיזם מכונה פְּטִישׁ. בפסיכולוגיה המונח פְּטִישִׁיזְם מתאר משמעות מיוחדת שאדם מעניק לגורם כלשהו, בעיקר על רקע מיני.

מימוש אקט פטישיסטי מסב הנאה לאדם ויכול להסב הנאה גם לשותף כשהוא נעשה בהסכמה. מדובר בשימוש בחפצים השייכים או קשורים לאחר, או שימוש כלשהו בחפצים כדי להגיע לגירוי מיני. למשל, לובשים חולצה של אחר, מריחים נעליים או גרביים, ואלה מביאים לידי גירוי מיני גם בהיעדרו של האחר. יש הרבה נטיות והרבה סוגי פטיש.

פטיש לכפות רגליים

פעולות שמעוררות פטישיסט רגליים הן ליקוק כפות הרגליים, מציצת הבהונות, אוננות בעזרת כפות הרגליים, הרחה של כפות הרגליים, דריכה ורמיסה תחת כפות הרגליים, דגדוג כפות הרגליים, כפות רגליים מלוכלכות ועוד. משערים שאחת הסיבות למשיכה לכפות רגליים היא בלוטות הזיעה הנמצאות שם ומפרישות את אותם החומרים שמפרישים איברי המין. ייתכן גם שמקרה מסוים בילדות גורם לקישור של כפות רגליים לנשיות, וייתכן



גם שכפות הרגליים מסמלות גבריות ומזכירות את איבר המין הזכרי. עוד אומרים שהחזרה על פעולות שבהן יש צורך להשתמש בכפות הרגליים מרגיעה ומפצה על טראומת ילדות שהיו מעורבות בה רגליים.

שירית, בת 23, ויש לה חבר כבר שנה. הם מקיימים מערכת יחסי מין סוערת ושניהם מגיעים לאורגזמה, אם כי לא יחד. בזמן האחרון החבר מוצץ לה את בהונות הרגליים ומלקק לה את כף הרגל במשחק המקדים, אחר כך מתבונן בה כאילו הוא מחכה שתידלק מזה. האמת היא שלא קורה לה כלום מבחינה מינית. שירית שואלת אם היא לא כמו כל הנשים בעניין העוררות המינית או מדובר באיזה פטיש של החבר לרגלי אישה.

לשירית, פטיש רגליים הוא פטיש נפוץ ביותר. הפטישיסט חייב כמעט תמיד לבטא את מושא הערצתו, כפות הרגליים, כדי להגיע לעוררות מלאה ולסיפוק מיני מלא. גם אם הפטישיזם לא עושה לך שום דבר, זה לא אומר דבר על העוררות המינית שלך ועל מיניותך. אם חברך נדלק מינית רק מליקוק כפות רגליך ורק כך יכול לקיים יחסי מין, עליו לפנות לטיפול.

פיוסקס



פיוסקס או סקספיוס – סקס המביא להתפייסות – בא לידי ביטוי לאחר מריבה קשה. כל האנרגיות התוקפניות וכל האדרנלין הופכים מאנרגיית מלחמה לאנרגיית תשוקה. בני הזוג מתפרקים יחד במקום לפרק זה את זה. לפעמים ריב מסתיים בשתיקה רועמת ובנתק של שעות, ימים או יותר. לפעמים הריב נפתר בפיוס של שיחה, במגע קל, בחיבוק, נשיקה – וממשיכים הלאה. ולפעמים יש פיוסקס, מין תשוקתי.

בני זוג יכולים לצעוק ולתקוף זה את זה עד בלי די. היא צועקת והוא שותק. היא בוכה והוא מתחנף. או להפך. ואחר כך יבוא הסקס המפצה. הפיוסקס הוא עוד פן של התקשורות הזוגית. הוא יכול להיות בריא לזוגיות, כאשר הוא קורה מדי פעם בפעם והוא חלק מתהליך של פיוס הנבנה בין בני הזוג, תורם לחוויה המינית של בני הזוג ומביא להרגעת הרתיחה.

ואולם כאשר זהו הכלי היחידי שבעזרתו בני הזוג פותרים את הקונפליקטים שלהם, כאשר זהו מצב כרוני – יש בו טעם לפגם. במצב שכזה יש בעיה העלולה להעיד על כך שהזוג למעשה בורח ונמנע ממציות פתרון בוגר ותקשורתי. הפיוסקס אינו מתכון בריא לפתרון קונפליקטים. הסקס הפיצוצי שמתרחש תמיד אחרי ריב הוא בעצם מסך ערפל על זוגיות מתפוררת. בריחה למין סוער אולי מבטאת את השקט והשממה שבזוגיות. יש מצב שאחד מבני הזוג יוצר ריב בכוונה, ומתחת לשצף וקצף המילים יש לו מטרה אחת – קדימה, נעשה את זה כבר. גם מצב זה אינו בריא לזוגיות. חשוב גם לדעת להתפייס בשיחה בארבע עיניים באופן בוגר ומבוקר ולא בקיום יחסי מין.

פנטזיה מינית



גברים ונשים

מחקר מעלה כי אין הבדלים ניכרים בין הפנטזיות המיניות של גברים ונשים. אצל שני המינים יש פנטזיות מיניות אינטימיות ורומנטיות. לגברים יש יותר פנטזיות מיניות משיש לנשים, מה שמאשר את הדעה הרווחת כי גברים נוטים לחשוב על מין בתדירות גבוהה יותר.

לנשים יש פנטזיות רומנטיות נעימות. גברים מפנטזים על התנסויות מיניות חדשות כמו מין קבוצתי, להשתתף באורגיה או להיות סווינגר ולהחליף בנות זוג רבות. הפנטזיות המיניות הבלתי נעימות ביותר קשורות להכנעה מינית. נשים יותר מגברים חושבות לעיתים על מין כפוי. אצל גברים פנטזיות שליליות קשורות לחוויות מיניות הומוסקסואליות. פנטזיות מיניות עשויות לתמוך בתשוקה ובגירוי מיני.

פנטזיות בזוגיות

לאחר פרק זמן בקשר זוגי יכול להיות שימוש בפנטזיה מינית בזמן האקט המיני. כך בקרב רוב הזוגות. השימוש בפנטזיה הוא נורמלי ומוצדק כשהוא משרת את מערכת היחסים ולא פוגע באיכות הקשר הזוגי ובטיבו. המצב שונה אם אחד מבני הזוג זקוק לפנטזיה כדי להרגיש עוררות מינית או נדרש לפנטזיה מסוימת בכל אקט מיני.

הפנטזיה של קיום יחסים עם אותו בן מין קיימת אצל הרבה מאוד נשים וגברים. החיפוש אחר הרפתקה מינית בידיעת בן הזוג קיים מאז קיום המין האנושי. זוהי אחת הדרכים לגוון ולהעשיר את חיי המין בלי לבגוד ללא ידיעת בן הזוג.

מילי, בת 40, נשואה פלוס שניים, ראתה סרט על שתי נשים מתעלסות, וזה נראה לה מדהים. מאז התמונות האלה לא יוצאות לה מהראש. כל הזמן בא לה לנסות את זה. מילי שואלת אם כדאי לה לשתף את בעלה בפנטזיה הזאת. היא חוששת שהוא יעלב.

למילי, פנטזי לך כרצונך. הקושי העיקרי שאת מתארת הוא רגשות אשם ופחד לחלוק עם בעלך את הפנטזיה ולממש אותה. חשוב שמימוש הפנטזיה יהיה בהסכמה משותפת של שניכם. צריך לקבוע מראש את הגבולות והחוקים באשר למה שיקרה במיטה, עם מי ועד איפה ללכת עם הפנטזיה. הכול תלוי בטיב היחסים. מוצע שתעלי את הנושא לפני בעלך לא באופן ישיר אלא כשאלה כללית פילוסופית על החיים. אם הוא יענה בחיוב, תוכלי ללכת עם הפנטזיה ולגרות אותו.

הנפלא בעולם הפנטזיות הוא שאפשר ליצור כל מה שרוצים בלי מגבלות של מציאות החיים. הפנטזיה יכולה להיות ביטוי לרצון לא מודע, אמצעי למימוש רצונות שאיננו יכולים לממש במציאות וגם דרך להעצים את החוויה המינית. אין בפנטזיה על אישה אחרת, על גבר אחר, או על כל דבר חווייתי אחר כדי להעיד על בעיה במערכת הזוגית או על הפרעה אישית. רוב הזוגות שנמצאים בקשר זמן רב נעזרים מדי פעם בפנטזיה מינית בזמן האקט.

ההתנסות

מי שמשחק באש עלול להיכוות. עם כל ההחלטות והחוקים ולצד המתח, הציפייה וההתרגשות הגדולה, יש לא מעט אנשים שהחוויה הפנטסטית עלולה להיות קשה להם מדי. החשיפה של בן הזוג למחשבה או למראה של

בן זוגו מתנה אהבים עם מישהו אחר עלולה לאיים ואפילו לחבל בקשר. פרץ קשה של קנאה יכול להציף אדם זה או אחר.

המתנגדים יגידו בפסקנות לא. הם יגידו שמימוש פנטזיה מעורר את מיצי הפנטזיה, ורוב הזוגות לא יעמדו במבחן המציאות. לאחר שזוג יחליט לעבור חוויה כזאת, זוגיותו לעולם לא תחזור להיות כמו שהייתה. לדברי המקטרגים, גבר שאוהב את בת זוגו אהבת אמת ואישה שאוהבת את בן זוגה אהבת אמת לא יצליחו לגרש מדמיונם את תמונות בן הזוג עם גבר או אישה אחרת. התמונות ישפיעו לרעה על מערכת היחסים ועלולות להרוס אותה. בתיאוריה הכול טוב, יפה, מפתה, מגרה וקל, אך כשהדברים מגיעים לידי מעשה הם לפעמים הם מתגלים בדיעבד כטעות חמורה ששני בני הזוג ישלמו עליה מחיר כבד.

יש זוגות שחוו ניסיון מיני כזה בהסכמה ואפילו תקופות ארוכות. יש זוגות בכל הגילים שהכניסו חוויה זו לרפרטואר המיני שלהם. יש זוגות שנהנו מהניסיון ומהחוויה, ויש זוגות שהתפרקו. כל זוג וההעדפות שלו. אין לדעת מראש למי זה יהרוס ולמי זה יועיל, וצריך לשקול היטב את התועלת לעומת הסכנות האפשריות.

דודו, בן 38, נשוי עשר שנים. בחגיגה משפחתית אשתו ואחותה הצעירה התחילו להשתעשע והתאבקו במשך חצי שעה, צווחו, מרטו שיער והתגלגלו זו על זו. דודו צפה בהן והרגיש גירוי מיני חזק, הגירוי הסתיים בלילה במשגל סוער עם אשתו. הוא סיפר לה שההתאבקות ביניהן גירתה אותו, והיא החליטה שהוא "סוטה", "מלוכלך" ומה לא. דודו שואל אם אומנם הפנטזיה שהוא במיטה עם אשתו ואחותה מעידה על סטייה מינית.

לדודו, סטייה מינית היא התנהגות מינית שאינה נמצאת בתחום ההתנהגויות המיניות המקובלות בחברה. תפישת הסטייה המינית היא תלוית תרבות וזמן. ככלל החברה המערבית סובלנית למגוון התנהגויות מיניות, כל עוד אלו אינן פוגעות בזולת או בסדר הציבורי. החלק הכי סקסי שלנו הוא בלתי נראה. הפנטזיות שלנו ממלאות תפקיד חשוב בבואנו לחקור את המיניות שלנו, וחשוב שנקבל אותן כחלק מהישות המינית שלנו. הן תולדה של גירויים המופעלים בחושים.

אם השימוש בפנטזיה היה חוזר על עצמו ומשמש מכניזם יחידי
 ליכולתך לקיים יחסי מין עם זוגתך, הייתה פה סטייה. מה שחווית
 הוא דבר נורמטיבי.

פעילות גופנית ומין



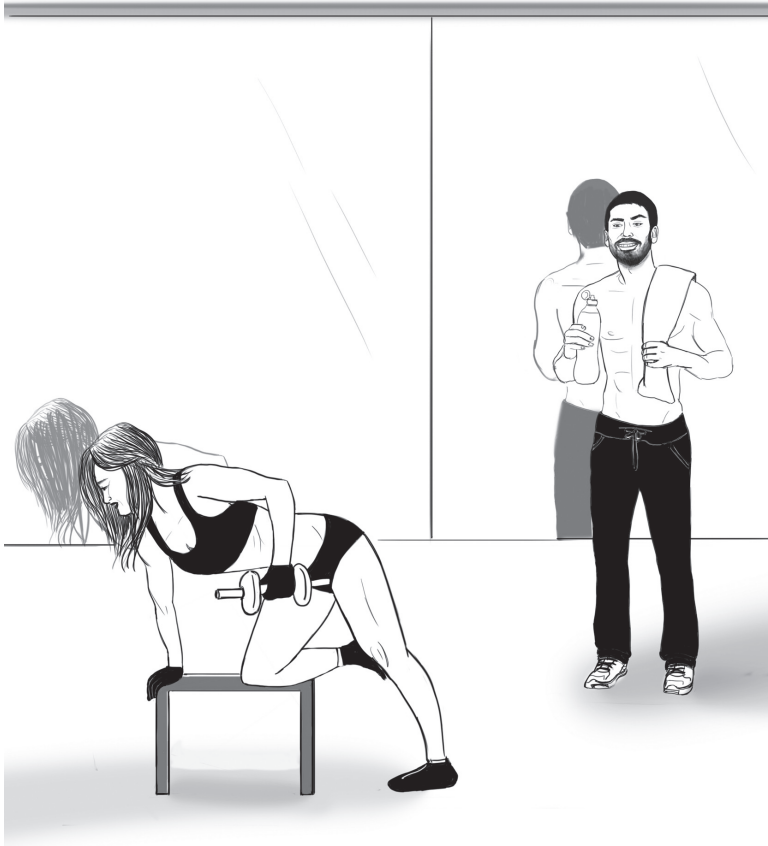
כושר ומיניות

יש קשר בין פעילות גופנית מחוץ למיטה ובין החשק לפעילות גופנית בתוך המיטה. כל מה שקשור בספורט – ריצה, רכיבה על אופניים, שחייה, אגרוף תאילנדי וכל ספורט אחר – מעלה את רמת האנדורפינים, מעלה את רמת הטסטוסטרון, מעלה את מצב הרוח, משפר את הדימוי הגופני והדימוי העצמי, ובכך גם מעלה את החשק המיני. כאשר אנו בכושר, חטובים ונראים טוב, אנחנו מרגישים מיניים ונחשקים.

מחקר אמריקני מצא שזרימת הדם לנרתיק אצל נשים ששמרו על כושר גופני וצפו בסרט כחול הייתה גבוהה ב-169% מזרימת הדם אצלן בתקופה שבה לא עסקו בפעילות גופנית. המלצת המחקר הייתה: הרבו בפעילות גופנית ושמרו על כושר – גם לטובת החשק וגם לשיפור התחושה.

שרון, בן 36, עד לא מזמן היה מתאמן פעמיים בשבוע אימונים אינטנסיביים באגרוף תאילנדי. אחרי שהפסיק להתאמן הוא שם לב לירידה בחשק המיני שלו. בתקופת האימונים היה ממש מטורף על סקס. החברה לא כל כך אוהבת את הירידה בחשק. שרון שואל למה זה קורה.

לשרון, לכל אחד יש תקופות שבהן מפלס החשק שלו יורד. בדרך כלל הירידה בחשק קשורה למצב הנפשי, לעומס החיים, למצב הזוגיות, וגם למצב הפיזי ולרמות הורמון הטסטוסטרון. רצוי שתחפש את



הגורם לירידה שלך בחשק המיני בין הרכיבים האלה. חשוב גם שתחזור לפעילות גופנית. החשק שלך יחזור.

רכיבה על אופניים

רכיבה על אופניים היא פעילות גופנית התורמת לסיבולת לב ריאה, זרימת דם טובה יותר לאיברי הגוף ולאיבר המין. העיסוק בספורט מעלה את הדימוי העצמי, משפר את הדימוי הגופני ואת הביטחון העצמי מחוץ למיטה ובתוכה.

עם זאת רכיבה למרחקים ארוכים עלולה לפגוע בתפקוד המיני. מחקרים מראים כי בין 20%–70 מרוכבי האופניים למרחקים ארוכים סובלים מנימול באיבר המין וסביבתו; ל-10% מהרוכבים הסימפטומים נמשכים עד שבוע; 13% מהרוכבים מדווחים על בעיות אימפוטנציה, ו-11% יסבלו מתופעה זו עד שבוע לאחר הרכיבה, 3% במשך חודש.

34% מהנשים הרוכבות דיווחו על נימול לאחר רכיבה ממושכת. הנימול מורגש באגן התחתון שעליו יושבים. שם עובר עצב ה-pudendal המכיל סיבים עצביים מוטוריים שאחראים לתנועה רצונית וסיבי עצב תחושתיים וגם עצמאיים. הם עוברים בתעלה מיוחדת ויוצאים מעצמות האגן כדי לספק תחושה ואספקת דם לאיבר המין וכדי לעצבב באזור זה שרירים החיוניים לתפקוד המיני. בנקודה שהעצבים יוצאים מן האגן הם חשופים לפגיעה. הם עלולים להילחץ בין עצמות האגן לבין מושב האופניים. אם יילחצו, תיפגע התחושה באזור ויורגשו תחושות נימול או הירדמות באיבר המין וסביבו. זוהי תופעה זמנית המעידה על לחץ על העצב. לחץ מתמשך עלול לגרום נזק שיתבטא בבעיות אי-אונות, חוסר יכולת להגיע לשפיכה וחוסר תחושה באזור איבר המין.

למניעה דרוש שינוי בהרגלי הרכיבה. אפשר לשפר את זרימת הדם אל איבר המין במהלך הרכיבה ברכיבה של כמה דקות בעמידה. רכיבה בעמידה משחררת את הלחץ המופעל על העצב ועל העורק בישיבה הממושכת על מושב האופניים. גם הפסקות ברכיבה מאפשרות את התאוששות זרימת הדם באזור.

מושב האופניים צריך להיות רחב דיו כדי להעניק תמיכה לעצמות הישיבה, ובכך למנוע לחץ באזור האגן. מומלץ לרכוב על מושב אשר שיש לו אף גמיש או לחלופין להטות מעט את המושב כך שהאף ייטה מעט מטה, וזאת כדי למנוע לחץ של המושב על נקודת היציאה של העצב מהאגן. צריך לזכור שבעקבות השינויים האלה יגבר העומס על הגפה העליונה, לכן זה לא מומלץ לאנשים עם בעיות כתף. המושב צריך להיות שטוח ולא קמור, כיוון שהקמור עלול להוסיף לחץ על עצמות הישיבה והעצב. מושבים עם פתח במרכזם נועדו למנוע את הלחץ.

הכידון צריך להיות נמוך ממושב הרכיבה, כי כאשר הכידון גבוה יותר מהמושב או בגובה המושב, יש סיכון גדול יותר ללחץ על העצב. הרוכב נאלץ

לבצע תנועה מהאגן כדי להגיע ברגלו אל הפדל, ונטיית האגן כלפי מטה בכל פידול עלולה לגרום לפגיעה בעצב עקב לחץ חוזר ונשנה בין עצמות האגן למושב האופניים.

כאשר לרוכב יש תנועה מוגבלת בירך (עקב חוסר גמישות), בכיפוף הוא ייאלץ להרים את האגן כדי לפצות על התנועה החסרה בירך, וכתוצאה מכך צידו האחר של האגן ישקע ויידחף אל המושב, דבר העלול לגרום לעוד לחץ. צריך לאבחן מה הסיבה לתנועת האגן הזאת הבלתי רצויה. הגבלה בתנועת הירך אפשר לפתור באמצעות תרגילים. וכמובן דרושה התאמה של האופניים.

ריקודים

בריקוד יש הרבה רכיבים של יחסי מין: קרבה פיזית, ריחות גוף, הזעה משותפת, תנועה משותפת. כל אלה דברים שפוגשים רק ביחסי מין או על רחבת הריקודים. כשגבר ואישה מוצאים שפה משותפת בריקוד, מתפתח באופן טבעי גם הרבה מתח מיני ביניהם.

בריקוד – כמו בסקס – יש צורך בתיאום, וכשזה לא הולך יש מאבקי שליטה. זוגות לא מתאימים יגלו שהם נתקעים, לא מצליחים בצעדים ובסיבובים. כשהזוגות מתאימים, הריקוד זורם ואפשר להרגיש זאת באופן האחיזה ובמבט בעיניים. נוצרים איתותים ושפת גוף שרק בני הזוג הרוקדים מבינים.

חשוב להבין שהמתח המיני נוצר עוד לפני הריקוד והקרבה הפיזית. זה כמו הנשיקה שלפני יחסי המין. השיחה, היציבה, המבט – כל אלה יוצרים את התקשורת הראשונית היוצרת מתח מיני. כמו הנשיקה במין גם המתח הזה נוצר לאט ויכול להגיע לידי תשוקה וסערה.

צרכים מיניים



**הדדיות היא יצירה משותפת נפלאה
שאין כמותה בשום מקום אחר.**

מרטין בובר

מקור החיים המניע ושומר על זוגיות מוצלחת הוא היכולת להבין את צרכיו של כל אחד מבני הזוג וללכת לקראתו. פער בצרכים המיניים הוא מנת חלקם של רוב הזוגות. כשמדברים על פער בצרכים המיניים של בני הזוג הכוונה לרצונות הנוגעים לתדירות המגע המיני ולאופיו. פער בצרכים המיניים יכול להיות מסיבות הורמונליות, חינוכיות, תרבותיות, אישיות, זוגיות ועוד. בדרך כלל הגבר רוצה לחוות יותר ולהתנסות יותר מהאישה – יותר סקס ביותר צורות. אבל יש לא מעט מקרים שהמצב הפוך.

הפער בצרכים המיניים יכול לגרום במקרה החמור והקיצוני לפרידה. בדרך כלל הוא מעורר מתחים וריבים בין בני הזוג. לפעמים זהו גם הגורם לבגידה – קשרים מיניים מחוץ למערכת הקבועה בצורה של סטוצים או רומן.

חשוב להבין שלכל אחד יש צרכים משלו, שאיפות ופנטזיות. צריך ללכת זה לקראת זה ולמצוא פשרה.

הפערים בצרכים לא בהכרח נובעים מסקס טוב או לא טוב. המיניות הבסיסית שונה בין אדם לאדם ומשתנה גם לאורך שנות הקשר. נוסף על כך לזוגות יש נטייה להיכנס עם הזמן לשגרה, ותדירות יחסי המין פוחתת בהדרגה.

מאחר שזוגות מקיימים יחסי מין כבר בשלב הראשוני של הקשר ביניהם,

הפערים בדחף ובצורך המיני אמורים להתבטא די מהר ולא לבוא בהפתעה. אבל בהתחלה זוגות מאוהבים לא שמים לב לבעיות ולחסרונות ומאמינים שהכול יסתדר. בשלב מתקדם יותר בזוגיות דרושה עבודה מצד שני בני הזוג, וזו השקעה כדאית, כי מתוך ההתקשרות יכולה לנבט תחושת חופש וצמיחה אישית. שיחה פתוחה על היחסים יכולה להביא לתדירות יחסי מין שבה שני בני הזוג מסופקים.

אי אפשר לקבוע מהי התדירות המתאימה והנכונה לכל זוג בכל גיל. ההנחה הרווחת היא שחסך בצרכים המיניים הוא נחלתם של גברים בלבד, אך זו מוסכמה חברתית. יש לא מעט נשים שאינן מסופקות, ובן זוגן הוא המלין על כאבי ראש ועייפות ואומר "לא היום, יקירתי". לעיתים קרובות האישה רוצה לקיים יחסי מין יותר מבעלה. היא פתוחה יותר, יצירתית יותר ומינית יותר. היא רוצה להתנסות ולחוות דברים חדשים, לגוון ולהתרגש, והוא עייף, כואב לו הראש ורוצה לצפות בטלוויזיה. הידברות כנה יכולה לעזור.

רונית בת 25 ויש לה חבר בן 27. הם ביחד כבר שלוש שנים. מערכת היחסים שלהם טובה ואינטימית, אבל רונית רוצה ממנו יותר סקס. היא רוצה כל יום, ולו מתאים פעמיים בשבוע. בשאר הימים הוא פשוט אוהב להתכרבל. הוא מודה שיש לו בעיה בחשק המיני, הנובעת מכך שרונית רוצה אותו יותר מדי. בנוסף הוא גם מתחזק בדת, וזה מקשה עליה. היא בטוחה שהוא לא בוגד ויודעת שהיא מושכת מאוד בעיניו, אבל לא מרגישה נחשקת וחוששת שמדובר בבעיה שתחמיר.

לרונית, הקושי שאת מעלה אינו קשור ישירות ליחסי המין אלא לקשר הזוגי. זה שחברך רוצה פעמיים בשבוע יחסי מין לא אומר שיש לו בעיה בחשק המיני. הוא ומיניותו ואת ותשוקתך. תדירות יחסי המין היא אחד הקונפליקטים היותר נפוצים בקרב זוגות בלי קשר לדת. כל קונפליקט שלבני הזוג אין יכולת להתמודד איתו עלול להביא אחד מהם לחפש דרכי מילוט. מציאת האושר בזוגיות ובמיניות תלויה במידה שכל אחד מבני הזוג מוכן להשקיע למען שותפו. שוחחי עם חברך, אמרי לו שאת נמשכת אליו וזקוקה ליותר מין וראי עד כמה אתם יכולים ללכת זה לקראת זה ולהגיע לשלוש עד חמש פעמים בשבוע.

קונדום



הקונדום הוא אמצעי מניעה עשוי לטקס המכסה את איבר המין הגברי במהלך קיום יחסי מין, כדי למנוע היריון בלתי רצוי או העברת מחלות מין.

הקונדומים הראשונים היו עשויים צמר ובדים אחרים, ולא היו אפקטיביים. הקונדומים היעילים הראשונים היו עשויים מעי כבש. בהתחלה שימשו הקונדומים את המבקרים אצל נערות ליווי להגנה מפני מחלת העגבת. נשים אלו היו עקרות בגלל מחלות, והקונדום לא נתפש כמונע היריון אלא כמונע מחלות. אותם גברים לא העלו על דעתם להשתמש בו עם נשותיהם, עד שלבסוף הבינו שמה שמונע הידבקות ממחלה ימנע גם כניסה להיריון. כשהומצאו קונדומי הלטקס נעשו הקונדומים אפקטיביים וזולים. לפני המאה ה-20 היו הקונדומים אסורים למכירה במקומות רבים מטעמים דתיים. עד היום הכנסייה הקתולית אוסרת את השימוש באמצעי מניעה.

יש קונדומים עם חומר קוטל זרע, המגביר את היעילות במניעת היריון. מחקרים גורסים שקונדומים אלו פוגעים ביעילות המניעה של מחלות מין בשל גירוי הריריות. כ-10% מהאוכלוסייה אלרגיים לחומר הלטקס, אבל יש קונדומים של פוליאוריתן, וגם הם יעילים במניעת היריון ובמניעת מחלות זיהומיות. הם דקים ונוחים לשימוש. יש גם קונדומים העשויים חומרים טבעיים, והם אופציה לגברים הרגישים למוצרי גומי, אך אינם מגינים מפני מחלות המועברות במגע מיני. הממברנה שממנה הם עשויים מכילה חורים קטנטנים שאינם מאפשרים מעבר תאי זרע, אך מאפשרים מעבר חיידקים ווירוסים.

הקונדומים מיוצרים בצבעים ובטעמים שונים. העבים יותר נוטים פחות להיקרע. אלה עם כיס מאגר בקצה בטוחים יותר, שכן הם בעלי יכולת קיבול גבוהה יותר. רוב הקונדומים אורכם 15–20 ס"מ וקוטרם כ-5 ס"מ. בשל גמישותם הרבה אינם נמכרים במידות, וכל אחד יכול להשתמש בכל קונדום בלי קשר לגודל איבר מינו. כדי להחליט על הסוג המתאים ביותר צריך לנסות כמה סוגים.

יש המדווחים על כך שהקונדום פוגם בהנאה המינית שלהם, ולעומתם יש המוצאים בירידה בגירוי המיני יתרון של הארכת המשחק המיני, שכן איבר המין נשאר זקוף זמן רב יותר ומעכב את השפיקה. זהו יתרון לגברים שהזקפה אצלם קצרה והם גומרים מהר. הלבשת הקונדום על איבר המין היא חלק מהמשחק המיני, ובדרך כלל אין בה כדי לפגום בהנאה. אבל לא מעט גברים מתלוננים שהקונדום משבית שמחות, כי זקפתם יורדת כשהם מנסים להלבישו בתוך המשחק המיני.

הקונדום מיועד לשימוש חד-פעמי. שמים אותו רק כשהאיבר זקוף. אין להתחיל את החדירה לפני שהנרתיק לח, שכן קיימת סכנת קריעת הקונדום עם החדירה לנרתיק יבש. אפשר להשתמש בג'ל על בסיס מים שלא יפגע בקונדום. אפשר להשתמש במשחות קוטלות זרע להגברת לחלוחית הנרתיק. חשוב להוציא את הפין מהנרתיק מייד לאחר פליטת הזרע, כשהוא עדיין זקוף, ולהדק את קצה הקונדום לבסיס איבר המין למניעה שפיכת תוכן הקונדום בנרתיק. אסור להשתמש בשמנים למיניהם, למשל בשמני תינוקות, קרם לחות, קרם פנים, שמני מסז'. אלה יכולים להחליש את קונדום הלטקס ולגרום להיווצרות חורים ומעבר זרע לנרתיק.

יעילות הקונדום במניעת היריון מושגת אצל 88–97 מהזוגות. רוב הכישלונות חלים בשנה הראשונה לשימוש. שימוש שגוי בקונדום – קריעתו בשל מגע עם ציפורניים, חפץ חד או חומר שמנוני – עלול להוביל להיריון לא מתוכנן. קונדומים ישנים נוטים להיקרע בנקל. לפיכך רצוי שלא להשתמש בקונדום כאמצעי יחיד למניעת היריון. הוא מומלץ כאמצעי נוסף לנשים עם בן-זוג לא קבוע – כנגד היריון ולמניעת הידבקות במחלות מין.

גבריאלה יוצאת עם בחור צעיר ממנה. לפני האקט הוא חרמן בטירוף. עומד לו והכול בסדר, אבל אחרי שהוא שם את הקונדום זה מתרכך.

כשהוא מוריד את הקונדום הכול חוזר לקדמותו ומוכן לתפקוד.
גבריאלה שואלת אם זה נורמלי.

לגבריאלה, אצל הרבה גברים שימת הקונדום גורמת לירידה בזקפה.
אין לזה קשר לגיל, וזה קורה בלי קשר לניסיון המיני. אין מקום
לבחורה להיעלב. חשוב לתרגל את לבישת הקונדום בלי קשר ליחסי
מין, אפילו באוננות, ואולי יש מקום לנסות קונדום אחר שלא ייצור
את אותה תגובה.

רווקים ונשואים



רווקים צריכים לשלם מס גבוה יותר,
כי זה לא הוגן שהם יהיו שמחים יותר.
אוסקר ויילד

יש סבורים שהדבר האמיתי הוא רווקות מאושרת, אהבה עצמית וחופש להתפתחות ולהיכרות. ואולם גם בזוגיות אפשר לממש את העצמיות. מחקרים גורסים שאנשים נשואים מאושרים יותר מרווקים; שאנשים שמחים ומאושרים נוטים להתחתן; שאנשים מסופקים פחות ושמחים פחות עלולים להיוותר רווקים; שאנשים שבעי רצון מחייהם וחיים בתחושת מיצוי והגשמה עצמית עוד ברווקותם יהיו מאושרים יותר עם הנישואים והקשר הזוגי; שהאושר אינו רק בתקופה הראשונה של הנישואים אלא נמשך עוד שנים רבות; שתוחלת החיים של אנשים הנשואים באושר ארוכה יותר.



המחקרים גורסים שזוגיות המגדירה את בן הזוג או את בת הזוג 'חבר הכי טוב' או 'חברה הכי טובה' היא הזוגיות הכי מאושרת. האושר הוא תלוי רכיבים רבים: גיל, תרבות, אישיות, מצב נפשי, ועוד. הרווקים יגידו שהאושר הוא בחופש הבחירה עם מי, איך, מתי, למה ולכמה זמן. הנשואים יגידו שצו החיים מחייב לקבל אחריות על זוגיות ועל הורות, להתבגר ולהתברגן, וכנראה כך טוב להזדקן. בשלב כזה או אחר יקנאו הנשואים ברווקים המתערבבים, ניצודים וצדים, והרווקים יחיו במועקה של ריקנות ובדידות עם כאב לב למראה זוג מהלך יד ביד. והסוגיה נשארת פתוחה, כי כל אחד והאושר שלו.

שפיכה מוקדמת



הבעיה

השפיכה נועדה להעביר זרע מאיבר המין של הגבר אל איבר המין של האישה. הזרע נמצא בשלפוחית הזרע, בדרכי הזרע ובשופכה האחורית. בתהליך השפיכה הוא יוצא בעוצמה ובקצב מהשופכה מלווה בתחושת הנאה וסיפוק של אורגזמה. כל הפרעה בהליך יכולה לפגוע באיכות התפקוד המיני של הגבר ושל בת זוגו.

השפיכה המוקדמת היא אחת הבעיות השכיחות בתפקוד המיני של הגבר, וסובלים ממנה 30–40% מן הגברים. זהו מצב שבו באופן קבוע גבר מגיע לשפיכה לאחר גירוי מיני מינימלי, וזה קורה לפני החדירה, מייד עם החדירה או זמן קצר לאחר החדירה בלי יכולת לשלוט בתחושות שלפני השפיכה ולדעת מה לעשות או לא לעשות כדי למנוע את השפיכה.

מבחינה רפואית גבר ייחשב פז"מניק (פולט זרע מהיר) כאשר אינו יכול לקיים יחסי מין פעילים בתוך נרתיק האישה במשך דקה. מצב זה גורם לו תסכול אישי, מתסכל גם את בת או בן הזוג ופוגע ביחסים. בתפיסה הפסיכולוגית-התנהגותית הגבר ייחשב פז"מניק אם אינו יכול לשלוט בתחושות שלפני השפיכה ולדעת מה לעשות או לא לעשות בשיתוף בת הזוג כדי לא לשפוך.

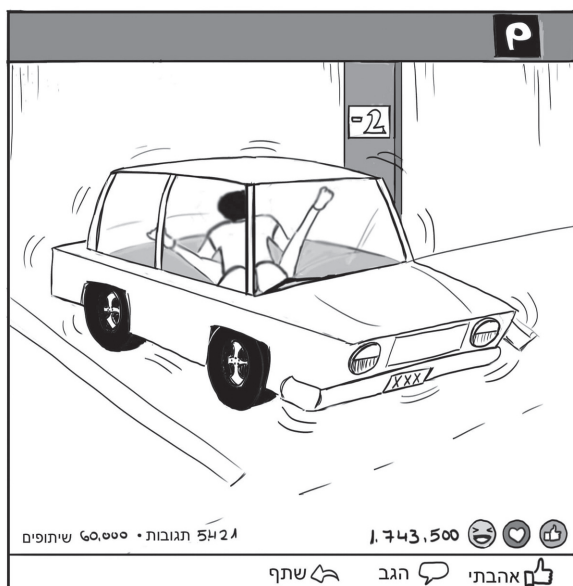
הסיבה לשפיכה המוקדמת יכולה להיות מולדת, כלומר ראשיתה כבר בניסיונות הראשונים לקיום יחסי מין. האבחנה נעשית במישור הפיזי, הפסיכולוגי והזוגי. היא יכולה להיות תוצאה של מחלות כגון סוכרת, פגיעה

בחוט השדרה, טיפולים כימותרפיים. ויש גם סיבות אחרות: לחץ ומתח; שינוי במערכת היחסים; פגיעה בתחושתיות של ראש הפין והחלק העליון של גוף הפין, שהוא מרכז הגירוי באיבר המין.

הסיבות הפסיכולוגיות

יש גברים שמתרגשים בעוצמות שאינן מאפשרות להם לשים לב לתחושות הפין שלהם. זה משתנה ביחסים עם נשים ותלוי במשך מערכת היחסים. החוויות המיניות הראשונות משפיעות על המשך הדרך. יש גברים שניסיונם המיני הראשון היה בלחץ ובמקומות לא נוחים, למשל במושב האחורי של מכונית או בסלון בית הורים האמורים לחזור הביתה, ואז הם גומרים מהר ולא מצליחים להיגמל מכך. לחץ זה נותן את אותותיו ההרסניים בכל פעם שהם פוגשים בת זוג חדשה.

הדאגה העצומה הכרוכה בביצועים המיניים גורמת לגבר לחוש שהוא חייב להיות המאהב האולטימטיבי, ואז הוא לא נרגע ולא נהנה מהאקט המיני. הגברים המתרגשים יותר מדי ולחוצים מהאישה שאיתם חרדים



ומרגישים אשמה. הם מתמקדים במחשבות ובתחושות השליליות ושופכים מהר.

סיבות פסיכולוגיות אחרות לשפיכה מוקדמת הן ספיגת מסרים אנטי-מיניים בילדות. חוסר או עודף מידע מיני עלולים לפגוע בתפקוד המיני ובשפיכה. יש גברים שמאבדים שליטה על רפלקס השפיכה כאשר הם נמצאים עם אישה מסוימת, אבל תפקודם עם אישה אחרת תקין. אצל גברים צעירים יש קשר ישיר בין תדירות יחסי המין ובין מהירות השפיכה. כאשר התדירות לא גבוהה, למשל פעם בשבוע, סביר שהצעיר יגמור מהר. בתדירות של כמה פעמים בשבוע, יש סבירות לשיפור בתפקוד.

גנטיקה

מחקרים מצאו השפעה של הגנטיקה על שפיכה מוקדמת. בפינלנד בדקו זוגות של תאומים והשוו אותם לאחים רגילים. נבדקה הפעילות המינית של כ-4,000 תאומים בני 18–48 בהתייחסות לשפיכה מהירה, לשפיכה מעוכבת ולהפרעות זקפה. ב-28% מזוגות התאומים נמצא דמיון וקשר גנטי לשפיכה מהירה. אחר כך בדקו מה קורה אצלם בקיום יחסי מין בפעם בראשונה והשוו לקרובי משפחה אחרים. נמצא ששפיכה מהירה הייתה נפוצה יותר אצל זוגות התאומים.

בהולנד נבדקה הגנטיקה של 90 גברים הסובלים משפיכה מוקדמת כל החיים ושהזמן התוך-נרתיקי שלהם הוא פחות מדקה. נמצא שהיה אצלם שינוי ברור בגנים האחראים למעבר של סרוטונין בסינפסה וברצפטור שלו, וגברים עם גרסה מסוימת של גן זה שופכים פי שניים מהר יותר מאחרים.

הטיפול

הטיפול הקלסי הוא טיפול פסיכו-תרפי אינדיבידואלי או עם בת זוג או טיפול התנהגותי. במשך שנים היו טיפולים אלו נפוצים, ולמעשה היחידים

הקיימים, אך לא תמיד נתנו מענה מספק. שלוש שנים אחרי תום הטיפול ובלי התמדה בתרגול דיווחו יותר מ-75% מהמטופלים על הופעה חוזרת של הבעיה. ממצא זה לימד שהטיפולים הפסיכולוגיים יעילים פחות, והיה צורך לפתח טיפולים חדשים.

לאחר שהתברר כי אחת הסיבות לשפיכה היא רגישות יתר בראש הפין, הוחל בפיתוח מקומי או סיסטמתי שיוריד את הרגישות מראש הפין, ובכך יאפשר את הארכת זמן השפיכה ומשך קיום יחסי המין. היו ניסיונות מוצלחים חלקית לטפל בשפיכה מהירה באמצעות תרסיס או במשחות לאלחוש מקומי, שמטרתם להפחית את התחושה בראש הפין, ויעילותם מגיעה ל-50%. אבל במקרים רבים הם גרמו לחוסר תחושה בראש הפין ובכך להחלשת הזקפה ולירידה בסיפוק המיני.

בשנים האחרונות נעשו ניסיונות לטפל בשפיכה מהירה בתרופות נוגדות דיכאון ובתרופות פסיכיאטריות ממשפחת SSRI. הטיפול בכמה מהתרופות הצליח חלקית, אך החולים סבלו מתופעות לוואי שמנעו מהם את המשך קבלת הטיפול. חולים שנטלו תרופות מעכבות ספיגה של הסרטונין במוח דיווחו על שיפור ניכר בזמן השפיכה, אך תרופות אלו נועדו לטיפול בבעיות פסיכיאטריות, ויש להן תופעות לוואי שבגללן הפסיקו את הטיפול. עם זאת, ההצלחה היחסית של הטיפולים התרופתיים החדשים פתחה עידן חדש של מחקר.

לא מכבר הוכח כי תרופות מעכבות שפיכה בשילוב עם גלולת ויאגרה שיפרו את השפיכה ואת התפקוד המיני. וגם כדורים לשיפור הזקפה נמצאו מעכבי שפיכה באופן כלשהו. כיום מוצע טיפול תרופתי לצד טיפול פסיכוסקסולוגי. זוהי ראייה מולטי-דיסציפלינרית הבוחנת היבטים פסיכולוגיים, פיזיולוגיים, אורגניים, סביבתיים וזוגיים. השיטה מקנה מיומנויות לשליטה על מנגנוני השפיכה לצד טיפול מקומי בעזרת משחות, תרסיסים או כדורים.

התרופה הייעודית לעיכוב שפיכה, דפוקסיטין-או פריליג'י, מאושרת בכמה מדינות באירופה ובארה"ב, אך עדיין לא קיבלה את אישור משרד הבריאות בישראל. בארץ פותחה מדבקה לשימוש חד-פעמי שהגבר מניח בין שק האשכים לפי הטבעת. היא מופעלת באפליקציה בטלפון הסלולרי.

לחיצה על האפליקציה מפעילה זרם חשמלי קל המכווץ את השריר הגורם לשפיכה, ובכך מעכבת את הגמירה המהירה.

עוד שיטת טיפול היא תפעול שרירי levator ani. קבוצת המחקר מנתה 36 גברים בני 24–58 שפנו למרפאה בתלונה על שפיכה מוקדמת. כל פונה עבר בדיקות כדי לשלול מחלה סיסטמית. כל פונה מילא שאלון כדי לשלול רכיב נפשי דיכאוני. לא נכללו גברים שהעידו על קונפליקטים בזוגיות שלהם. 9 נפסלו. 1 נמצא במצב דיכאוני. 3 היו עם קונפליקטים זוגיים. 4 החליטו לפרוש מהמחקר לאחר ההנחיה הראשונה. 1 נמצא ללא בעיה בתפקוד המיני. מתוך 27 הנשארים 15 היו נשואים בממוצע 8.7 שנים, 7 חיו עם בת זוג 3.7 שנים בממוצע. 25 גברים היו עם שפיכה מוקדמת פרימרית, 2 עם סקונדרית. למשתתפי המחקר הודגמה טכניקה של הפעלת לחץ בטני בעזרת שרירי הבטן לשחרור שרירי levator ani. כדי לשלוט בטכניקה זו הם קיבלו הוראה לתרגל זאת בלי מין שלוש פעמים ביום עשר דחיפות כל פעם. כשהיו בקיאים בטכניקה, הם התבקשו לתפעלה תוך כדי אוננות ולפני תחושת השפיכה. לאחר שליטה בטכניקה גם בזמן אוננות, ההנחיה הייתה לעשות זאת עם בת זוג באוננות, במין אוראלי וביחסי מין מלאים. 24 מתוך 27 דיווחו על תוצאה משביעת רצון בשיפור השליטה ובעיכוב השפיכה. שנה לאחר סיום המחקר דיווחו 3 כי לא חל אצלם שינוי.

מוקי בן 32, נשוי ופעיל מינית, סובל משפיכה מוקדמת. מבקש לדעת אם שיטת הטיפול המאריכה את המשגל לא פוגעת באיכותו ואם התכשירים המאלחשים פוגעים בזקפה.

למוקי, בשוק יש לא מעט תכשירים אשר עוזרים כמאלחשים ועשויים לעזור בעיכוב השפיכה. יש חנויות סקס שמציעות משחות ותרסיסים. התכשירים המוכרים בשוק הם עזרקאין, אמלה, סטאד 100. נסה ומצא מה מתאים לך.

שואל, בן 18, לאחרונה התחיל לקיים יחסי מין עם החברה שלו. לאכזבתו הוא גומר בתוך חמש דקות ולפעמים אפילו פחות, וזה מוציא לו את החשק. שואל שואל מה יוכל לעשות כדי שזה ישתנה.

לשואל, אין לזלזל בתסכולך, אבל כדאי שתדע שתפקודך תקין.
חמש דקות זה זמן מעל הממוצע.

ההשפעה על האישה

השפיכה המוקדמת עלולה להשפיע גם על האישה. ליקוי בתפקודו המיני של הגבר פוגע גם בתפקודה. אישה שלבן זוגה יש בעיית שפיכה מוקדמת עלולה להרגיש לא מושכת, לא מינית. דימויה הגופני והנשי עלול להיפגע. היא עלולה לפתח גם היא קושי בתפקודה המיני, להתרחק מבן הזוג ולהימנע ממין. מחקר באיכילוב גורס כי בעיה בתפקוד המיני של הגבר עלולה ליצור בעיה משנית בתפקוד המיני של האישה.

שפיכה מעוכבת



הבעיה

שפיכה מעוכבת או מאוחרת היא קושי של הגבר לשפוך. גברים הלוקים בכך חווים סבל רב. מחקרים מלמדים כי 4%–7 מהגברים לוקים בשפיכה מעוכבת ברמה זו או אחרת. התופעה נעה בין קושי לשפוך ביחסי מין מלאים ועד קושי לשפוך בכלל, אפילו באוננות עצמית. לא מדובר בגברים הלוקים באזוספרמיה, מצב אי-פוריות של הגבר בגלל פגם בייצור תאי הזרע.

הסיבות הגופניות הן מחלות כגון סוכרת וטרשת נפוצה הפוגעות ברפלקס השפיכה, שימוש בתרופות נוגדות דיכאון, שימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות, שימוש בסמים קשים.

הסיבות הפסיכולוגיות הן הרגלים ודפוסים של תחילת יחסי המין. גבר שמתרגל לאונן בדרך מסוימת, למשל בחיכוך במזרן במגע חזק ומסיבי על איבר המין, יתקשה לשפוך בדרך אחרת. ויש גם פחד, אמביוולנטיות ורגשות אשם משפיכה בגלל קונפליקטים שנדחקו בילדות לתת-מודע ולא באו לידי פתרון. יש חרדת נטישה מהילדות: הילד חשש שאימו תנטוש אותו אם יעשה דברים הגורמים לו הנאה או שאינם לרוחה. ויש קושי להשתחרר, חרדה תפקודית הבאה לידי ביטוי בקושי לשפוך. משפיעה גם האמביוולנטיות לגבי הקשר הזוגי ומאבקי הכוחות בתוכו. משפיעים גם אירועים מכאיבים כגון גילוי בגידה. גם חשש מהיריון. גם הגיל המתקדם.

אם אין גורם גופני, הטיפול פונה להבנת הרכיב הפסיכולוגי, וניתנים תרגילים שאמורים לשפר את התפקוד. מלמדים את הלוקה לשפוך באוננות

לבד, לשפוך באוננות ליד בת הזוג, לאחר מכן עם בת הזוג, ובסופו של התהליך לשפוך ביחסי מין מלאים.

התאמה מינית

בכל הקשור בשפיכה מעוכבת, בשפיכה מהירה ובקושי בשפיכה יש גם רכיב של התאמה מינית. אף שלא נעשו מחקרים מדויקים בתחום, ידוע שיש קשר ישיר בין מבנה הפין ובין מבנה הנרתיק, וחיבור לא מתאים של שניהם עלול להיות גורם לשפיכה מהירה או לשפיכה מעוכבת. כך הדבר עם בחורה מסוימת ולא עם בחורה אחרת, שמבנה הנרתיק שלה שונה.

רמי בקשר קבוע עם שתי נשים כבר זמן רב. עם האחת הוא גומר בקלות רבה, אפילו פעמיים, ועם השנייה הוא לא מצליח לגמור אפילו פעם אחת. הוא גומר רק בעבודת יד לאחר סקס מטורף שבו היא גומרת פעמים רבות.

לרמי, הסיבות הפסיכולוגיות לעיכוב השפיכה הן רבות ומגוונות. ייתכן שיש לך אמביוולנטיות לגבי הקשר עם אחת הנשים. ייתכן שהקושי בשפיכה הוא על רקע קונפליקטים עימה. ייתכן שהיא מזכירה לך דמות שהודחקה בתת־מודע שלך והמגע מציד זיכרונות לא חיוביים. וייתכן גם חוסר התאמה בין גודל איבר המין שלך לגודל ולזווית הנרתיק של האישה שאיתה אתה מתקשה לשפוך. מצב כזה גורם לשפיכה רגילה עם האחת ולבעיה עם האחרת.

גמירה בלי שפיכה

בגישה הטאו־טנטרית למרידיאנים ולצ'אקרות יש השפעות אנרגטיות על המיניות. ההנחה היא שכ־30% מאנרגיית החיים של הגבר אובדת במהלך חייו עקב אורגזמות המסתיימות בפליטה. מאחר שהגבר יכול להגיע לאורגזמה בלי שפיכה, הוא לכאורה מתעל את האנרגייה ומשתמש בה

להגברת ההנאה, היצירתיות והבריאות. התרגיל המוכר קשור בהפעלת שריר רצפת האגן pubococcygeus ובנשימות עמוקות וקצובות. הפעלה נכונה של שריר זה בדחיפה בדומה למתן צואה עוזרת ליכולת לשלוט באורגזמה ובשפיכה ולכוון לעיתוי הרצוי. התנועה של השריר והנשימה מביאות למודעות גבוהה ולחופש.

רוני בן 35, אחרי קיום יחסי מין הוא פשוט מותש. רוני שמע שבטכניקה מסוימת אפשר לגמור בלי לשפוך, כך לגמור כמה פעמים ברציפות וגם לשמור על רמת אנרגייה אחרי הסקס. הוא מבקש לדעת איך מיישמים את הטכניקה הזאת.

לרוני, לא השפיכה היא הגורמת תשישות. אימון יומי יכול להביא אותך לשיפור, ואולי תרגיש פחות תשוש. המשפיע הבולט ביותר על התשישות הוא כושר גופני. אורגזמה בלי שפיכה אינה מצב בריא. זרע שלא נפלט נאגר בתעלת הזרע ועלול ליצור קרקע פורייה לדלקות. שים לב כי המאמץ בהשקעה בטכניקה עלול לפגום בנתינה לבת הזוג ולהפוך את הריקוד המיני לעבודה שאין בה הנאה.

למישה יש חברה כחודשיים. מיום שהוא מכיר את עצמו הוא לא הצליח לגמור במהלך יחסי המין שלו עם אף בחורה חוץ מפעמים אחדות. החברות שלו דווקא גומרות, והחברה הנוכחית מדגישה שהיא נהנית בסקס. לפני שהיו לו חברות היה פעיל מאוד באוננות.

למישה, כל גבר רוצה להיות המאהב האולטימטיבי, אך במציאות גברים לוקים בשפיכה מעוכבת וחווים סבל ותסכול. אפשר להניח שהקושי שלך הוא על רקע פסיכולוגי-התנהגותי. ייתכן שהמצב ישתפר עם חיזוק הקשר. חשוב שבזמן הקרוב לא תאונן, ואז תגיע ליחסי מין עם חברתך עם סף גירוי גבוה יותר. ואם לא יחול שינוי, פנה לייעוץ מקצועי.

מומי, בן 36, בזמן האחרון מצליח לשפוך במהלך יחסי המין עם אשתו אך לא גומר. אובדן החושים לאחר הפליטה – נעלם. מומי שואל אם זה טבעי.

למומי, יש לך זקפה תקינה ושפיכה תקינה, אך אינך חש את

הגמירה. אם אומנם זה כך, אין זו תופעה טבעית לגילך. אם אינך חולה במחלה כלשהי ואינך נוטל כדורים, פנה לגורם מקצועי. אורולוג המתמחה בתפקוד מיני יוכל לעזור לך בעזרת מכשור הבודק מוליכות עצבית ורגישות של האיבר. ואם כל הבדיקות יהיו תקינות, פנה לטיפול סקסולוגי.

שפיכה נשית



שפיכה נשית היא אחת התופעות המסתוריות בעולם המיניות. במאה הרביעית לפני הספירה כתב אריסטו כי במהלך האורגזמה נשים מפרישות נוזל שאין לו מרקם של שתן ושאינו מכתים את הסדינים. לא מעט נשים מדווחות שכאשר הן מגיעות לסיפוק, יש להן תופעה של שפיכה. סרטוני פורנו מתעדים נשים המשפריצות לכל עבר בזמן האורגזמה. ואולם ההשפריצות המוגזמות בסרטי פורנו אינן אלא טכניקה קולנועית. לאיבר הקטן, שהוא מערכת הבלוטות והצינורות המקיפים את צינור השתן, קראו בעבר "ערמונית נשית". באמצע שנות השמונים החלו לחקור את תפקודו בתהליך השפיכה הנשית. התברר שבחלק החיצוני של הנרתיק יש בלוטות – סקנה וברטולין – שמפרישות נוזל סיכה שרובו אלקאלים וגלוקוזה. תפקידו לסכך את איבר המין של האישה ולהוריד את החיכוך בין הנרתיק לאיבר המין המוחדר. כמות ההפרשה הולכת ועולה עם הגירוי המיני. הכמות שונה מאישה לאישה, ואצל אותה אישה משתנה ממגע למגע. יש נשים שאצלן הכמות הזאת עולה מאוד עם האורגזמה. הנוזל הזה מכונה "השפיכה הנשית".

המאפיינים הם הרטבה בעקבות העוררות המינית ופליטה המתרחשת סמוך לאורגזמה. אצל נשים מבוגרות יכולה להיות בריחה ופליטה של שתן כאשר הן מפעילות לחץ על שרירי רצפת האגן.

תנוחות



מהי התנוחה הכי טובה? הכי מגרה? הכי מהנה? התשובה היא שחשוב לשאול את בני הזוג מה עושה טוב לכל אחד ואיך.

התנוחה המיסיונרית

זו התנוחה הבסיסית ביותר. האישה שוכבת על גבה, הגבר שוכב מעליה ומחדיר את איבר מינו לשלה. תנוחה זו מאפשרת לבני הזוג להביט זה בזה, להתלטף ולהתנשק.

דוגי – תנוחת הכלב

זוהי התנוחה הטבעית של בעלי החיים. בני הזוג האנושיים יכולים להתענג ולענג גם בחדירה לנרתיק וגם ביד. קשה עד בלתי אפשרי לבני הזוג להביט זה לזה בעיניים.

תנוחת האישה מעל

האישה יושבת על הגבר. אין הכרח שתשב בכל כובד משקלה. יש לה שליטה בתנועה. האישה יכולה לשנות את הזווית מעל הגבר וכך להעצים את הנאתה.

תנוחת כפיות

הגבר שוכב מאחורי האישה ובטנו לעבר גבה. ביד אחת הוא יכול לכוון את עצמו ולהחזיק בה, וביד השנייה הוא יכול להגיע לדגדגן ולענג את האישה באצבעותיו. היתרון הוא היכולת למשוך את הסקס זמן רב, שכן החיכוך נמוך והחלק הרגיש של איבר המין כמעט לא חווה לחץ ומהירות תנועה בנרתיק.

69 תנוחת

בתנוחה זו אין חדירה בפועל של איבר המין הגברי לתוך איבר המין הנשי. המטרה היא סיפוק אוראלי הדדי. הראש של הגבר תחוב בין ירכי האישה ולשונו מענגת את איבר המין והדגדגן שלה. פיה של האישה מענג את האיבר שלו. אפשר לעשות זאת כשאחד על ארבע והשני שוכב או על הצד.

עוד תנוחות



יש עוד תנוחות רבות, וחשוב לנסות לגוון לפי הרצון, הפתיחות, המוכנות והנכונות של בני הזוג. לא תמיד טוב להרבות בתנוחות ולהפוך את האינטימיות המינית לאקרובטיקה במיטה. חשוב שכל זוג יבחר ויתנסה בתנוחות שנוחות ומתאימות לו.

בן הזוג של **יפית** אוהב מאוד את התנוחה 69, והיא מרגישה שקשה לה להתרכז בתנוחה הזאת, כי היא צריכה לדאוג להנאה שלו וגם להיות מרוכזת בהנאה שלה בו בזמן. יפית שואלת אם היא חריגה ואם אפשר לגמור בתנוחה הזאת. הוא מאוד רוצה לגמור כך, אך היא תמיד מפסיקה אותו באמצע ומשנה לתנוחה שיותר נוחה לה.

ליפית, החיסרון הגדול של התנוחה הוא שכדי לענג בן זוג במין אוראלי דרושה מידה כלשהי של ריכוז, ומידה זו נעלמת לפני האורגזמה ובזמן האורגזמה ומקשה על התפקוד ההדדי. מי שמתקרב לאורגזמה בתנוחה זו מתקשה להתרכז באיבר של בן זוגו. חיסרון נוסף הוא שהתנוחה יכולה להיות לא נוחה כאשר יש פער גובה בין בני הזוג. בהחלט אפשר לגמור בתנוחה זו. עם זאת טוב גם לשנות למצב נוח יותר. החליטו יחד מה נכון לשניכם ועשו כלבבכם.

יוסי, בחור גבוה וחסון בן 26, 1.90 מטר, התאהב בבחורה בת גילו שקומתה 1.57 מטר, חמודה כמו בובה, שנונה וסקסית. ליוסי יש ניסיון מיני רק עם בנות גבוהות. יוסי שואל מהי התנוחה המתאימה בהפרש גובה כזה.



ליוסי, אתה צריך לברר איתה מה עושה לה טוב ואיך, איזה מגע ואיזו תנוחה יענגו אותה. כך לא תגרום לה או לך להרגיש כמו לוליינים. כשיש הפרש גדול בגובה אולי עדיף לוותר על תנוחת 69. אפשריות תנוחת כלב וגם התנוחה המיסיונרית השווה לכל נפש ומתאימה לכל גובה. לא הגובה והתנוחה אמורים לחבר או להפריד ביניכם.

תנוחות של כבדי משקל

בדרך כלל אנשים כבדי משקל סובלים ממחלות נוסף על תופעת ההשמנה. גברים כבדי משקל נוטים לפתח יתר לחץ דם, סוכרת, רמה גבוהה של שומנים בדם, טריגליצרידים וכולסטרול, בעיות נשימה, הפרעות אנדוקריניות, וגם חסימות בכלי הדם ההיקפיים, בכללן אלה שמפעילים את מנגנון הזקפה. הם מתעייפים מהר יותר, כי הם סובלים יותר מאי-ספיקת לב, כלומר הלב לא מצליח לספק את התפוקות הגבוהות שנדרשות ממנו כדי להזרים דם למסה כל כך גדולה של גוף. המחלות האלה פוגעות בתפקוד המיני.

אנשים כבדי משקל בדרך כלל יהיו בעלי דימוי גוף וביטחון עצמי נמוכים. אצל גברים כאלה איבר המין עלול להיבלע בין קפלי השומן, דבר שיקשה על החדירה בזקפה ויגרום קושי במציאת תנוחות מתאימות. הם צריכים להיות יצירתיים מבחינת התנוחות. יתאימו להם תנוחות בסגנון כפיות.

במקרים קיצוניים יכולות להיות גם בעיות של הזעת יתר, חררה (גירוי בעור), פטרת מתחת לחזה, בבית השחי ובקפלים בין הרגליים, ריח לא נעים של זיעה. לא כל אישה או גבר ישמחו לקיים יחסי מין עם אדם כבד משקל. הכושר הגופני שלהם בדרך כלל נמוך, והם עלולים להתקשות לקיים יחסי מין סוערים.

ואף על פי שלאנשים כבדי משקל יש בעיות בתפקוד המיני בכ-50% יותר מלאנשים במשקל נורמטיבי, אלה שאינם מתביישים בגופם ורואים את משקלם כמאפיין סקסי ומיני, מיניותם בהחלט פורה ושמחה. רבים נהנים ומתפקדים לשביעות רצון שני הצדדים, ואין הבדל בתשוקה ובהנאה ובתפקוד בהשוואה לאחרים.

גדעון וחברתו ביחד שלוש שנים ואפילו חושבים על חתונה. הוא בן 26 והיא בת 24. יחסי המין שלהם מושלמים. הם יודעים לרגש זה את זה ולגעת במקומות הנכונים. גדעון וחברתו הם אנשים שמנים, ולכן כמעט תמיד היחסים ביניהם בתנוחה המיסיונרית. את גדעון השגרה הזאת מתחילה לשעמם. השניים ניסו תנוחות אחרות, אך הן פחות נוחות להם. גדעון מבקש לשמוע על תנוחות אחרות שיכולות לרגש אותם.

לגדעון, אפשר לקלקל יחסי מין אם מרבים להחליף תנוחות. כאשר הסקס הופך למופע אקרובטיקה קשה מבחינה פיזית, הוא לא מאפשר ליהנות מהמגע המיני. אבל גם מיעוט תנוחות עלול לגרום שיעמום או שחיקה בחיי המין. יצירתיות והנאה ממין אינן פונקציה של תנוחות בלבד. עוד לפני התנוחות אפשר להגיע לחוויה מענגת. דבר עם זוגתך, ונסו כל תנוחה שתיהנו ממנה. תיהנו מהתנוחה ואל תיתנו למשקל לנהל אתכם.

תודות

להוריי ז"ל שאהבתם פתחה לפניי צוהר לאתגרים ולהרפתקאות בחיים.
לאשתי דליה על אהבתה, תמיכתה וקבלתה אותי.
לילדיי עומר יעל ורועי, שנוכחותם מעמידה לפניי אתגרים משמחים.
לקרוביי ולחבריי הרבים, המעשירים אותי בחוויות חיים.